EBOOK

ANATOMÍA APLICADA A LA FLEXIBILIDAD

Qué te frena en cada estiramiento, cómo se gana rango de verdad y qué sí / qué no según el alumno

200 PÁGINAS · +70 ESTIRAMIENTOS Y TESTS
CADERA · COLUMNA · HOMBROS · SPLIT

MÚSCULO · FRENO · INTENSIDAD · MÉTODO

ANATOMÍA APLICADA A LA FLEXIBILIDAD

La guía visual de los estiramientos que funcionan

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- Un método claro para entender qué limita tu flexibilidad.
- Láminas anatómicas detalladas de los músculos clave.
- Fichas de estiramientos con el paso a paso, errores comunes y adaptaciones.
- Herramientas para evaluar y progresar con seguridad.

LA PROTAGONISTA: LA PRACTICANTE EN EL ESTIRAMIENTO (CONSISTENTE EN TODO EL LIBRO)

Como en un atlas de anatomía aplicada premium: una PRACTICANTE ADULTA (18–65 años, rostro realista pero neutro y sin parecido a nadie famoso), con ropa deportiva lisa y ajustada sin marcas, descalza o con medias, sobre un mat o el piso de una sala limpia. Su CUERPO es el protagonista: sobre la piel se dibuja POR TRANSPARENCIA el músculo o la estructura de la página (fibras en rojo anatómico, tendones en blanco, hueso en marfil, nervios en amarillo, cápsula y ligamentos en azul), con el nombre en etiqueta y línea guía. Cuando la página compara, van DOS paneles: BIEN vs. MAL con check ✅ vs. ❌ (por ejemplo, pelvis anteversa con la espalda larga vs, pelvis retroversa con la lumbar redondeada).

Alterná practicantes de distintas edades, cuerpos (delgado, robusto, muy flexible, rígido, adulta mayor, hombre y mujer) y tonos de piel.

EL PROFE es una segunda figura de linea, más chica de pie o arrodiado al lado entra SOLO el ajuste con las manos (dónde apoya, hacia dónde guia) o el cue con cors a flecha. Manos siempre correctas (S dedos).

Los elementos se dibujan GENÉRICOS: mat, bloques, cinta, pared, barra de danza, silla, banda elástica lisa.

NUNCA logos ni marcas reales.

PROHIBIDO en el fondo: playas, atardeceres, velas, inciensos, fotos de revista, gente sonriendo a cámara. Es un manual de anatomia aplicada, no una revista de bienestar.

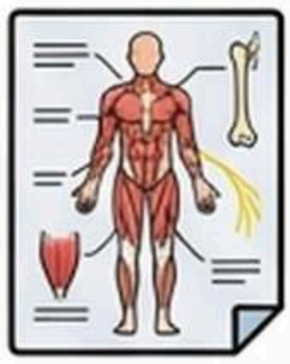
80px

TU MAPA de ruta.

Este no es un catálogo de posturas, sino **un método para que entiendas qué limita realmente tu flexibilidad.**

IDENTIFICÁ EL FRENO

ESTUDIÁ LA ANATOMÍA



APLICÁ LA TÉCNICA

MEDÍ Y PROGRESÁ

• Porque cuando sabés si el **freno es muscular**, **capsular** o **neural**, podés elegir el estiramiento correcto con la técnica precisa.

• Por eso, cada capítulo se organiza alrededor de un **grupo muscular** clave: primero te mostramos su anatomía con **ilustraciones detalladas**, luego te damos tests para evaluarlo y, finalmente, las **fichas de ejercicios** con **progresiones y regresiones**.

• las fichas de ejercicios con **progresiones** y l□tlas para que puedas aplicarlo con criterio en tus clases o en tu práctica personal.

EN LA SALA

"Cuando una alumna te dice "siempre sentí rígida esta zona", acá tenés el proceso para entender por qué y cómo trabajarlo con fundamento."

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ: Usar este libro como una consulta permanente para planificar con fundamento.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ NO: Saltear la teoría y pasar directo a los ejercicios sin entender la causa del acortamiento.

INTRO

CÓMO LEER LAS FICHAS DE ESTIRAMIENTO

LA LUPA EN LA FICHA

MÚSCULOS:
Identificá rápido qué estás elongando

MÉTODO Y TIEMPO:
La dosis exacta para que el tejido responda

PASO A PASO:
La secuencia clara para guiar o auto-guiarte

ERRORES COMUNES:
Anticípate a las compensaciones que ves todos los dias en la sala

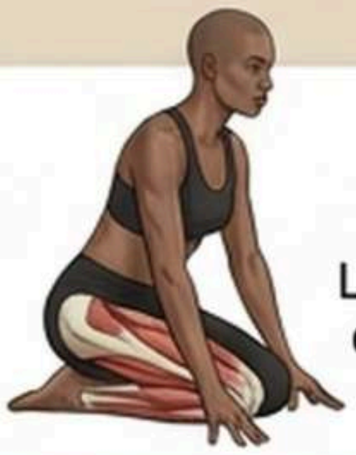
ADAPTACIONES:
La clave para personalizar y cuidar a cada alumno (hernia, hipermovilidad, embarazo)

LA FICHA: TU HERRAMIENTA PROFESIONAL

Cada ficha está diseñada para darte toda la información que necesitás de un vistazo. No solo te mostramos el "qué" (el ejercicio), sino el "cómo" (el método, el tiempo, la intensidad) y el "para quién". La sección de errores comunes nace de veinte años de observar la práctica, y te ayuda a corregir con precisión.
Las adaptaciones para casos especiales son fundamentales, porque un mismo estiramiento no es para todo el mundo. **Es tu herramienta para enseñar con seguridad y profesionalismo.**

EN LA SALA: ANTES DE ENSEÑAR

Antes de darle una progresión a un alumno, chequeá en 10 segundos la sección de "Qué sí / Qué no" para confirmar que es segura para él.

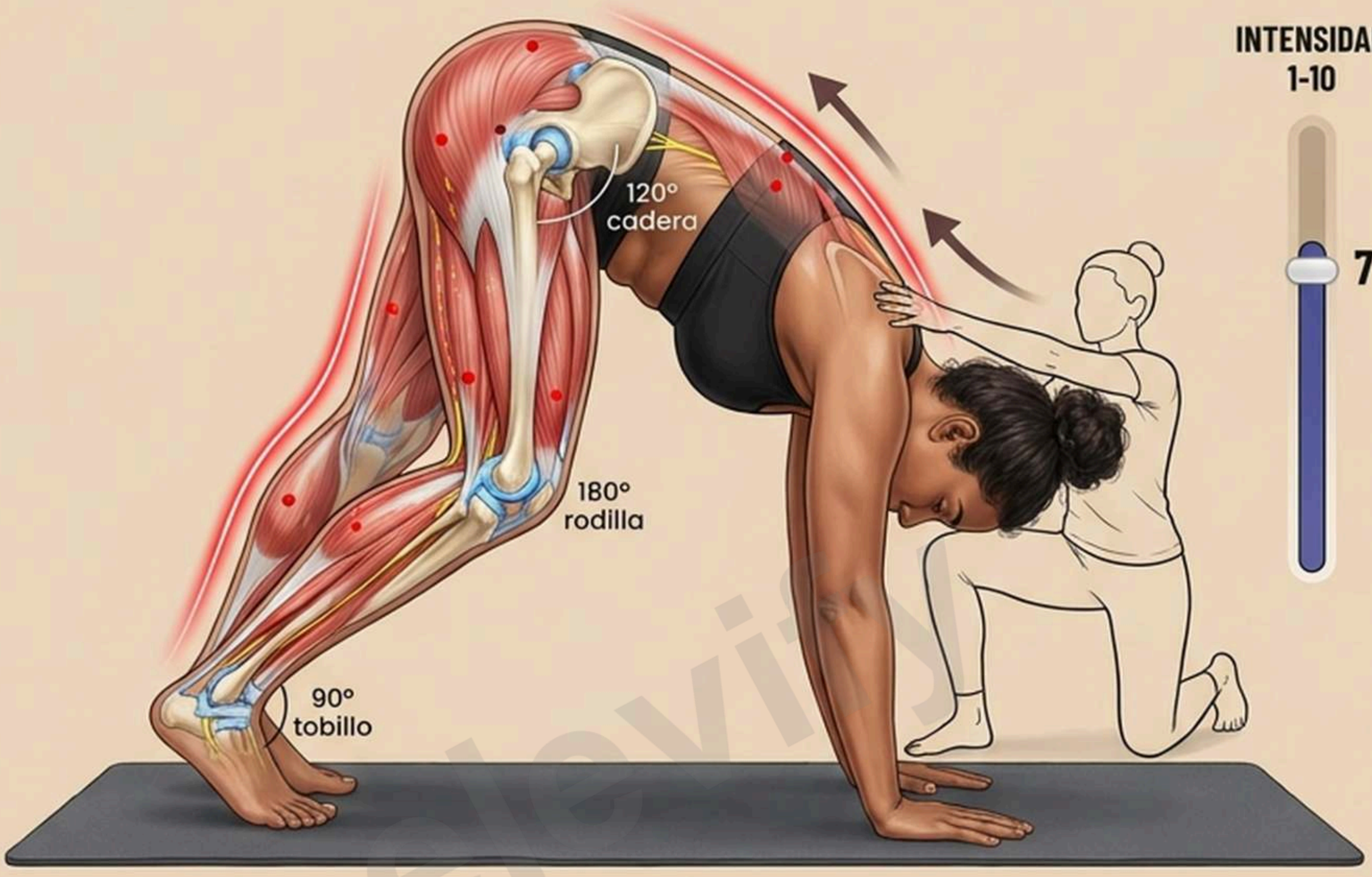


✓ QUÉ SÍ

Leer la ficha completa antes de enseñar un ejercicio por primera vez.

✕ QUÉ NO

Asumir que un estiramiento es apto para todos sin revisar las contraindicaciones.



QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vamos a **desarmar los mitos** sobre la flexibilidad. Vas a entender la **diferencia clave entre flexibilidad y movilidad, qué tejidos se estiran realmente, por qué el sistema nervioso es el que manda y cómo aplicar los principios de la ciencia para diseñar prácticas** más seguras y efectivas para vos y tus alumnos.

TRES CONCEPTOS CLAVE

FLEXIBILIDAD | **MOVILIDAD** | **ELASTICIDAD**

EN LA SALA, ESTOS TRES TÉRMINOS SE USAN COMO SINÓNIMOS, PERO SON MUY DISTINTOS.

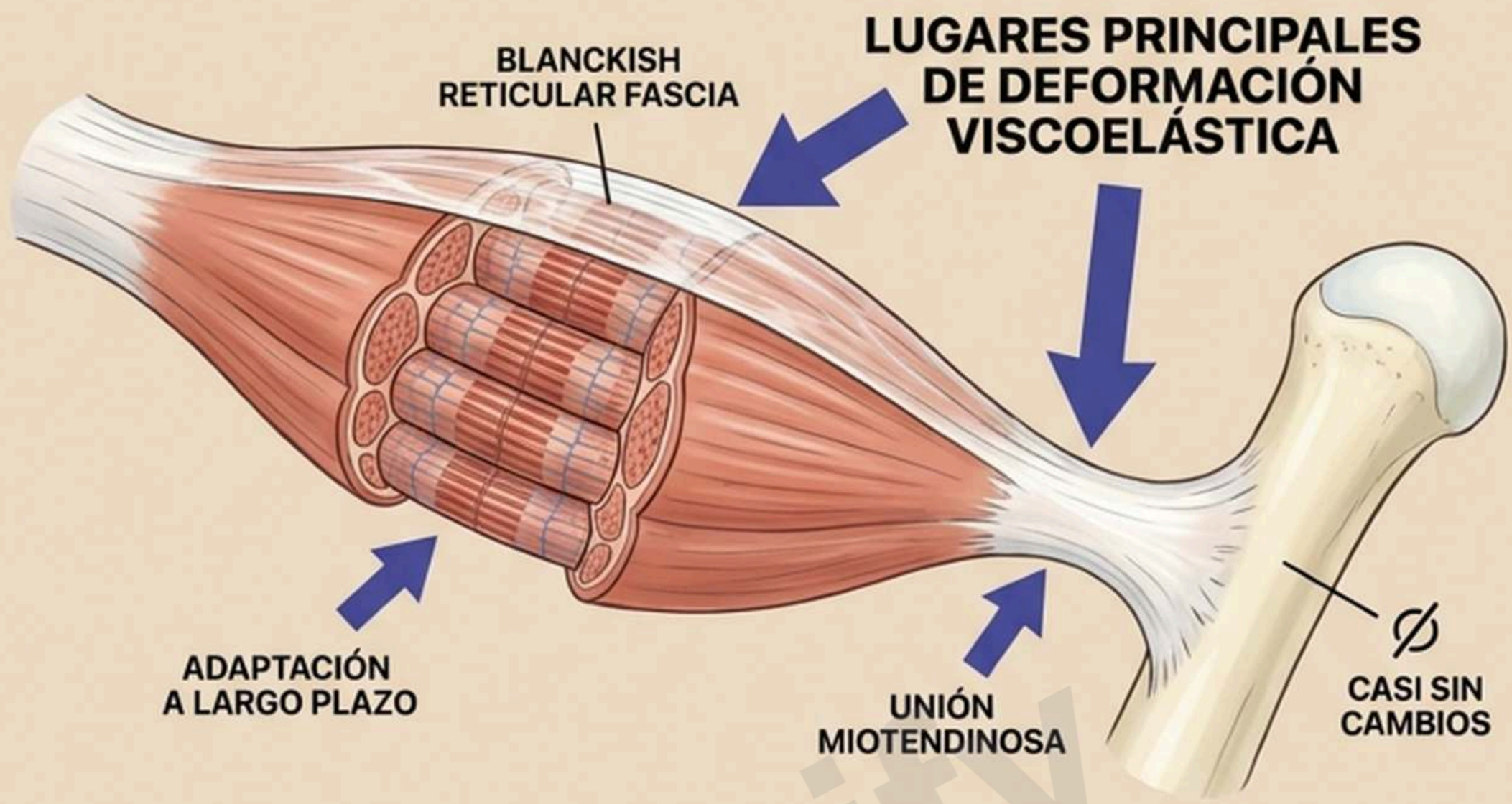
La **flexibilidad** es el rango de movimiento máximo de una articulación, casi siempre medido de forma pasiva. La **movilidad** es la capacidad de controlar ese rango de movimiento con tu propia fuerza. Y la **elasticidad** es la **propiedad** de **un tejido** de deformarse y volver a su estado.

Confundirlos lleva a programar mal: de nada sirve tener un gran rango pasivo si no podés controlarlo activamente, porque esa brecha es una zona de riesgo.

FRANJA 'EN LA SALA'

El típico alumno que llega al piso en un "pancake" pasivo pero no puede levantar la pierna ni 90 grados por su cuenta.

QUÉ SE ALARGA CUANDO ESTIRÁS

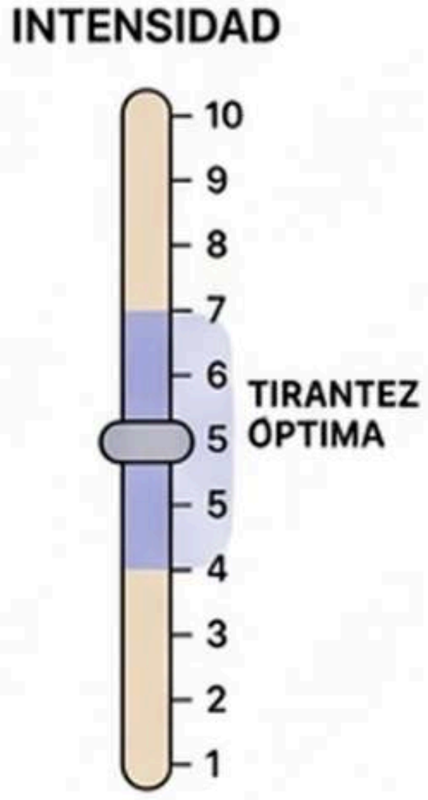


QUÉ CEDE REALMENTE

Cuando estiramos, la sensación es que 'alargamos el músculo como un elástico', pero es más complejo. El cambio inmediato se da en las **propiedades viscoelásticas del tejido conectivo, la fascia,** que se vuelve más fluida y permite un mayor deslizamiento.

A largo plazo y con estímulo constante, el **músculo puede añadir sarcómeros en serie.**

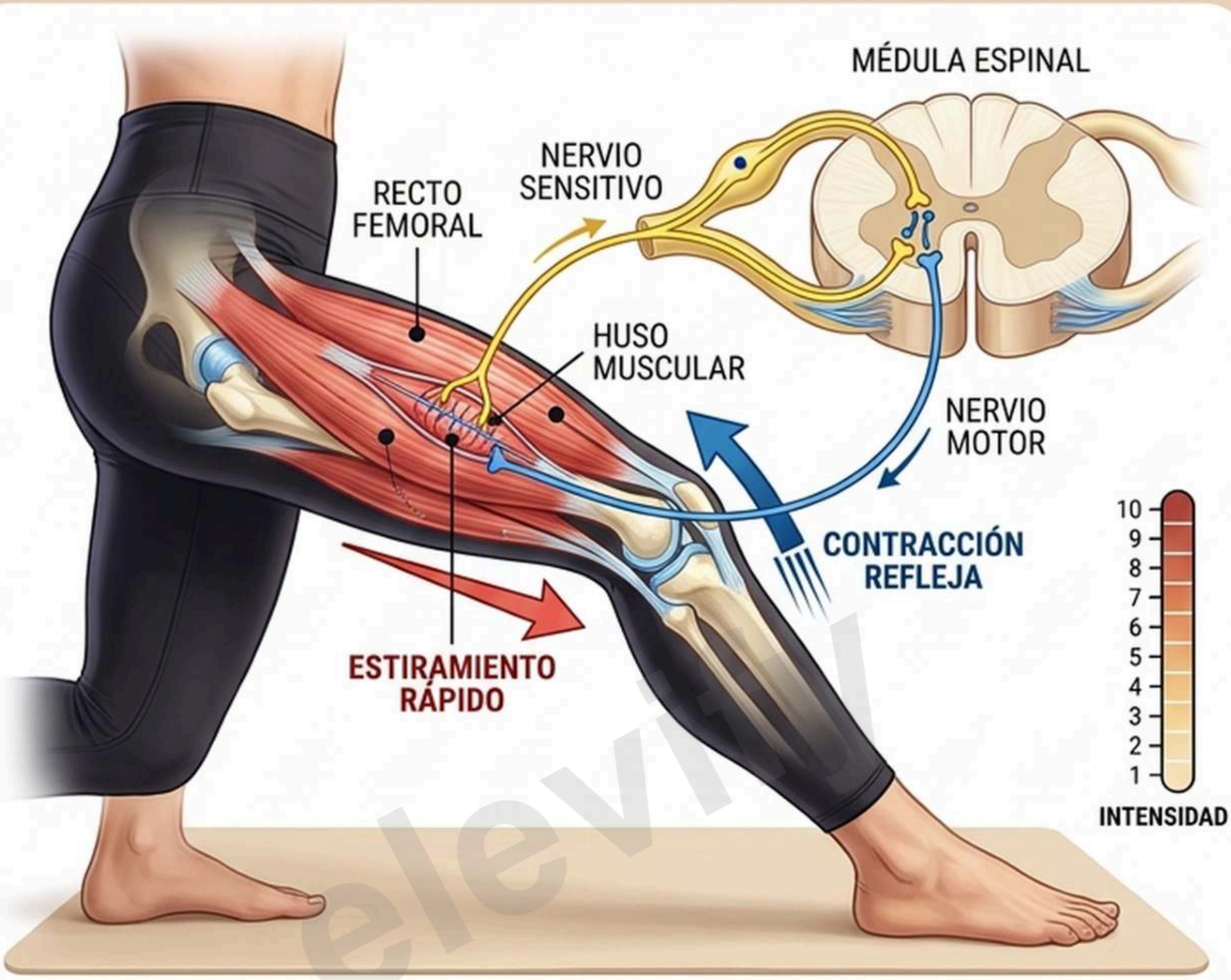
El **tendón** es mucho más rígido y cambia muy poco, y el **hueso no cambia.**
Por eso, la sensación de 'tirón' casi siempre está en la fascia o en la unión del músculo con el tendón, no en el medio del vientre muscular.



EN LA SALA

Cuando un alumno dice **'siento que se me va a cortar el tendón',** en realidad está sintiendo la tensión en la unión miotendinosa, que es donde están los sensores.

EL REFLEJO MIOTÁTICO: EL FRENO



EL FRENO DE MANO.

El reflejo miotático es el principal mecanismo de defensa del músculo ante un estiramiento. Cuando las fibras se alargan de forma demasiado rápida o intensa, los sensores llamados husos musculares envían una señal de alarma a la médula espinal.

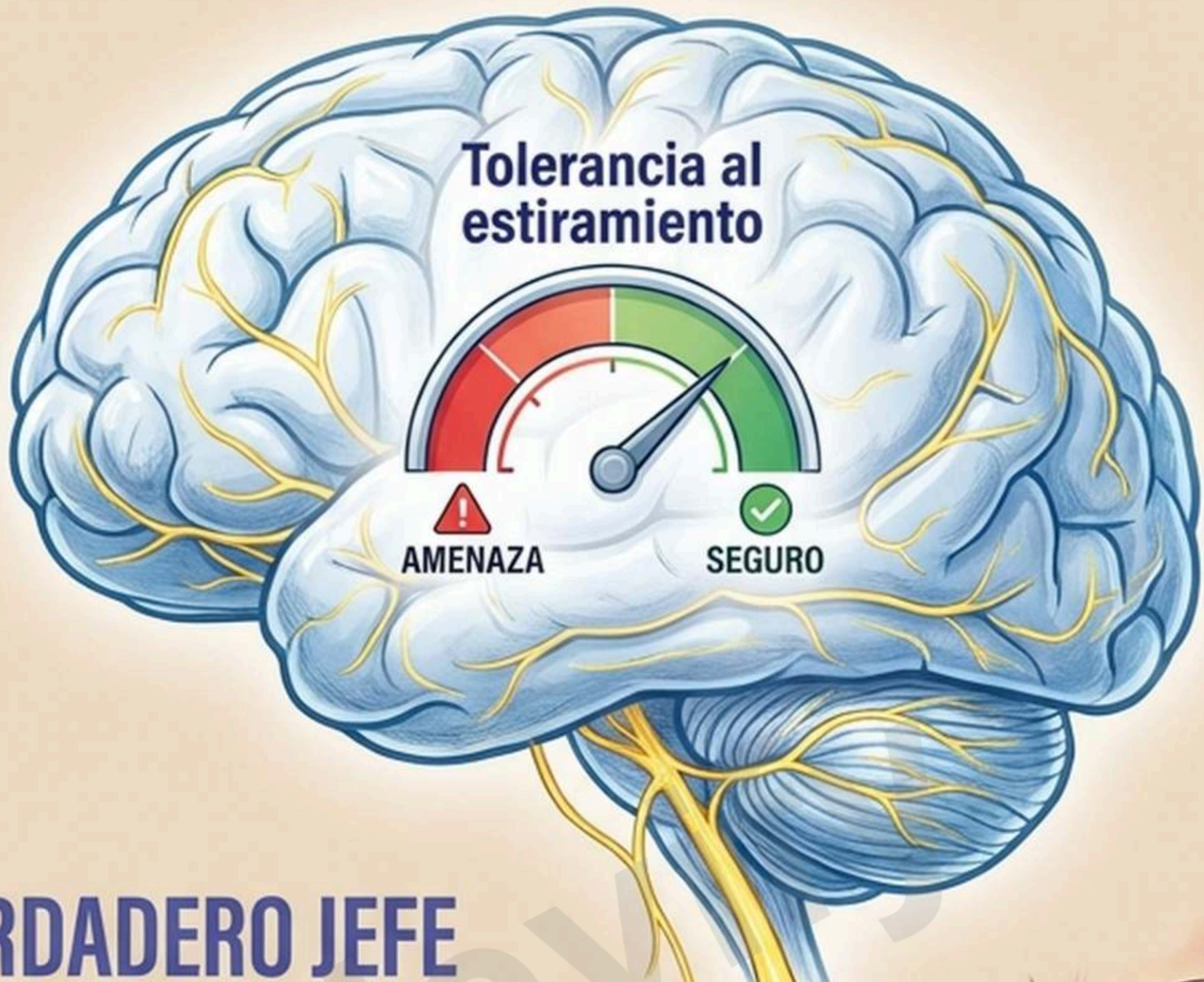
La respuesta es inmediata: una orden de contracción para ese mismo músculo, para protegerlo de un posible desgarro.

Por eso, estirar con rebotes o tirones bruscos es contraproducente: estás luchando constantemente contra el sistema de protección de tu propio cuerpo. Para ganar flexibilidad, necesitamos 'dialogar' con este reflejo, no pelear con él.

EN LA SALA

Es la 'patadita' que da la pierna cuando el médico te golpea la rodilla. En clase, es la contracción que sentis si vas demasiado rápido a la postura.

EL SISTEMA NERVIOSO MANDA



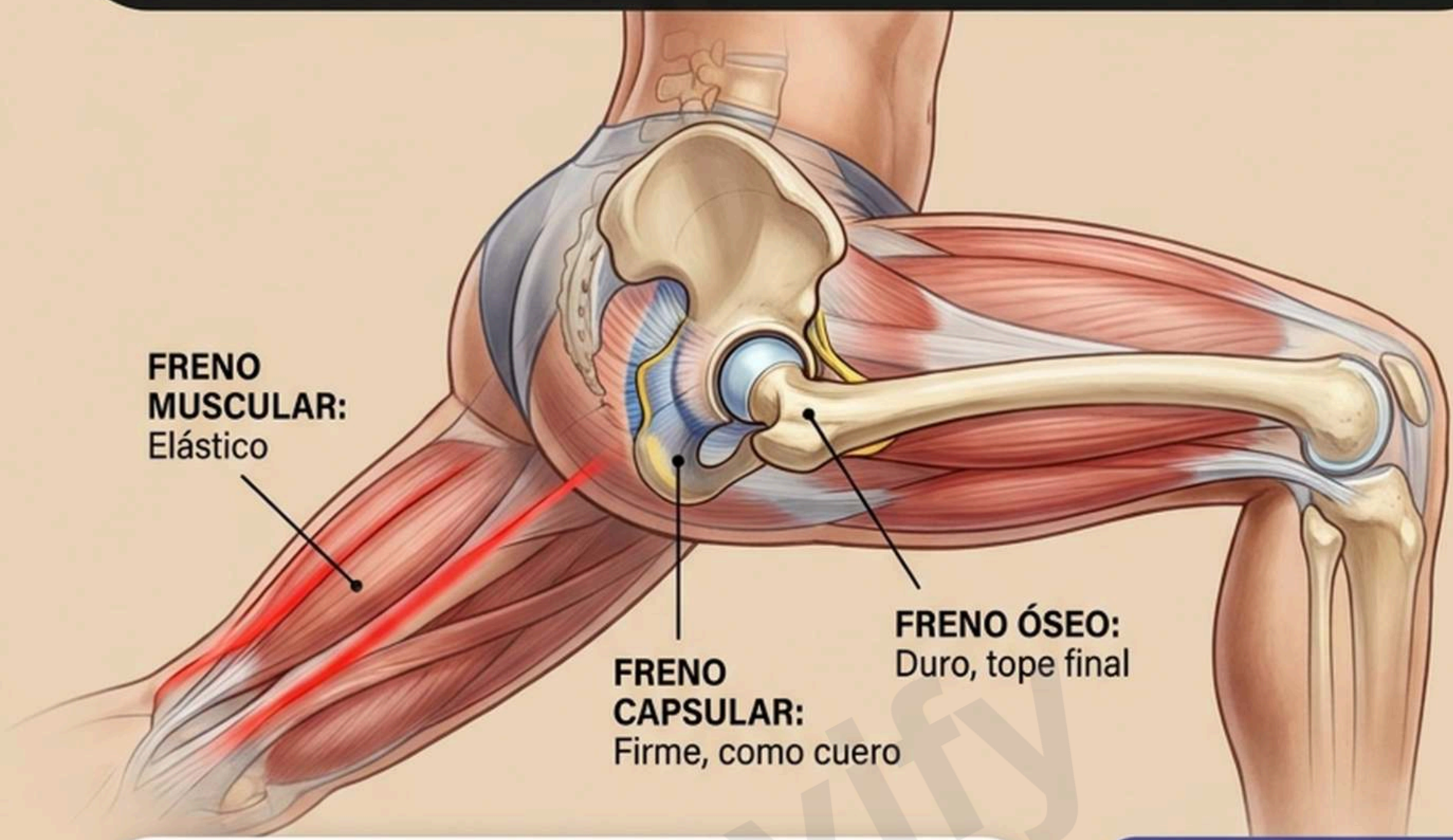
EL VERDADERO JEFE

Las ganancias de flexibilidad que ves en las primeras semanas de práctica casi nunca son por un cambio estructural real en el músculo. Son neurológicas. Tu sistema nervioso central es el que decide hasta dónde es seguro llegar. Al principio, interpreta una tirantez intensa como una posible amenaza de lesión y activa los frenos. Con la práctica constante, gradual y sin dolor, el cerebro 'aprende' que ese nuevo rango es seguro y recalibra su percepción. Simplemente, aumenta su tolerancia al estiramiento y te permite ir más lejos. Por eso la consistencia es más importante que la intensidad.

EN LA SALA

La alumna que el primer día no se toca los pies y a la tercera clase llega, no 'alargó' sus isquiotibiales en una semana. Su sistema nervioso se relajó.

LOS TRES FRENOS CORPORALES



No todos los límites son musculares.

Cuando llegás al final de un rango de movimiento, la sensación (end-feel) te dice qué te está frenando.

El **freno muscular** es elástico y cede un poco.
El **freno capsular**, de la cápsula articular y ligamentos, es más firme y menos elástico, como estirar cuero.

Y el **freno óseo** es un tope duro e inamovible, hueso contra hueso.

Saber identificar qué freno estás sintiendo es clave para saber si podés seguir trabajando para ganar rango o si llegaste al límite anatómico de tu propia estructura.

EN LA SALA

En una torsión de columna, la sensación de "tope" que no cede más casi musurrai siempre es un freno óseo o capsular, no solo muscular.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ: Trabajar con paciencia sobre el freno muscular y capsular.

QUÉ NO: Forzar nunca un tope óseo. La anatomía no se negocia.

RANGO ACTIVO VS. RANGO PASIVO

RANGO PASIVO

RANGO ACTIVO

LA BRECHA: RIESGO DE LESIÓN

El **RANGO PASIVO** es hasta dónde llega una articulación con una ayuda externa (la gravedad, un profe, una banda).

El **RANGO ACTIVO** es el que podés alcanzar y sostener usando solo la fuerza de tus músculos.

Una brecha muy grande entre tu rango pasivo y tu activo es un indicador de riesgo de lesión. Significa que tenés un rango de movimiento al que podés acceder, pero que no tenés la fuerza para controlar o proteger. Un buen **entrenamiento de movilidad busca cerrar esa brecha**, enseñándole al cuerpo a ser fuerte en todo su rango de movimiento disponible.

EN LA SALA

LA ALUMNA HIPERLAXA (Pasivo)

Se "cae" en el split (rango pasivo) sin esfuerzo, pero con poca estabilidad y control.

EL PROBLEMA (Activo)

No tiene fuerza para hacer una patada alta controlada (rango activo). Ahi es donde se lesiona.

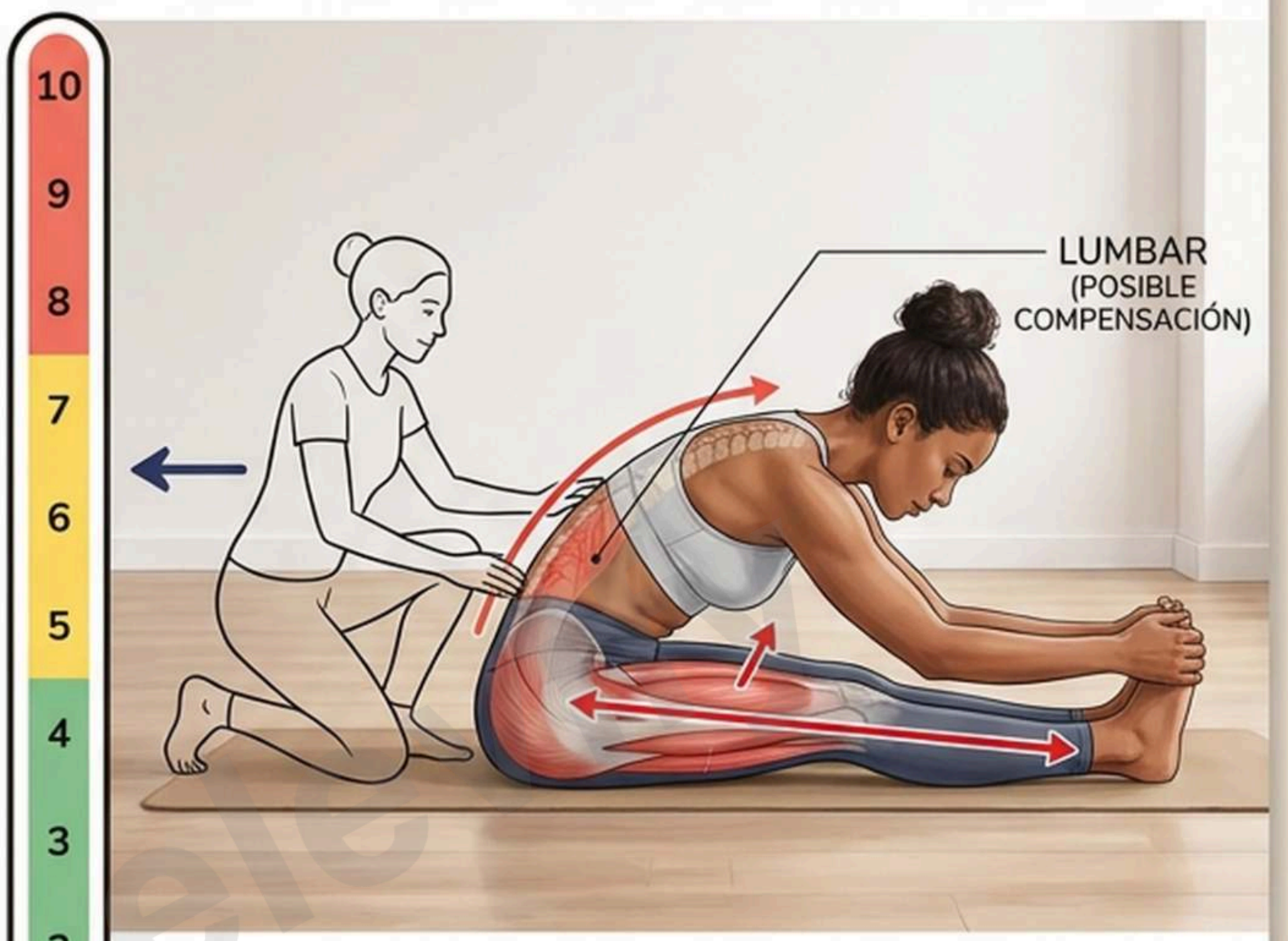
☑ **OBJETIVO:**
Convertir el rango pasivo en rango activo utilizable.

LA ESCALA JUSTA

DOLOR
Zona de riesgo

TIRANTEZ PRODUCTIVA
Zona de flexibilidad

TENSIÓN SUAVE
Zona de movilidad



Para estirar de forma segura y efectiva, tenés que aprender a regular la intensidad. Usamos una escala de percepción subjetiva del 1 al 10.

Del 1 al 4 es una tensión suave, útil para movilizar o calentar. El trabajo para ganar flexibilidad se hace **en la zona amarilla, entre un 5 y un 7:** sentís una tirantez clara e incómoda, pero podés mantener la posición y respirar de forma fluida. Si llegás a **8 o más, ya es dolor**. Es una señal de alarma que activa los reflejos de protección y convierte el estiramiento en algo contraproducente y potencialmente lesivo.

EN LA SALA

Le pregunto siempre al alumno: “Del 1 al 10, ¿dónde estás?”. Si no puede hablar fluidamente, es que está en zona roja.

LA DOSIS CORRECTA

30-60
SEGUNDOS
por serie

x2-4
SERIES
por músculo

4
VECES
por semana

Aunque cada cuerpo es un mundo, la evidencia científica nos da pautas claras sobre la **'dosis'** efectiva para **ganar flexibilidad con estiramientos estáticos.**

Para generar cambios viscoelásticos en el tejido, se recomienda mantener cada estiramiento **entre 30 y 60 segundos.** Menos tiempo es poco efectivo.

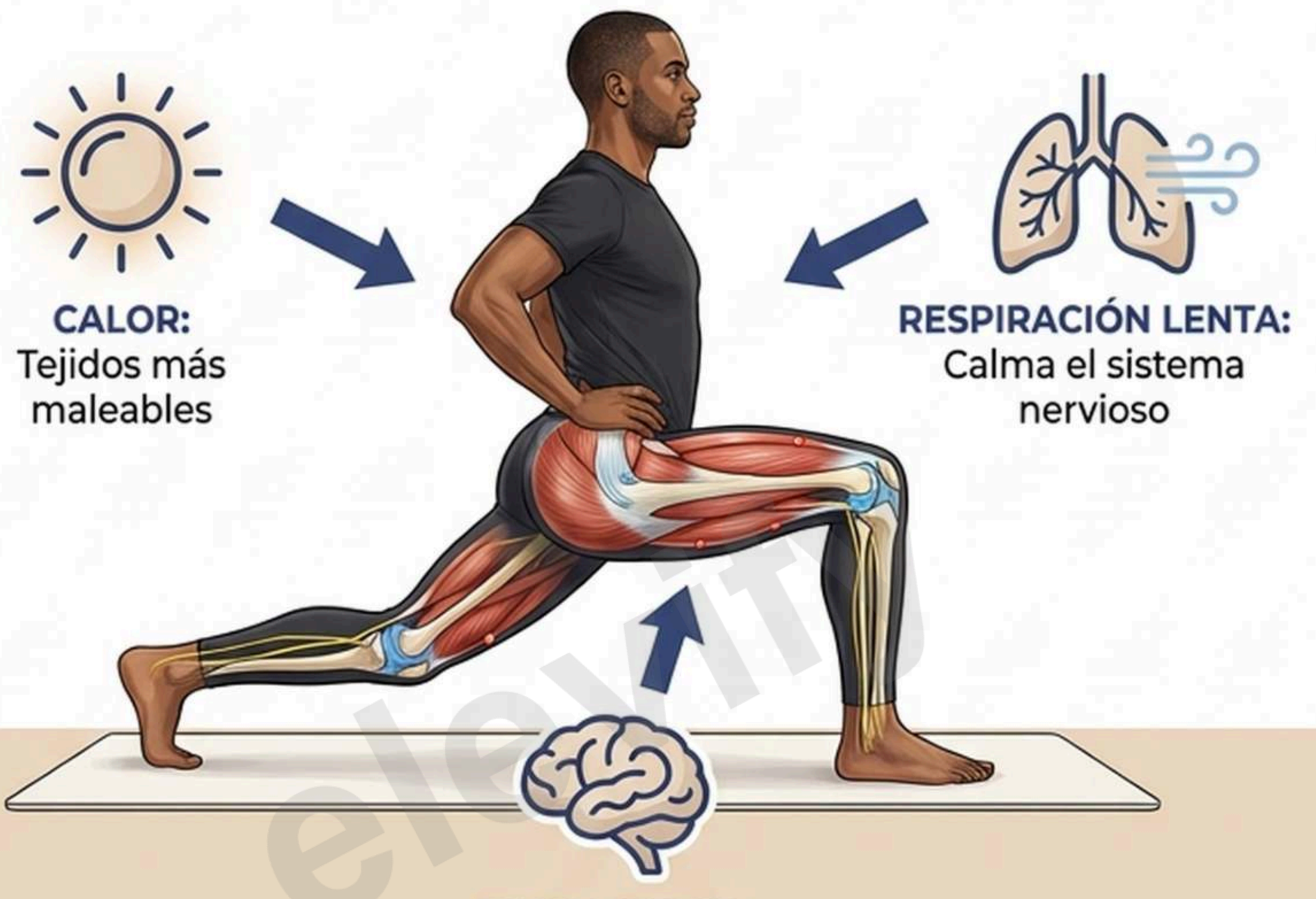
Se sugiere realizar de **2 a 4 series por grupo muscular** en cada sesión.

Y para que las adaptaciones se consoliden, la **frecuencia** es clave: lo ideal es trabajar un mismo grupo muscular entre **3 y 6 veces por semana.**

En flexibilidad, la constancia siempre le gana a una sesión aislada muy intensa.

EN LA SALA: Mejor estirar isquiotibiales 5 minutos, 5 días a la semana, que hacer una sesión durísima de una hora solo el domingo.

TUS TRES ALIADOS



FACTORES CLAVE

El resultado de un mismo estiramiento puede variar muchísimo dependiendo de tres factores. El **calor**, conseguido con una buena entrada en calor (no con la temperatura de la sala), hace que el tejido conectivo sea más dúctil.

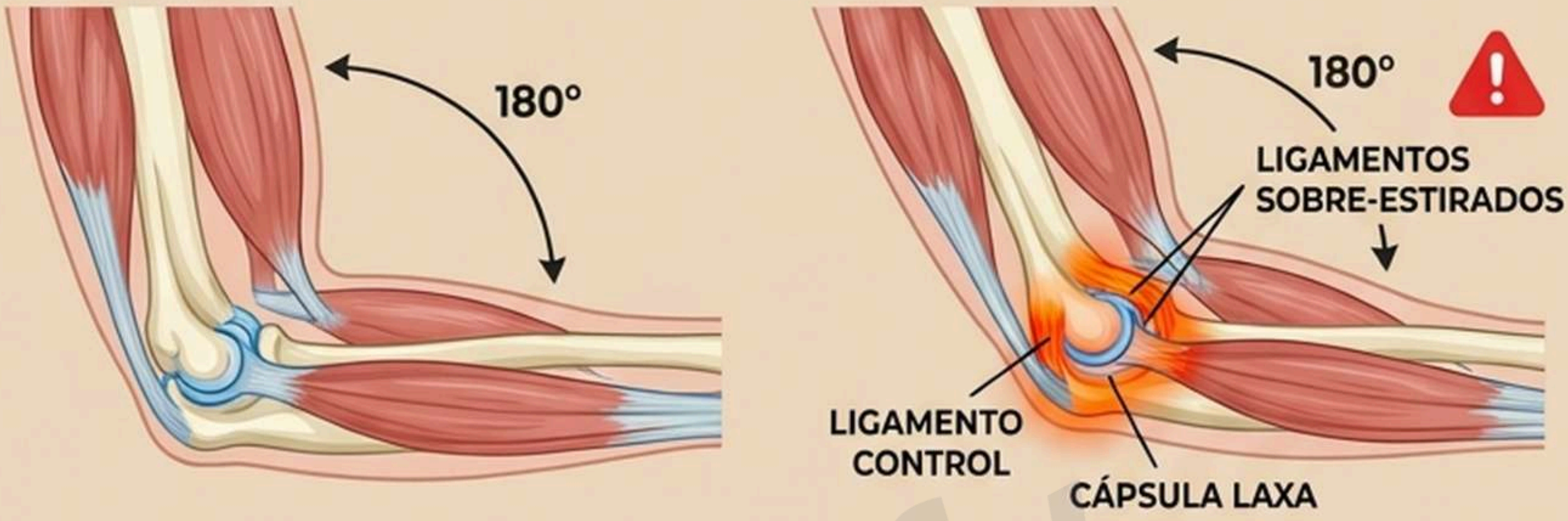
La **respiración diafragmática**, lenta y profunda, activa el **sistema nervioso parasimpático**, el de 'descansar y digerir', que inhibe la respuesta de tensión.

Y el **foco mental**, estar presente en la sensación, te permite regular la intensidad, notar compensaciones y evitar que la mente active el **modo 'lucha o huida'**.

EN LA SALA: Por eso nunca estiramos 'en frío' al empezar la clase, y por eso insisto tanto con que '**exhalen en la parte más intensa**'.

HIPERMOVILIDAD: CUANDO MÁS ES PEOR

CUANDO “MÁS” ES “PEOR”



QUÉ ES LA HIPERMOVILIDAD

La hipermovilidad es una condición del tejido conectivo, a menudo genética, que permite a las articulaciones un rango de movimiento mayor de lo normal.

Para estas personas, buscar más flexibilidad pasiva es un error, porque puede generar inestabilidad y aumentar el riesgo de luxaciones y lesiones.

El objetivo en un alumno hiperlaxo es el opuesto: necesita control y fuerza. El foco de su práctica debería ser la movilidad activa y el fortalecimiento de los músculos que estabilizan la articulación, sobre todo en los rangos finales que ya posee. Para ellos, la consigna no es 'relajar', sino 'activar y sostener'.

EN LA SALA

A la alumna que apoya los codos en el piso en un “perro boca abajo”, no la empujo. Le pido que active los brazos y sostenga la alineación.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ QUÉ SÍ

Fortalecer en los rangos finales, trabajar la propiocepción, evitar “colgarse” de las articulaciones.

✗ QUÉ NO

Estiramientos pasivos largos, buscar rangos extremos, forzar hiperextensiones.

ESTIRAR ANTES O DESPUÉS

ANTES DE ENTRENAR: MOVILIDAD DINÁMICA

- Prepara el sistema nervioso para la acción.
- Lubrica las articulaciones con líquido sinovial.
- Aumenta la temperatura corporal y el flujo sanguíneo.

DESPUÉS DE ENTRENAR: FLEXIBILIDAD ESTÁTICA

CUÁDRICEPS · PSOAS · INTENSIDAD 6 · 45 SEG

- Busca ganar rango de movimiento a largo plazo.
- Promueve la relajación y reduce la tensión muscular.
- Aprovecha el calor residual del cuerpo después del esfuerzo.

EL TIPO Y MOMENTO DEPENDEN DE TU OBJETIVO

El tipo de estiramiento y el momento de hacerlo dependen de tu objetivo específico. Antes de una actividad intensa o entrenamiento de fuerza, lo ideal es la movilidad articular y los estiramientos dinámicos; estos preparan al cuerpo para el esfuerzo sin reducir su capacidad de generar fuerza o potencia explosiva.

De hecho, está demostrado que los estiramientos estáticos largos (más de 60 segundos) justo antes de un entrenamiento pueden disminuir el rendimiento deportivo. Por eso, el trabajo de flexibilidad estática para ganar rango de movimiento lo dejamos para después de la sesión principal, o para una sesión aparte dedicada exclusivamente a la flexibilidad.

EN LA SALA: En la entrada en calor hacemos círculos articulares y balanceos controlados. La postura del 'split' o estiramientos profundos la dejamos para el final de la clase, cuando el cuerpo está caliente y receptivo.

AVISO IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Este libro es un material educativo premium diseñado para profesionales y practicantes serios del movimiento, la danza y el deporte.

La información detallada sobre anatomia aplicada, biomecánica y técnicas de estiramiento a aquí tiene **fines exclusivamente instructivos y no reemplaza, bajo ninguna circunstancia, el diagnóstico médico profesional** ni el tratamiento de un médico, kinesiólogo o fisioterapeuta cualificado. Cada cuerpo es único y presenta sus propias condiciones y limitaciones.

- **CONSULTÁ SIEMPRE:** Ante un dolor agudo, persistente, una lesión reciente, sensación de hormigueo, chasquidos, un embarazo de riesgo o cualquier duda sobre tu condición fisica particular, consultá siempre con un profesional de la salud antes de intentar realizar los ejercicios o técnicas descritas en esta guía.

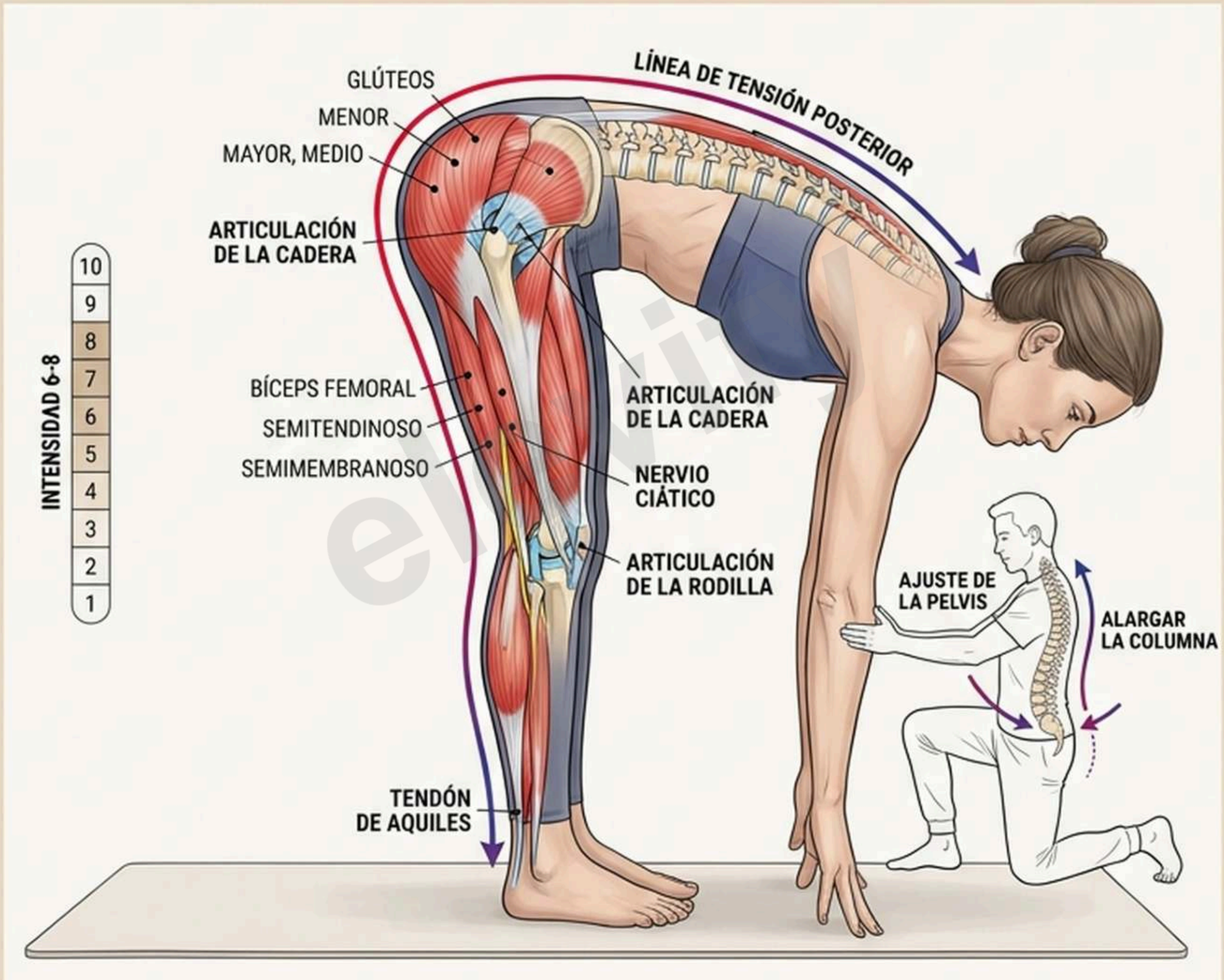
- **CONTRAINDICACIONES:** Si un ejercicio, postura o técnica está contraindicado para vos debido a una condición médica preexistente, lesión, cirugía reciente o limitación estructural, NO lo hagas. Respetá siempre las indicaciones de tu médico o terapeuta.

- **ESCUCHÁ TU CUERPO:** La flexibilidad se desarrolla progresivamente. Nunca fuerces una posi flexibilidad se desarrolla progresivamente. Nunca fuerces una posición más allá de tu limite seguro. La sensación debe ser de estiramiento o tensión controlada, nunca de dolor agudo o incomodidad intensa. Tu seguridad y bienestar son la prioridad absoluta.

Tu seguridad es la prioridad. Practicá con conciencia y responsabilidad.

LAS LÁMINAS

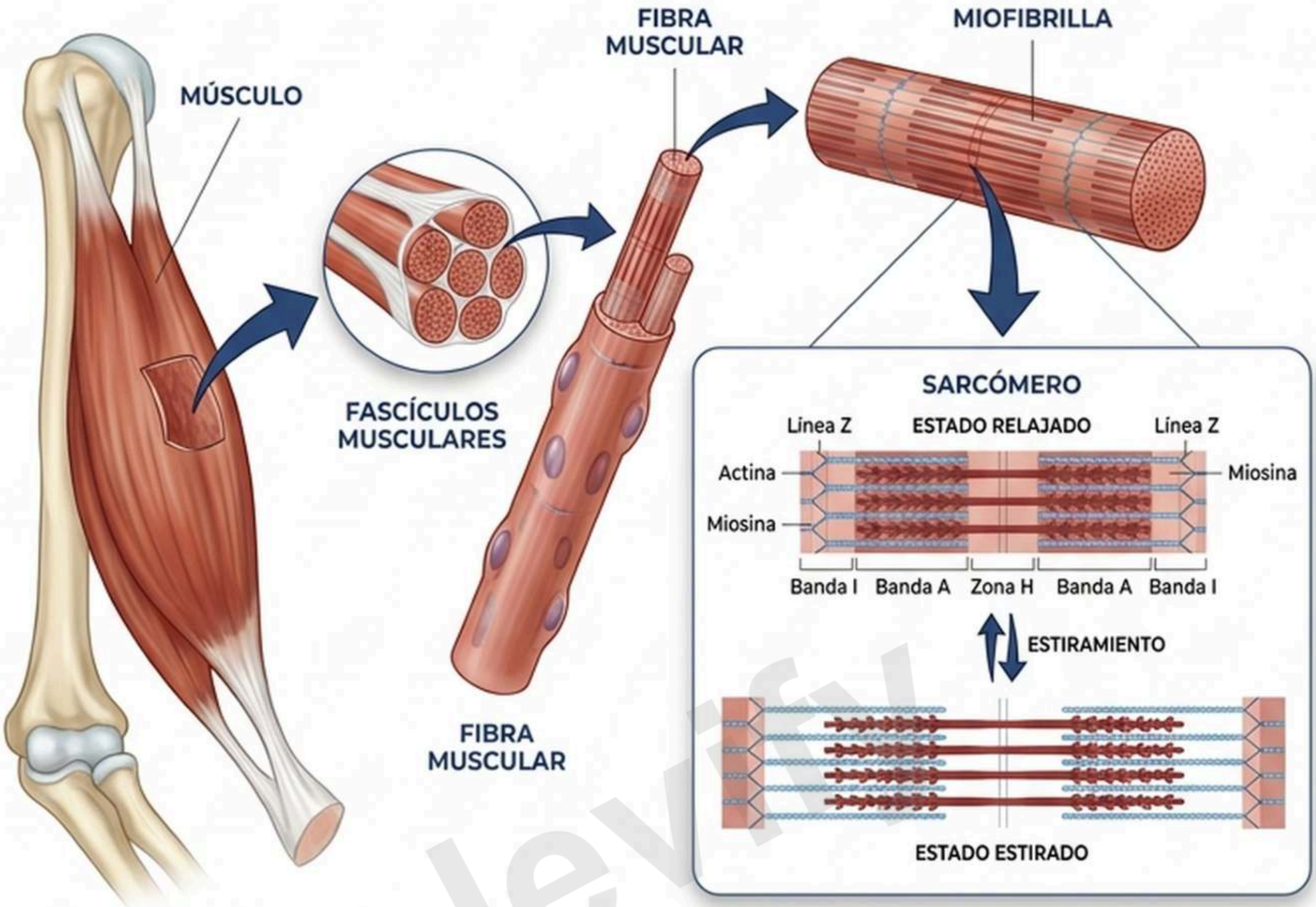
Entender la anatomía te da la llave para estirar mejor, con más seguridad y con más criterio.



QUÉ VAS A ENCONTRAR

Un viaje profundo a los tejidos y las estructuras que permiten o limitan el movimiento.
Vamos a ver el músculo, la fascia, el tendón, el nervio y .. para que sepas qué estás estirando en cada posición, por qué algo frena y cómo cuidar el cuerpo de tus alumnos con criterio profesional.

EL MÚSCULO POR DENTRO



EL MÚSCULO: MOTOR Y FRENO

El músculo es el tejido contráctil que genera movimiento, pero también es uno de los principales frenos a la flexibilidad. Está compuesto por fibras que contienen sarcómeros.

Cuando estirás, no estás alargando las fibras como si fueran una banda elástica, sino que estás deslizando los filamentos de actina y miosina dentro de cada sarcómero.

Este deslizamiento, repetido en millones de sarcómeros, es lo que permite que el músculo entero ceda y gane longitud. Por eso, el estiramiento es un proceso de adaptación neuromuscular, no solo un evento mecánico.

EN LA SALA

Cuando un alumno siente que "tira", lo que percibe es la tensión de miles de sarcómeros llegando a su limite elástico fisiológico. Es la resistencia natural de los puentes cruzados de actina y miosina siendo separados más allá de su longitud de reposo.

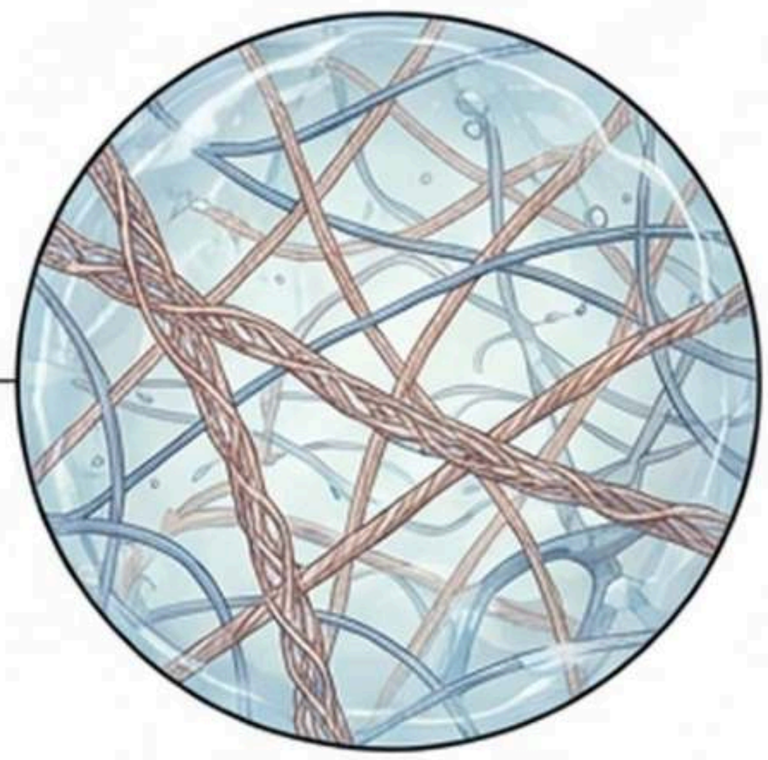
LA ADAPTACIÓN NEUROMUSCULAR

La mejora en la flexibilidad a largo plazo no es solo alargar el tejido, sino enseñar al sistema nervioso a tolerar mayores rangos de movimiento sin activar el reflejo de protección.

FACTORES QUE INFLUYEN

- Temperatura muscular
- Hidratación
- Frecuencia de entrenamiento
- Edad y genética
- Tensión residual (tono muscular)

LA FASCIA: LA RED CONECTORA



MATRIZ FASCIAL: COLÁGENO Y ELASTINA EN GEL ACUOSO

DÓNDE ESTÁ

Es una red de tejido conectivo que envuelve y conecta todo: músculos, huesos, órganos y nervios.

QUÉ HACE

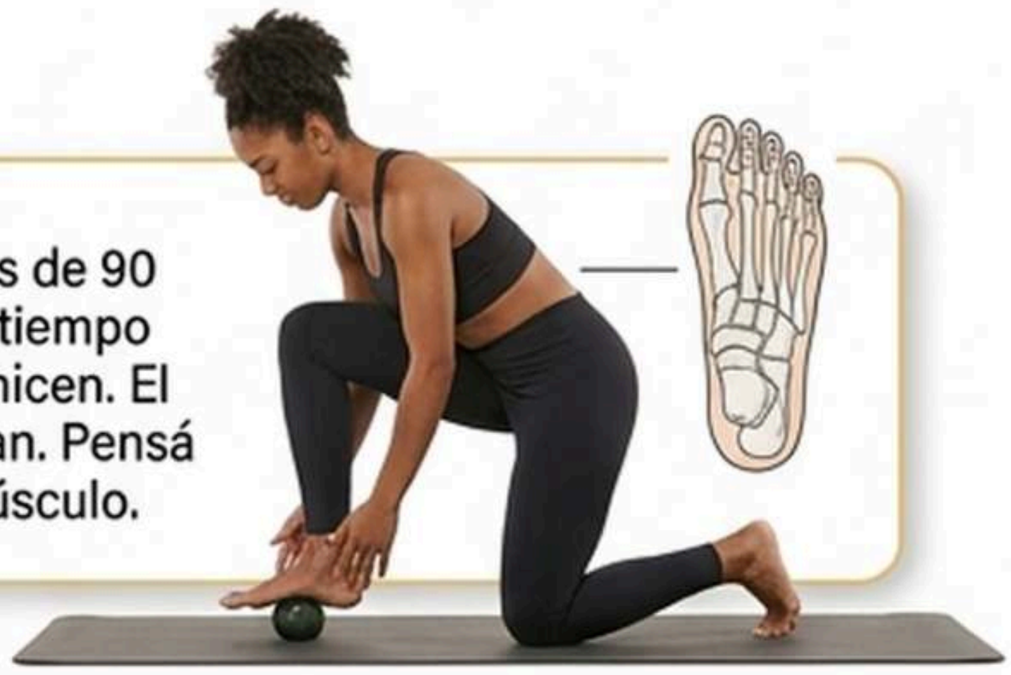
Da soporte estructural, transmite fuerzas y permite el deslizamiento entre tejidos.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA

Cuando está deshidratada o con adherencias, restringe el movimiento en cadenas enteras, no solo en un músculo.

CÓMO SE ESTIRA

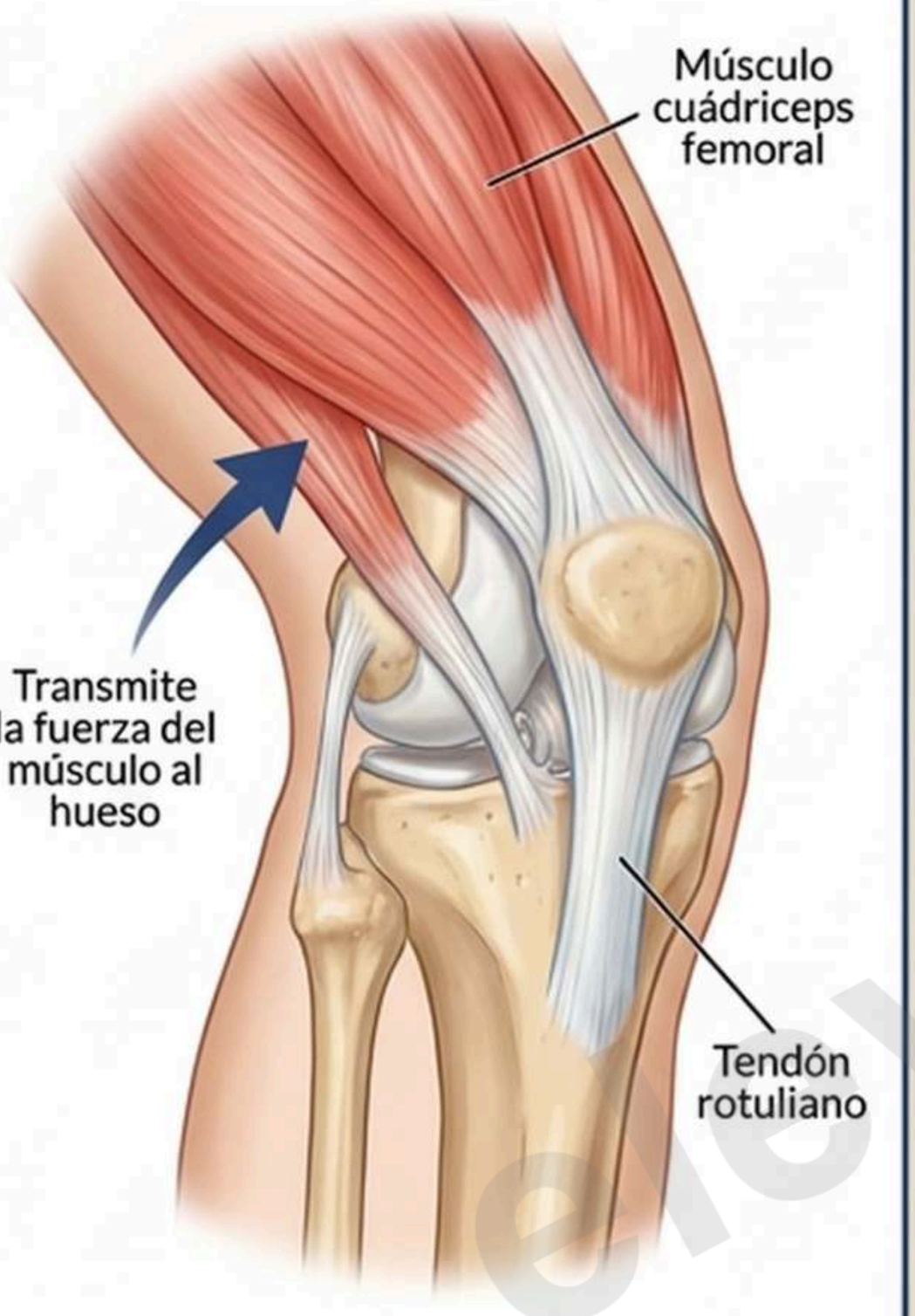
La fascia responde mejor a estiramientos sostenidos (más de 90 segundos), suaves y multidireccionales, porque necesita tiempo para rehidratarse y que sus fibras de colágeno se reorganicen. El calor y la presión (como en la liberación miofascial) ayudan. Pensá en movimientos globales y lentos, no solo en aislar un músculo.



CUE DE LA FORMADORA: Si estirás los isquiotibiales y no ceden, probá liberar la fascia plantar y la nuca; a veces la tensión viene de lejos.

TENDÓN Y LIGAMENTO

TENDÓN



LIGAMENTO

DÓNDE ESTÁN: El tendón conecta músculo a hueso. El ligamento conecta hueso a hueso.

- **QUÉ HACEN:** El tendón transmite fuerza para el movimiento. El ligamento restringe el movimiento excesivo para proteger la articulación.
- **QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO:** Un tendón no se 'acorta', pero la rigidez en la unión miotendinosa sí limita. Un ligamento no debe estirarse; su función es ser un tope.

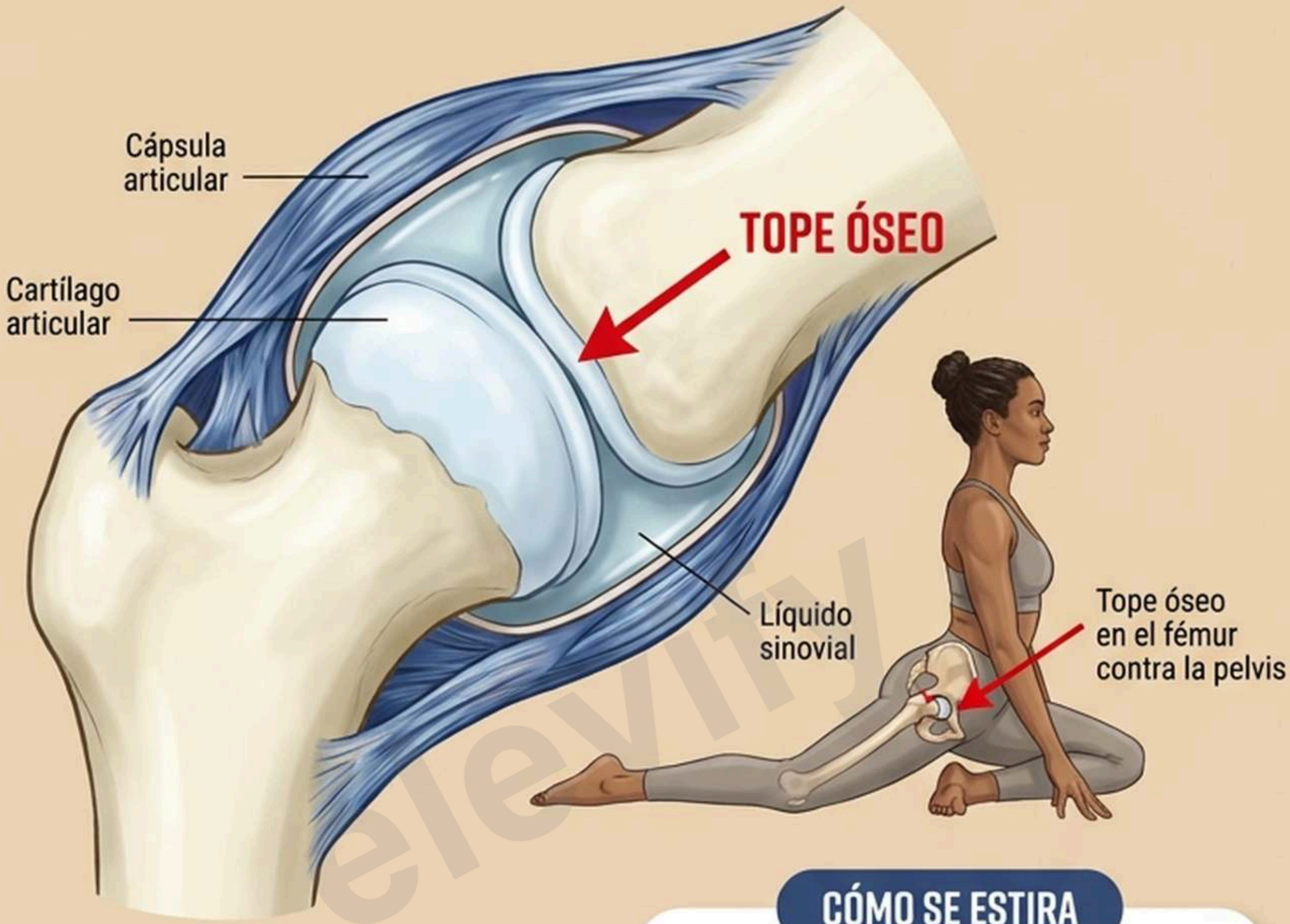
CÓMO SE ESTIRA

No queremos estirar los ligamentos, porque eso genera inestabilidad (un esguince). Tampoco estiramos el tendón en sí, que es poco elástico. Lo que trabajamos es la unión miotendinosa y el músculo. Si un alumno siente un pinchazo agudo en la inserción o en la articulación, no es el 'buen' estiramiento; es una señal de alerta.

CUE DE LA FORMADORA

En alumnos hiperlaxos, el foco nunca es ganar más rango pasivo, sino fortalecer para proteger sus ligamentos ya laxos.

LA ARTICULACIÓN Y EL TOPE ÓSEO



DÓNDE ESTÁ:
Es la unión entre dos o más huesos que permite el movimiento.

QUÉ HACE:
Permite la movilidad mientras mantiene la estabilidad.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA:
La cápsula articular puede engrosarse y limitar el rango. El propio choque de los huesos (tope óseo) es el límite estructural final.

CÓMO SE ESTIRA

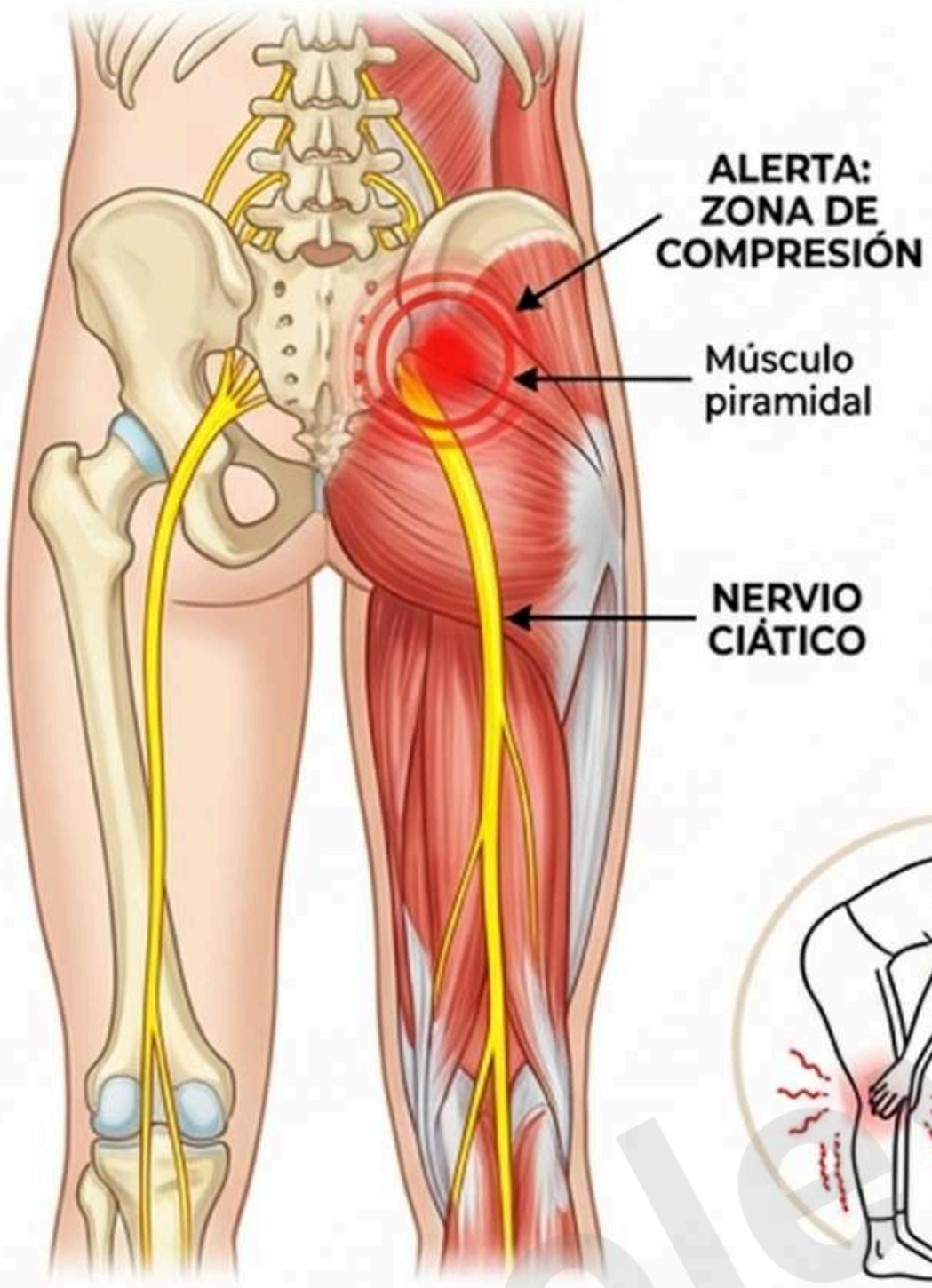
La cápsula se flexibiliza con movilidad articular suave y estiramientos sostenidos. Pero el tope óseo es un límite anatómico que hay que respetar. Si la alumna siente un bloqueo duro y a veces doloroso al final del rango, es el hueso. Forzarlo solo puede dañar el cartilago o el borde de la articulación. Cada persona tiene una estructura ósea única.

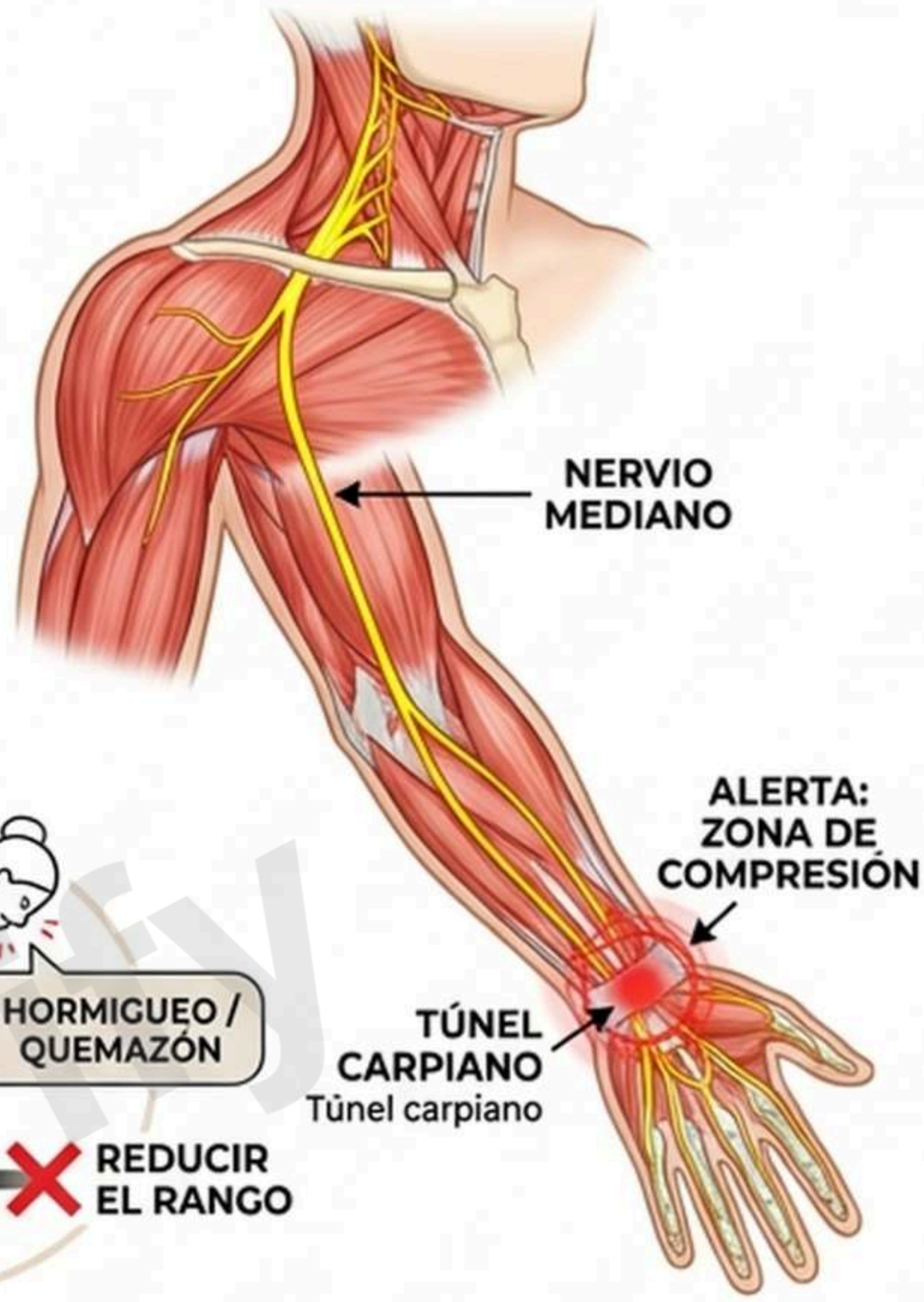
CUE DE LA FORMADORA

La forma de los huesos de cada persona es única; por eso no todos llegarán a la misma profundidad en una postura.

LOS NERVIOS Y EL HORMIGUEO

LÁMINA ANATÓMICA: LOS NERVIOS





DÓNDE ESTÁN

Recorren todo el cuerpo como un cableado complejo, pasando entre músculos, huesos y fascias.

QUÉ HACEN

Transmiten señales motoras desde el cerebro a los músculos y señales sensoriales desde el cuerpo al cerebro.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Un nervio **NO** se estira como una banda elástica, se **DESLIZA**. Si está atrapado o adherido en su recorrido, su falta de deslizamiento se siente como una tirantez eléctrica, quemazón o con hormigueo, no como un estiramiento muscular.

CÓMO SE ESTIRA: NEURODINAMIA

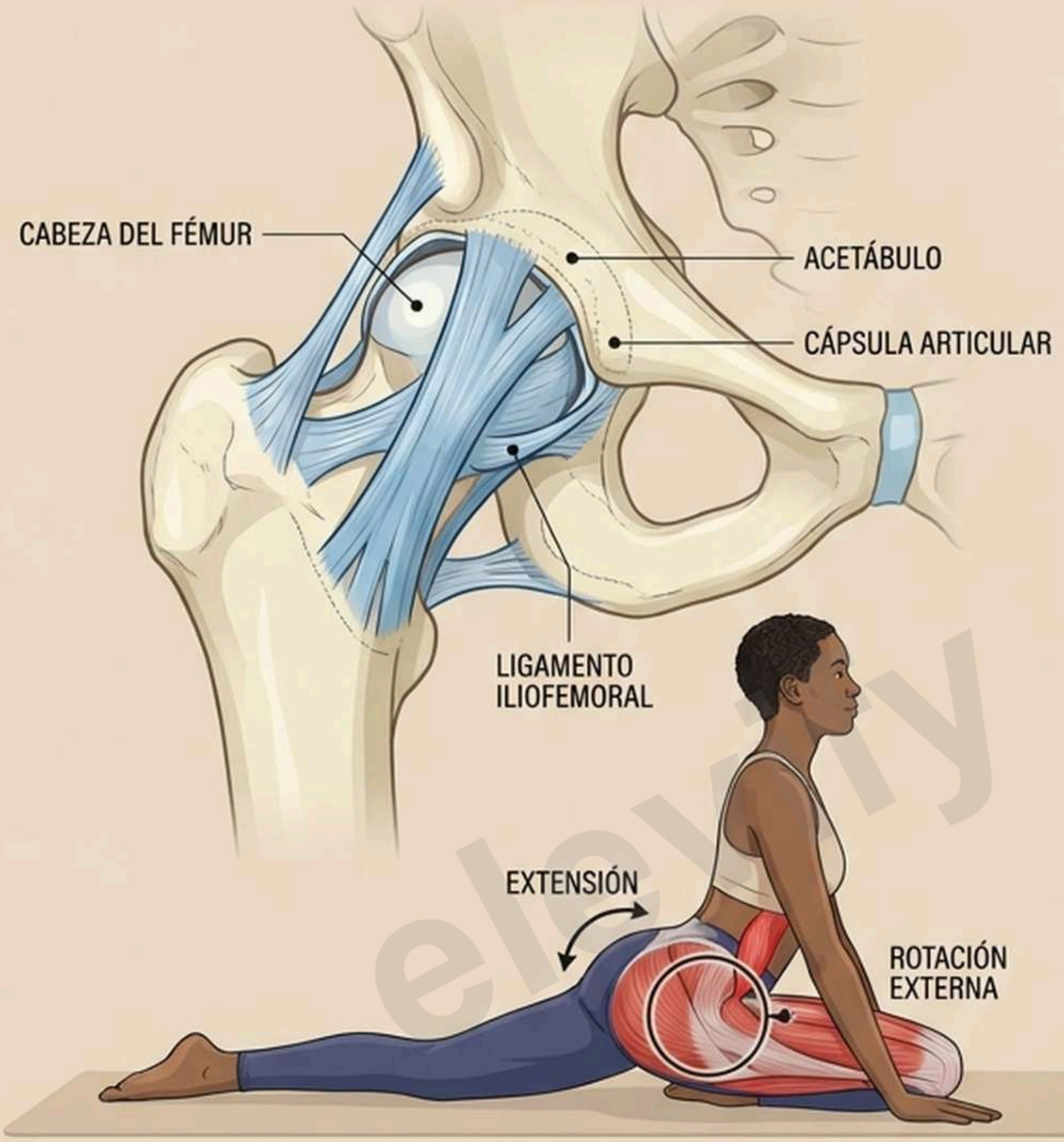
Los nervios no se estiran de forma estática y sostenida como un músculo. Se movilizan con técnicas de **NEURODINAMIA**: movimientos suaves, ritmicos y con-
ntinuos que los hacen deslizar a través de los tejidos sin generar tensión excesiva.

Si al estirar aparece **HORMIGUEO, QUEMAZÓN, ENTUMECIMIENTO** o **DOLOR IRRADIADO,** es el nervio avisando que está en su limite o comprimido. Hay que **SALIR** inmediatamente de la postura, **REDUCIR** el rango de movimiento o **CAMBIAR** el ángulo hasta que desaparezca la sensación nerviosa

CUE DE LA FORMADORA

Enseñale a tus alumnos a diferenciar la sensación de **"TIRA EL MÚSCULO"** (una sensación sorda, profunda y tolerable de estiramiento) de **"ME HORMIGUEA LA PIERNA"** (una señal de alerta nerviosa, eléctrica o quemante que **NO** se debe forzar)

LA CADERA: LA ARTICULACIÓN CLAVE

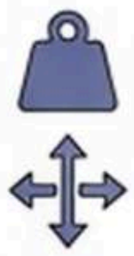


DÓNDE ESTÁ

Es la articulación que une el fémur (muslo) con la pelvis.

QUÉ HACE

Soporta el peso del cuerpo y permite un enorme rango de movimiento en los tres planos.



QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA

Músculos potentes (psoas ilíaco, glúteos, aductores), ligamentos fuertes y la propia estructura ósea. Es clave en casi todos los estiramientos del tren inferior.

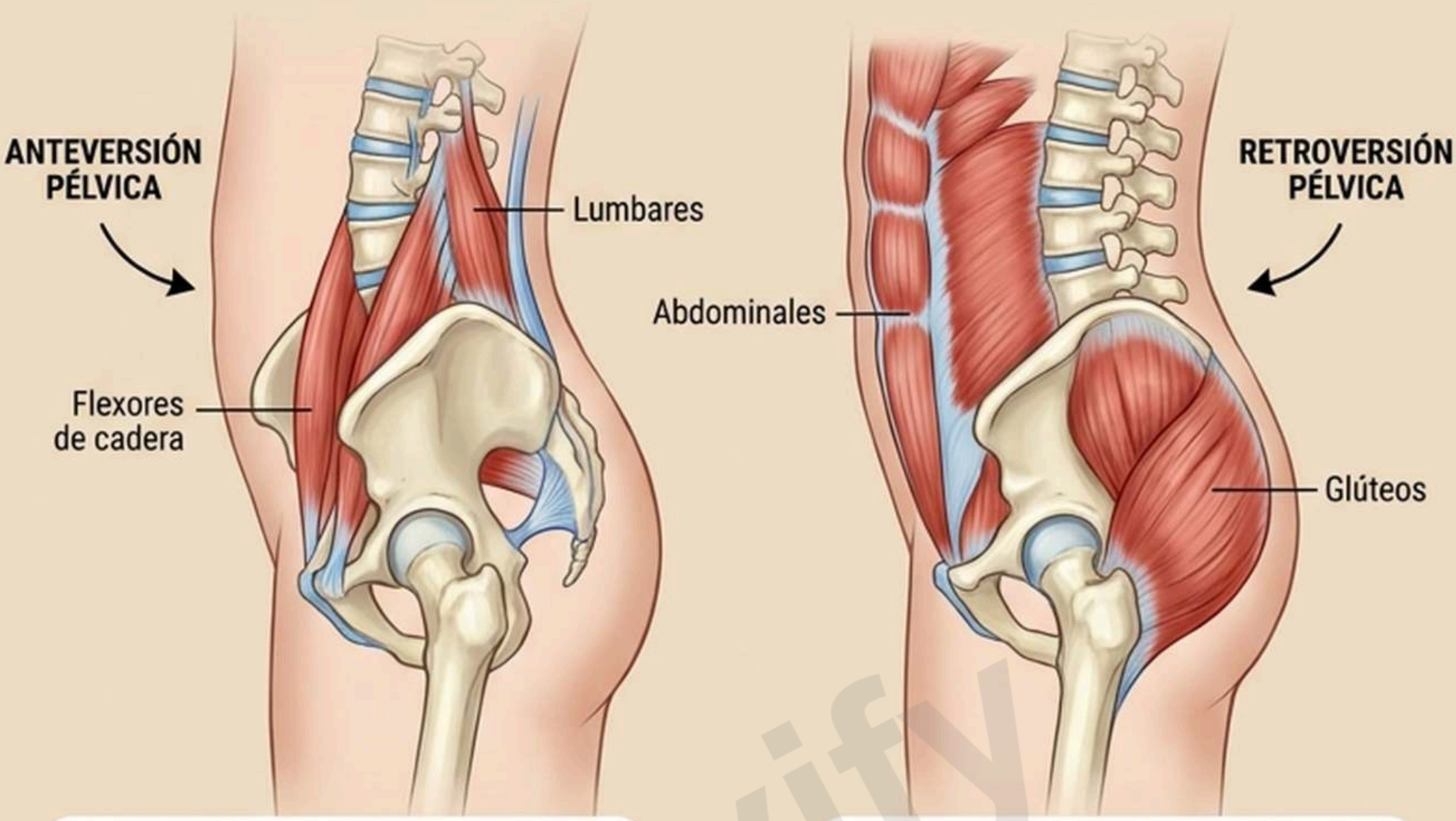
CÓMO SE ESTIRA

Para ganar flexibilidad en la cadera de forma completa, hay que trabajar sus seis movimientos. La clave es estabilizar la pelvis para que el movimiento ocurra realmente en la articulación y no en la columna lumbar. Por ejemplo, al estirar el psoas iliaco en una zancada, es fundamental mantener la retroversión pélvica para que la extensión de cadera sea real y efectiva.

CUE DE LA FORMADORA

Casi siempre, una lumbar que duele o se sobrecarga es por una cadera que no se mueve lo suficiente en algún plano.

LA PELVIS: ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN



ANTEVERSIÓN: La pelvis inclinada hacia adelante, exagerando la curva lumbar.

RETROVERSIÓN: La pelvis inclinada hacia atrás, aplanando la curva lumbar.

DÓNDE ESTÁ: Es el anillo óseo que conecta la columna vertebral con las piernas.

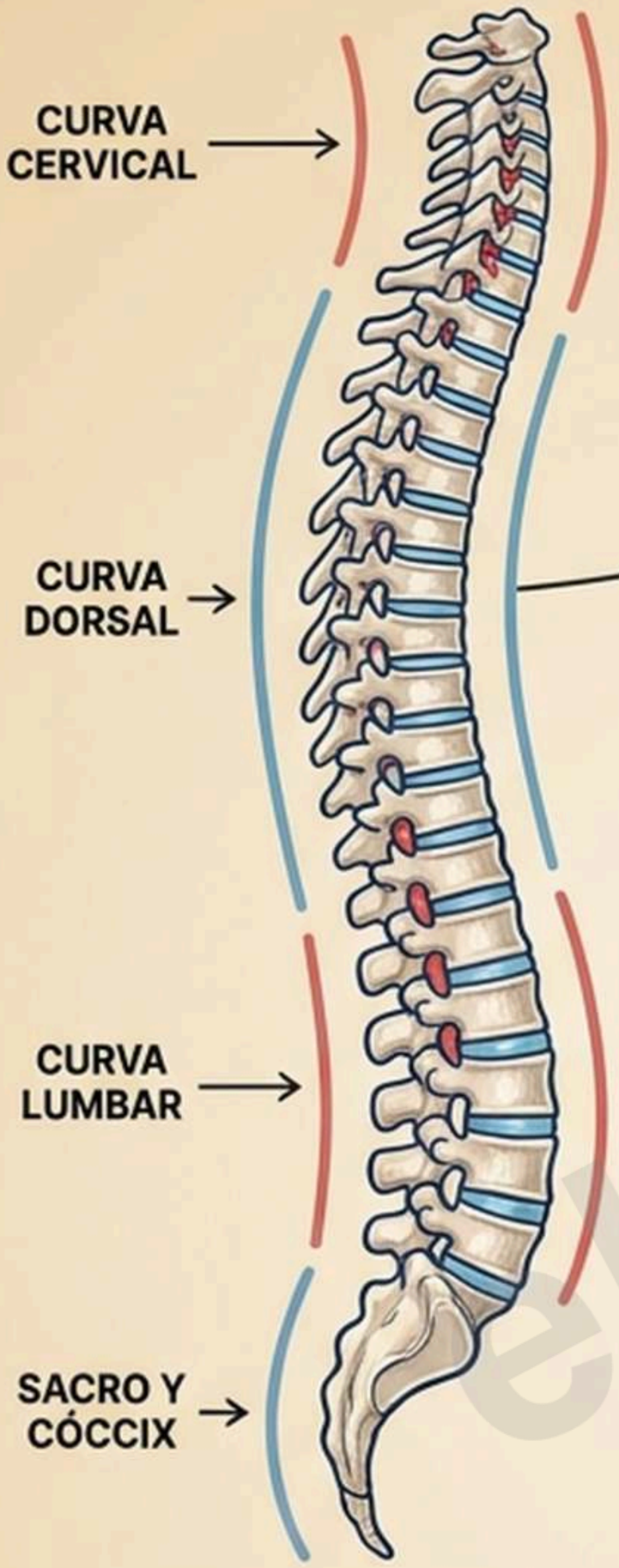
QUÉ HACE: Transfiere el peso y su posición (báscula) determina la alineación de la columna y las caderas.

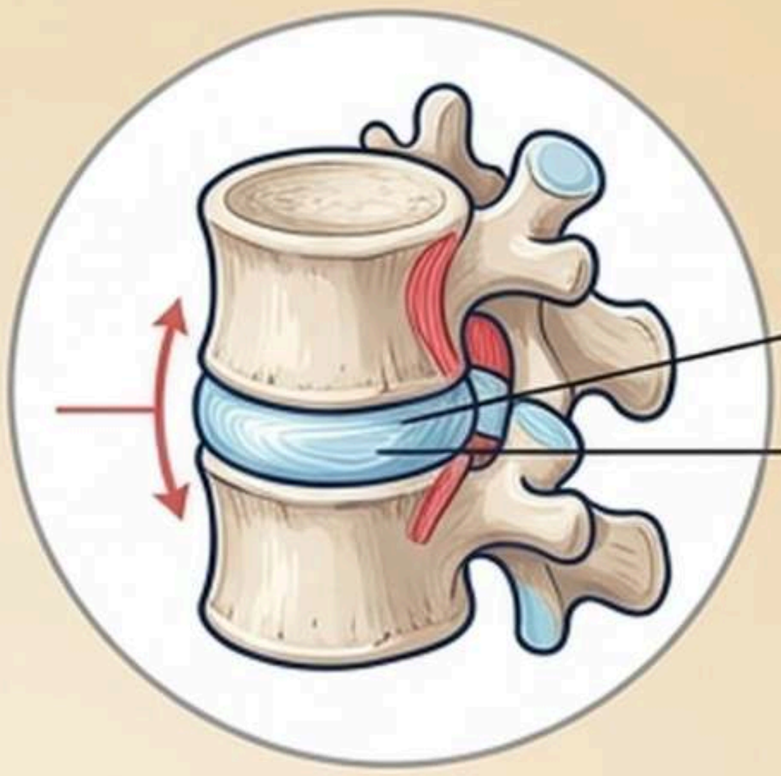
QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA:
La posición pélvica está controlada por el equilibrio entre abdominales, lumbares, flexores y extensores de cadera.

CARD "CÓMO SE ESTIRA":
La posición de la pelvis es la base de casi cualquier estiramiento del tren inferior y del tronco. Controlar la anteversión y retroversión te permite aislar el músculo que querés estirar. Para isquiotibiales, necesitás anteversión. Para el recto femoral, necesitás retroversión. Es la diferencia entre un estiramiento efectivo y uno que compensa con la lumbar.

CUE DE LA FORMADORA:
Antes de pedirle a una alumna que "baje más", chequeá si su pelvis está en la posición correcta. La calidad es más importante que la cantidad.

LA COLUMNA VERTEBRAL





FLEXO-EXTENSIÓN, ROTACIÓN, INCLINACIÓN (CERVICAL)

ROTACIÓN (DORSAL)

FLEXO-EXTENSIÓN, INCLINACIÓN (LUMBAR)

MOVILIDAD GLOBAL: FLEXIÓN Y EXTENSIÓN

DÓNDE ESTÁ:
Eje central del esqueleto, desde el cráneo hasta la pelvis.

QUÉ HACE:
Proporciona soporte, protege la médula espinal y permite el movimiento del tronco.

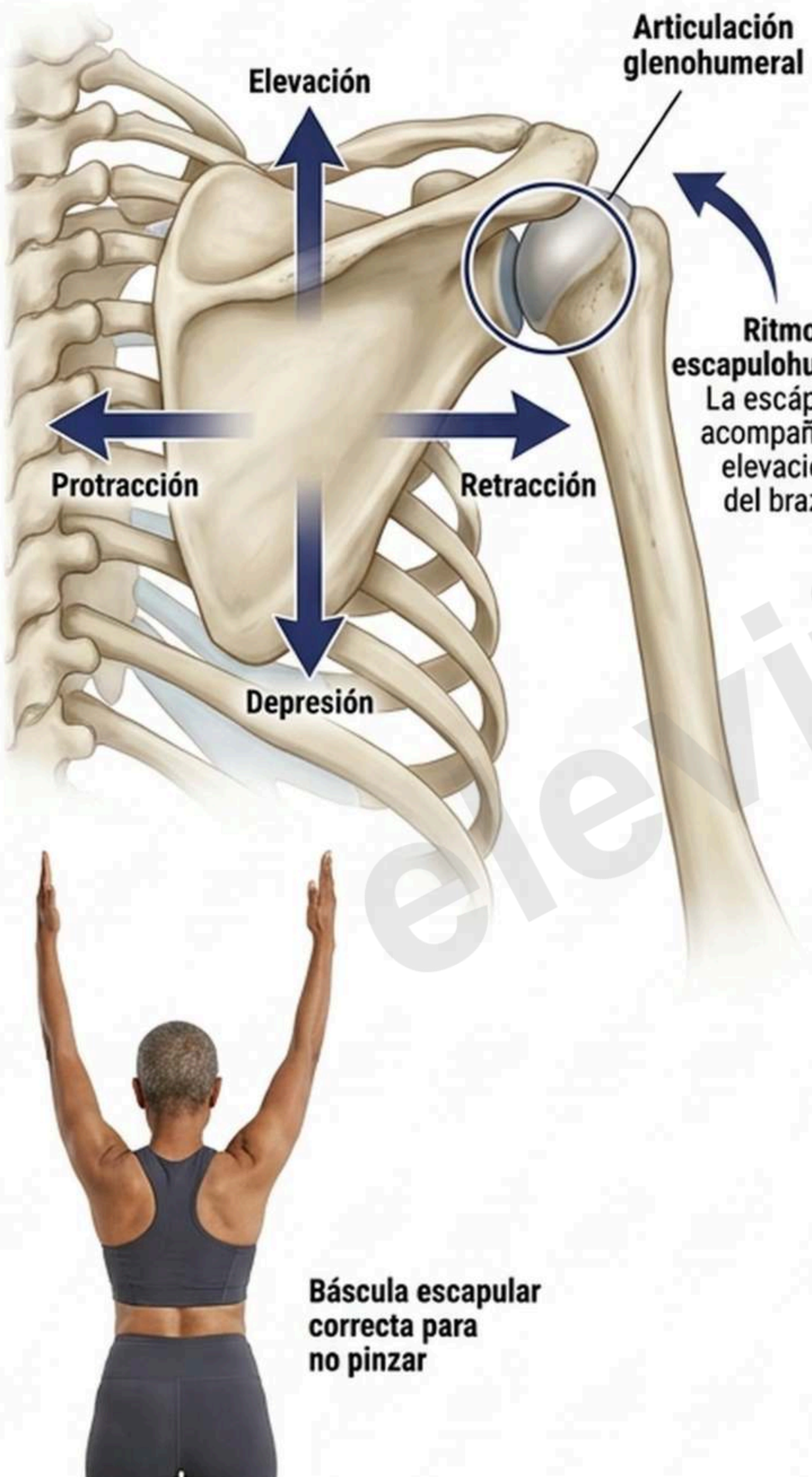
QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA:
Ligamentos, mŭsculos paravertebrales, carillas articulares y los discos. Cada segmento tiene un rango de movimiento especifico.

CÓMO SE ESTIRA

La columna debe moverse de forma segmentada y controlada. Es clave entender qué zona hace qué. En una torsión, el movimiento principal debe venir de la zona dorsal, no de forzar la lumbar que apenas rota. En una flexión hacia adelante, gran parte del movimiento es de la cadera. Estirar la columna implica moverla en todos sus planos de manera consciente y distribuida.

CUE DE LA FORMADORA: "Alargá la columna" no es solo estirarse para arriba; es crear espacio entre cada vértebra en cada movimiento que hacés.

LÁMINA ANATÓMICA DEL MÚSCULO O ESTRUCTURA: EL HOMBRO



Báscula escapular correcta para no pinzar

DÓNDE ESTÁ:

Es el complejo articular que une el brazo con el tronco.

QUÉ HACE:

Es la articulación con mayor rango de movimiento del cuerpo, lo que la hace también muy inestable.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA:

Músculos como el dorsal ancho y pectorales. La posición de la escápula es determinante.

CÓMO SE ESTIRA

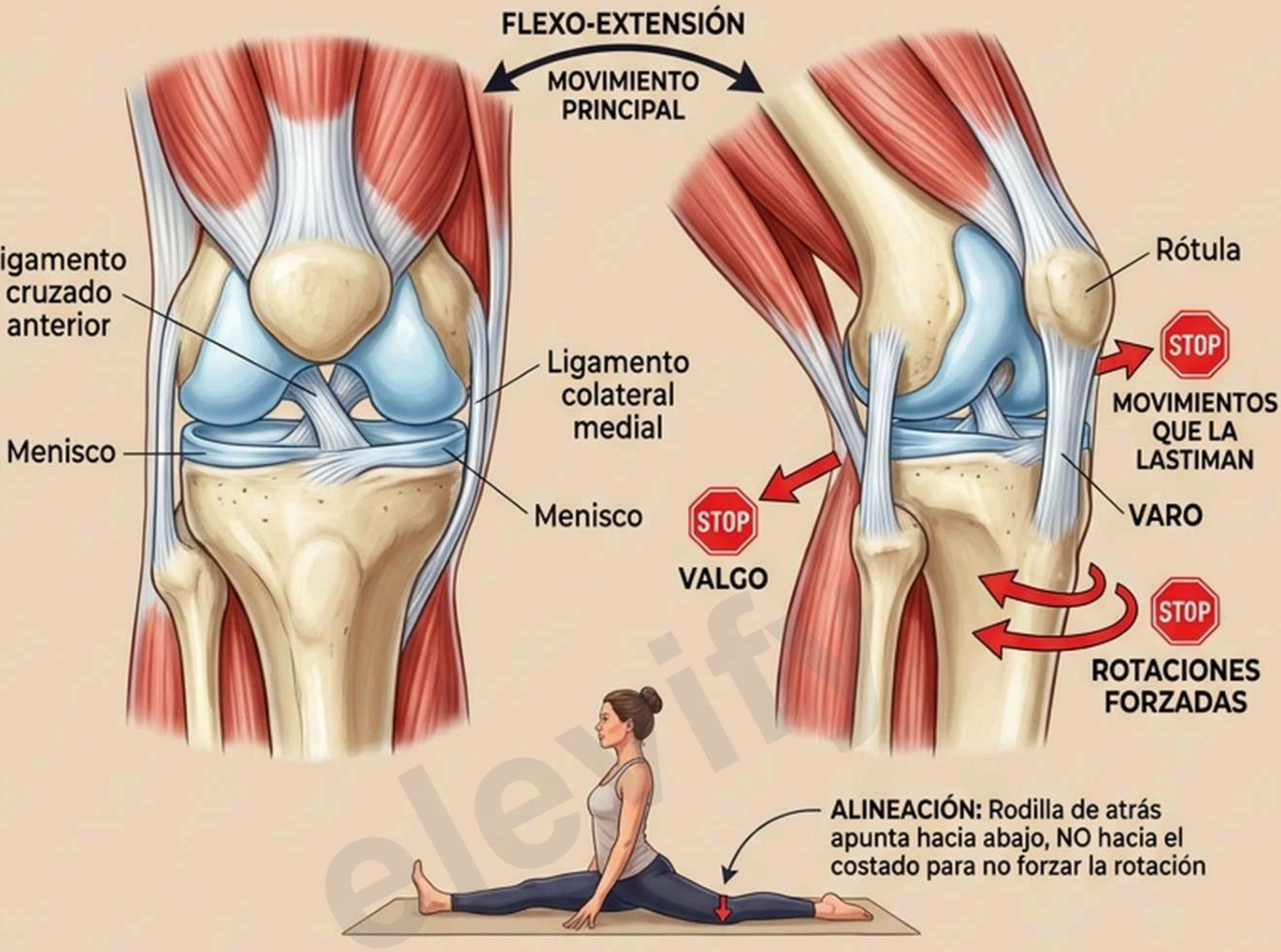
Para estirar el hombro de forma segura, primero hay que estabilizar la escápula. Si la escápula se mueve sin control, el estiramiento no llega a donde tiene que llegar. Por ejemplo, al estirar el pectoral, es clave mantener las escápulas en retracción y depresión para que la elongación ocurra en el pecho y no solo en la parte anterior del hombro, donde se puede generar un pinzamiento.

CUE DE LA FORMADORA

Antes de buscar más rango en el hombro de un alumno, preguntate: ¿dónde está su escápula? El control escapular es la base.

elevify

LA RODILLA: QUÉ PROTEGER



DÓNDE ESTÁ

La articulación intermedia de la pierna, une el muslo con la pantorrilla.

QUÉ HACE

Permite la flexo-extensión y soporta grandes cargas. Su función es la de una bisagra estable.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA

El tope óseo en extensión y los tejidos blandos en flexión. Sus ligamentos son su principal freno a movimientos laterales o de rotación.

CÓMO SE ESTIRA

La rodilla no se estira; se protege. Es una articulación para la estabilidad, no para la movilidad en todos los planos.

En posturas como el loto o el split, la rotación debe venir de la cadera. Si la cadera no rota lo suficiente, la fuerza de torsión se transmite a la rodilla, poniendo en riesgo los meniscos y ligamentos.

La clave es alinear siempre rodilla con cadera y pie.

CUE DE LA FORMADORA: Si a un alumno le duele la rodilla en una postura, casi seguro el problema está en una falta de movilidad de la cadera o del tobillo.

EL TOBILLO Y EL PIE

DÓNDE ESTÁN Son la base del cuerpo, el primer punto de contacto con el suelo.

QUÉ HACEN Absorben impacto y nos propulsan. La dorsiflexión del tobillo es clave para la sentadilla y la zancada.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA La dorsiflexión suele estar limitada por la rigidez del sóleo y los gemelos. La estructura ósea también puede ser un límite.

CÓMO SE ESTIRA

Para mejorar la dorsiflexión, es importante estirar los músculos de la pantorrilla (gemelos con rodilla extendida, sóleo con rodilla flexionada).

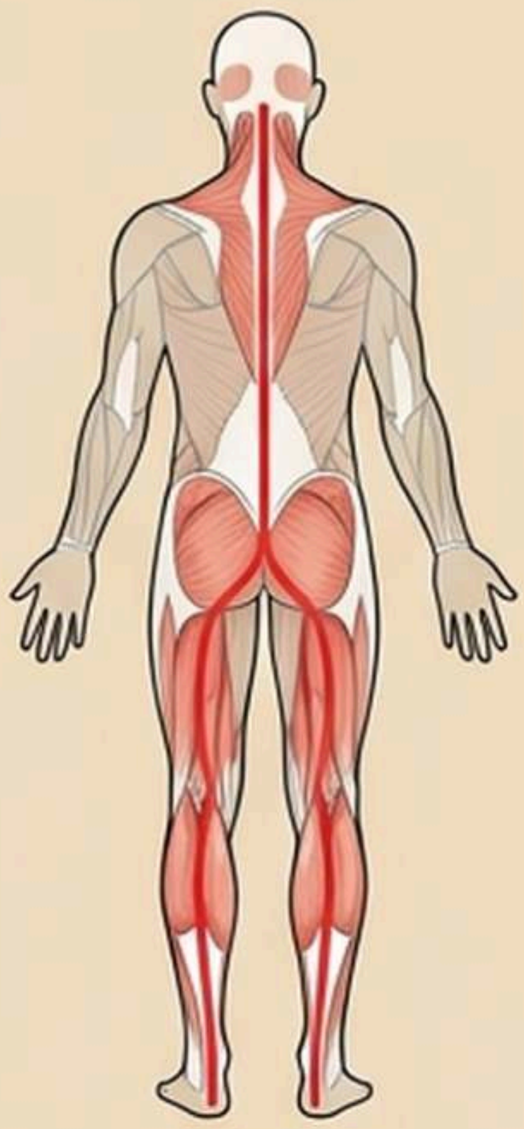
La movilidad activa del tobillo, con círculos y flexo-extensiones, también es fundamental.

No hay que olvidarse de la fascia plantar; liberarla puede mejorar la flexibilidad de toda la cadena posterior, que empieza justo ahí.

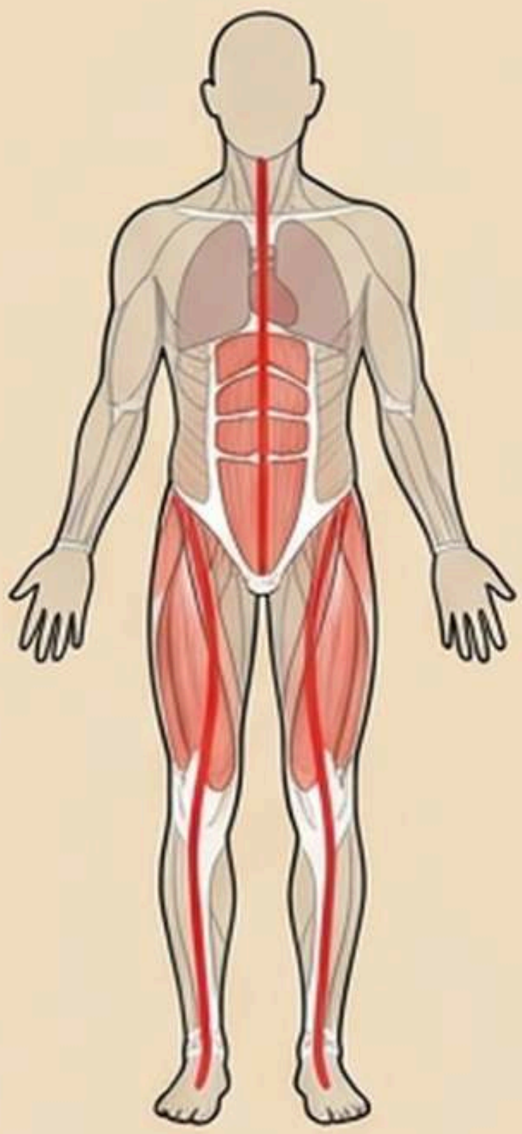
CUE DE LA FORMADORA

Un tobillo rígido obliga a la rodilla y a la lumbar a compensar. A veces, el dolor de espalda de una alumna empieza en sus pies.

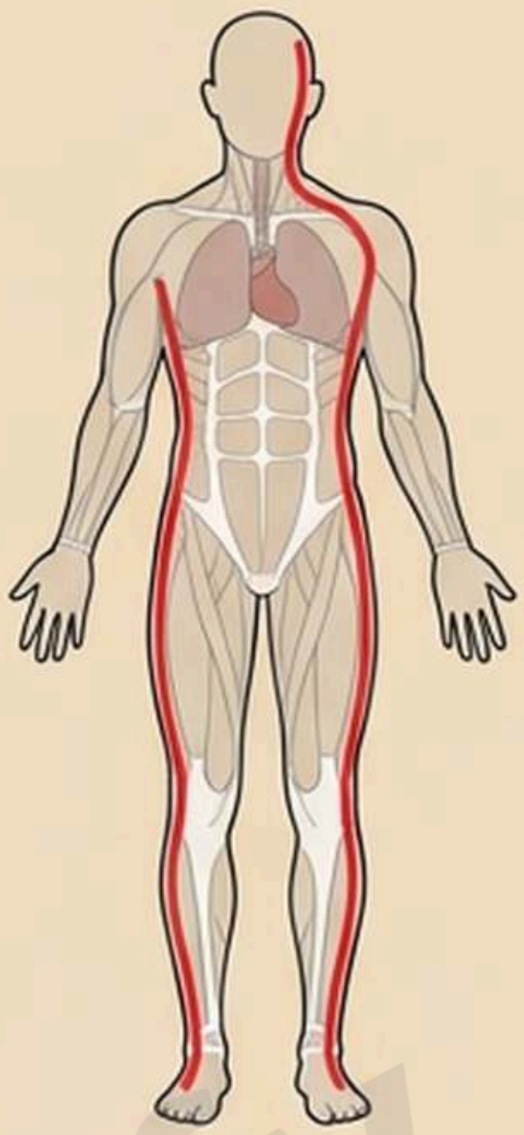
LAS CADENAS MUSCULARES



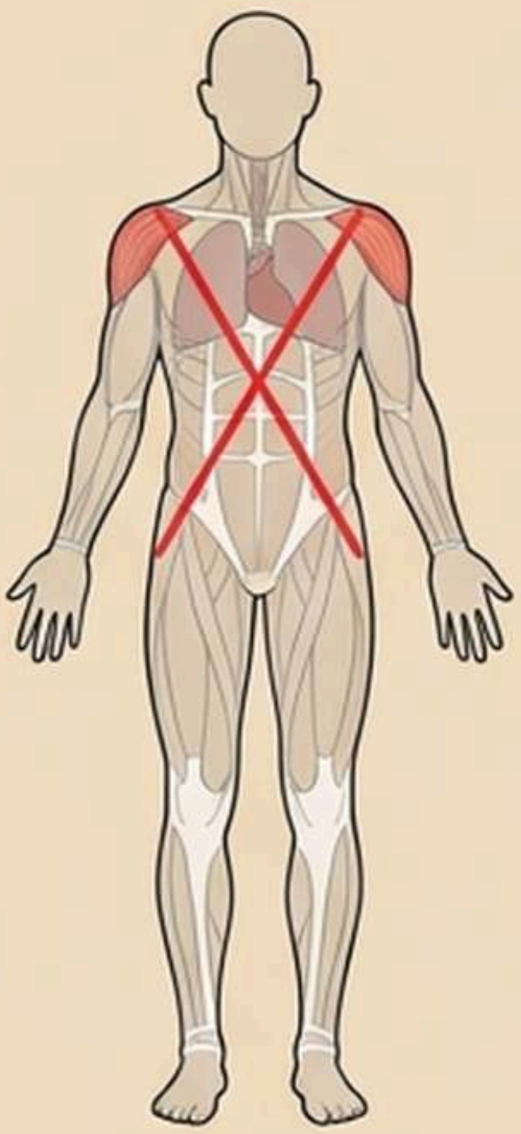
CADENA POSTERIOR



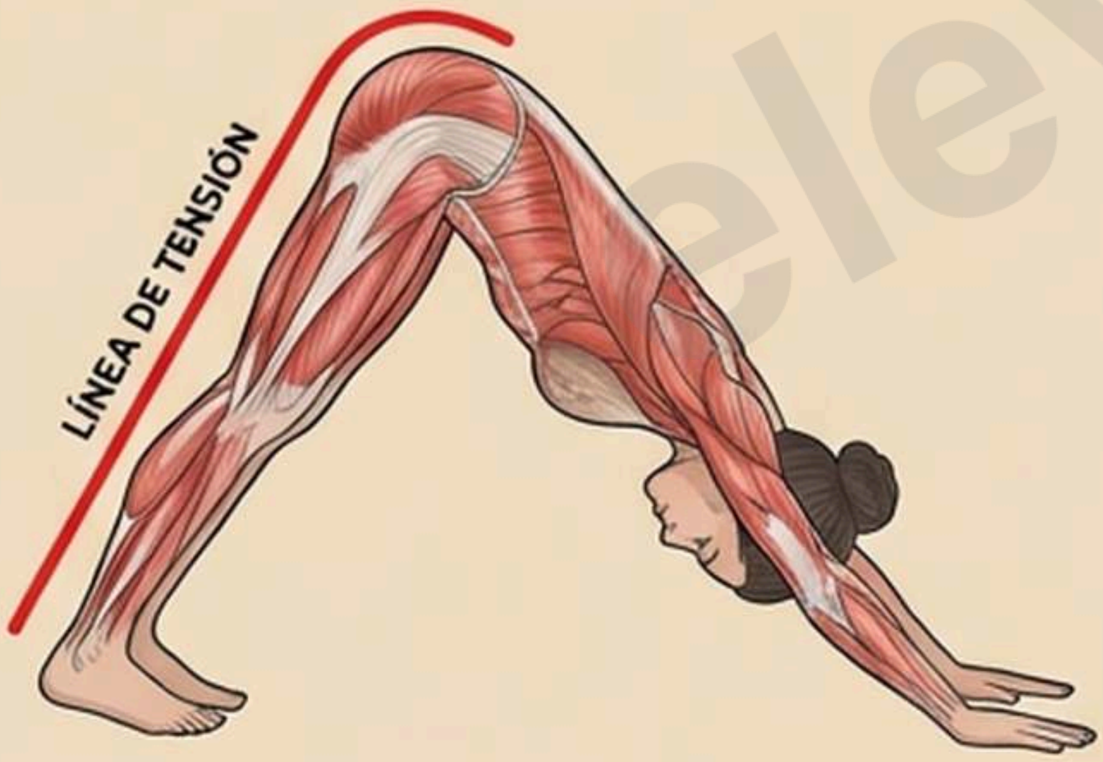
CADENA ANTERIOR



CADENA LATERAL



CADENA CRUZADA



DÓNDE ESTÁN

- Son lineas de continuidad anatómica y funcional formadas por músculos y fascias.
- Organizan el movimiento y la postura de forma global.
- Una tensión en un punto afecta a toda la linea.

QUÉ HACEN

- Una retracción en una cadena (por ejemplo, la posterior) puede causar desequillbrios posturales.
- Permiten la transmisión de fuerza y coordinación entre diferentes partes del cuerpo.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTA

- Limita la amplitud de movimiento en múltiples articulaciones.
- Compensa con otras partes del cuerpo, sobrecargándolas.
- Genera patrones de movimiento ineficientes y rigidez.

CÓMO SE ESTIRA

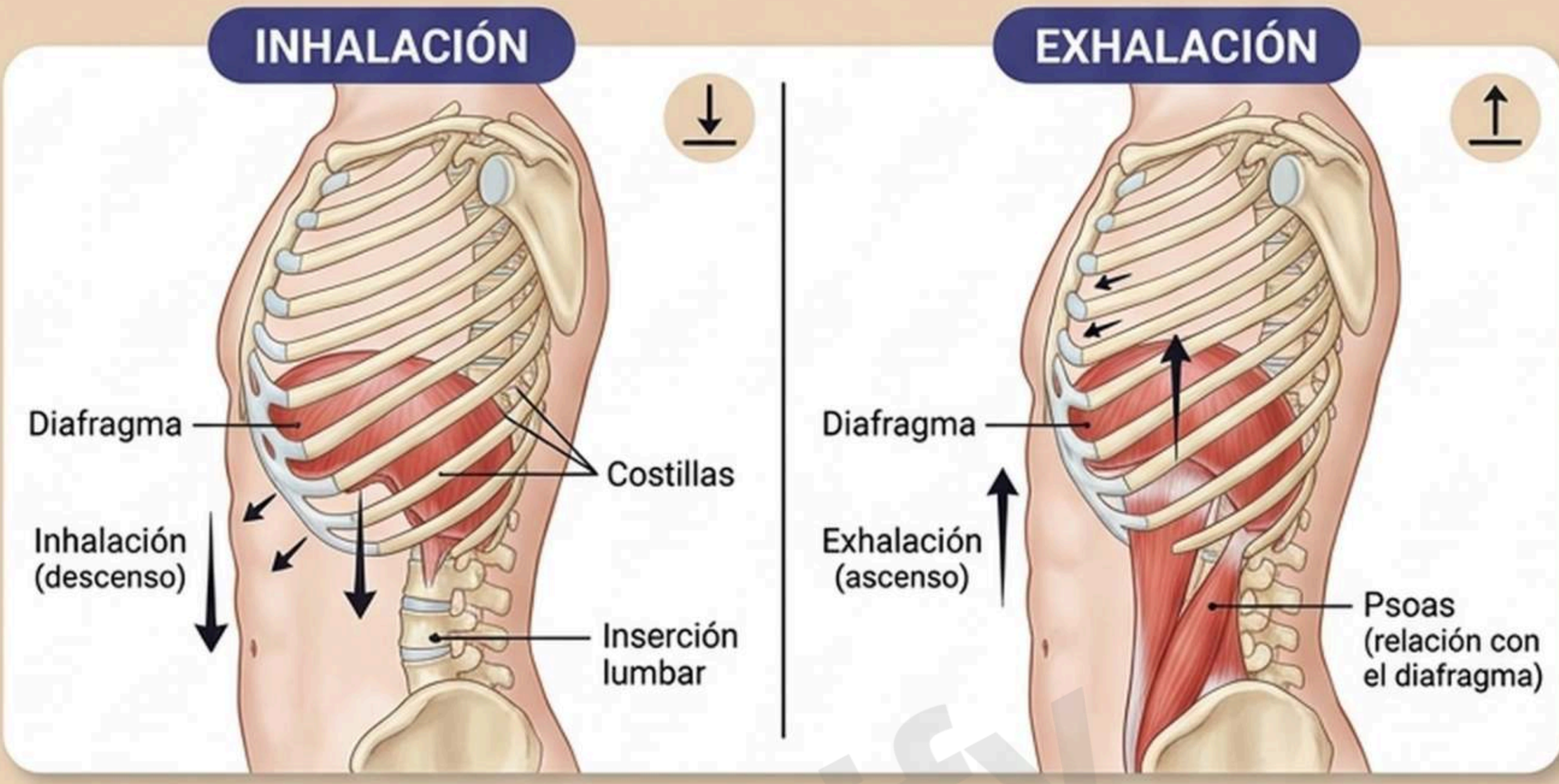
Estirar por cadenas es más funcional que aislar músculos. Implica elegir posturas globales que pongan en tensión toda una linea de fuerza.
Por ejemplo, el perro boca abajo es un excelente estiramiento para toda la cadena posterior.

Pensar en cadenas te ayuda a entender por qué una molestia en la lumbar puede estar relacionada con isquiotibiales cortos.

CUE DE LA FORMADORA

Cuando corrijas la postura de un alumno, pensá en la cadena completa, no solo en la parte del cuerpo que ves mal alineada. Buscá el origen real de la restricción a lo largo de la linea de tensión.

EL DIAFRAGMA Y LA RESPIRACIÓN



DÓNDE ESTÁ

Un músculo en forma de cúpula en la base de la caja torácica. Separa el tórax del abdomen.

QUÉ HACE

Es el principal músculo de la respiración. También estabiliza el core y se conecta con el psoas.

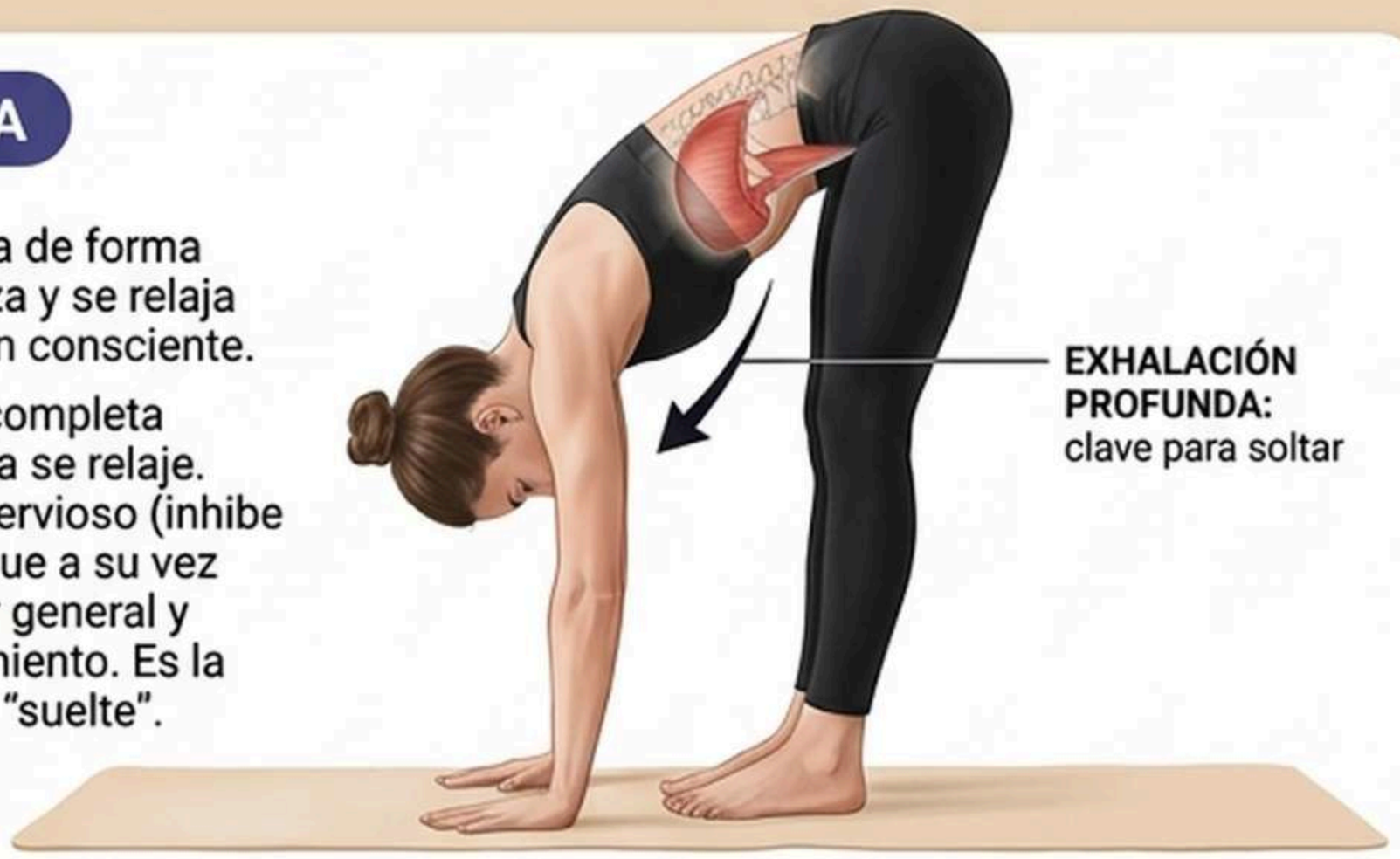
QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Un diafragma tenso limita la expansión torácica y puede generar rigidez en la columna lumbar y el psoas.

CÓMO SE ESTIRA

El diafragma no se estira de forma convencional; se moviliza y se relaja a través de la respiración consciente.

Una exhalación larga y completa permite que el diafragma se relaje. Esto calma el sistema nervioso (inhibe el reflejo miotático), lo que a su vez reduce el tono muscular general y facilita cualquier estiramiento. Es la llave para que el cuerpo "suelte".



CUE DE LA FORMADORA

La respiración no es un accesorio del estiramiento; es el motor. Una exhalación profunda es la mejor herramienta para que tu alumna suelte la tensión.

EL TEJIDO EN CADA EDAD

NIÑOS

Alta elasticidad, foco en el control motor.

Los tejidos son muy maleables y acuosos. El objetivo es objetivo es desarrollar la coordinación y el control del rango de movimiento, no forzar la flexibilidad extrema.

ADULTOS

Madurez del tejido, equilibrio fuerza-flexibilidad.

Los tejidos son más densos y fuertes. Se busca un equilibrio entre mantener el rango y desarrollar la fuerza para la salud articular y postural.

ADULTOS MAYORES

Menor elasticidad, más rigidez, foco en la funcionalidad.

Los tejidos pierden hidratación y elasticidad con la edad.
El calentamiento es más largo, más largo, los movimientos son más suaves y el objetivo principal es mantener el rango de movimiento funcional y seguro para la vida diaria.

EL TEJIDO CONECTIVO CAMBIA A LO LARGO DE LA VIDA Y NUESTRA FORMA DE ABORDAR LA FLEXIBILIDAD DEBE CAMBIAR CON ÉL.

EN LA SALA: ADAPTACIONES PRÁCTICAS

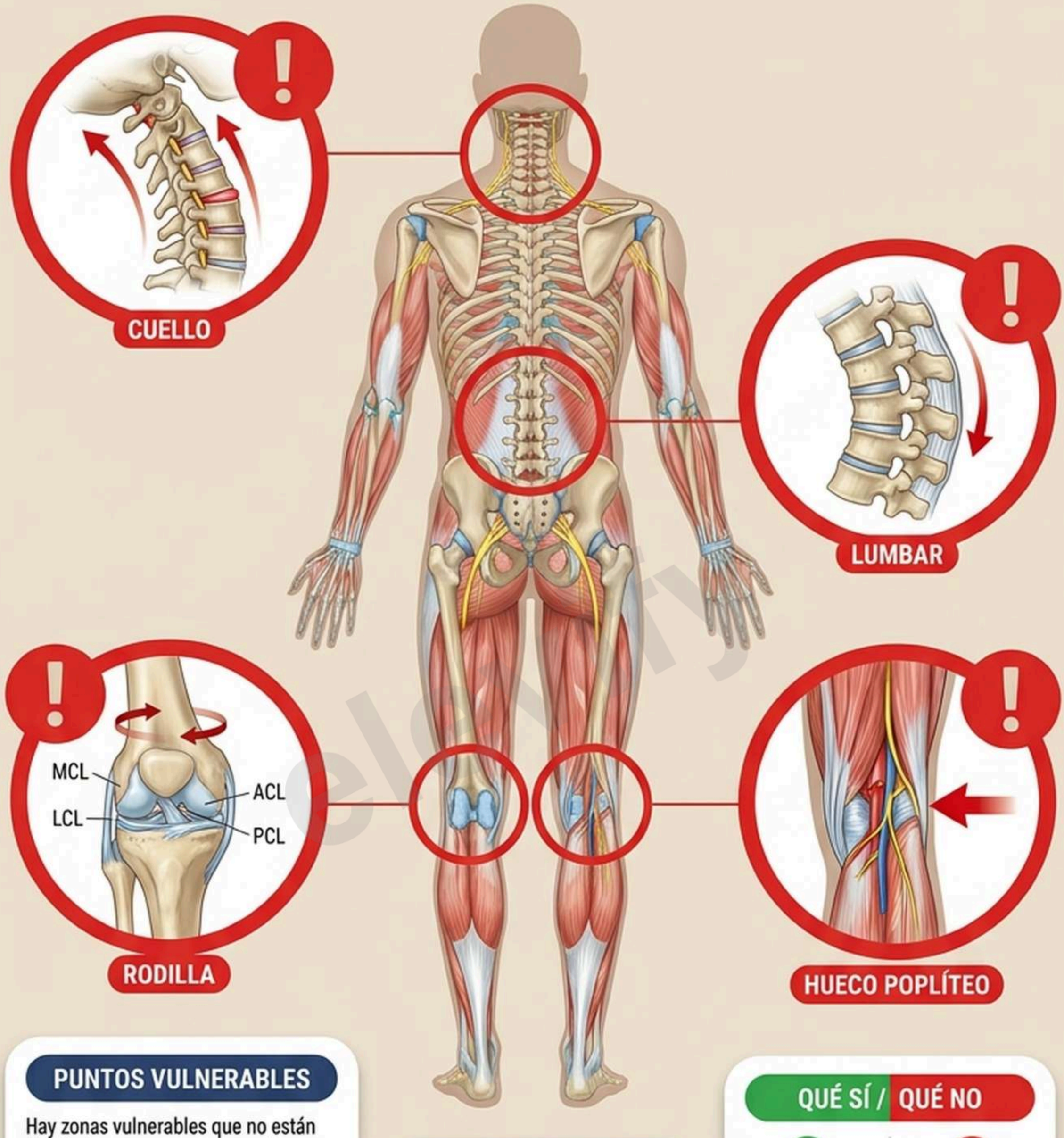
- Un niño no necesita forzar un split, necesita aprender a controlar su rango y desarrollar patrones de movimiento seguros. El juego y la exploración son clave.
- Un adulto mayor necesita moverse seguro y sin dolor, no hacer la clase de un joven de 20. Priorizar la movilidad articular, el equilibrio y la prevención de caídas.

QUÉ SÍ / QUÉ NO: ENFOQUE POR EDAD

QUÉ SÍ
Adaptar la intensidad, duración y tipo de estiramiento a la edad y condición individual. Escuchar al cuerpo y respetar sus límites. Incluir ejercicios de fuerza y movilidad.

QUÉ NO
Aplicar la misma receta o rutina de estiramiento para todos, independientemente de la edad. Ignorar el dolor o forzar rangos de movimiento no naturales. Compararse con otros o con uno mismo en el pasado.

PUNTOS QUE NO SE FUERZAN



PUNTOS VULNERABLES

Hay zonas vulnerables que no están diseñadas para soportar grandes fuerzas de estiramiento. Forzarlas para buscar más rango en otro lado es un error peligroso.

La rodilla no debe rotar, la lumbar no debe sobrecargarse para compensar una cadera rigida, el cuello debe mantenerse alineado y el hueco popliteo, lleno de estructuras sensibles, no debe ser presionado.

El objetivo es dirigir la tensión al vientre muscular, no a la articulación ni a un paquete neurovascular.

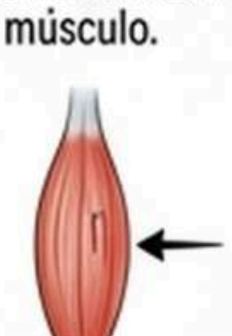
EN LA SALA: CUE DE LA FORMADORA

Cuando un alumno dice "me tira justo detrás de la rodilla", es señal para que flexione un poco la pierna y el estiramiento se mueva al centro de los isquiotibiales.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

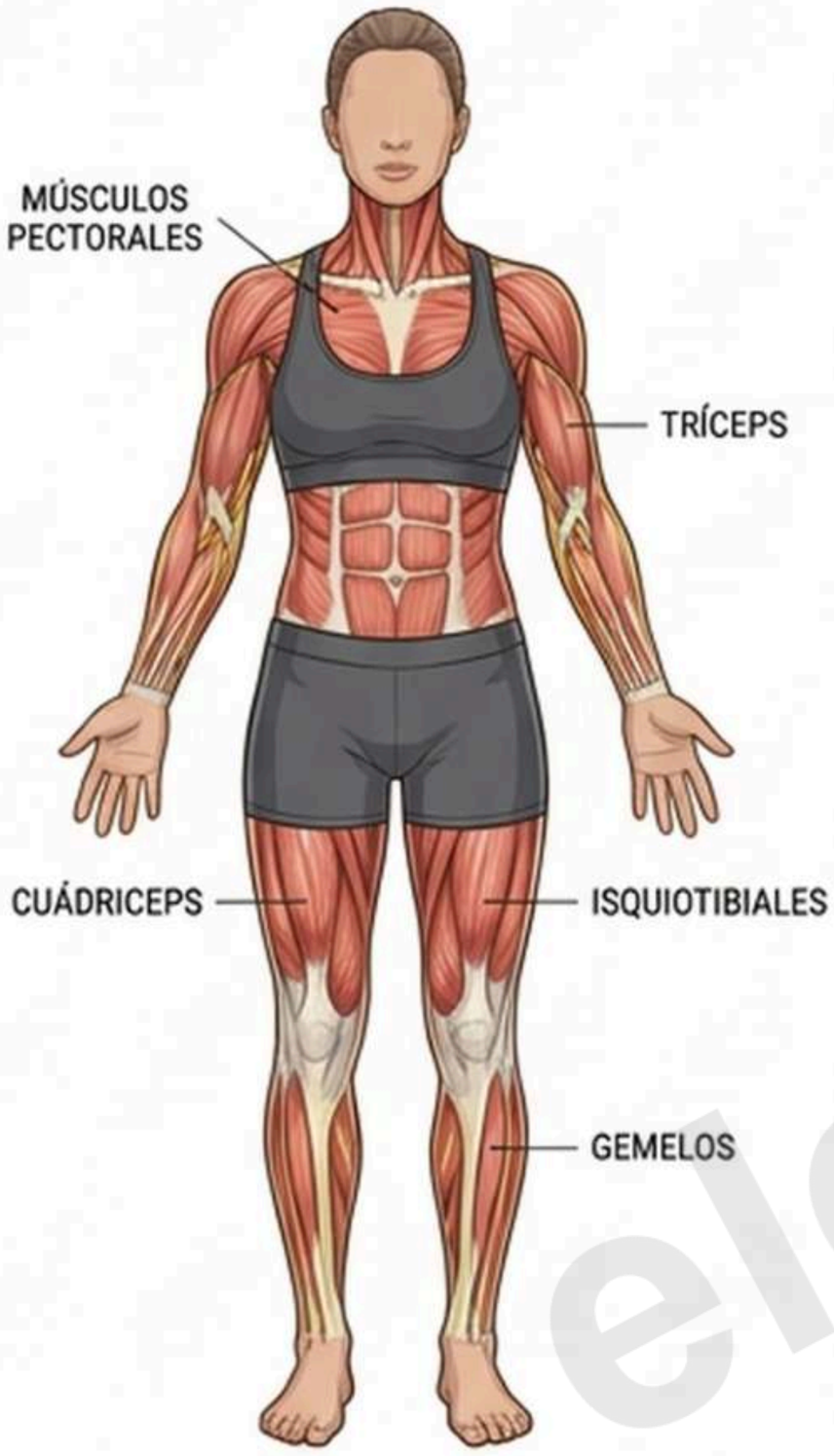
Sentir la tensión en el centro del músculo.

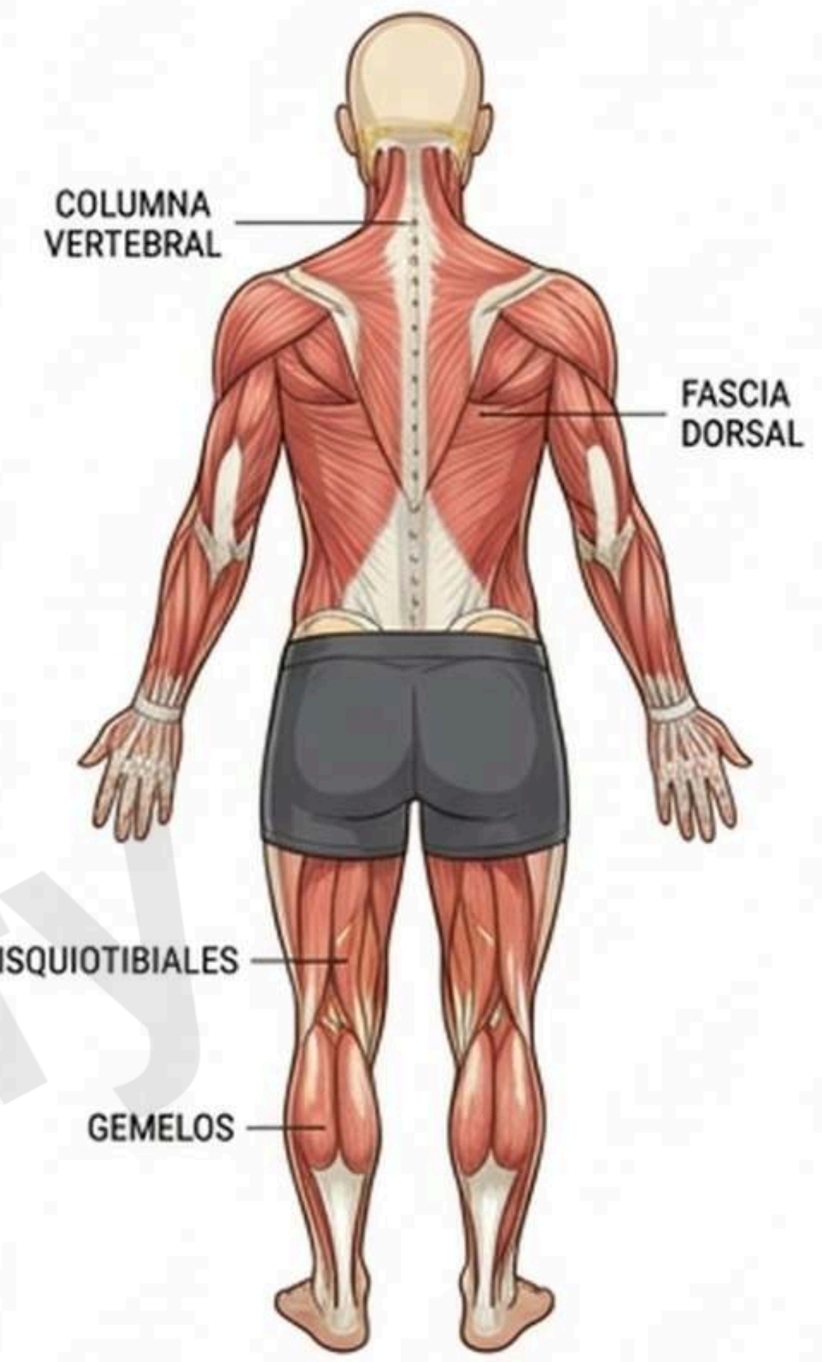


QUÉ NO

Sentir dolor agudo, pinchazos o presión directa en una articulación.

MAPA CORPORAL: MI PUNTO DE PARTIDA





- **Círculo Rojo:** Zona de dolor o lesión actual.
- **Círculo Azul:** Zona que sentís rígida o "acortada".
- **Círculo Verde:** Zona que sentís muy flexible o inestable.

CÓMO USAR ESTA PLANTILLA

Usá este mapa para registrar tus sensaciones antes de empezar un programa de flexibilidad. Te va a ayudar a vos y a tu profesor a identificar patrones, elegir los ejercicios correctos y ver tu progreso a lo largo del tiempo.

No tiene que ser perfecto, solo reflejar cómo te sentís hoy. Actualizalo cada 4-6 semanas para seguir tu evolución.

REGISTRO DE EVOLUCIÓN

FECHA	ZONA RÍGIDA PRINCIPAL	ZONA DE CUIDADO PRINCIPAL

elevify

EVALUACIÓN

Medir antes de estirar para saber dónde estás parado

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- Una guía práctica para realizar una evaluación de flexibilidad inicial.
- Aprenderás a observar la postura, a hacer las preguntas clave sobre historial y sensaciones, y a ejecutar los tests más importantes de la sala con precisión.
- Con estos datos objetivos, vas a poder elegir los ejercicios justos para cada alumno, programando con seguridad y eficacia, evitando lesiones y optimizando el progreso.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR

Sin evaluación, el estiramiento es una suposición. Medir te permite identificar desequilibrios, establecer una línea de base y monitorear el avance real. La flexibilidad es específica para cada articulación y movimiento; no se puede generalizar.

LA ENTREVISTA DE 10 MINUTOS

QUÉ PREGUNTAR antes de tocar

¿Cuál es tu objetivo?
(e.g., correr, bailar, bienestar diario)

¿Qué actividad física hacés?
(frecuencia, intensidad, tipo)

El Alumno

¿Pasás mucho tiempo sentado?
(trabajo, estudio, ocio)

¿Tenés alguna molestia o dolor ahora?
(agudo, crónico, ubicación)

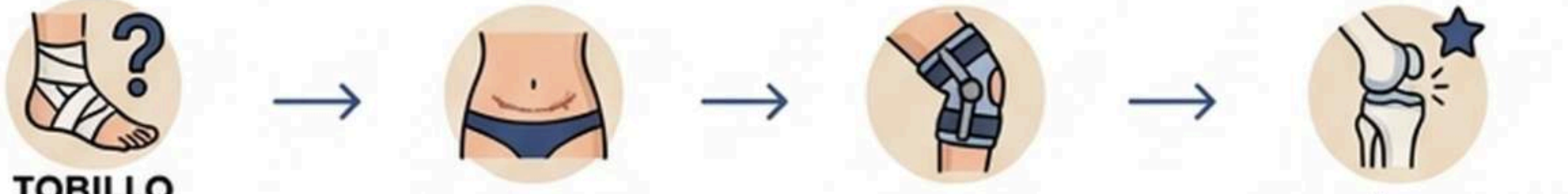
LA EVALUACIÓN EMPIEZA CON LA ESCUCHA

Antes de medir un solo grado de movimiento, una buena entrevista te da el 90% de la información necesitás. Preguntar por los objetivos, el estilo de vida y las sensaciones corporales te permite entender el contexto del alumno.

Un isquiotibial acortado no significa lo mismo en un corredor que en una persona que trabaja 10 horas sentada; por eso, el plan de ambos tiene que ser distinto. La escucha activa construye confianza y define el punto de partida real.

EN LA SALA: Cuando un alumno te dice "quiero ser más flexible", preguntale siempre: "¿flexible para qué? ¿qué movimiento querés lograr que hoy no te sale?".

EL HISTORIAL que no se ve



INFORMACIÓN CRUCIAL OMITIDA

Hay información crucial que los alumnos no suelen mencionar porque creen que no es relevante.

Una cirugía abdominal de hace cinco años puede generar adherencias que limitan la flexión de cadera.

Un esguince de tobillo mal recuperado puede ser la causa de una cadena de compensaciones.

PREGUNTAS ESENCIALES

- Siempre preguntá especificamente por:
- cirugías, fracturas, esguinces, cicatrices importantes, y si alguna vez le dijeron que era "muy flexible" o hiperlaxo.
- Estos datos cambian por completo el abordaje.

EN LA SALA

"Ah, sí, me operaron de apendicitis de chico, pero eso no tiene nada que ver, ¿no?"...

...casi siempre tiene que ver.

RESUMEN VISUAL

COMPENSACIÓN OCULTA (MAL)

Alumno compensando con lumbar redondeada y rodilla bloqueada debido a un esguince de tobillo antiguo no declarado.

Tensión en la espalda baja.

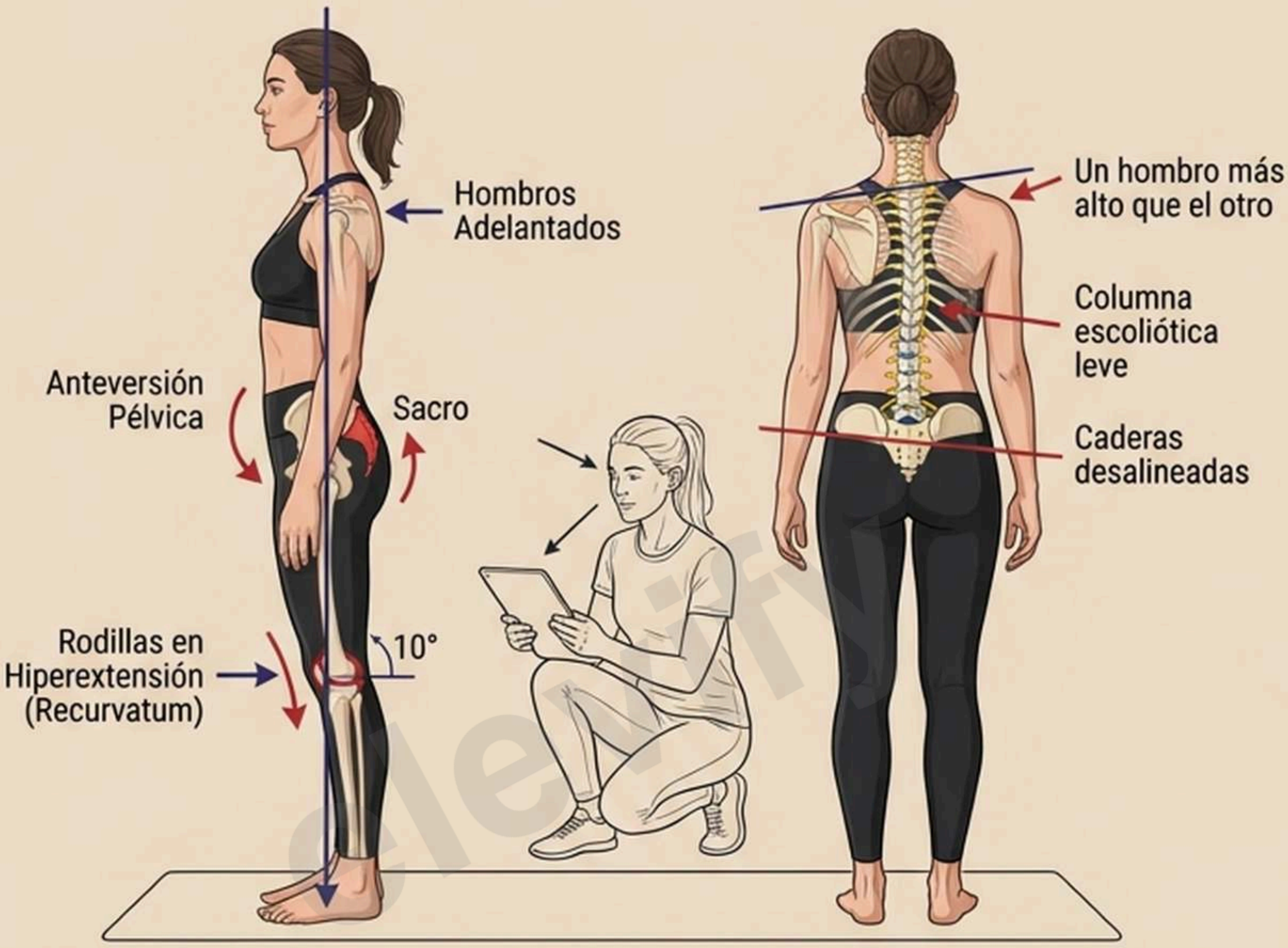
CORRECCIÓN INFORMADA (BIEN)

Ajuste con bloque para acomodar la limitación del tobillo y mantener la columna neutra.
El historial permitió adaptar la postura.

Tensión correcta en isquiotibiales.

OBSERVAR LA POSTURA ESTÁTICA

CÓMO SE PARA tu alumna



LA POSTURA ESTÁTICA: PUNTO DE PARTIDA

La postura estática es el punto de partida de todos los movimientos. Observar cómo una alumna se para descalza te da pistas sobre sus patrones neuromusculares y sus posibles acortamientos. ¿La pelvis está en anteversión, retroversión o neutra? ¿Las rodillas se hiperextienden? ¿Hay un hombro más alto que el otro? Estas observaciones no son un diagnóstico, pero te ayudan a formular hipótesis sobre qué músculos pueden estar cortos y cuáles elongados o débiles, orientando tu elección de tests y ejercicios.

QUÉ SÍ:

Observar patrones generales sin juzgar. Anotar las observaciones para comparar a lo largo del tiempo y usarlas como guía inicial.

QUÉ NO:

"Corregir" la postura de forma inmediata pidiéndole que se ponga derecha. Esto no resuelve la causa subyacente y solo genera una tensión innecesaria.

TEST DE ISQUIOTIBIALES

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST: ISQUIOTIBIALES

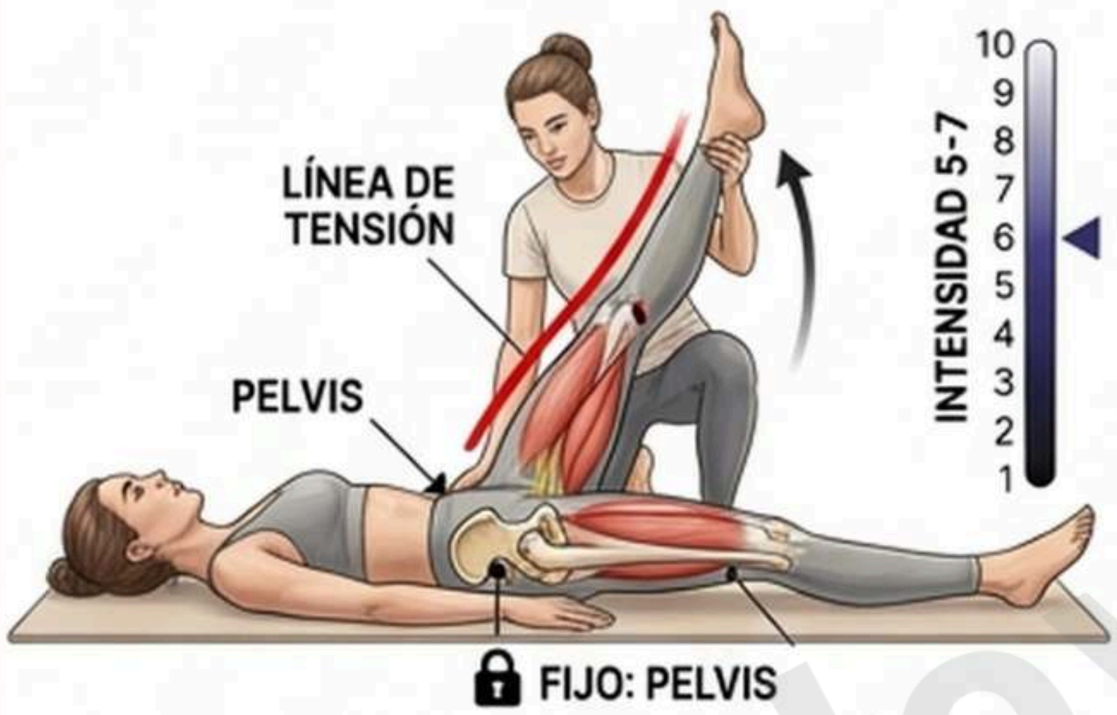
NIVEL: Básico **FRENO:** Muscular/Neural

PARA QUIÉN: Alumnos que refieren tirantez en la parte de atrás de la pierna o que muestran una retroversión pélvica al intentar flexionar la cadera.

QUÉ SE MIDE: La flexibilidad de los isquiotibiales y la movilidad de la columna lumbar.

FRENO EVALUADO: Muscular (isquiotibiales) y neural (nervio ciático).

TEST 1: ELEVACIÓN DE PIERNA RECTA



ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 6 · MEDIR ÁNGULO

PASO A PASO

1. El alumno se acuesta boca arriba (decúbito supino) con ambas piernas extendidas y la zona lumbar apoyada.
2. Fijás con una mano la pelvis del lado opuesto para que no se eleve.
3. Le pedís que eleve una pierna extendida, sin doblar la rodilla, tan alto como pueda sin que el sacro se despegue del suelo.
4. Medís el ángulo (un ángulo de 80-90° se considera normal).

TEST 2: SIT AND REACH

PASO A PASO

1. El alumno se sienta con piernas extendidas y juntas.
2. Le pedís que se incline hacia adelante desde la cadera, intentando tocarse los pies.
3. Observás si la flexión viene de la cadera o si compensa curvando excesivamente la columna lumbar.

ERRORES COMUNES

Test 1: Doblar la rodilla, despegar el sacro, dejar que la pelvis rote.

Test 2: Iniciar el movimiento desde la columna dorsal en lugar de la cadera.

QUÉ FRENO SUGIERE CADA RESULTADO

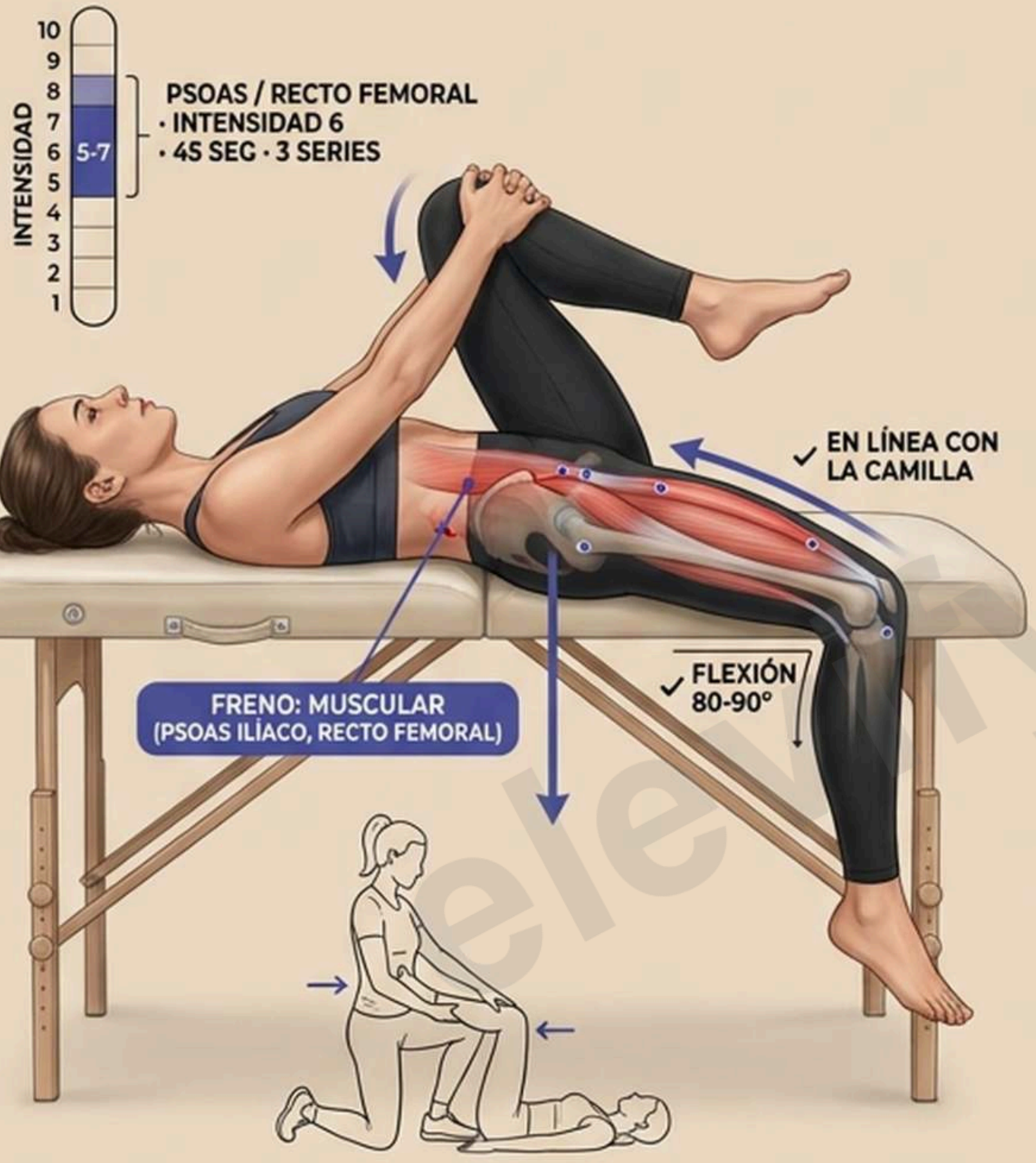
- Elevación **limitada** a menos de 80° sugiere acortamiento de isquiotibiales.
- Si al hacer una dorsiflexión del tobillo en el punto máximo aparece un hormigueo o tirantez intensa, puede haber un componente neural.
- En el Sit and Reach, si la pelvis se va rápido a retroversión, los isquiotibiales están frenando la anteversión.

PARA SU CASA

"Vamos a medir hasta dónde llega tu pierna hoy para tener una referencia clara de tu progreso".

TEST DE THOMAS: PSOAS Y CUÁDRICEPS

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST:
NIVEL: Básico.



PARA QUIÉN

Alumnos que pasan mucho tiempo sentados, corredores, o quienes presentan una marcada anteversión pélvica.

QUÉ SE MIDE: La flexibilidad de los flexores de cadera (psoas iliaco y recto femoral).

EL TEST

Se realiza en el borde de una camilla, cajón o banco estable.

POSICIÓN DE PARTIDA: El alumno se sienta en el borde, se toma una rodilla con ambas manos y se deja caer hacia atrás hasta que la espalda y el sacro queden completamente apoyados. La rodilla sujetada queda flexionada contra el pecho.

PASO A PASO

1. Desde la posición de partida, asegurate de que la zona lumbar del alumno esté plana contra la superficie. La rodilla que sujeta contra el pecho ayuda a lograrlo.
2. Dejá que la otra pierna cuelgue libremente fuera de la camilla.
3. Observá la posición de la pierna que cuelga.
4. Repetí del otro lado.

QUÉ SE MIDE Y VALORES DE REFERENCIA

1) Muslo: ¿El muslo de la pierna que cuelga logra apoyarse o quedar por debajo de la linea de la camilla?

2) Muslo: ¿El muslo de la pierna que cuelga logra apoyarse o quedar por debajo de la linea de:de la camilla', suglere un levantado avxr costado.

1) Muslo: ¿El muslo de la pierna que cuelga logra spoyarse o quedar por debajo de la linea de la camilia? Si se queda levantado, sugiere un acortamiento del psoas illaco.

2) Rodilla: ¿La rodills de esa misma pierns css en una flexión de 80-90°? Si la pierna se extiende y la rodilla queda con un ángulo más abierto, sugiere un acortamiento del recto femoral (que es biarticular).

ERRORES QUE VES EN LA SALA

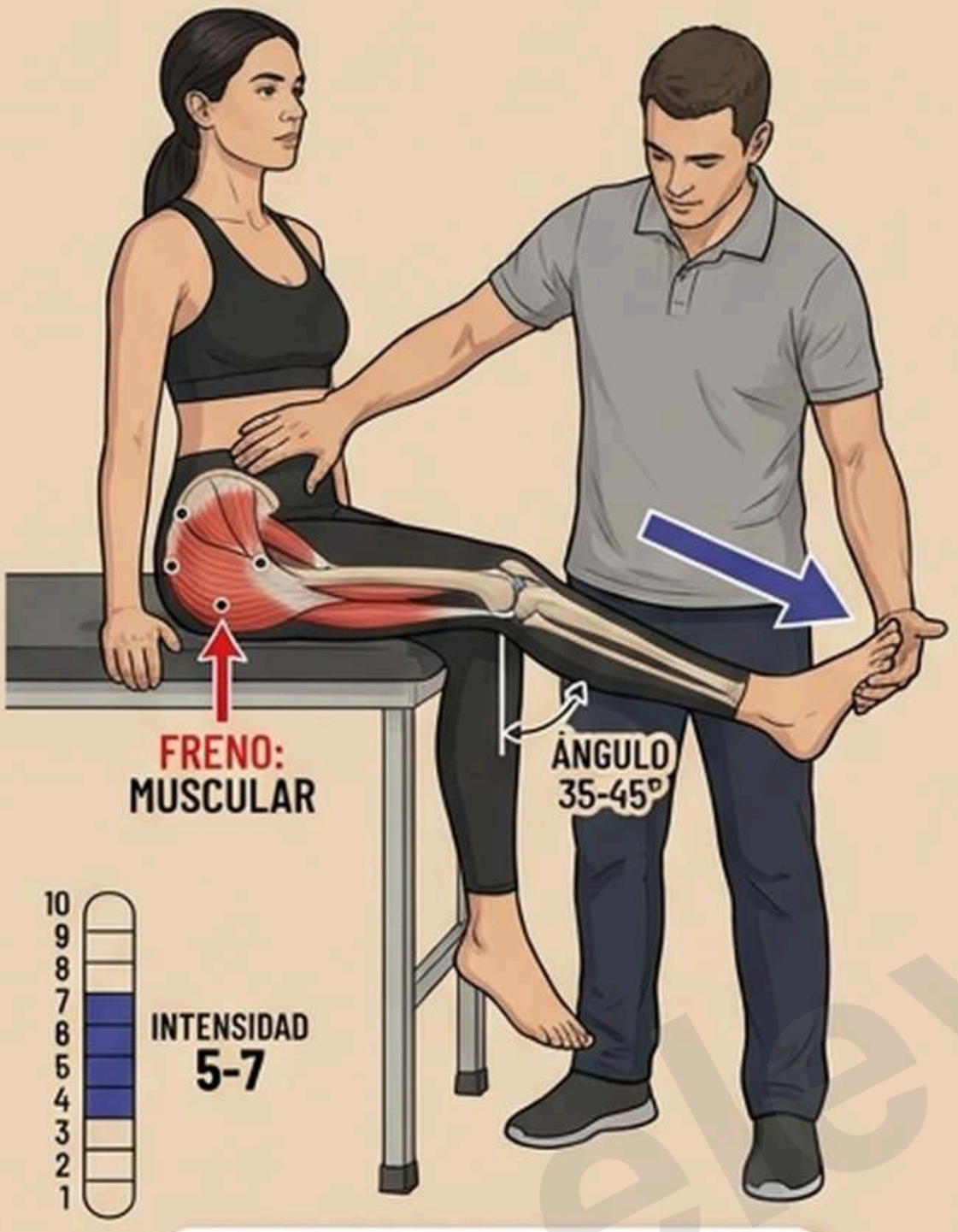
No llevar la rodilla al pecho lo suficiente y permitir que la lumbar se arquee, lo que falsea el resultado.
Dejar que la pierna que cuelga se abra hacia el costado.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

En embarazo avanzado, esta posición puede ser incómoda; se busca una alternativa.

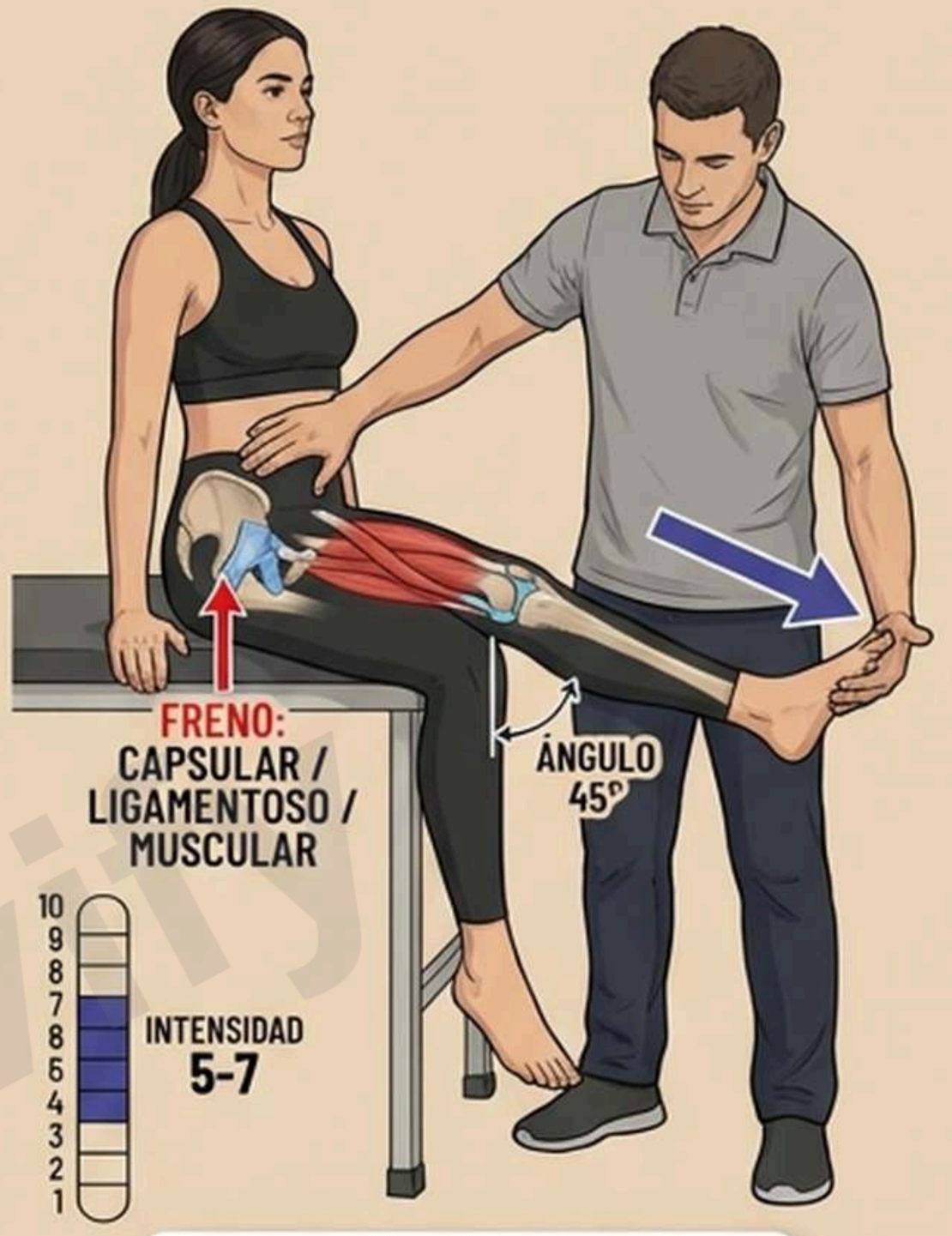
TEST DE ROTACIÓN DE CADERA

ROTACIÓN INTERNA



FRENO PRINCIPAL: TENSIÓN EN ROTADORES EXTERNOS

ROTACIÓN EXTERNA



FRENO PRINCIPAL: CÁPSULA ANTERIOR Y LIGAMENTOS

PARA QUIÉN

Practicantes de danza, artes marciales, yoga, o alumnos con molestias en la cadera, zona lumbar o rodilla. Mide el rango de la articulación coxofemoral.

EL TEST

Se realiza sentado o boca abajo para evaluar el rango de movimiento pasivo y detectar asimetrías.

PASO A PASO (Versión sentada)

1. La alumna se sienta en una camilla alta con los muslos apoyados y las rodillas a 90°.
2. Estabilizá su pelvis con tus manos en las crestas ilíacas para evitar compensaciones.
3. Para rotación externa, guiá el pie hacia adentro; para interna, hacia afuera.
4. Medí el ángulo que forma la tibia con la vertical y compará ambos lados.

ERRORES COMUNES

Mover la pelvis para ganar rango, inclinar el tronco, no mantener la rodilla a 90°.

QUÉ LE DECÍS PARA SU CASA

"Conocer cómo rotan tus caderas nos ayuda a entender por qué algunas posturas te cuestan más y cómo podemos trabajarlas de forma segura."

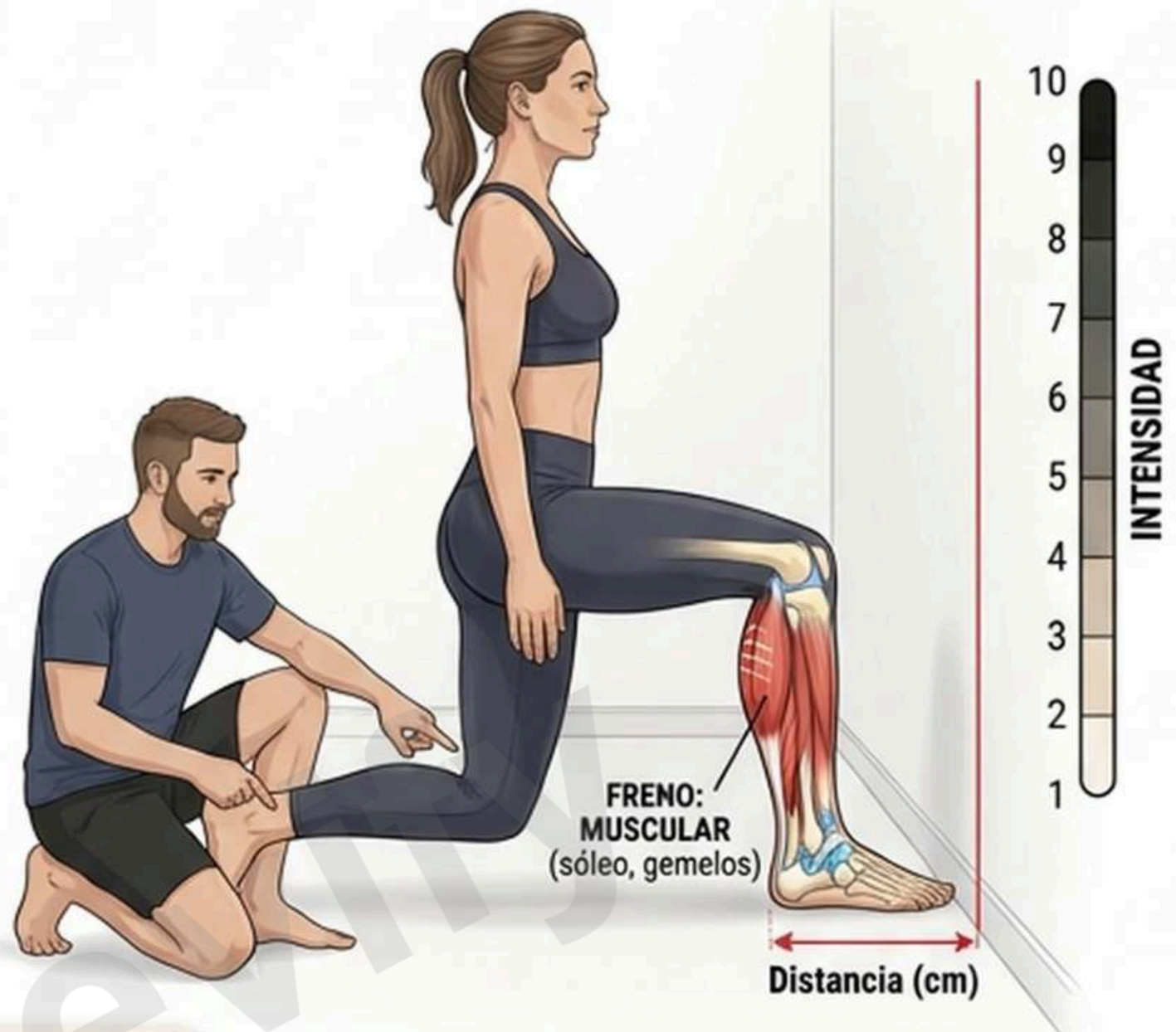
TEST DE **DORSIFLEXIÓN** DE TOBILLO

NIVEL: Básico.

PARA QUIÉN: Alumnos que levantan los talones en la sentadilla (squat), que refieren tirantez en las pantorrillas o que han tenido esguinces de tobillo.

QUÉ SE MIDE: El rango de dorsiflexión del tobillo.

FRENO EVALUADO: Muscular (sóleo, gemelos) o articular (articulación talocrural).



EL TEST

POSICIÓN DE PARTIDA: El alumno se para frente a la pared, con un pie adelante y otro atrás, en posición de estocada.

PASO A PASO:

1. Coloca el pie a evaluar a unos 5 cm de la pared, con los dedos apuntando al frente.
2. Le pedís que, manteniendo el talón pegado al suelo, flexione la rodilla e intente tocar la pared con ella.
3. Si lo logra sin levantar el talón, le pedís que aleje el pie un centimetro y repita.
4. El test termina cuando encuentra la máxima distancia a la que puede tocar la pared con la rodilla sin que se despegue el talón.
5. Medís la distancia en centímetros entre la punta del dedo gordo y la pared.

ERRORES COMUNES

BIEN: Talón pegado, rodilla alineada.

MAL: Despegar el talón.

MAL: Pronación excesiva o rodilla hacia adentro.

QUÉ SE MIDE Y VALORES DE REFERENCIA

Una distancia de 10-12 cm se considera un buen rango funcional. Menos de 9 cm puede indicar una limitación que afectará la profundidad y la técnica de la sentadilla, la zancada y otros movimientos.

QUÉ LE DECÍS PARA SU CASA

"Esta medida nos sirve de punto de partida. Mejorar la movilidad de tu tobillo te va a dar mucha más libertad y seguridad en las sentadillas".

CAP 3 · EVALUACIÓN:
MEDIR ANTES DE ESTIRAR

TEST DE MOVILIDAD DE HOMBRO

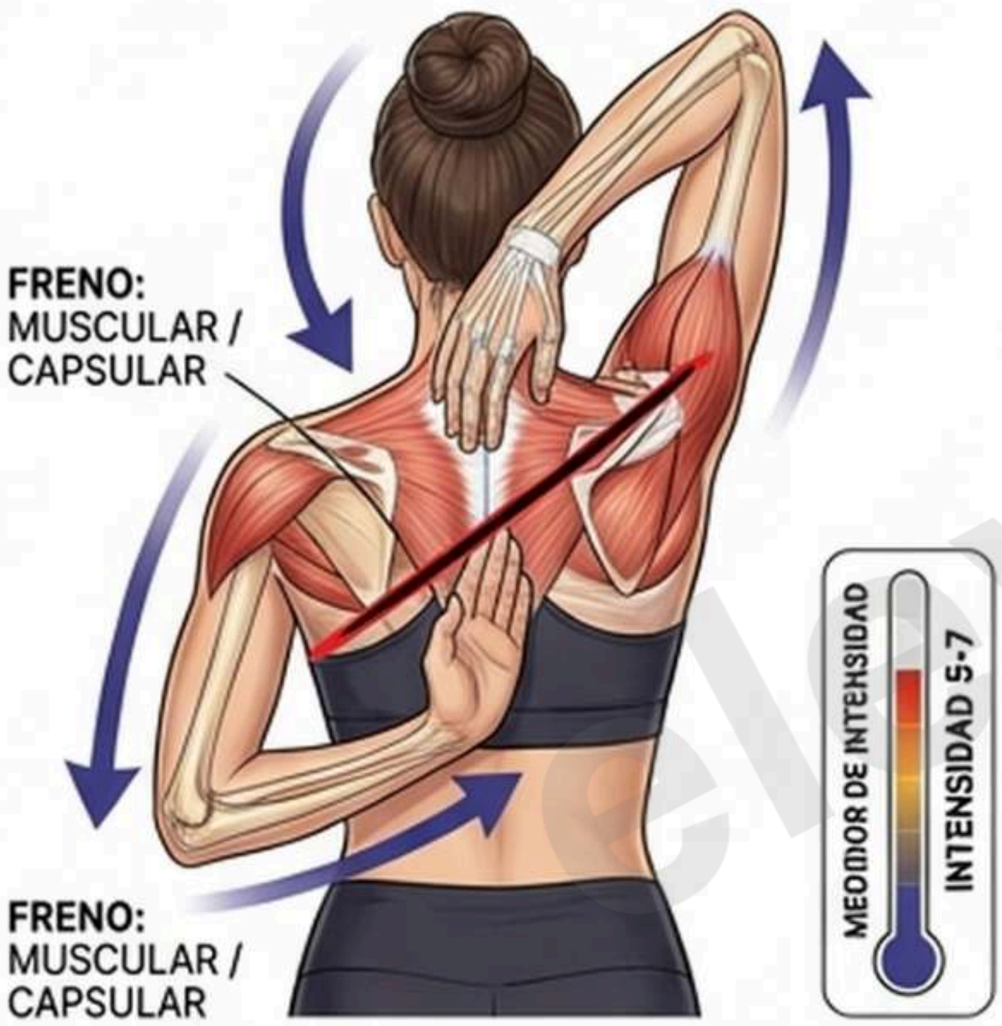
FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST: NIVEL: Básico

PARA QUIÉN: Nadadores, lanzadores, practicantes de yoga o cualquiera con sensación de hombros "trabados" o que trabaje mucho tiempo en un escritorio.

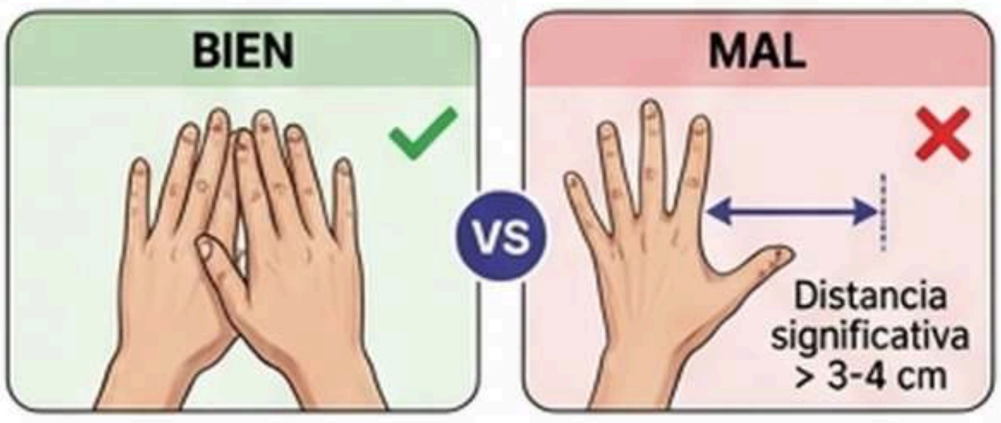
QUÉ SE MIDE: La movilidad global del hombro en flexión, abducción y rotaciones.
FRENO EVALUADO: Muscular (dorsal ancho, pectorales, redondos) y capsular.

EL TEST: Combina dos pruebas sencillas.

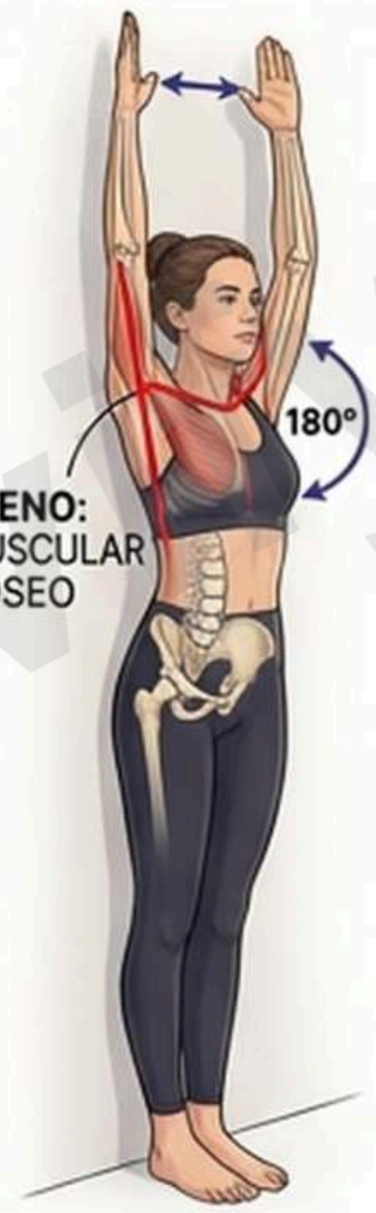
Test 1 (Apley's Scratch Test):



1. El alumno, de pie o sentado, intenta tocarse las manos en la espalda.
2. Un brazo va por arriba del hombro y el otro por debajo.
3. Se mide la distancia entre las puntas de los dedos (si no se tocan es distancia negativa, si se sobreponen es positiva).
4. Se repite cambiando los brazos de posición.

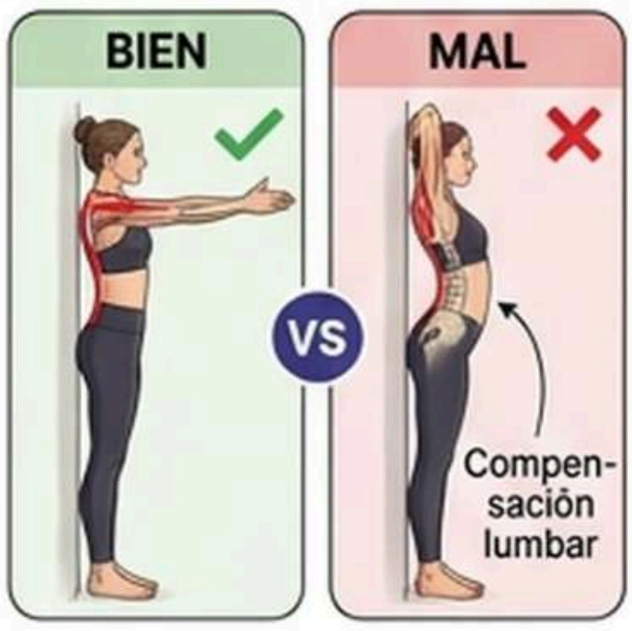


Test 2 (Flexión contra la pared):



1. El alumno se para de espaldas a una pared, talones, sacro y escápulas en contacto.

2. Le pedís que eleve ambos brazos extendidos por el frente, intentando tocar la pared con los pulgares sin arquear la espalda lumbar.



QUÉ SE MIDE Y VALORES DE REFERENCIA:
En el Test 1, una asimetría de más de 3-4 cm entre un lado y otro es significativa.
En el Test 2, un rango completo es de 180°, logrando tocar la pared sin compensar. Si la lumbar se arquea, indica que la falta de movilidad del hombro se compensa con la columna.

ERRORES:
- ✗ Arquear la espalda, encoger los hombros hacia
- ✗ las orejas, flexionar los codos en el test de pared.

QUÉ LE DECÍS PARA SU CASA:
"Observar cómo se mueven tus hombros nos ayuda a prevenir lesiones y a mejorar todos los ejercicios que se hacen por encima de la cabeza".

TEST DE MOVILIDAD DE COLUMNA

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST: NIVEL: BÁSICO

PARA QUIÉN: Cualquier alumno, para tener un panorama general de cómo se mueve su columna. Especialmente útil si hay rigidez o molestias lumbares o dorsales.

QUÉ SE MIDE: La calidad y distribución del movimiento en los tres planos: sagital (flexión/extensión), frontal (inclinación) y transversal (rotación).
FRENO EVALUADO: Muscular (cuadrado lumbar, erectores espinales) y articular/ligamentoso.

EL TEST: Se evalúan los movimientos por separado, observando la fluidez.

PASO A PASO

1. Flexión: De pie, le pedís que se enrolle vértebra a vértebra hacia el suelo. Observá si la curva es homogénea o si hay segmentos planos (común en la zona dorsal).

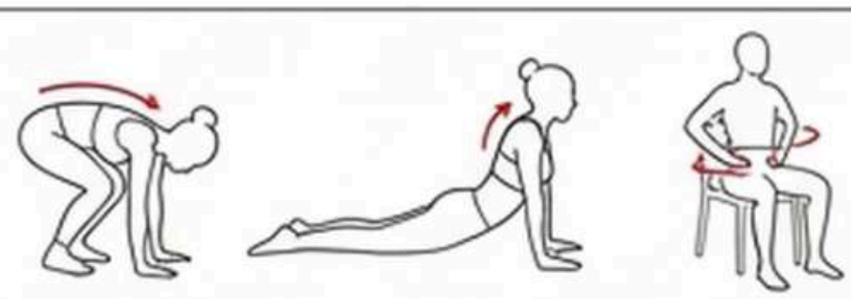
2. Extensión: Boca abajo, manos bajo los hombros, le pedis que empuje el suelo para levantar el torso (como en una cobra). Observá si la extensión se distribuye o se concentra solo en la zona lumbar.

3. Rotación: Sentado en una silla con la pelvis fija, le pedis que rote el torso a un lado y al otro, con los brazos cruzados sobre el pecho. Observá el rango y la simetria.

QUÉ SE MIDE Y VALORES DE REFERENCIA: No buscamos tanto un número, sino la calidad del movimiento. **¿Es fluido o segmentado? ¿Hay dolor? ¿Es simétrico? Una zona dorsal que no rota ni se extiende suele sobrecargar la zona lumbar y cervical. Buscamos una curva armónica en la flexión y una participación equilibrada de toda la columna en los otros movimientos.**

ERRORES QUE VES EN LA SALA

En la **flexión**, doblar las rodillas demasiado pronto.
En la **extensión**, encoger los hombros.
En la **rotación**, mover la pelvis.



QUÉ SÍ (Check verde): Movimientos controlados y fluidos. Escuchar al cuerpo.
QUÉ NO (Cruz roja): Dolor agudo, hormigueo, forzar el movimiento. Ante dolor irradiado (ciática), no se realizan los tests y se deriva a un profesional de la salud.

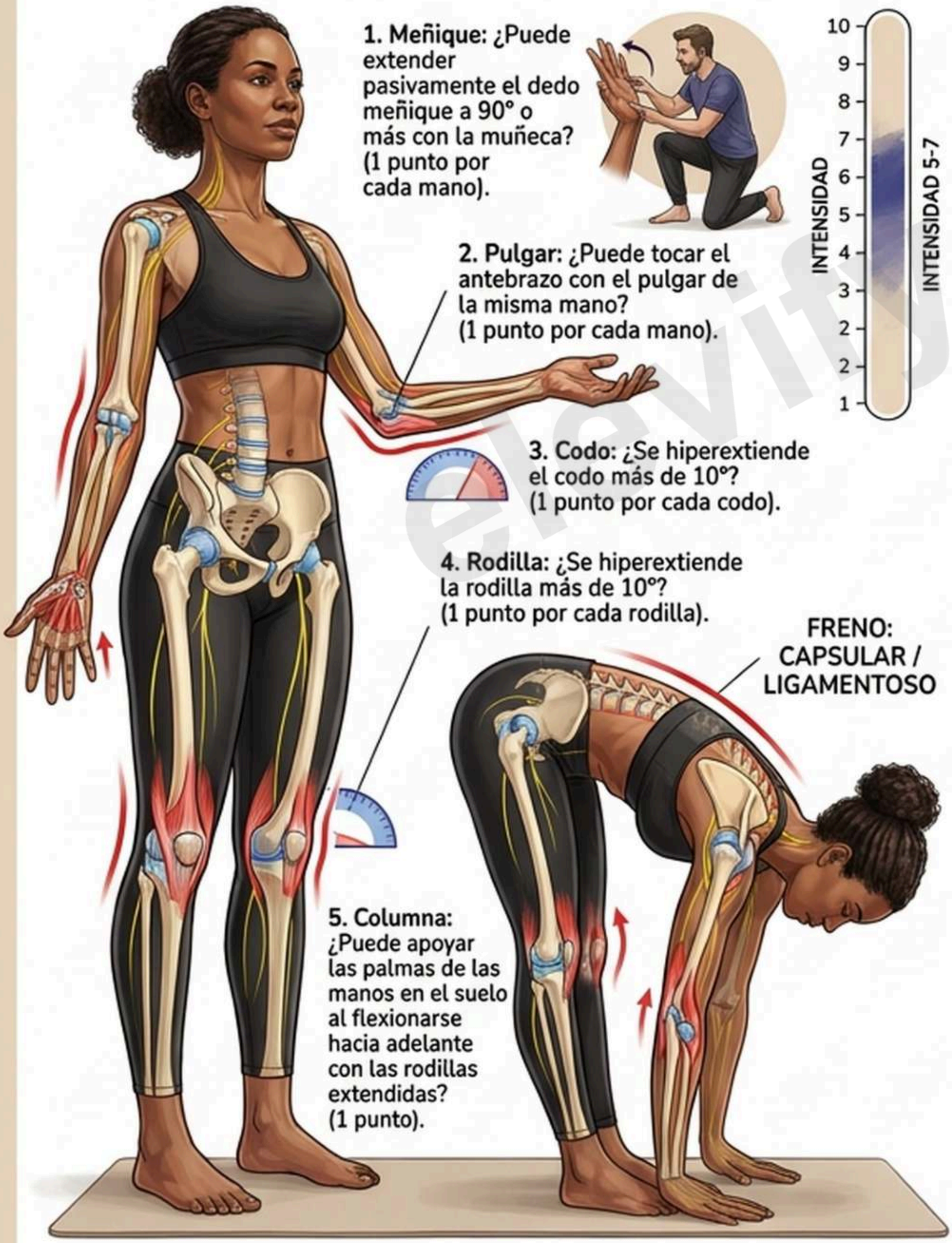
CUE DE LA FORMADORA: Observá la calidad, no la cantidad. La simetría es clave.

TEST DE BEIGHTON: HIPERMOVILIDAD

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST: NIVEL: Básico.

PARA QUIÉN: Alumnos que se describen como “muy flexibles”, que se lesionan con facilidad, o en quienes sospechás que la falta de estabilidad es el problema, no la falta de flexibilidad.

QUÉ SE MIDE: La hipermovilidad articular generalizada, usando una escala de 9 puntos.
FRENO EVALUADO: Laxitud del tejido conectivo (ligamentos, cápsulas).



QUÉ SE MIDE Y VALORES DE REFERENCIA:

Una puntuación de 5 o más en adultos (6 o más en niños/adolescentes) es indicativa de hipermovilidad generalizada. Este resultado no es una enfermedad, pero sí una condición a tener muy en cuenta. En alumnos hiperlaxos, el foco del trabajo no debe ser ganar más rango pasivo, sino construir estabilidad y control en el rango que ya tienen.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- Forzar el movimiento.
- Medir de forma imprecisa el ángulo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

A estos alumnos no les damos estiramientos pasivos sostenidos en los rangos finales; priorizamos el trabajo de fuerza y control motor.

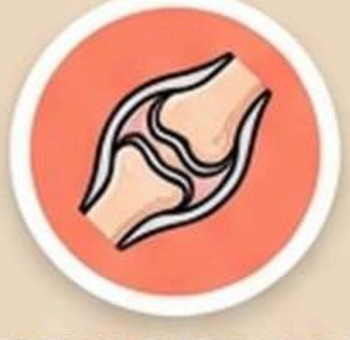
QUÉ **FRENO** TIENE CADA **ALUMNO**

Los tests no te dan un diagnóstico definitivo, sino pistas valiosas sobre las limitaciones de movilidad. Un mismo movimiento limitado en dos personas distintas puede tener causas completamente diferentes, desde la tensión de un músculo hasta la estructura de un hueso.

TIPOS DE FRENO

FRENO MUSCULAR (CONTRÁCTIL)

Ejemplo:
- Test de Thomas positivo (psoas corto)
- Isquiotibiales tensos en elevación de pierna recta



FRENO CAPSULAR (ARTICULAR)

Ejemplo:
- Rigidez profunda en rotación externa de hombro
- Sensación de tope en la cadera

FRENO NEURAL (NERVIO)

Ejemplo:
- Hormigueo o ardor en la planta del pie en test de elevación de pierna (ciático)
- Tensión punzante en el brazo

FRENO ÓSEO (HUESO)

Ejemplo:
- Contacto óseo en flexión profunda de cadera
- No llegar a tocarse los pies por la forma de la cadera
- Tope duro al final del rango

FRENO MUSCULAR VS. FRENO ÓSEO

FRENO MUSCULAR (ACORTAMIENTO REAL)

SOLUCIÓN: ESTIRAR EL MÚSCULO

Un alumno puede no llegar a tocarse los pies por un acortamiento real de sus isquiotibiales, o tener un Test de Thomas positivo por psoas corto. La sensación es de tensión y se puede trabajar con estiramiento progresivo.

FRENO ÓSEO (LÍMITE ESTRUCTURAL)

SOLUCIÓN: ACEPTAR EL LÍMITE

Otro alumno puede estar limitado simplemente por la forma de sus huesos de la cadera, sintiendo un "tope" duro. Forzar este límite es riesgoso. Aprender a diferenciar te permite elegir la herramienta correcta.

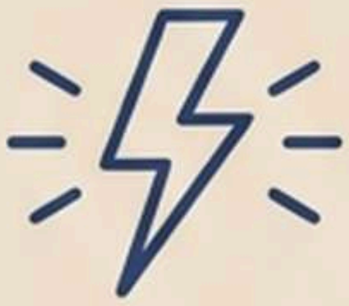
EN LA SALA: SEÑAL DE ALERTA

Si un alumno siente un "pinzamiento" duro al final de un rango de movimiento, es una señal de alerta inmediata. Casi siempre indica un freno óseo o articular. Forzar esta sensación es peligroso para la articulación. Se debe retroceder y buscar una alternativa, nunca insistir.

CUÁNDO DERIVAR ANTES DE EMPEZAR

SABER DECIR "NO SÉ"

SÍNTOMA NEURAL: HORMIGUEO, ADORMECIMIENTO



DOLOR AGUDO, PUNZANTE

CLIC DOLOROSO O CHASQUIDO

BANDERA ROJA

Nuestro rol es entrenar el movimiento, no diagnosticar ni tratar patologías. Es fundamental reconocer los límites de nuestra competencia. Si durante la entrevista o los tests un alumno reporta un dolor agudo, **punzante, quemante,** hormigueo, **adormecimiento, un** chasquido doloroso **en una articulación o una sensación de inestabilidad (que "se le va" la articulación), no debemos seguir.** Esas son **"banderas rojas"** que indican la necesidad de una evaluación médica o kinesiológica. Nuestra responsabilidad es la seguridad del alumno.

QUÉ SÍ	QUÉ NO
Decir con calma y profesionalismo: "Esta sensación que me describís necesita la opinión de un médico o un kinesiólogo antes de que empecemos a trabajar".	Intentar "arreglarlo" con un estiramiento, masajear la zona o dar un diagnóstico improvisado.

FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL DE FLEXIBILIDAD

SECCIÓN 1: DATOS PERSONALES

Nombre Completo: _____

Fecha: ___/___/___ Edad: _____

Teléfono / Email: _____

SECCIÓN 2: ENTREVISTA

Objetivo Principal:

☐ Mejora Rendimiento ☐ Salud / Bienestar
☐ Alivio de Tensión ☐ Otro: _____

Actividad Física Semanal (Tipo y Frecuencia)**:**

_____

Horas sentado/a por día (Aprox.): _____

Historial de Lesiones / Cirugías Relevantes:

_____

Molestias Actuales (Zona y Tipo de Dolor)**:**

_____

¿Diagnosticado/a con hipermovilidad? ☐ **SÍ**
☐ **NO** (Consulta profesional si tenés dudas)

SECCIÓN 3: OBSERVACIÓN POSTURAL

Pelvis (Alineación, Inclinación)**:**

_____

_____

Rodillas (Valgo/Varo, Hiperextensión)**:**

_____

_____

Hombros (Altura, Protracción)**:**

_____

_____

Columna (Curvaturas, Alineación)**:**

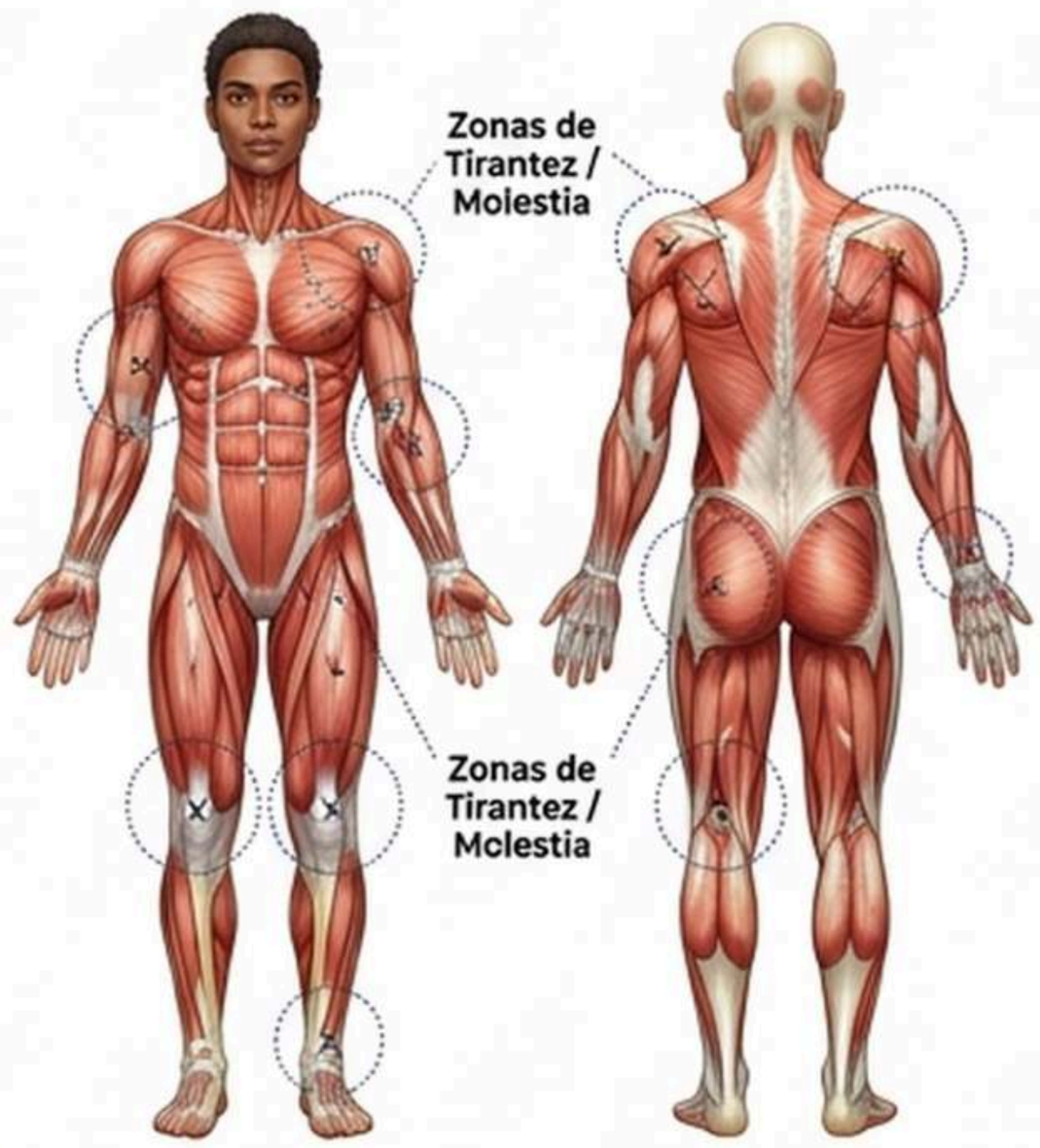
_____

_____

SECCIÓN 4: TABLA DE TESTS

Test	Resultado	
Isquiotibiales (Ángulo °)	____ °	____ °
Thomas (Psoas D/I)	____ D I	____ D I
Thomas (Recto Femoral D/I)	____ D I	____ D I
Rot. Cadera (Ext D/I)	____ ✓	____ ✓
Rot. Cadera (Int D/I)	____ ✓	____ ✓
Dorsiflexión (cm D/I)	____ cm	____ cm
Hombro (Distancia cm D/I)	D ✓ I ✓	D ✓ I ✓
Columna (Notas)		
Beighton (Puntaje /9)	____ /9	

SECCIÓN 5: MAPA CORPORAL

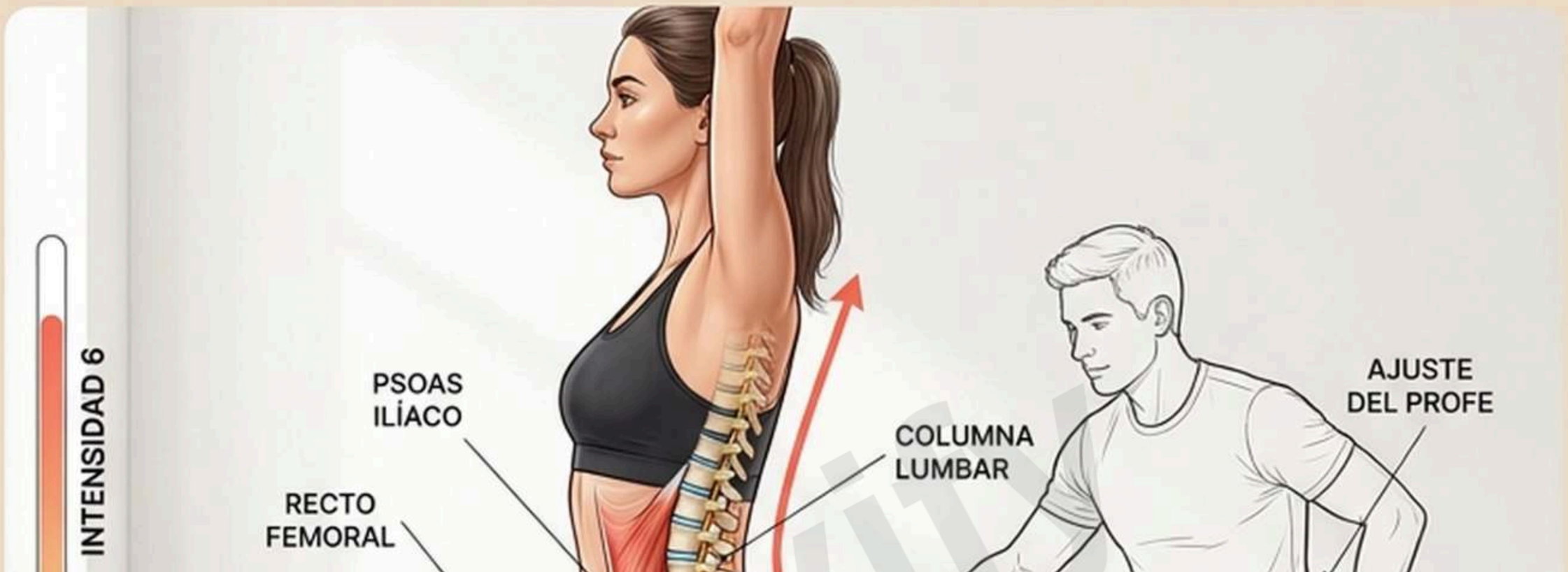


CARD INSTRUCCIONES

Usá esta ficha para registrar el punto de partida de cada alumno. Anotá los resultados de forma clara y precisa. Reevaluá cada 8–12 semanas para objetivar el progreso, adaptar el plan de trabajo y ajustar el programa de flexibilidad según las necesidades individuales. ¡El registro constante es clave para el avance!

LOS MÉTODOS

Descubrí qué técnica usar según tu freno, tu objetivo y tu alumno.



QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capitulo vamos a desglosar las principales formas de estirar.

Vas a aprender las diferencias entre los métodos estáticos, dinámicos y PNF, cuándo es mejor usar cada uno y cómo combinarlos en una misma sesión para obtener resultados seguros y eficientes.

Te daremos el criterio para elegir la herramienta correcta para cada cuerpo y cada momento.

PELVIS EN RETROVERSIÓN, ESPALDA LARGA

PELVIS EN ANTEVERSIÓN, LUMBAR REDONDEADA

ELEGIR EL MÉTODO

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?

1. Preparar para la actividad
(Calentamiento)

→ **ESTIRAMIENTO DINÁMICO**

2. Ganar rango de movimiento
(Flexibilidad)

¿CUÁL ES EL FRENO PRINCIPAL?

A. Tensión Muscular/Neural

→ **PNF / ESTÁTICO ACTIVO**

B. Rigidez Capsular/Fascial

→ **ESTÁTICO PASIVO / CON CARGA**

CARD · LA CLAVE DEL ÉXITO: ADAPTAR EL MÉTODO

La **efectividad** de un **estiramiento** no está en la **intensidad**, sino en **elegir el método correcto** para el freno que te limita.

Si el sistema nervioso de tu alumna está en **alerta (freno neural)**, un **estiramiento pasivo forzado** solo **aumentará la tensión**. En ese caso, es mejor empezar con **respiración y movimientos dinámicos suaves.**

Si el freno es la **viscoelasticidad del músculo**, un **estático pasivo sostenido** o un **PNF** serán más efectivos.

Conocer la causa te permite elegir la **solución adecuada**.

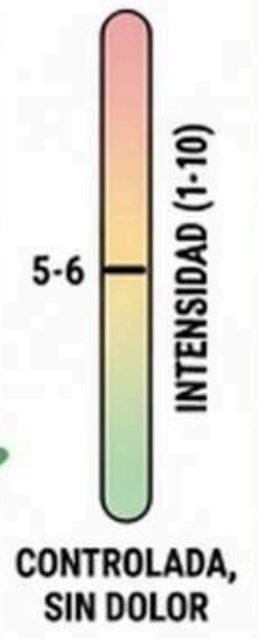
EN LA SALA · CASO PRÁCTICO: TENSIÓN VS. RIGIDEZ

SITUACIÓN COMÚN

Un alumno llega contracturado y quiere 'romper' la tensión con un estiramiento fuerte.

LA SOLUCIÓN

Primero lo hacés respirar y relajar. Priorizá la movilidad suave y la respiración diafragmática.



SECUENCIA INTELIGENTE

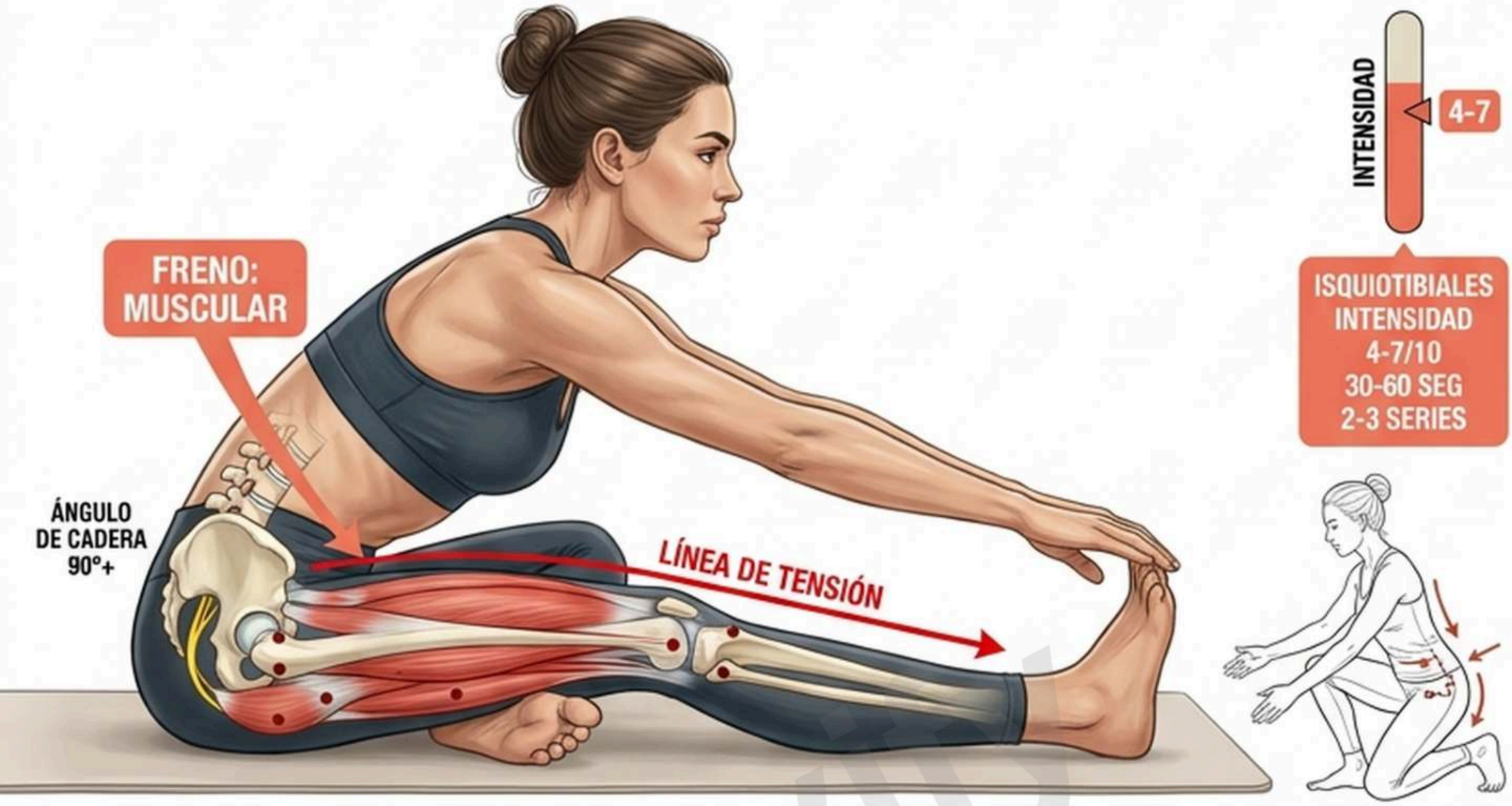
EL ORDEN IMPORTA

No tiene sentido hacer un estiramiento pasivo profundo con el cuerpo frío y el sistema nervioso en alerta. Una sesión bien estructurada sigue una lógica de preparación progresiva. **Empezás calmando el sistema nervioso y lubricando las articulaciones**. Luego, **aumentás la temperatura y el flujo sanguíneo** con **movimientos dinámicos**. Recién ahí, cuando el cuerpo **está receptivo, realizás el trabajo principal de ganancia de rango.** Finalmente, es clave **activar la musculatura** en ese nuevo rango para que el cerebro lo registre como seguro y útil.

EN LA SALA

Después de un PNF de isquiotibiales, le pedís una elevación lenta de la pierna para que el sistema nervioso integre el nuevo rango.

MÉTODO: ESTÁTICO PASIVO



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Ideal al final de la clase para bajar revoluciones y trabajar sobre la viscoelasticidad del tejido, sobre todo en alumnos con rigidez muscular general.
Posición de partida: Sentado en el suelo con las piernas extendidas (ej. para isquiotibiales).
Zona y músculos que se estiran: Cadena posterior,
El freno que se trabaja: Muscular.

EL ESTIRAMIENTO: MÉTODO ESTÁTICO PASIVO

Intensidad 4-7/10, una tirantez que te permita relajar.
Tiempo: 30-60 segundos por serie, 2-3 series.
Respiración: Larga y profunda, usando la exhalación para soltar la tensión.
Qué se mantiene fijo: La pelvis en una ligera retroversión, evitando que la flexión venga de la zona lumbar.

PASO A PASO

1. Sentate sobre un almohadón si es necesario para mantener la espalda erguida.
2. Inhalá para alargar la columna.
3. Exhalá y flexionate hacia adelante desde la cadera, no desde la cintura.
4. Sostené la posición cuando sientas la primera tirantez.
5. Mantené 30-60 segundos, respirando y permitiendo que el cuerpo ceda.
6. Volvé lentamente.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Encorvar toda la espalda** para llegar más lejos.
   Corrección: Pensar en llevar el pecho hacia los pies.
2. **Aguantar la respiración.**
   Corrección: Exhalar con sonido para relajar.
3. **Rebotar.**
   Corrección: Es un método estático, el movimiento es quietud.

ERROR: LUMBAR REDONDEADA

CORRECTO: FLEXIÓN DESDE CADERA, ESPALDA NEUTRA

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hipermovilidad** (evitar o con mínima intensidad).
- **Hernia discal** (evitar flexión lumbar profunda, mantener espalda neutra).
- **Embarazo** (adaptar posición para no comprimir el vientre).
- **Adulto mayor** (con suavidad).

REGRESIÓN:
Flexionar las rodillas, usar una banda en los pies.

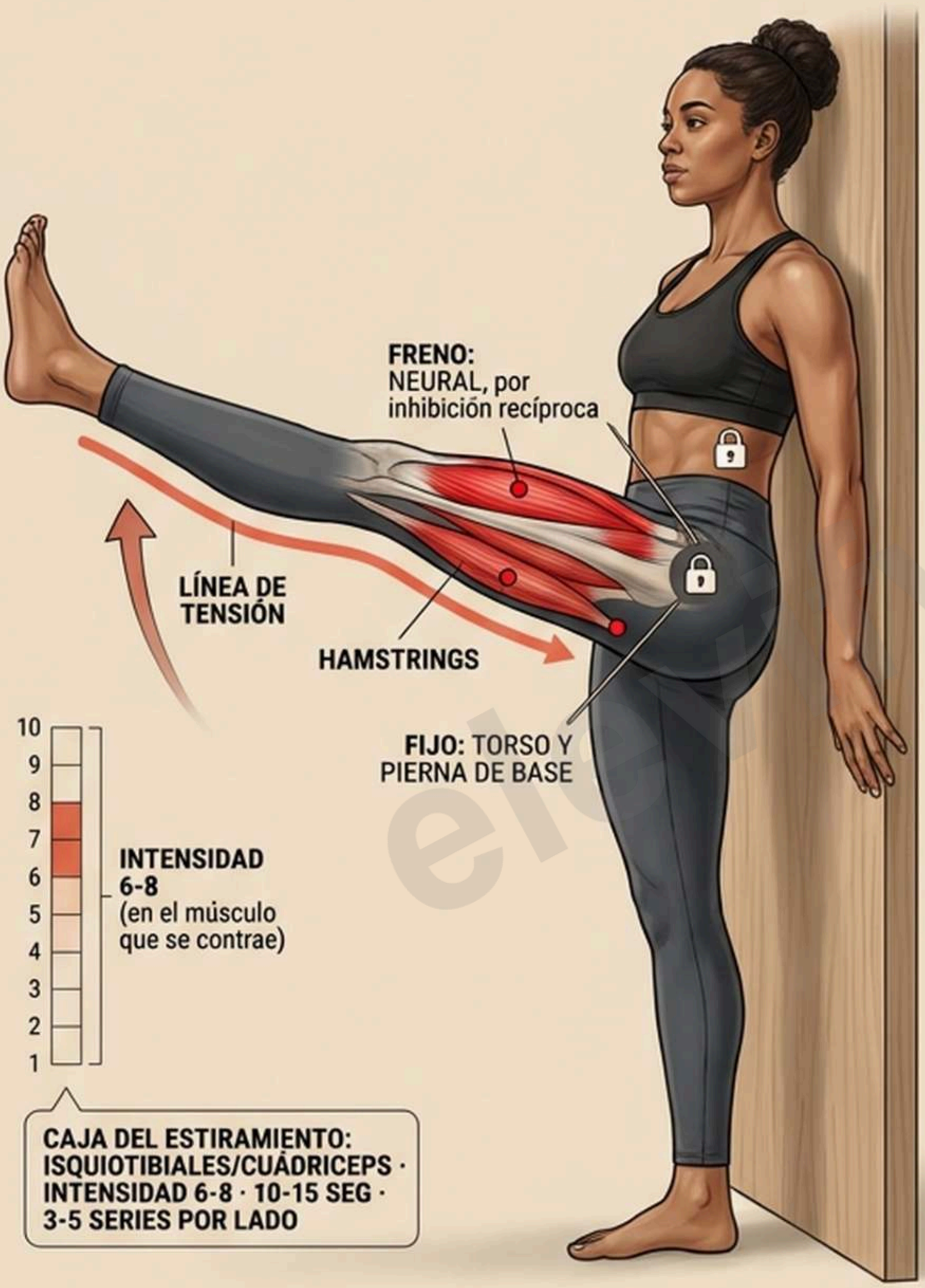
PROGRESIÓN:
Aumentar el tiempo de sostén.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA:
"Buscá una tirantez amable que te permita respirar. No es una lucha, es una invitación a que el músculo se suelte".

NIVEL: BÁSICO

MÉTODO: ESTÁTICO ACTIVO

Para practicantes que quieren ganar rango de movimiento útil y control motor. Excelente para bailarinas, artistas marciales o cualquiera que necesite usar su flexibilidad de forma activa.



CAJA DEL ESTIRAMIENTO: ISQUIOTIBIALES/CUÁDRICEPS · INTENSIDAD 6-8 · 10-15 SEG · 3-5 SERIES POR LADO

EL ESTIRAMIENTO

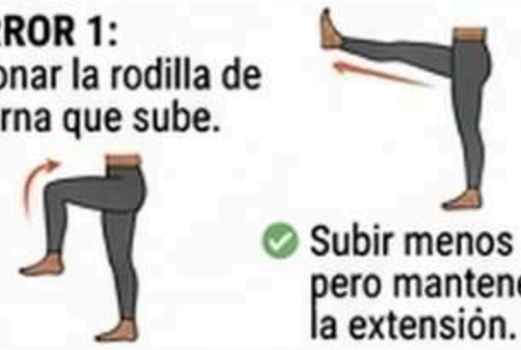
- **Método:** Estático activo.
- **Intensidad:** 6-8/10 en el músculo que se contrae para sostener la posición.
- **Tiempo:** Sostener 10-15 segundos, 3-5 repeticiones por lado.
- **Respiración:** Fluida, no la contengas.
- **Qué se mantiene fijo:** El torso y la pierna de base, sin inclinarse ni perder el equilibrio.

PASO A PASO

1. De pie junto a una pared para tener apoyo si lo necesitás.
2. Activá el abdomen.
3. Elevá una pierna extendida al frente, contrayendo fuertemente el cuádriceps.
4. Sostenela en el punto más alto que puedas alcanzar sin compensar con el cuerpo.
5. Mantené la posición por 10-15 segundos.
6. Bajá la pierna de forma controlada.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

ERROR 1:
Flexionar la rodilla de la pierna que sube.



Subir menos pero mantener la extensión.

ERROR 2:
Inclinar el torso hacia atrás.

Mantener el core activo y el torso vertical.

ERROR 3:
Perder el equilibrio.

Fijar la vista en un punto y usar la pared de apoyo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ:

- **Hipermovilidad** (excelente para ganar control en los rangos finales).
- **Embarazo** (con cuidado y evitando la compresión abdominal excesiva).
- **Adulto mayor** (adaptando la altura y el apoyo).

QUÉ NO:

- **Hernia discal** (cuidado con la compresión, activar muy bien el core).
- **Lesión reciente** (no recomendado en la zona afectada).

REGRESIÓN: Hacer el mismo ejercicio acostado boca arriba.

PROGRESIÓN: Aumentar el tiempo de sostén.

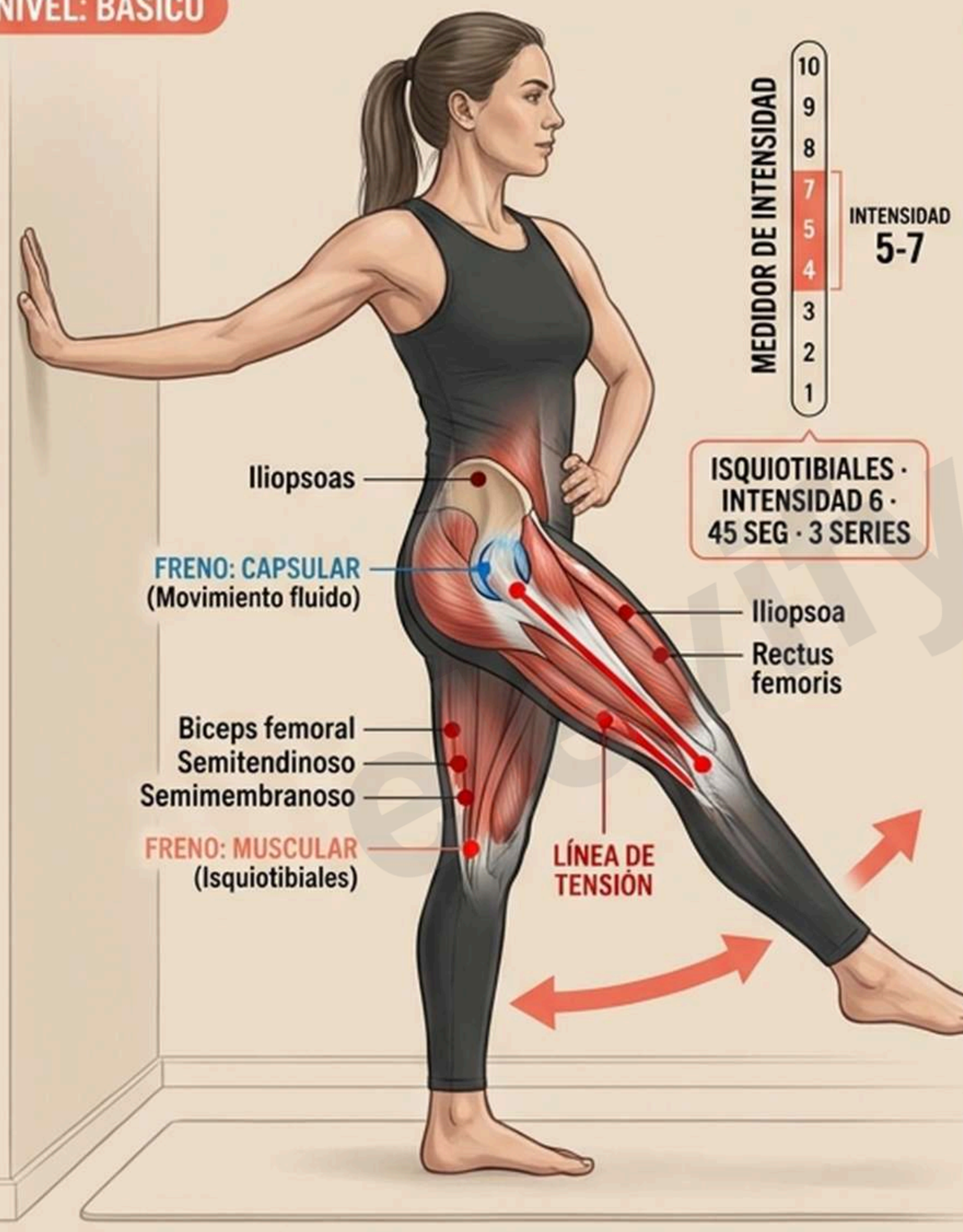
PARA SU CASA: "Sentí cómo el músculo de adelante de tu muslo es el protagonista. Su contracción le envia una señal al de atrás para que se relaje y te deje subir".

NIVEL: INTERMEDIO

ESTIRAMIENTO DINÁMICO CONTROLADO

PARA QUIÉN: Fundamental para el calentamiento. Prepara el cuerpo y el sistema nervioso sin forzar.

NIVEL: BÁSICO



ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 6 · 45 SEG · 3 SERIES

PASO A PASO

1. De pie de costado a una pared, apoyá una mano.
2. Mantené el abdomen firme y la espalda neutra.
3. Balanceá la pierna de afuera hacia adelante y hacia atrás, como un péndulo.
4. El movimiento nace en la cadera, es fluido y sin rebotes bruscos al final del rango.
5. Aumentá la altura del balanceo gradualmente en cada repetición.
6. Hacé 8-12 repeticiones y cambiá de lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Arquear la espalda al llevar la pierna atrás.**
   CORRECCIÓN: Activar más el abdomen y reducir el rango.
2. **Lanzar la pierna con envión.**
   CORRECCIÓN: Hacer el movimiento más lento y controlado,
   CORRECCIÓN: Hacer el movimiento más lento y controlado.
3. **Mover todo el torso.**
   CORRECCIÓN: Imaginar que el torso está encerrado en un bloque de cemento.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Dinámico controlado. Intensidad baja, el foco está en el control y la fluidez, no en forzar el rango.

TIEMPO: 8-12 repeticiones por lado.

RESPIRACIÓN: Coordinada con el movimiento, por ejemplo, exhalar en la fase de mayor estiramiento.

QUÉ SE MANTIENE FIJO: El core. El torso no debe moverse ni compensar.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

HIPERMOVILIDAD: Muy bueno, enfocarse en el control y no en el rango máximo.

ADULTO MAYOR: Con rango reducido y más lento.

LESIÓN RECIENTE: No.

EMBARAZO: Con adaptaciones y menor rango.

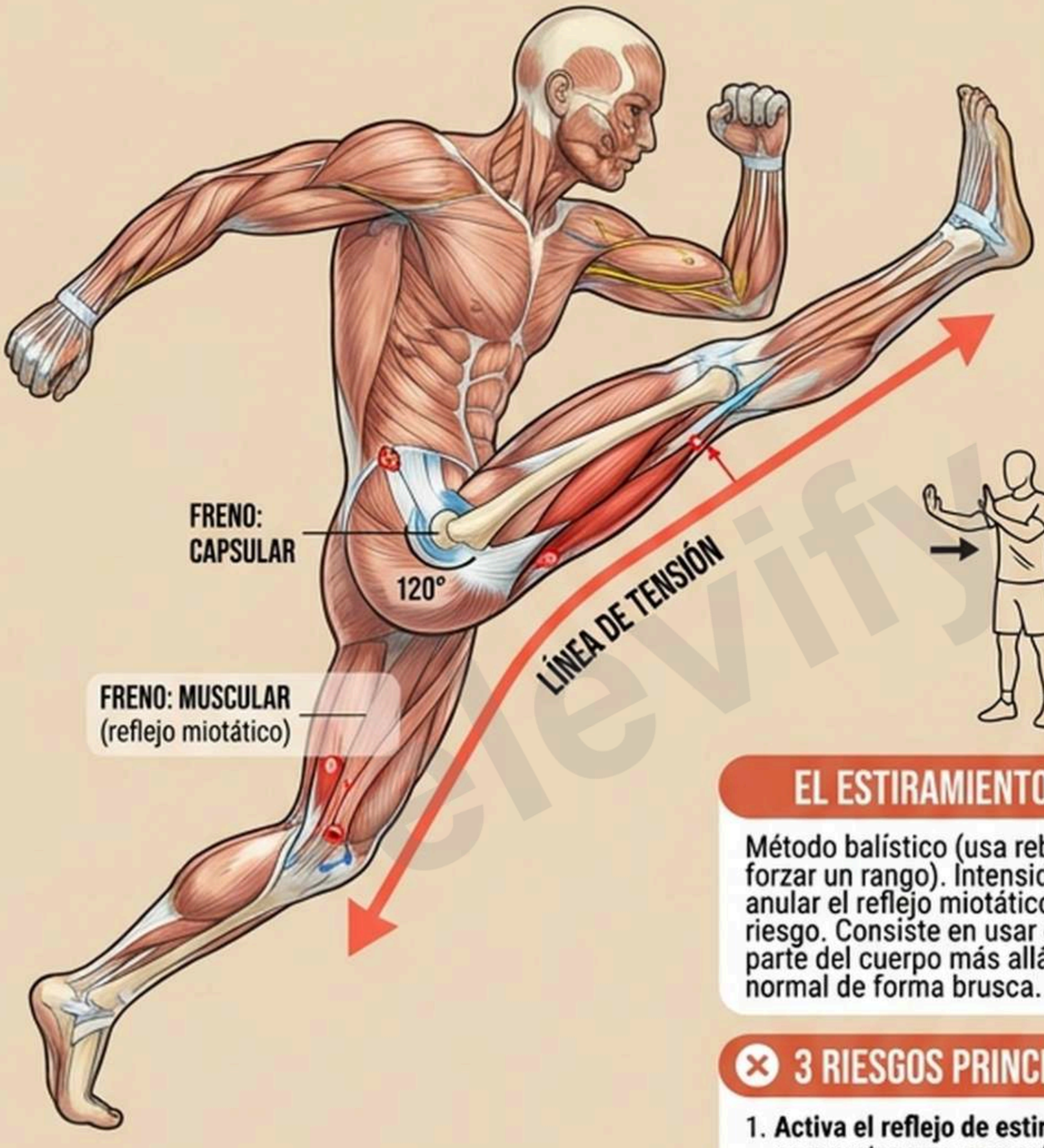
REGRESIÓN: Rango de movimiento más corto y lento.

PROGRESIÓN: Aumentar la velocidad del movimiento, siempre con control.

PARA SU CASA: "Imaginá que estás aceitando la articulación de la cadera. Es un movimiento para despertar el cuerpo, no para conquistarlo."

BALÍSTICO: CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NO.

Para quién y en qué situación: Exclusivamente para atletas avanzados cuyo deporte requiere movimientos explosivos en rangos finales (gimnastas, bailarines, artistas marciales), y siempre como parte de una preparación muy específica y supervisada. No es para la población general.



ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 7
5 REBOTES · 3 SERIES

CUE: "NO REBOTES, CONTROLÁ EL FINAL"

EL ESTIRAMIENTO

Método balístico (usa rebotes o lanzamientos para forzar un rango). Intensidad muy alta y rápida. Intenta anular el reflejo miotático, lo que lo hace de alto riesgo. Consiste en usar el impulso para llevar una parte del cuerpo más allá de su rango de movimiento normal de forma brusca.

3 RIESGOS PRINCIPALES

1. **Activa el reflejo de estiramiento**: el músculo se contrae para protegerse, aumentando el riesgo de desgarro.
2. **Estrés en articulaciones y tendones**: la fuerza del rebote no es absorbida por el mūsculo, sino por tejidos pasivos.
3. **No mejora la flexibilidad funcional de forma segura:** ensefia al cuerpo a moverse con impulso y sin control.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

- Atletas de alto rendimiento (con supervisión).
- Deportes con gestos explosivos especificos (artes marciales, danza).

QUÉ NO

- Población general.
- Principiantes.
- Personas con hipermovilidad, hernias, lesiones recientes, embarazadas, adultos mayores.

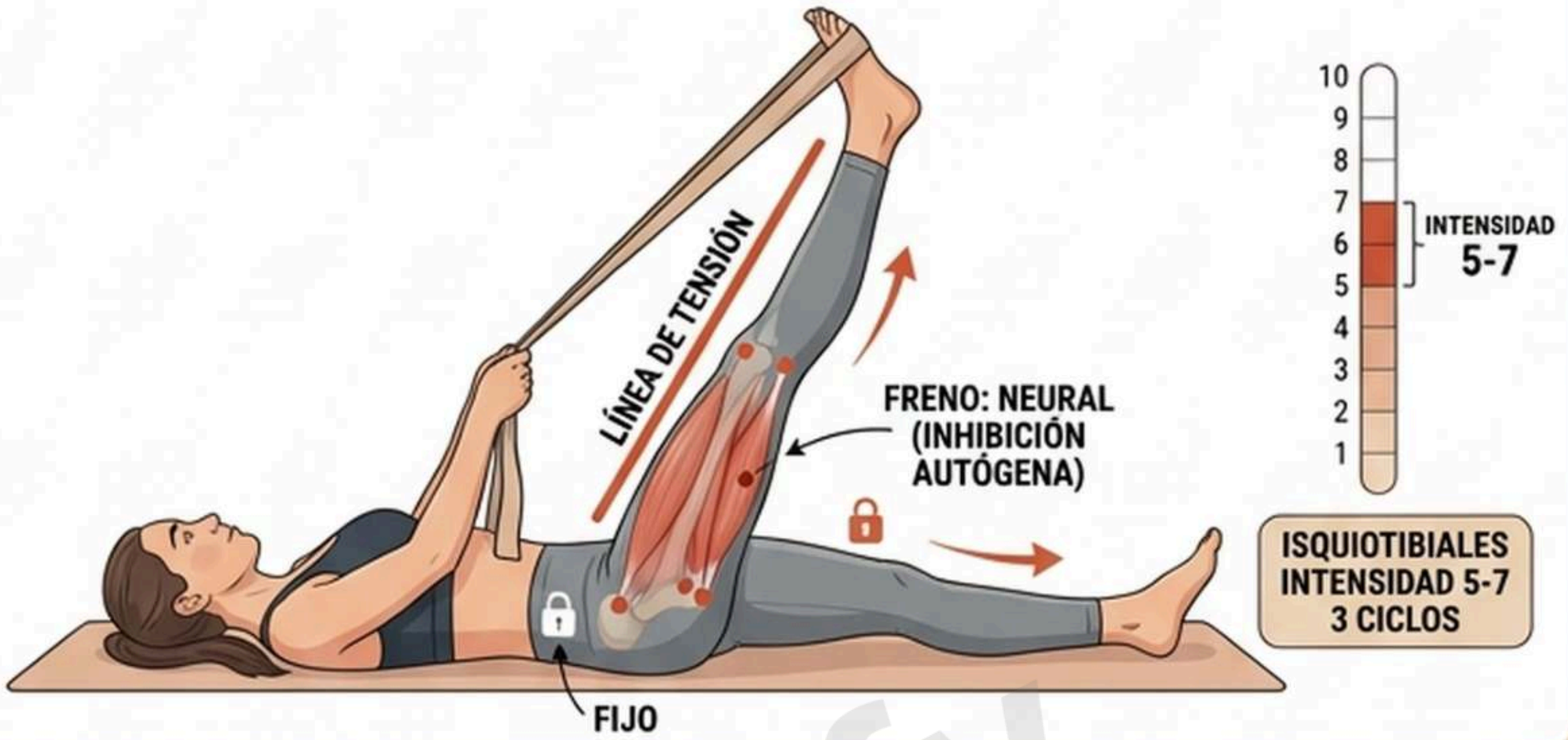
REGRESIÓN Y PROGRESIÓN

La alternativa segura es el **estiramiento dinámico controlado**. No hay regresión para el balístico, simplemente se desaconseja su uso fuera del contexto deportivo de élite.

PARA SU CASA: "En nuestras clases buscamos generar adaptaciones seguras y duraderas. Los rebotes son un atajo peligroso que casi siempre termina en lesión. Preferimos dialogar con el cuerpo, no gritarle".

MÉTODO PNF: CONTRAER-RELAJAR

MÉTODO PNF: CONTRAER-RELAJAR NIVEL INTERMEDIO



PARA QUIÉN: Alumnos que buscan una ganancia rápida de rango pasivo, con freno principalmente neural (tono muscular elevado) o muscular.

EL ESTIRAMIENTO: MÉTODO PNF

Intensidad: Estiramiento pasivo 4-6/10, contracción isométrica al 50-70% de la fuerza máxima.
Tiempo: Ciclo de estiramiento pasivo (15s), contracción (6s), relajación en nuevo rango (30s). Repetir 2-3 veces.
Respiración: Clave para la relajación.
Qué se mantiene fijo: La pelvis y la pierna de abajo, bien apoyadas.

PASO A PASO

1. Llevá la pierna al primer punto de tirantez suave y sostené 15s.
2. Inhalá profundo y luego, mientras sostenés el aire o exhalás suave, contraé el isquiotibial como si quisieras bajar la pierna. La banda lo impide, por eso la contracción es isométrica. Sostené 6s.
3. Exhalá completamente y relajá el músculo de inmediato.
4. Al relajar, usá la banda para llevar la pierna a un nuevo rango de estiramiento pasivo.
5. Sostené ahí por 30s.
6. Repetí el ciclo.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Hacer la contracción al 100%.**
   Corrección: Pedir una fuerza del 50%, es más que suficiente.
2. **No relajar del todo después de contraer.**
   Corrección: Guiar una exhalación larga y sonora.
3. **Levantar la cola del piso.**
   Corrección: Pedir que presione activamente la otra pierna contra el suelo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad (con contracciones de baja intensidad) ✓.
Lesión aguda (no) ✗.
Adulto mayor (con contracciones muy suaves) ✓.
Embarazo (con precaución) ✓.

REGRESIÓN: Contracción más suave o por menos tiempo.

PROGRESIÓN: Pasar a la técnica completa de la página siguiente.

PARA SU CASA: "La magia ocurre en la relajación post-contracción. Al contraerlo primero, engañás al sistema nervioso para que te permita relajarlo más profundo".

PNF: Contraer, Relajar y Contraer el Antagonista.

CAPÍTULO 4 · NIVEL AVANZADO

PARA QUIÉN

Para practicantes intermedios/avanzados que no solo quieren ganar rango pasivo, sino también control motor en ese nuevo rango. Busca romper la barrera neural con control activo.

EL ESTIRAMIENTO

Método PNF (Hold-Relax-Agonist-Contraction). **Intensidad:** 5-7.
Tiempo: Pasivo (15s) -> Contracción Isométrica Isquiotibial (6s) -> Relajación -> Contracción Activa Cuádriceps para sostener (10-15s).
Respiración: Inhalar en contracción, exhalar al relajar y mover. Pelvis estable.

PASO A PASO

1. Realizá el estiramiento pasivo con la banda (15s).
2. **Contraé isquiotibiales** contra la banda sin mover (6s), inhalando.
3. **Relajá**, quitá tensión de la banda y exhalá.
4. **INMEDIATAMENTE** contraé activamente el **CUÁDRICEPS** y flexores de cadera para elevar la pierna más alto sin ayuda (10-15s).
5. **Bajá controladamente** y repeti el ciclo 2-3 veces.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

ERROR: ENVIÓN EN FASE ACTIVA FINAL
Corrección: El movimiento debe ser lento y originado en la fuerza muscular del cuádriceps, sin impulso.

ERROR: FLEXIONAR LA RODILLA
Corrección: Mantener el cuádriceps activo para extender la rodlila completamente. Si se dobla, bajar la pierna.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

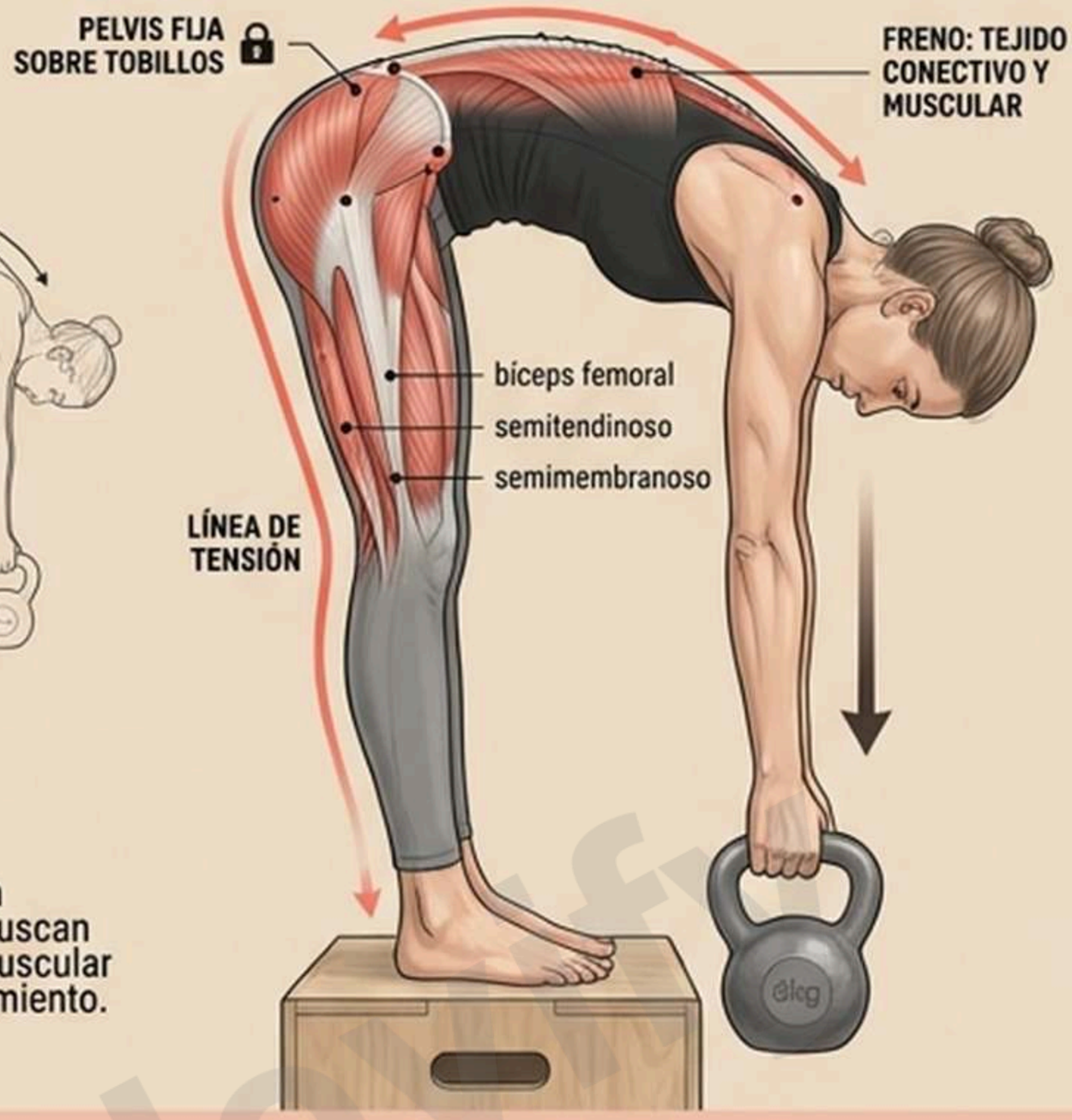
✅ **Hipermovilidad** (Excelente para control en rango final).
❌ **Lesión muscular reciente** (No realizar).
⚠️ **Embarazo** (Con cuidado, sin forzar, consultar).
✅ **Adulto mayor** (Adaptar intensidad, excelente).

REGRESIÓN: Volver a la técnica simple de Contraer-Relajar con banda.

PROGRESIÓN: Aumentar la duración (hasta 20s) o la intensidad de la contracción activa final sin banda.

PARA SU CASA: "Este es el paso final: después de crear el espacio, lo ocupás con tu propia fuerza. Así le enseñás a tu cerebro que ese nuevo rango no solo es accesible, sino también seguro y útil."

MÉTODO: ESTIRAMIENTO CON CARGA



PARA QUIÉN

Para practicantes avanzados con excelente control corporal, que buscan fortalecer el tejido conectivo y muscular en posiciones de máximo alargamiento. No es para principiantes.

JEFFERSON CURL
INTENSIDAD 5-7
5-8 REPS · 5-8 SEG BAJADA

EL ESTIRAMIENTO

- **MÉTODO:** Activo con carga
- **INTENSIDAD:** 5-7 (control sobre peso)
- **RESPIRACIÓN:** Fluida
- **TIEMPO:** 5-8s bajada, 1-2s pausa, 5-8s subida. 5-8 repeticiones
- **FIJO:** Caderas sobre tobillos

PASO A PASO

1. De pie, pies al ancho de caderas sobre el cajón, sosteniendo la carga.
2. Iniciá el movimiento llevando el mentón al pecho, redondeando cervicales.
3. Continuá redondeando la espalda vértebra por vértebra, de forma secuencial.
4. Dejá que la carga te ayude a profundizar en el estiramiento, sin forzar.
5. Bajá hasta tu máximo rango controlado, manteniendo las rodillas extendidas.
6. Subí deshaciendo el movimiento, apilando la columna desde la lumbar hasta la cervical, vértebra por vértebra.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Usar demasiada carga.**
  Corrección: Empezar sin carga o con un peso minimo para priorizar la técnica.
- **Dejarse caer por la gravedad.**
  Corrección: Controlar activamente tanto la bajada como la subida con los músculos.
- **Flexionar las caderas en lugar de la columna.**
  Corrección: Pensar en "despegar" y "apilar" una vértebra a la vez, no en doblarse por la cintura.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hernia discal o dolor lumbar agudo** — Contraindicado.
- **Ciática** — Contraindicado.
- **Principiantes** — No recomendado.
- **Hipermovilidad** — Con mucho control, puede ser beneficioso para fortalecer.

REGRESIÓN
Hacerlo sin carga, solo con el peso del cuerpo.

PROGRESIÓN
Aumentar muy gradualmente la carga o la profundidad del rango.

PARA SU CASA
"Esto es estirar y fortalecer al mismo tiempo. La carga le enseña a tus tejidos a ser resilientes y a generar fuerza incluso cuando están alargados. Es a prueba de balas para tus músculos". Nivel: Avanzado.

MÉTODO: ROTACIONES ARTICULARES

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para absolutamente todos, todos los días. Es el mantenimiento básico para la salud articular, ideal como parte del calentamiento o como una práctica de movilidad independiente.

EL ESTIRAMIENTO: MÉTODO CARS

INTENSIDAD: Baja (control y aislamiento).
TIEMPO: 3-5 rotaciones lentas por dirección.
RESPIRACIÓN: Fluida y constante.
QUÉ SE MANTIENE FIJO: Todo el cuerpo excepto la articulación.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Mover la pelvis o la lumbar para hacer trampa.
Corrección: Reducir el tamaño del círculo hasta aislar el movimiento.

1. Mover la pelvis o la lumbar para hacer trampa.
Corrección: Reducir el tamaño del círculo hasta aislar el movimiento.
2. Hacerlo rápido y con impulso.
Corrección: Moverse al ritmo de una respiración exageradamente lenta.
3. No generar tensión en el resto del cuerpo.
Correceión: Apretar puños y abdomen (irradiación) para estabilizar.

PASO A PASO (CAR de cadera en cuadrupedia)

1. Posición de cuatro apoyos, abdomen firme para estabilizar la columna y la pelvis.
2. Sin mover nada más, levantá una rodilla.
3. Lentamente, dibujá el círculo más grande posible: flexión, abducción, extensión y vuelta al inicio.
4. El movimiento debe ser deliberadamente lento y consciente. 5. Hacé 3-5 círculos en un sentido y luego en el otro. Cambiá de lado.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

En general es seguro para todos.
CON ARTROSIS: Rango libre de dolor.
ADULTO MAYOR: Excelente, con menor rango.
LESIÓN RECIENTE: Consultar al kinesiólogo.

PROGRESIÓN GRAL

CON ARTROSIS: Rango libre de dolor.
ADULTO MAYOR: Excelente, con menor rango.
LESIÓN RECIENTE: Consultar al kinesiólogo.

REGRESIÓN (smaller circles)
PROGRESIÓN (mayor tensión de irradiación)

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA PARA SU CASA: "Esto es como cepillarte los dientes, pero para tus articulaciones. Las nutre, las mantiene sanas y le recuerda a tu cerebro todo el movimiento que tienen disponible".

TENSIÓN ACTIVA DE RANGO FINAL

NIVEL: AVANZADO

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN:

Para practicantes intermedios/avanzados que ya tienen un buen rango pasivo y quieren hacerlo fuerte, seguro y utilizable.
El freno que se trabaja expande el rango de movimiento activo al ensefiarle al sistema nervioso a generar fuerza en posiciones de alargamiento.

EL ESTIRAMIENTO (PRINCIPIOS FRC®):

Isométricos en rango final. Contracción isométrica progresiva, desde 0% hasta 100% de esfuerzo seguro.
TIEMPO: Sostén pasivo (1-2 min) -> Contracción progresiva (10-15s) -> Contracción del antagonista (10-15s). 1-2 ciclos.
RESPIRACIÓN: Controlada, especialmente al aumentar la tensión.
QUÉ SE MANTIENE FIJO: El torso y las extremidades que no trabajan.

PASO A PASO (EJ. 90/90 PARA ROTACIÓN EXTERNA DE CADERA)

1. Entrá en la posición y relajate en el estiramiento pasivo por 1-2 minutos.
2. Inhalá y generá tensión en todo el cuerpo. Empezá a presionar el tobillo y la rodilla de la pierna de adelante contra el suelo, aumentando la fuerza graduaimente del 20% al 40%, 60%, 80% y 100% durante 15s.
3. Después, cambiá la intención: intentá levantar el tobillo y la rodilla del suelo (contrayendo los músculos opuestos) por 15s.
4. Relajá y tratá de profundizar un poco más en el estiramiento pasivo.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Empezar la contraccién de golpe.**
   Corrección: La progresión debe ser lenta y gradual para que el sistema nervioso se adapte.
2. **Sentir un pinzamiente.**
   Correeclón: Retroceder en el rango y trabajar en una posición sin dolor.
3. **No estabilizar el resto del cuerpo.**
   Corrección: Usar las manos en el suelo y activar el core.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

DOLOR AGUDO O PINZAMIENTO ARTICULAR (NO). **HIPERMOVILIDAD** (SÍ, EXCELENTE PARA DAR ESTABILIDAD). **HERNIA** (SÍ, CON MODIFICACIÓN). **RODILLA OPERADA** (NO, CONSULTAR). **EMBARAZO** (SÍ, CON MODIFICACIÓN). **ADULTO MAYOR** (SÍ, CON MODIFICACIÓN). **LESIÓN RECIENTE** (NO, CONSULTAR)

REGRESIÓN: Hacer las contracciones con menos intensidad (ej. hasta un 60%).

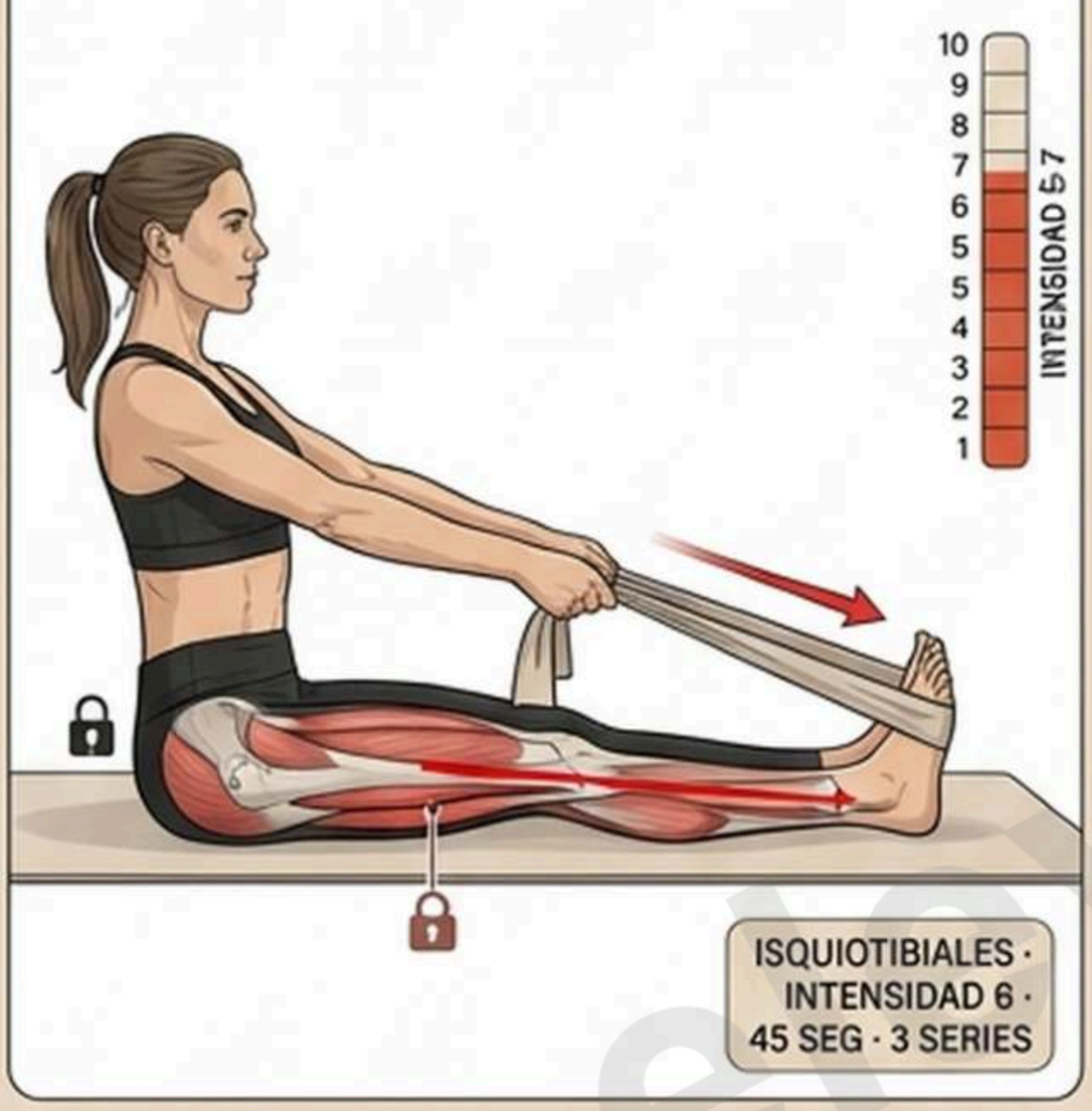
PROGRESIÓN: Aumentar la intensidad o la duración de las contracciones.

PARA SU CASA: "Acá le demostrás a tu cerebro que sos dueño de este rango. Construir fuerza en tus límites es lo que convierte la flexibilidad en movilidad real y a prueba de lesiones".

Herramientas: Estirar con Banda y con Pared

Para quién y en qué situación: Para todos los niveles. Son asistentes perfectos cuando necesitás un punto fijo, un poco de ayuda para mantener la alineación o una fuerza externa suave. NIVEL: BÁSICO / TODOS

LA BANDA (DE TELA, NO ELÁSTICA)



Qué hace: Funciona como una extensión de tus brazos. Te permite alcanzar los pies sin encorvar la espalda, aplicar una tracción suave y constante, y relajar los hombros.

Ejemplo (isquiotibiales): Sentado, pasá la banda por la planta del pie.

Ejemplo (isquiotibiales): Sentado, pasá la banda por la planta del pie. Sostené los extremos y usala para tracionar suavemente el torso hacia adelante, manteniendo la columna larga.

Error común: Tirar de la banda con fuerza para vencer al músculo. La banda guía, no fuerza.

LA PARED

Qué hace: Es tu punto de apoyo más estable. Ideal para el equilibrio, para aplicar una fuerza isométrica (como en un PNF) o para fijar una parte del cuerpo mientras movés otra.

Ejemplo (pectorales): De pie junto a la pared, apoyá la palma y el antebrazo.

Ejemplo (pectorales): De pie junto a la pared, apoyá la palma y el antebrazo. Da un paso adelante y rotá el torso suavemente alejándolo del brazo hasta sentir la tirantez en el pecho.

Error común: Llevar el hombro hacia adelante en una posición de riesgo. Hay que mantener el hombro conectado en su articulación.

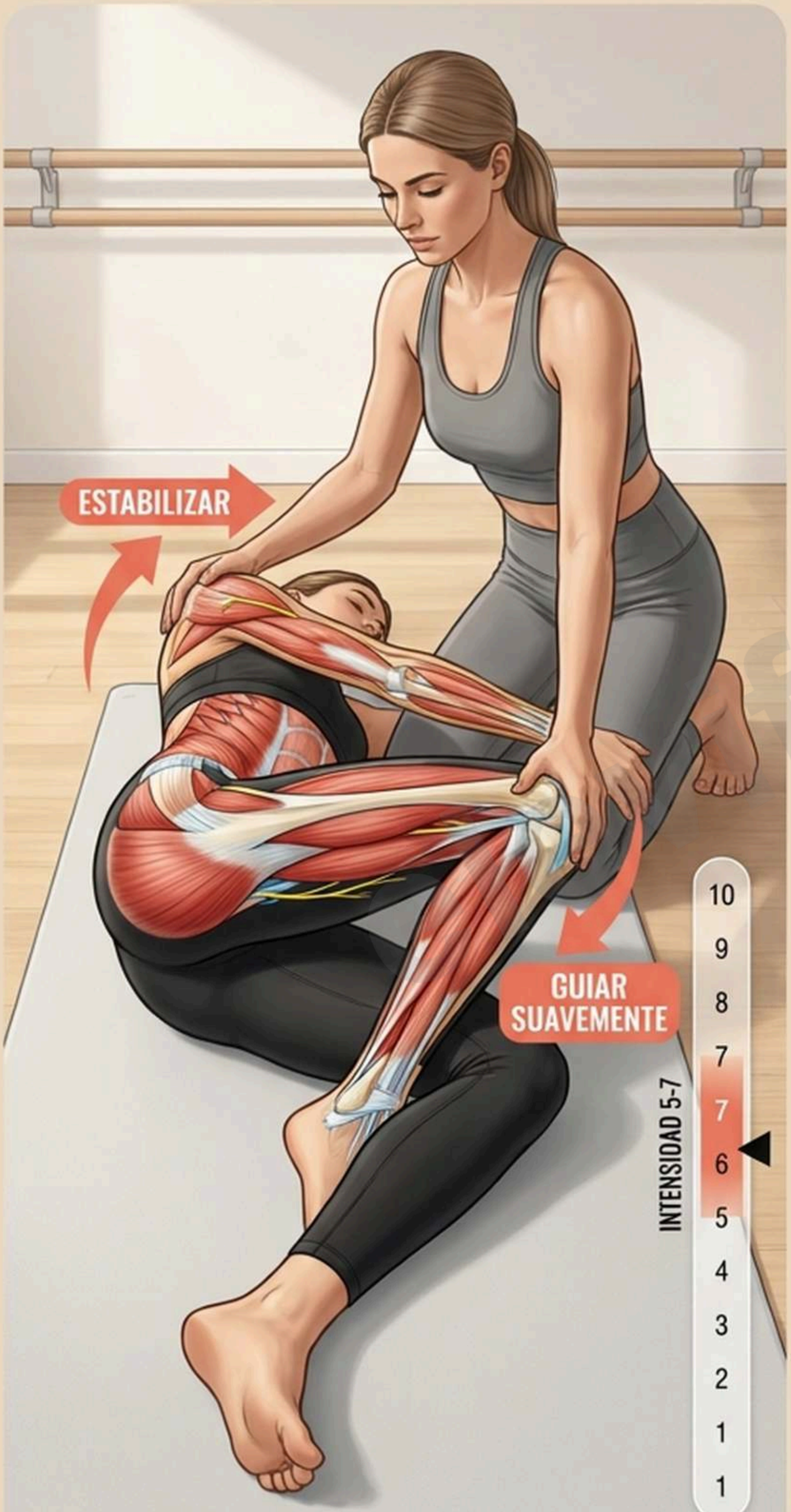
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- [x] Estas herramientas son versátiles y seguras para casi todos, siempre que se usen con el principio de no forzar. Son especialmente útiles para adultos mayores o personas con menos movilidad.
- [ ] Estas herramientas son versátiles y persosas para cotos con menos movilidad.

PARA SU CASA

La pared y la banda son tus profesoras particulares en casa. Te dan feedback instantáneo sobre tu alineación y te permiten sostener los estiramientos de forma relajada, que es donde ocurre la magia.

AJUSTE: CÓMO ASISTIR AL ALUMNO



PARA QUIÉN: Para profesores, entrenadores y formadores del movimiento.

El objetivo del ajuste: No es forzar al alumno a ir "más lejos". Es ofrecer seguridad, darle feedback propioceptivo para que entienda la dirección del estiramiento, y ayudarle a encontrar una posición más eficiente. Un buen ajuste enseña.

PRINCIPIOS CLAVE

1. **Pedí permiso:** Siempre. El contacto físico requiere consentimiento.
2. **Comunicación constante:** Preguntá "¿Cómo se siente esto? ¿Intensidad del 1 al 10?". Creéle a tu alumno.
3. **Estabilizá primero, mové después:** Antes de guiar hacia el estiramiento, asegurate de que la parte que debe quedar fija (ej. la pelvis) esté estable.
4. **Usá tu peso corporal, no tu fuerza muscular:** Posiciónate cerca y de forma estable. Dejá caer tu peso suavemente en lugar de empujar.
5. **Manos seguras y amables:** No presiones sobre articulaciones, nervios o zonas blandas. Usá palmas abiertas sobre grandes masas musculares o reparos óseos.
6. **Andá con la exhalación:** El mejor momento para profundizar es cuando el alumno exhala y se relaja.

QUÉ NO HACER NUNCA

Empujar de forma brusca o con rebotes.

Ignorar las señales de incomodidad.

Aplicar palancas en articulaciones (especialmente rodilla y lumbar).

Ajustar a alguien con una lesión aguda sin ser su kinesiólogo.

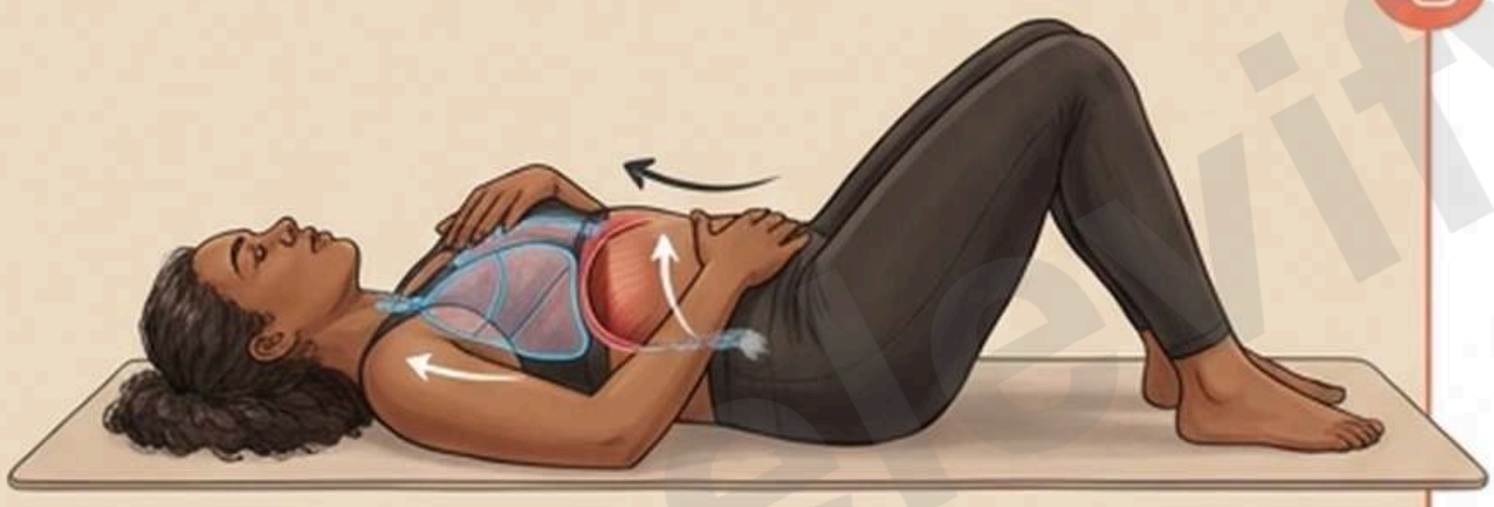
CUE DE LA FORMADORA: "Tu rol es ser un faro que guía, no un tractor que arrastra. El mejor ajuste es el que le da al alumno la confianza y la información para que pueda encontrar el camino por sí mismo la próxima vez".

RESPIRACIÓN Y LIBERACIÓN: CÓMO BAJAR EL TONO ANTES DE ESTIRAR.

Para quién y en qué situación: Para todos, pero especialmente para alumnos que llegan a clase estresados, ansiosos o con una alta tensión muscular general. Es el paso cero de cualquier sesión de flexibilidad.

Por qué es clave: Un sistema nervioso en estado de alerta (simpático) protege al cuerpo manteniendo los músculos tensos. Intentar estirar en ese estado es como acelerar y frenar al mismo tiempo. La respiración diafragmática y los movimientos suaves activan el sistema parasimpático ("descansar y digerir"), enviando una señal de seguridad que permite que los músculos se relajen.

TÉCNICA DE RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA



Paso a paso:

1. Inhalá lento por la nariz, sintiendo cómo el abdomen se expande y empuja tu mano hacia arriba. La mano del pecho se queda quieta.
2. Exhalá lento por la boca, sintiendo cómo el ombligo baja.
3. Hacé la exhalación un poco más larga que la inhalación (ej. inhalar en 4, exhalar en 6).
4. Continuá por 2-5 minutos.

MOVIMIENTOS SUAVES DE LIBERACIÓN

Qué son: Movimientos fluidos y rítmicos que no buscan un estiramiento máximo, sino lubricar articulaciones y relajar la musculatura superficial.

Ejemplo
(Balanceo de rodillas)

Qué le decís a la alumna para su casa: "Antes de pedirle a tu cuerpo que se abra y se suelte, tenés que asegurarte de que se sienta seguro. Estos 5 minutos de respiración y movimiento suave son la forma de decirle: 'tranquilo, estamos en un lugar seguro, podés relajarte'".
Nivel: Básico.

LIBERACIÓN MIOFASCIAL: QUÉ HACE Y QUÉ NO.

Para quién y cuándo: Como preparación antes de estirar para reducir la percepción de tensión en una zona, o después de entrenar para facilitar la recuperación.

QUÉ SÍ HACE

QUÉ NO HACE

QUÉ SÍ HACE (EL MECANISMO REAL)

Es principalmente un efecto neurofisiológico. La presión del rodillo o la pelota sobre la piel y el músculo estimula receptores nerviosos. El sistema nervioso interpreta esta señal y responde reduciendo el tono (la tensión) de esa musculatura. Es un diálogo con el cerebro, no una acción mecánica sobre el tejido. También puede aumentar el flujo sanguíneo local y la hidratación del tejido.

QUÉ NO HACE (LOS MITOS)

No "rompe" adherencias ni tejido cicatricial. La fascia es más resistente que el acero; se necesitaría una fuerza imposible de aplicar con estas herramientas para deformarla permanentemente.

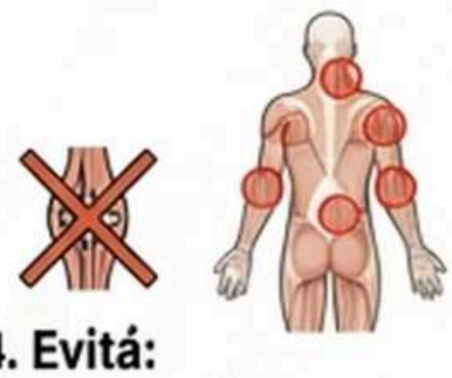
El efecto de "sentirse más suelto" es una reducción del tono muscular, es transitorio y neural.

CÓMO SE USA

1. Lento y consciente: Movete muy despacio.

2. Presión justa: Buscá una intensidad de 6-7/10. Si duele tanto que aguantás la respiración, estás generando el efecto contrario.

3. Pausa en los puntos clave: Al encontrar un punto de mayor tensión, detenete por 20-30 segundos y respirá profundo.



4. Evitá: Estructuras óseas, articulaciones y paquetes neurovasculares (cuello, axila, detrás de la rodilla, zona lumbar).

PARA SU CASA: QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO

"Pensá en el rodillo como una forma de comunicarte con tus músculos a través de tu sistema nervioso. Le estás pidiendo amablemente que baje el volumen de la tensión, no lo estás aplastando para someterlo".

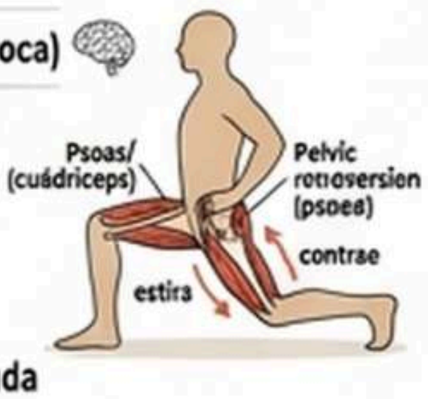
TABLA RESUMEN DE MÉTODOS

ESTÁTICO PASIVO

MÉTODO	Estático Pasivo
FRENO PRINCIPAL	Muscular / Viscoelástico
INTENSIDAD (1-10)	4-7
DURACIÓN / REPS	30-60s sostenido
CUÁNDO USARLO	Vuelta a la calma / Post-entreno
A EVITAR EN...	Hipermovilidad, lesión aguda

ESTÁTICO ACTIVO

MÉTODO	Estático Activo
FRENO PRINCIPAL	Neural (Inhib. Reciproca)
INTENSIDAD (1-10)	6-8 (en contracción)
DURACIÓN / REPS	10-15s sostén x 3-5
CUÁNDO USARLO	Ganar rango activo y control
A EVITAR EN...	Lesión muscular aguda



DINÁMICO CONTROLADO

MÉTODO	Dinámico Controlado
FRENO PRINCIPAL	Rigidez dinámica / SN
INTENSIDAD (1-10)	Baja (foco en control)
DURACIÓN / REPS	8-12 reps
CUÁNDO USARLO	Calentamiento / Preparación
A EVITAR EN...	Lesión aguda, dolor articular

BALÍSTICO

MÉTODO	Balístico
FRENO PRINCIPAL	Reflejo miotático (riesgo)
INTENSIDAD (1-10)	Muy Alta (explosiva)
DURACIÓN / REPS	Especifico del deporte
CUÁNDO USARLO	Solo atletas avanzados para su gesto deportivo
A EVITAR EN...	¡Casi todos los casos!

PNF (CONTRAER-RELAJAR)

MÉTODO	PNF (Contraer-Relajar)
FRENO PRINCIPAL	Neural (Inhib. Autógena)
INTENSIDAD (1-10)	5-7 (contracción)
DURACIÓN / REPS	Ciclo 15-6-30s x 2-3
CUÁNDO USARLO	Ganar rango pasivo rápido
A EVITAR EN...	Lesión aguda, hipermovilidad

PNF (TÉCNICA COMPLETA)

MÉTODO	PNF (Técnica Completa)
FRENO PRINCIPAL	Neural (Doble mecanismo)
INTENSIDAD (1-10)	5-8 (contracciones)
DURACIÓN / REPS	Ciclo completo x 2-3
CUÁNDO USARLO	Ganar rango activo y pasivo
A EVITAR EN...	Lesión aguda

CON CARGA (LOADED)

MÉTODO	Con Carga (Loaded)
FRENO PRINCIPAL	Tejido Conectivo
INTENSIDAD (1-10)	Baja-Mod (carga)
DURACIÓN / REPS	5-8 reps lentas
CUÁNDO USARLO	Fortalecer en rango final
A EVITAR EN...	Hernia discal, ciática aguda

CARs (ROTACIONES ART.)

MÉTODO	CARs (Rotaciones Art.)
FRENO PRINCIPAL	Capsular / Control Motor
INTENSIDAD (1-10)	Baja (foco en control)
DURACIÓN / REPS	3-5 reps lentas
CUÁNDO USARLO	Mantenimiento diario / Calentamiento
A EVITAR EN...	Dolor articular agudo (reducir rango)

ANATOMÍA APLICADA A LA FLEXIBILIDAD

CADERA: EL CENTRO DE TODO

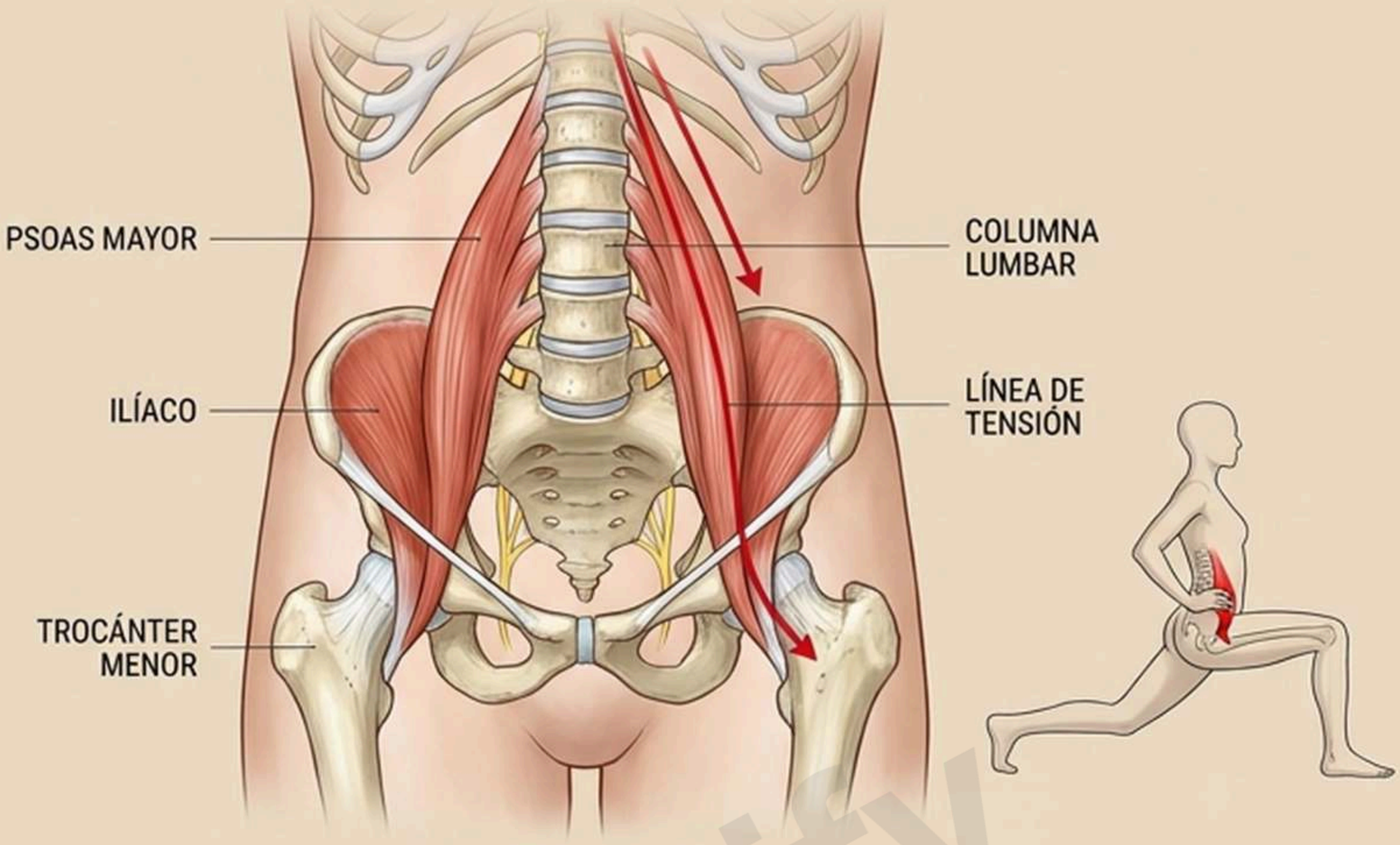
QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vamos a desarmar la complejidad de la cadera. Vas a aprender a identificar los principales músculos que limitan su movimiento, a diferenciar la tensión muscular de un freno articular y a aplicar los estiramientos más efectivos y seguros para vos y tus alumnos, respetando la anatomía de cada uno.

ANATOMÍA CLAVE

TÉCNICAS SEGURAS

PSOAS ILÍACO: EL FLEXOR PROFUNDO



DÓNDE ESTÁ

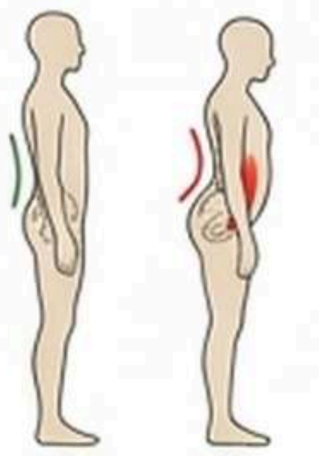
Es el único músculo que conecta la columna vertebral con las piernas. Se extiende desde las vértebras lumbares y la cara interna de la pelvis hasta la parte alta y de adentro del fémur.

QUÉ HACE

Su función principal es flexionar la cadera (acercar el muslo al torso), siendo fundamental para caminar, correr y subir escaleras. También participa en la rotación externa del fémur.

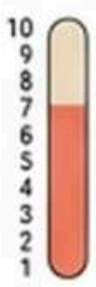
QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Limita la extensión de la cadera, es decir, la capacidad de llevar la pierna hacia atrás. Por eso, un psoas corto suele tirar de las lumbares hacia adelante, provocando una anteversión pélvica y aumentando la curva lumbar.



CÓMO SE ESTIRA

Se estira llevando la cadera a extensión, como en una zancada baja. La clave es fijar la pelvis en retroversión (llevando el pubis hacia el ombligo y contrayendo el glúteo de la pierna de atrás) para que el estiramiento ocurra realmente en la cadera y no compensando con el arco lumbar. La sensación debe ser de una tirantez profunda y sostenida en la ingle y la parte frontal del muslo, nunca un pinzamiento o dolor en la cintura.



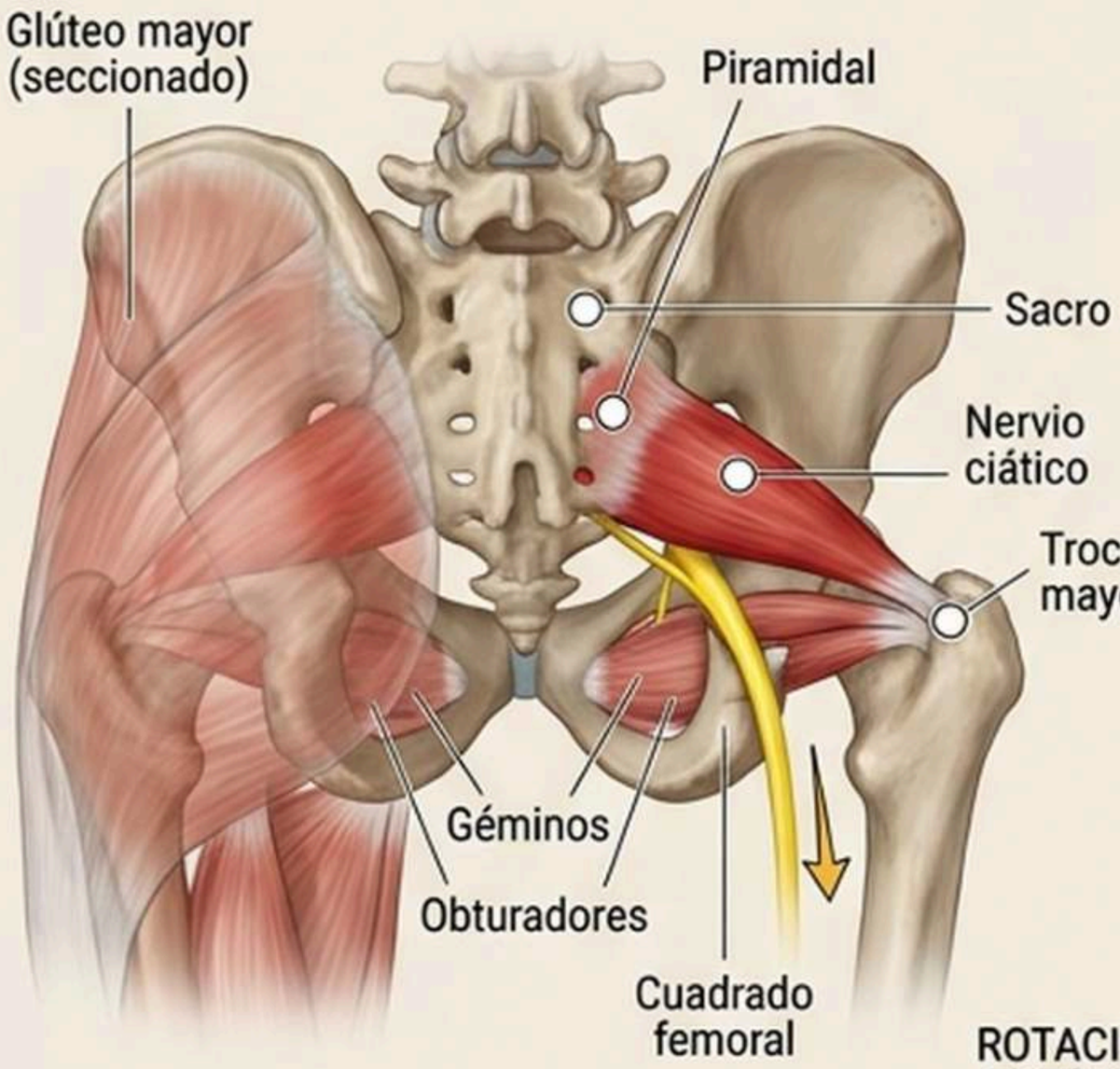
INTENSIDAD **5-7**

PSOAS ILÍACO · INTENSIDAD 6
45 SEG · 3 SERIES

CUE DE LA FORMADORA

Para aislarlo y asegurar la posición correcta, decile a tu alumna: **"Imaginá que tus dos huesos de la cadera son faros que apuntan siempre hacia adelante"**. Esto ayuda a mantener la pelvis alineada y evita la rotación.

GLÚTEOS Y ROTADORES PROFUNDOS



DÓNDE ESTÁ

El piramidal va desde la cara anterior del sacro hasta el trocánter mayor del fémur. Está cubierto por el glúteo mayor y cruza sobre el nervio ciático.

QUÉ HACE

Rota la pierna hacia afuera (rotación externa) y ayuda a la abducción (separar la pierna) cuando la cadera está flexionada.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Limita la rotación interna y la flexión de cadera con aducción, un movimiento clave para la salud de la articulación. Su contractura puede comprimir al nervio ciático, causando ciatalgia.

CÓMO SE ESTIRA

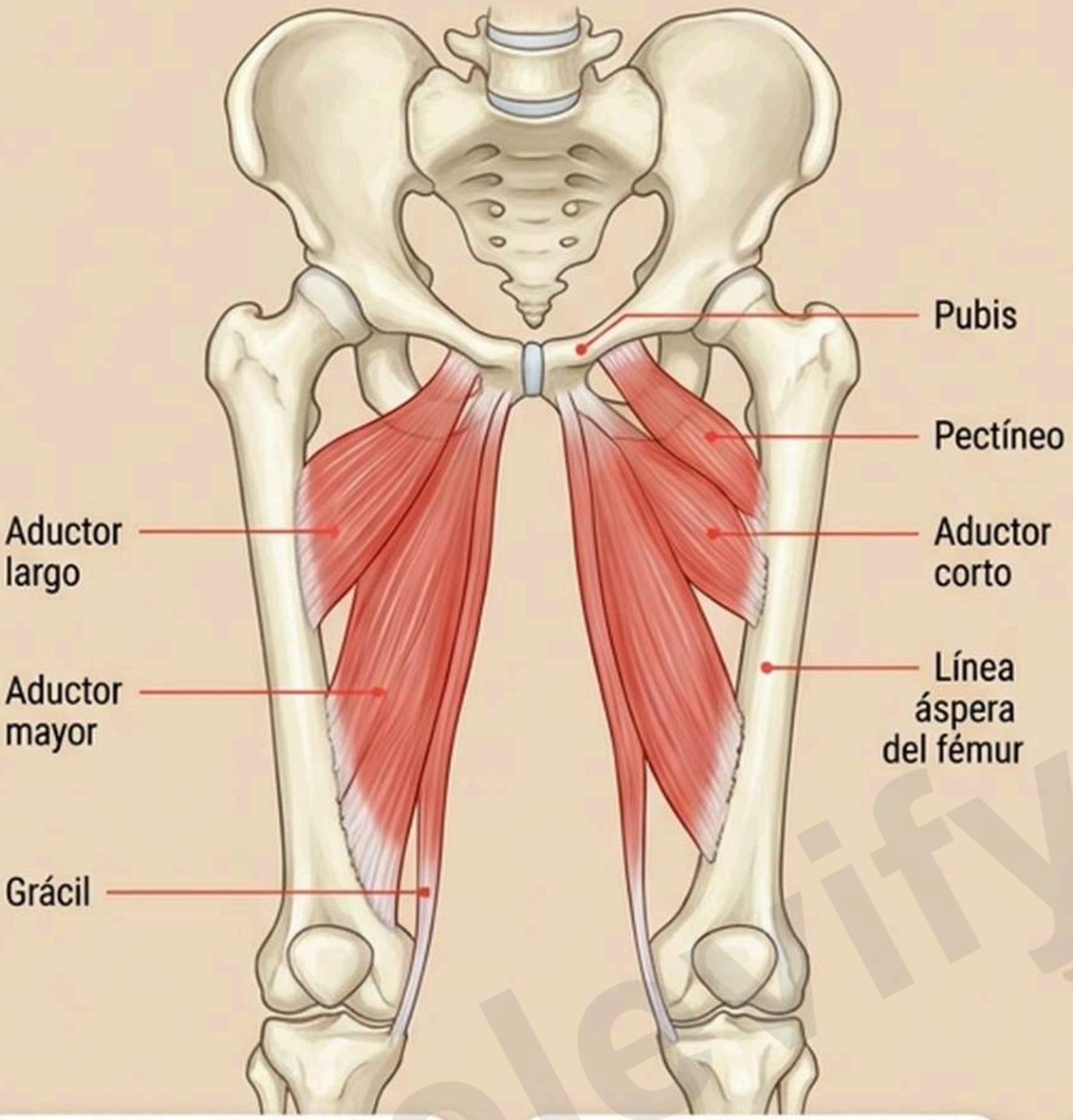
En posturas como la Paloma o el "cuatro", donde se combina flexión, abducción y rotación externa. Lo fundamental es mantener la pelvis estable y cuadrada, sin dejar que caiga hacia un lado, y proteger la rodilla evitando cualquier torsión. La sensación es de una apertura profunda en la nalga.

INTENSIDAD 6 · 45 SEG · 3 SERIES

CUE DE LA FORMADORA

Alargá desde el sacro hasta el talón de atrás para mantener el espacio en tu lumbar y profundizar el estiramiento en el glúteo sin forzar la rodilla.

ADUCTORES: LOS CINCO INTERNOS



Rana

DÓNDE ESTÁ

Forman un abanico en la cara interna del muslo, desde el hueso púbico hasta el fémur (y la tibia, en el caso del grácil).

QUÉ HACE

Su función principal es la aducción, es decir, juntar las piernas. También asisten en la flexión y rotación.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

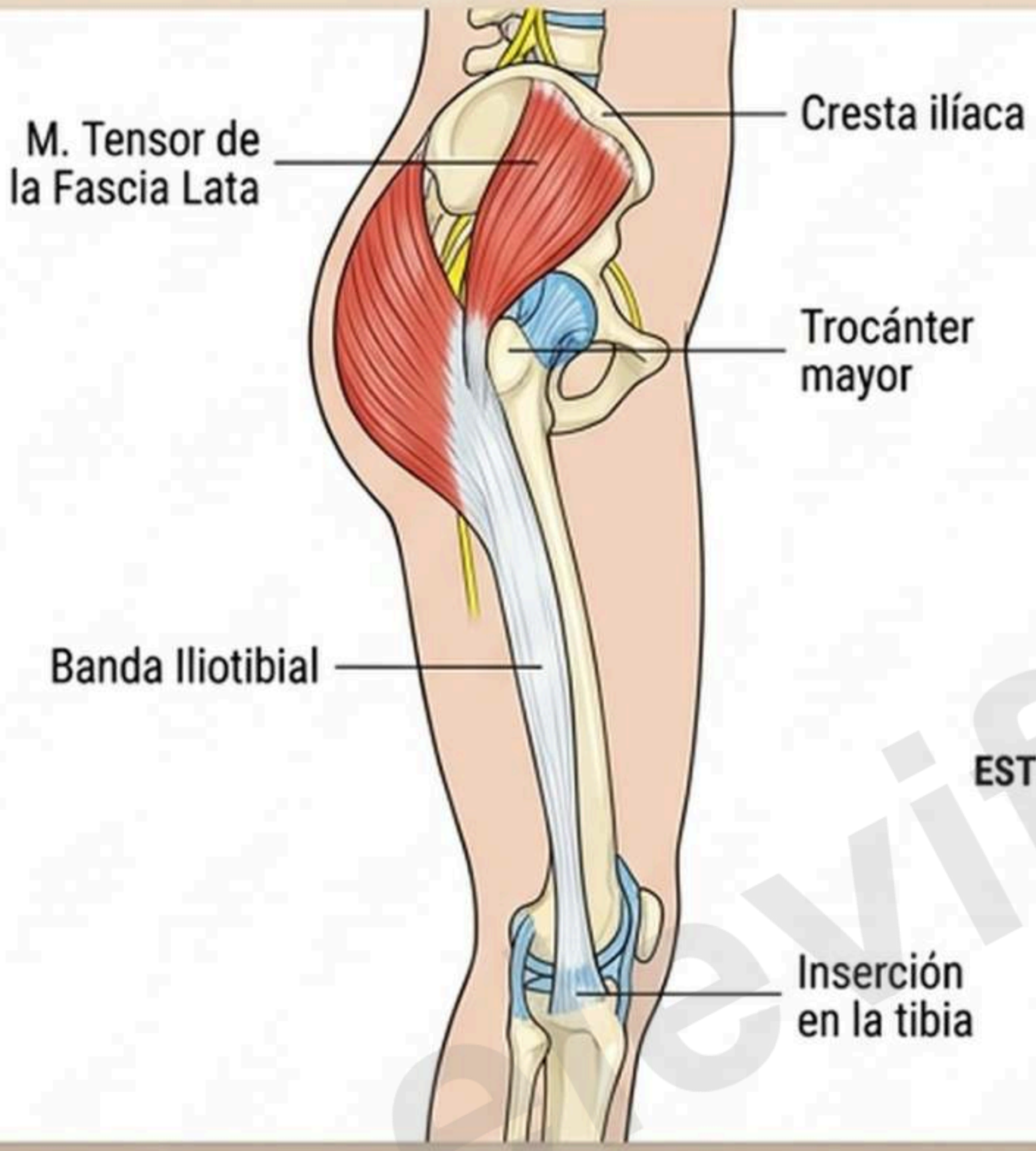
La abducción o apertura de piernas. Un acortamiento severo limita posturas como la "mariposa" o la "rana".

CÓMO SE ESTIRA

Se estiran en todas las posturas de apertura lateral. Para hacerlo de forma segura, es vital iniciar el movimiento desde la peivis, con una suave anteversión, y mantener las rodillas alineadas y sin dolor. La intensidad debe ser progresiva, porque son músculos que tienden a defenderse con una contracción refleja (reflejo miotático) si se los fuerza.

CUE DE LA FORMADORA: "En vez de empujar las rodillas hacia abajo, pensá en alejar un muslo del otro desde la cadera".

LÁMINA ANATÓMICA: TENSOR DE LA FASCIA LATA Y BANDA ILIOTIBIAL



DÓNDE ESTÁ

El TFL es un músculo chico en la parte de adelante y afuera de la cadera. Se continúa con la banda iliotibial, una cinta fibrosa que recorre todo el lateral del muslo.

QUÉ HACE

El TFL ayuda a flexionar, abducir y rotar internamente la cadera. La banda iliotibial estabiliza la cadera y la rodilla al caminar o correr.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

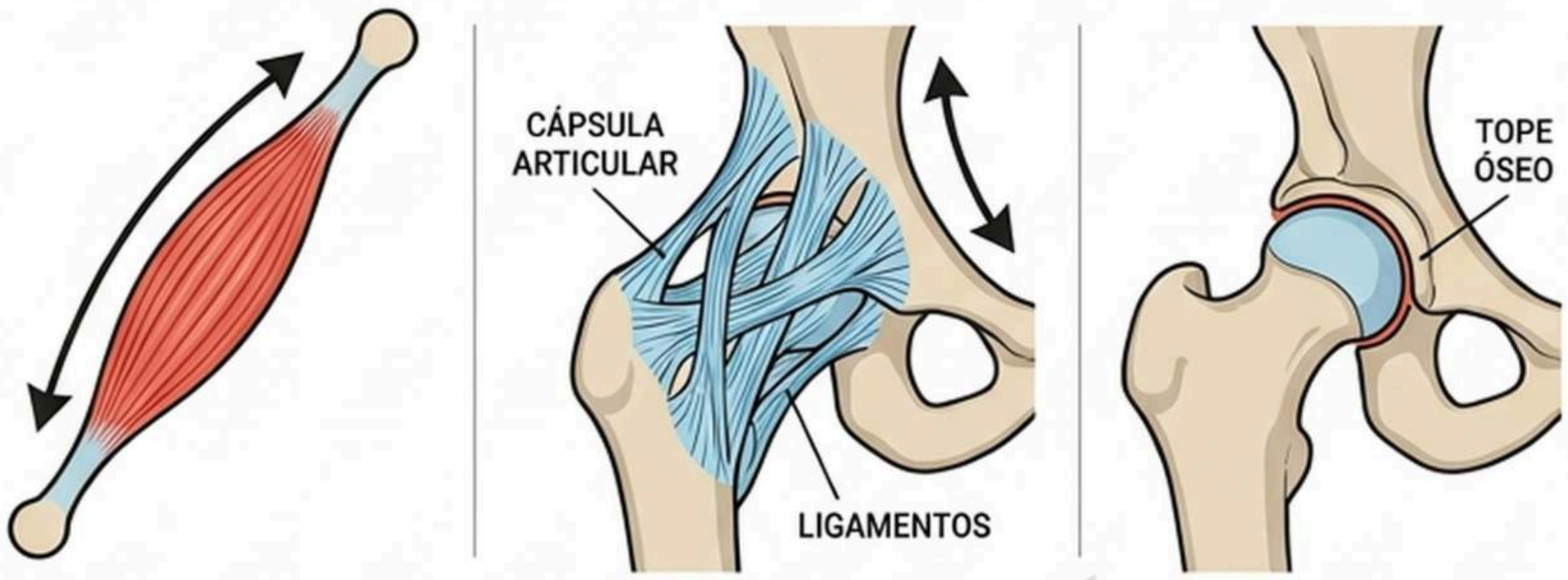
Limita la aducción (cruzar la pierna por detrás) y la extensión de la cadera. Su tensión puede generar molestias en la cadera o en la cara externa de la rodilla.

CÓMO SE ESTIRA

Se estira de forma indirecta, porque la banda iliotibial es tejido conectivo muy denso y poco elástico. El objetivo es relajar el músculo TFL con posturas que combinen extensión y aducción de cadera, como cruzar una pierna por detrás y llevar esa misma cadera hacia afuera. Se debe sentir en la parte alta y lateral de la cadera, no en la rodilla.

CUE DE LA FORMADORA: "Empujá con tu cadera hacia la pared de al lado como si quisieras tocarla".

LA CÁPSULA articular



EL FRENO PROFUNDO

No todo lo que frena en una articulación es un músculo. **La cadera está envuelta en una cápsula articular, un tejido conectivo muy resistente reforzado por ligamentos.** Su función es dar estabilidad y contener el líquido sinovial.

A diferencia de un músculo, la cápsula tiene muy poca elasticidad. Cuando en un movimiento sentís un tope duro, seco y definitivo, es probable que hayas llegado a tu límite capsular u óseo. Forzarlo no va a dra rango, pero sí puede generar inestabilidad o una lesión.

Por eso es clave aprender a diferenciar la sensación de tirantez muscular (que cede) de un freno estructural (que no cede).

EN LA SALA

El alumno que se cuelga de sus ligamentos en una postura de apertura y siente un pinzamiento en la ingle en lugar de un estiramiento muscular.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

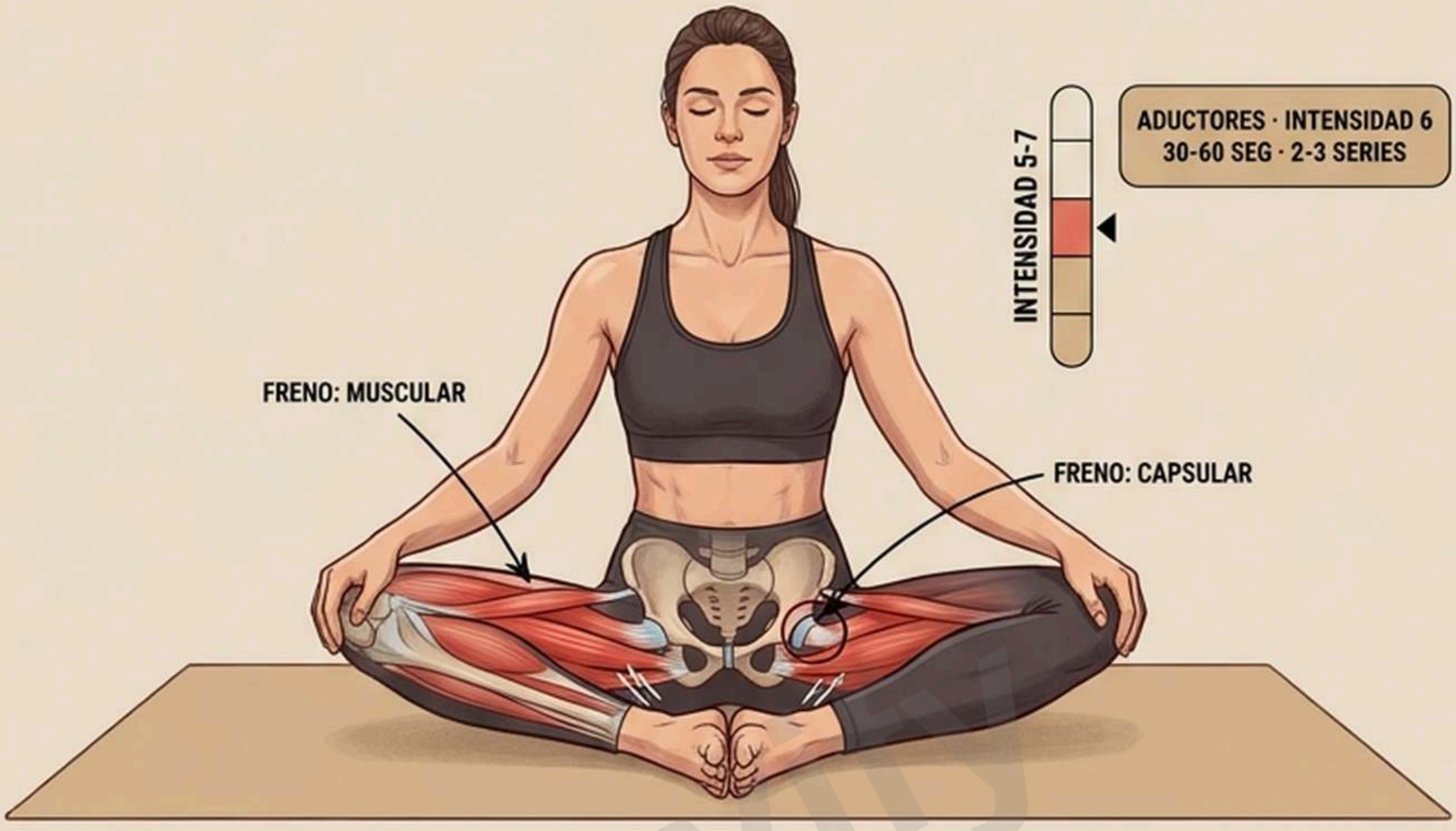
QUÉ SÍ

Movilidad articular suave y controlada para nutrir la cápsula.

QUÉ NO

Forzar el rango con rebotes o cargas externas cuando se siente un tope duro.

APERTURA DE CADERA EN MARIPOSA



PARA QUIÉN

Alumnos principiantes que necesitan ganar flexibilidad en aductores y rotadores externos de forma segura. Ideal al inicio de la práctica para evaluar la movilidad.

PASO A PASO

1. Sentate, si es necesario sobre un almohadón.
2. Juntá las plantas de los pies cómodamente.
3. Tomá tus pies y alargá la columna.
4. Inhalá, y al exhalar, permiti que tus rodillas desciendan sin empujar. Sostener 30 seg.
5. Si hay comodidad, inclinar el torso desde la cadera. Sostener 30 seg.

EL ESTIRAMIENTO

- **Método**: Estático Pasivo.
- **Intensidad**: 4-6/10.
- **Tiempo**: 30-60 seg, 2-3 series.
- **Respiración**: Alargá la columna al inhalar, relajá las ingles al exhalar.
- **Qué se mantiene fijo**: La pelvis (evitar retroversión).

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA ✕

1. **Encorvar la espalda**: Alargar la columna y llevar el ombligo hacia los pies.
2. **Empujar las rodillas**: El movimiento nace de la relajación.
3. **Aguantar la respiración**: Guiar una respiración fluida.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ **Hipermovilidad**: Sí, enfocar en activación final.
✓ **Hernia lumbar**: Sí, espalda erguida sobre soporte.
✕ **Rodilla operada**: Con precaución, evitar dolor.
✕ **Embarazo**: Sí, sin forzar inclinación.

REGRESIÓN: Sentarse sobre bloques, alejar los pies.
PROGRESIÓN: Acercar los pies, inclinar el torso.
PARA SU CASA: Hacelo un par de minutos al día sentado, dejando que la gravedad actúe.

NIVEL: Principiante.

120px

CAP 5 · CADERA: EL CENTRO DE TODO

ESTIRAMIENTO DE PSOAS EN ZANCADA

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Fundamental para personas que pasan mucho tiempo sentadas y para deportistas (corredores, ciclistas) con flexores de cadera acortados.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático Activo **Intensidad:** 6-7/10 **Tiempo:** 30-45 seg
Respiración: Exhalar al iniciar **Fijo:** Torso erguido, abdomen activo

PASO A PASO

1. Colocá las manos en la cadera.
2. Inhalá. Al exhalar, realizá una retroversión pélvica.
3. Mantené y desplazá el peso adelante lentamente (5 seg).
4. Detenete al sentir tirantez clara (Sostener 30 seg).
5. Respirá sin quebrar la cintura.
6. Volvé lentamente a la posición inicial.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Arquear la zona lumbar. **CORRECCIÓN:** Retroversión pélvica.
2. Dejar caer la pelvis. **CORRECCIÓN:** Huesos ilíacos al frente.
3. Poner tensión en los hombros. **CORRECCIÓN:** Relajar hombros y mandibula.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hipermovilidad:** Sí, con control.
- **Hernia lumbar:** Sí, abdomen activo.
- **Rodilla operada:** Sí, con acolchado.
- **Embarazo:** Sí, con apoyo.

PARA SU CASA: "No se trata de qué tan lejos vas, sino de cuánto podés aislar el estiramiento justo en la parte de adelante de tu cadera. El secreto está en mover la pelvis, no la cintura".

80px

PALOMA: GLÚTEO Y PIRAMIDAL

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para practicantes intermedios que buscan un estiramiento profundo del glúteo y los rotadores externos. Muy útil para aliviar la tensión asociada al nervio ciático por contractura del piramidal.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático Pasivo. **INTENSIDAD:** 7-8/10. **TIEMPO:** Sostener de 45 a 90 segundos por lado.
RESPIRACIÓN: Profunda y relajada, usando la exhalación para soltar la tensión en la nalga.
MANTENER FIJO: La pelvis nivelada, sin caerse hacia el lado de la pierna flexionada.

PASO A PASO

1. Desde cuatro apoyos, deslizá la rodilla derecha hacia la muñeca derecha.

2. El tobillo derecho se ubica por delante de la cadera izquierda. No es necesario que la tibia quede paralela al mat; ajustalo a tu rango.

3. Extendé la pierna izquierda recta hacia atrás, con el empeine apoyado.

4. Chequeá que tu cadera esté cuadrada. Si hay un hueco grande bajo el glúteo derecho, rellenalo con un bloque o manta.

5. Mantené el torso erguido para un estiramiento más suave, o inclinate hacia adelante sobre la pierna para intensificar. (Sostener 45-90 seg).

6. Respirá profundo, dirigiendo el aire hacia la zona de tensión.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Dejar caer la cadera:** El alumno se sienta sobre la nalga de la pierna flexionada, perdiendo la alineación. **CORRECCIÓN:** Usar un soporte bajo la cadera para mantenerla elevada.
2. **Forzar la rodilla:** Se siente dolor en la rodilla de adelante. **CORRECCIÓN:** Flexionar más la rodilla, acercando el pie a la ingle. Si persiste, cambiar de ejercicio.
3. **Tensionar los hombros y el cuello:** El esfuerzo se acumula arriba. **CORRECCIÓN:** Apoyar la frente en las manos o en un bloque al inclinarse.

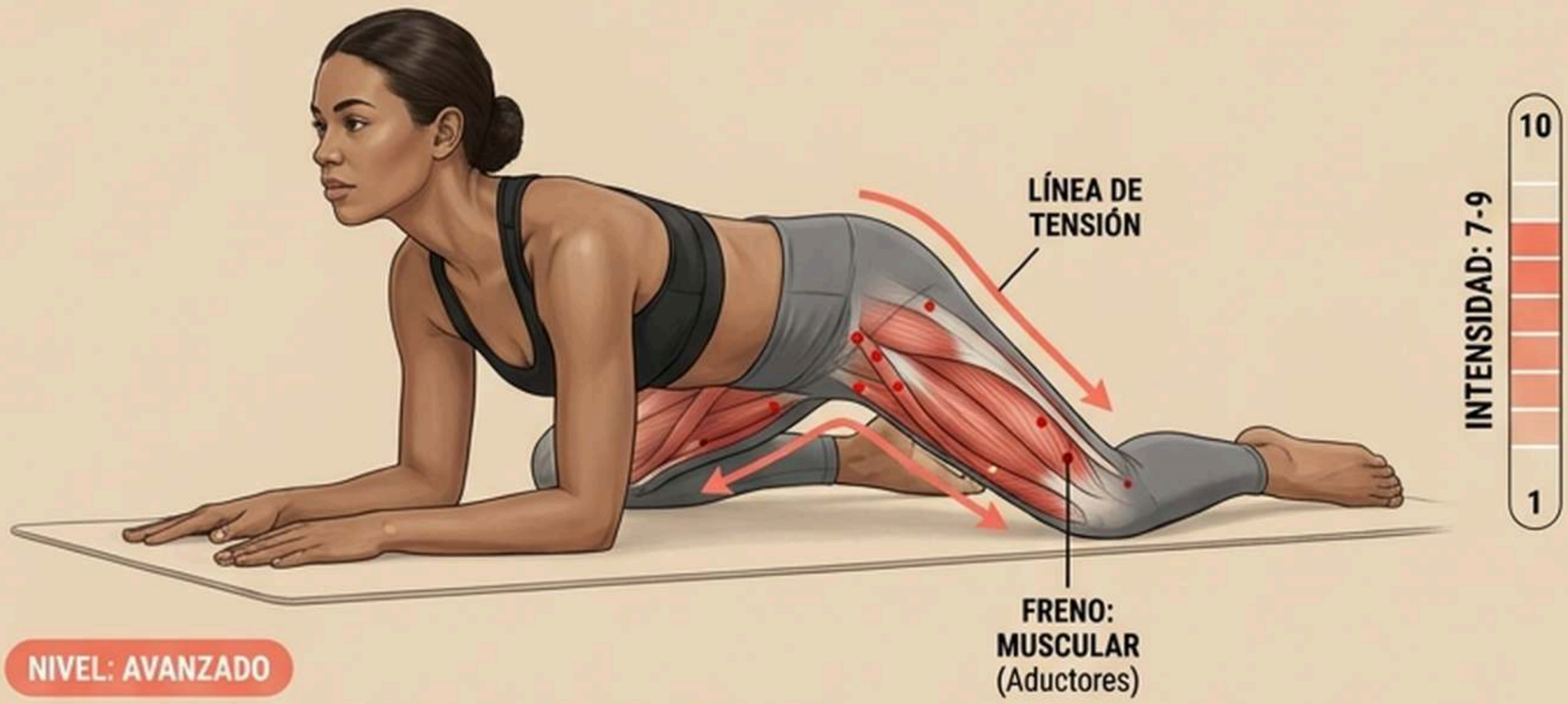
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** Sí, con leve activación muscular.
- ✓ **Hernia lumbar:** Sí, con torso erguido, evitar flexión profunda.
- ✗ **Rodilla operada/sensible:** Con extrema precaución o evitar.
- ✗ **Embarazo:** Sí, en etapas tempranas con torso erguido.

> **PARA SU CASA:** "La clave no es qué tan adelante ponés el pie, sino mantener tus caderas niveladas. Usá todos los soportes que necesites".

REGRESIÓN: El 'cuatro' acostado **PROGRESIÓN:** Inclinar el torso completamente **NIVEL:** Intermedio

RANA: ADUCTORES EN EL PISO



NIVEL: AVANZADO

RANA: ADUCTORES EN EL PISO

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para practicantes de nivel intermedio a avanzado que buscan una apertura intensa de aductores. Requiere paciencia y control. Muy común en danza, artes marciales y gimnasia.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático Pasivo.
INTENSIDAD: 7-9/10 (manejable).
TIEMPO: 60-120 seg.
RESPIRACIÓN: Muy lenta y controlada, exhalando largo para relajar.
MANTENER FIJO: Ángulos de 90 grados en caderas y rodillas.

PASO A PASO

1. Colocá una manta o doblá el mat para acolchar las rodillas.
2. Desde cuatro apoyos, deslizá las rodillas hacia los lados hasta sentir un estiramiento claro en las ingles.
3. Apoyá los antebrazos en el suelo, espalda neutra.
4. Verificá caderas en línea con rodillas (no adelante ni atrás).
5. Mantené tobillos flexionados (dorsiflexión) para proteger rodillas. (Sostener 60-120 seg).
6. Respirá muy profundo, sentí cómo cede la tensión al exhalar, sin forzar. Para salir, llevá el peso adelante y juntá piernas lentamente.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Arquear la espalda baja:**
   La alumna saca cola y quiebra la cintura.
   CORRECCIÓN: Activar suavemente el abdomen para pelvis neutra.

2. **Dejar que los tobillos colapsen:**
   Los pies se juntan y se pierde alineación.
   CORRECCIÓN: Insistir en dorsiflexión y línea rodilla-tobillo.

3. **Salir de la postura demasiado rápido:**
   Puede causar contractura.
   CORRECCIÓN: Guiar salida extremadamente lenta y controlada.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad: Con mucho cuidado, no buscar máximo rango.
Hernia lumbar: Evitar o hacer versión muy suave.
Rodilla operada: Generalmente no se recomienda, consultar kinesiólogo.
Embarazo: No se recomienda por intensidad y presión pélvica.

REGRESIÓN: Hacerlo con menos apertura o colocar almohadones bajo el pecho y la pelvis.

PROGRESIÓN: Llevar las caderas un poco más hacia atrás, profundizando la apertura.

PARA SU CASA: "Esta es una postura muy intensa. Entrá y salí con más lentitud de la que creés necesaria. Tu cuerpo te lo va a agradecer".

ROTACIÓN INTERNA DE CADERA SENTADO

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para cualquier persona, especialmente aquellas con mucho trabajo de rotación externa (yoga, danza) que necesitan reequilibrar la articulación. Es un movimiento a menudo olvidado.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Movilidad Articular Dinámica o Estático Pasivo.
Intensidad: 3-5/10.
Tiempo: 8-12 repeticiones dinámicas por lado, o sostener 20-30 segundos en estático.
Respiración: Exhalar al bajar la rodilla.
Qué se mantiene fijo: Ambos isquiones (huesos de la cola) apoyados en el suelo.

PASO A PASO

1. En la posición de partida, alargá la columna.
2. Inhalá y, al exhalar, dejá caer lentamente una rodilla hacia el centro, en dirección al pie opuesto. (Movimiento dinámico, 8-12 reps).
3. Bajá solo hasta donde puedas mantener el isquion de esa misma pierna apoyado en el suelo. El movimiento es pequefio.
4. Inhalá para volver al centro y exhalá para repetir con la otra pierna.
5. Para la versión estática: bajá la rodilla hasta tu límite y sostené la posición por 20-30 segundos, respirando con calma.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- ✗ **Levantar el glúteo del suelo:** El alumno quiere bajar más la rodilla y para eso levanta la cadera, perdiendo el trabajo de rotación interna.
  CORRECCIÓN: Indicar que el glúteo debe permanecer "pegado" al piso. "El movimiento es en la cadera, no en la pelvis".
- ✗ **Mover el torso:** El cuerpo se tuerce para compensar la falta de rango.
  CORRECCIÓN: Mantener el pecho apuntando hacia adelante.
- ✗ **Forzar el movimiento:** Se intenta ir más allá del tope articular.
  CORRECCIÓN: Recordar que este movimiento suele tener menos rango que la rotación externa y que eso es normal.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** Sí, es excelente para el control motor. Hacerlo de forma lenta y consciente.
- ✓ **Hernia lumbar:** Sí, la versión sentada es segura y estable.
- ✓ **Rodilla operada:** Con precaución. Si hay alguna molestia en la rodilla.
- ✗ **Rodilla operada:** Con precaución. Si hay alguna molestia en la rodilla, reducir el rango.
- ⚠ **Embarazo:** Si, es una movilidad suave y segura.
- ✓ **Adulto mayor:** Sí, es ideal, pueden hacerlo sentados en una silla.

REGRESIÓN: Hacerlo con menos rango de movimiento. Sentarse en una silla y hacer el mismo gesto.

PROGRESIÓN: Quitar el apoyo de las manos atrás, manteniendo el torso erguido solo con el control del abdomen.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA: "Este movimiento es como limpiar el aceite de la articulación. Hacelo suave, varias veces por semana, para mantener tu cadera sana y equilibrada".

NIVEL: Principiante

90/90: ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para practicantes intermedios que quieren trabajar la rotación interna y externa de la cadera de forma simultánea y activa. Excelente para evaluar asimetrias. **POSICIÓN DE PARTIDA:** Sentada en el suelo con las piernas formando dos ángulos de 90 grados. La pierna de adelante en rotación externa (como en la Paloma) y la de atrás en rotación interna.
ZONA Y MÚSCULOS QUE SE ESTIRAN: Pierna adelantada: rotadores externos (piramidal, glúteo). **Pierna atrasada**: rotadores externos (en estiramiento excéntrico) y cápsula. **FRENO QUE SE TRABAJA**: Muscular y capsular en ambas caderas.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Movilidad Activa o Estático. **Intensidad**: 5-7/10.
Tiempo: Sostener 30-60 segundos por lado, o 5-8 transiciones dinámicas. **Respiración**: Fluida. Exhalar al inclinar el torso o en la transición. **Qué se mantiene fijo:** La posición de 90/90 en las piernas.

PASO A PASO

1. **Sentate y armá la posición**: muslo derecho adelante, paralelo al borde del mat; tibia derecha perpendicular. Muslo izquierdo al costado, en linea con la cadera; tibia Izquierda perpendicular.
2. **Apoyá las manos a los lados para estabilizar**. Intentá que ambos isquiones estén lo más cerca del suelo posible.
3. **Para estirar la cadera de adelante (rot. externa)**: incliná el torso sobre la tibia derecha. (Sostener 30 seg).
4. **Para estirar la cadera de atrás (rot. interna)**: girá el torsc hacia esa pierna y tratá de mantener la rodilla en el suelo. (Sostener 30 seg).
5. **Transición dinámica**: sin usar las manos, levantá las rodillas y cambialas de lado, manteniendo los pies en el mismo lugar. (5-8 reps).

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Dejarse caer sobre la cadera de adelante:** El alumno no mantiene la cadera de atrás activa y apoyada.
   CORRECCIÓN: Pedir que presione activamente la rodilla y el pie de atrás contra el suelo. Usar un bloque bajo la cadera de adelante si es necesario.
2. **Levantar la rodilla de atrás al girar:** Se pierde el trabajo de rotación interna.
3. **Encorvar la espalda al inclinarse:** El movimiento deja de ocurrir en la cadera.
   CORRECCIÓN: 'Alargá la columna antes de bajar, como si quisieras llevar el pecho lejos, hacia adelante'.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

· **Hipermovilidad**: Sí, con mucho control y sin buscar rangos extremos. La transición activa es excelente.
· **Hernia lumbar**: Sí, pero sin inclinaciones frontales profundas; mantener el torso erguido.
· **Rodilla operada**: Con mucha precaución, especialmente en la pierna en rotación interna. Si duele, no hacerlo.
· **Embarazo**: Sí, la posición estática con el torso erguido, pero evitar las transiciones dinámicas en etapas avanzadas.

REGRESIÓN

Colocar bloques bajo las manos para tener más altura y control. Reducir el rango de movimiento.

PROGRESIÓN

Realizar las transiciones sin usar las manos. Desde la posición, levantar el torso y alinearlo con la tibia de atrás (más dificil).

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA

'Este ejercicio te muestra la verdad sobre tus caderas. Es normal que un lado se sienta muy diferente al otro. Sé paciente y trabajá ambos por igual'.

CADERA HIPERMÓVIL: ESTABILIZAR

Activación isométrica para construir el "freno muscular" en rangos profundos.
No se busca más estiramiento, se busca control y fuerza donde ya llegás.

ZANCADA BAJA (ACTIVACIÓN) · INTENSIDAD 5-7 · SOSTENER 5-10 SEG · 5-8 REPETICIONES

PARA QUIÉN Y QUÉ SE BUSCA: EL FOCO ES EL CONTROL

Ideal para alumnos con hipermovilidad articular que sienten que "no tienen tope" o inestabilidad en estiramientos profundos. El objetivo es enseñar a la musculatura estabilizadora a trabajar en el rango final para proteger la cápsula.

EL EJERCICIO: MÉTODO ISOMÉTRICO

Método: Activación en rango final (isométricos).
Intensidad: Contracción muscular del 30-50% del máximo.
Tiempo: Sostener 5-10 seg, 5-8 repeticiones por lado.
Respiración: Exhalar al contraer.

PASO A PASO (EN ZANCADA BAJA)

1. **Armá una** zancada baja cómoda, lejos de tu máximo.
2. **Co-activá los músculos:** Pensá en "juntar" la pierna de adelante y la de atrás como si cerraras una tijera (aductores). Sostener 5 seg.
3. **Contraé el glúteo de la pierna de atrás** con fuerza, empujando el suelo hacia adelante. Sostener 5 seg.
4. **Relajá y repetí.** El objetivo no es ganar rango, sino sentir fuerza en la posición.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Ir al rango másimo y "colgarse" pasivamente. Corrección:** Educar, el objetivo no es ir más lejos, sino ser fuerte.
- **Rebotar en la postura sin control. Corrección:** Pedir movimientos lentos y deliberados.
- **Estirar sin activar previamente. Corrección:** Siempre empezar con activación de glúteos y core.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **SÍ:** Activación isométrica en rangos amplios, trabajo de fuerza.
- **NO:** Estiramientos pasivos sostenidos, rebotes.

REGRESIÓN, PROGRESIÓN Y CONSEJO

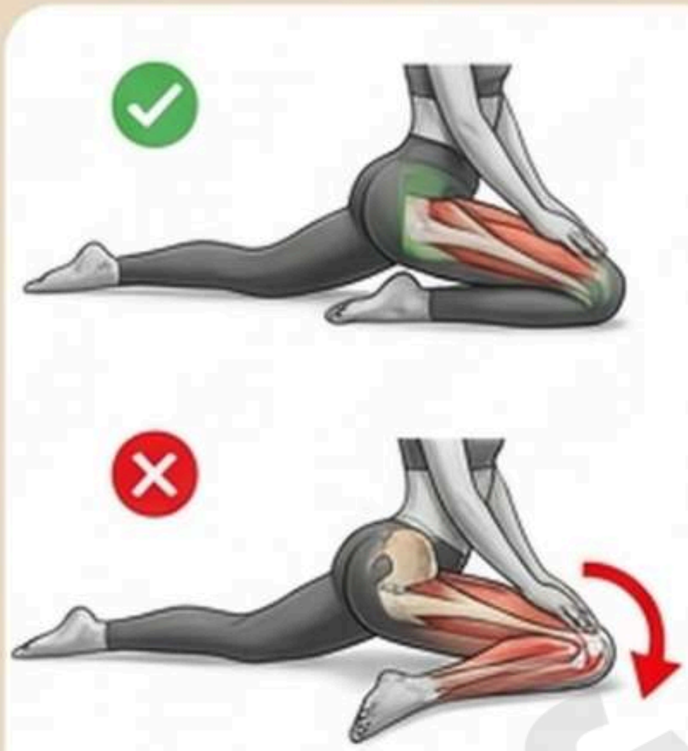
Regresión: Reducir el rango de movimiento o hacer activaciones en posturas más sencillas (puente de glúteos).
Progresión: Aumentar el tiempo de contracción isométrica o agregar una resistencia suave con banda elástica.
Para su casa: "Tu superpoder es la flexibilidad, pero tu tarea es construir la fuerza que la controle. Menos 'soltar' y más 'sostener'. Cada estiramiento es una oportunidad de activar". **NIVEL: TODOS CON CONCIENCIA CORPORAL.**

ERRORES FRECUENTES DE CADERA

COMPENSACIONES de cadera.

Compensación Lumbar

Torsión de Rodilla



El Rebote

EL CUERPO BUSCA EL CAMINO FÁCIL

El cuerpo es inteligente y buscará el camino de menor resistencia. Cuando la cadera no tiene el rango de movimiento que le pedimos, otra articulación —casi siempre la columna lumbar o la rodilla— se moverá de más para compensar. Esto no solo hace que el estiramiento sea ineficaz, sino que traslada la tensión a zonas más vulnerables.

Aprender a estabilizar la pelvis y la columna es el primer paso para estirar la cadera de forma segura y efectiva. El rebote, por su parte, activa el reflejo miotático, un mecanismo de defensa que hace que el músculo se contraiga en lugar de relajarse, siendo contraproducente.

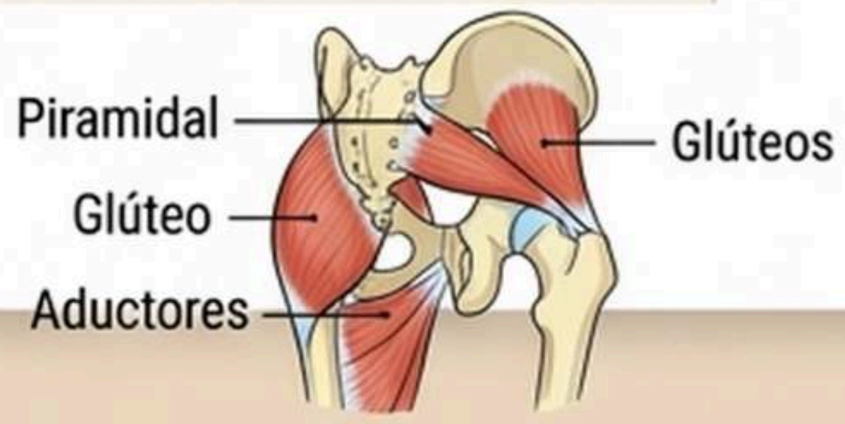
EN LA SALA

La alumna que dice "siento que estiro mucho", pero cuando la observás, todo el movimiento viene de su espalda baja.

QUÉ SÍ	QUÉ NO
Movimientos lentos y controlados, aislando la articulación de la cadera. Usar la respiración para relajar.	Forzar, rebotar, o permitir que la lumbar o las rodillas se muevan para "ganar" rango.

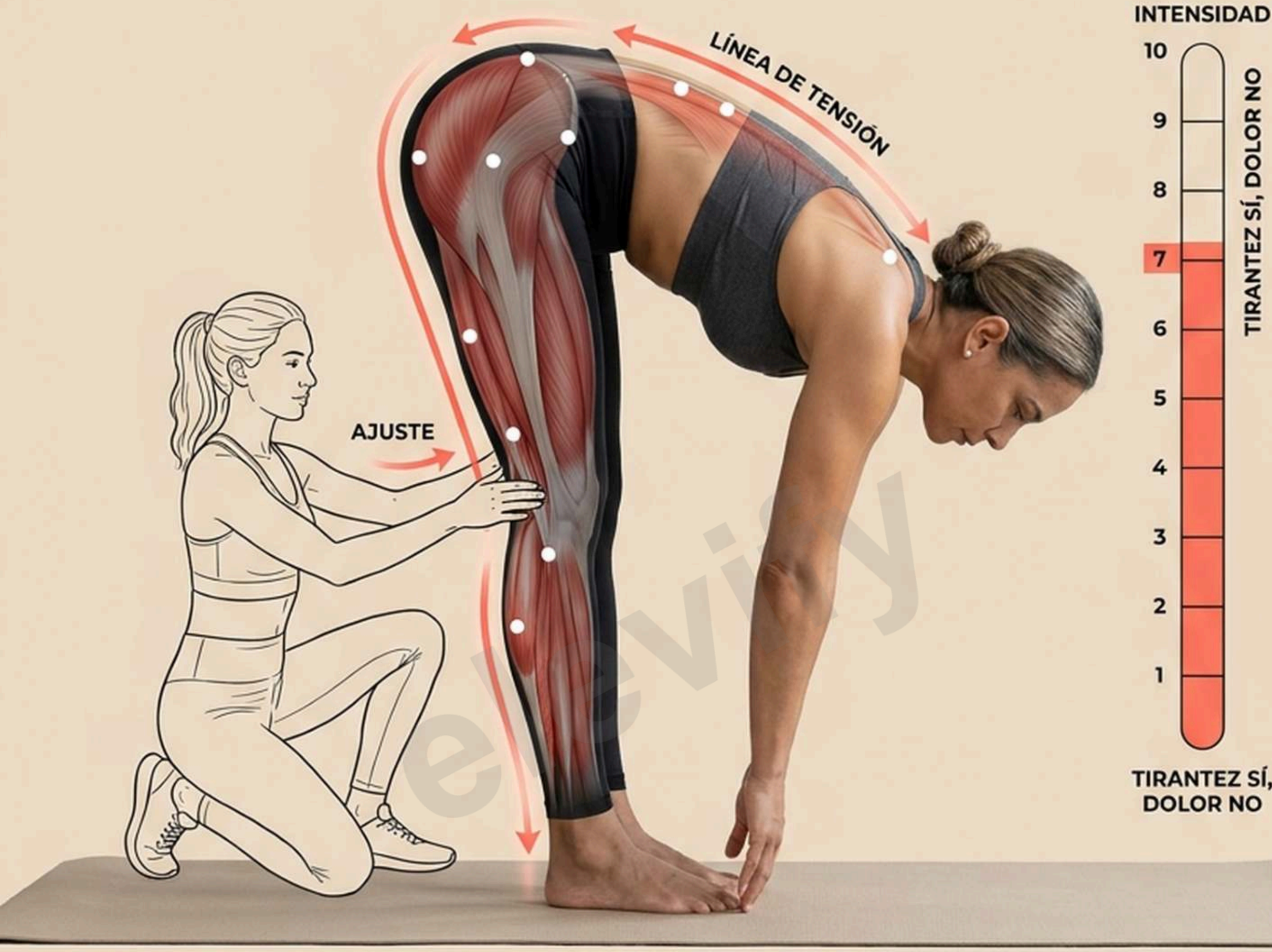
Tabla de referencia: Limitación de cadera

'SI EL ALUMNO NO PUEDE O LE CUESTA...'	EL FRENO MUSCULAR PROBABLE ES...'	EJERCICIO SUGERIDO (en este capítulo)
Llevar la pierna estirada hacia atrás (extensión)	Psoas Ilíaco, Recto Femoral	📖 **Zancada con pelvis fija** (pág. 72)
Abrir las piernas hacia los lados (abducción)	Aductores	**Rana** (pág. 74) o **Mariposa** (pág. 71)
Cruzar una rodilla sobre la otra al sentarse	Glúteo, Piramidal y rotadores externos	**Paloma** (pág. 73) o **90/90** (pág. 76)
Llevar una rodilla hacia adentro (rotación interna)	Rotadores externos (Piramidal, Glúteos)	📖 **Rotación interna sentado** (pág. 75) o **90/90** (pág. 76)
Levantar la rodilla hacia el pecho (flexión)	Glúteo mayor, Isquiotibiales (ver Cap. 6)	(Referencia a otro capítulo)
Sentir un pinzamiento adelante al flexionar la cadera	Tensión en la cápsula anterior, posible acortamiento del psoas	**Movilidad controlada**, no forzar la flexión
Sentir dolor en la cara externa de la rodilla o cadera al correr	Tensor de la Fascia Lata (TFL) tenso	📖 **Estiramiento de TFL** cruzando la pierna por detrás
Juntar las rodillas al hacer una sentadilla	Aductores cortos y TFL tensos, glúteo medio débil	**Mariposa** (pág. 71) y **activación de glúteos**



ANATOMÍA APLICADA
A LA FLEXIBILIDAD

CADENA POSTERIOR: LA QUE MÁS SE PIDE



QUÉ VAS A ENCONTRAR

LA ANATOMÍA DE LOS MÚSCULOS QUE TE IMPIDEN TOCARTE LOS PIES.

Comprende la conexión miofascial de la cadena posterior.

EJERCICIOS SEGUROS PARA ELONGARLOS SIN COMPENSAR CON LA LUMBAR.

Técnicas para aislar el isquiotibial protegiendo tu espalda.

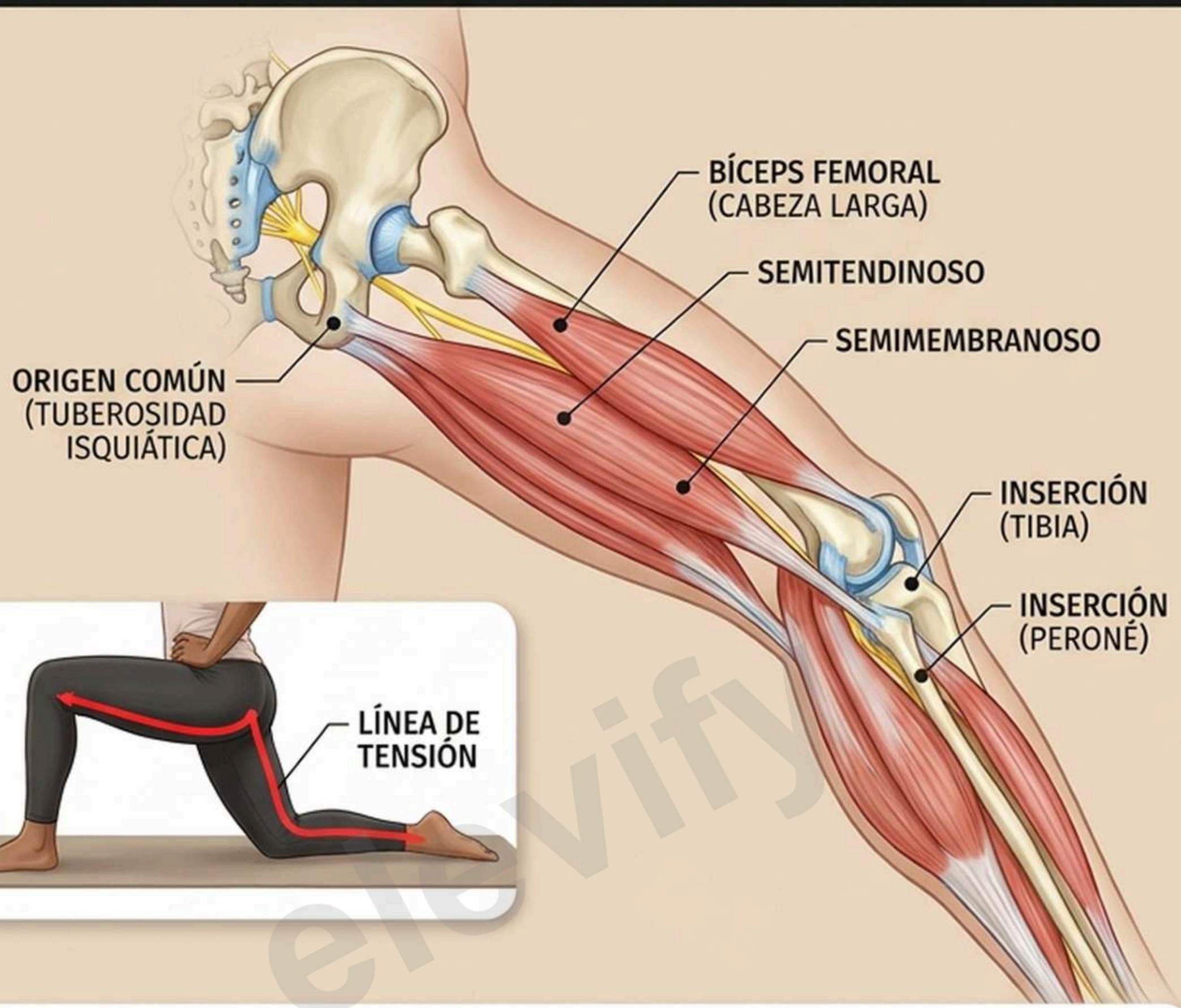
CÓMO ADAPTAR LOS ESTIRAMIENTOS SI TENÉS UNA HERNIA DE DISCO.

Modificaciones clave para evitar la compresión nerviosa.

CLAVE DEL EXPERTO:

- La diferencia entre tirantez muscular y nerviosa es fundamental para un estiramiento seguro.

ISQUIOTIBIALES: TRES MÚSCULOS CLAVE



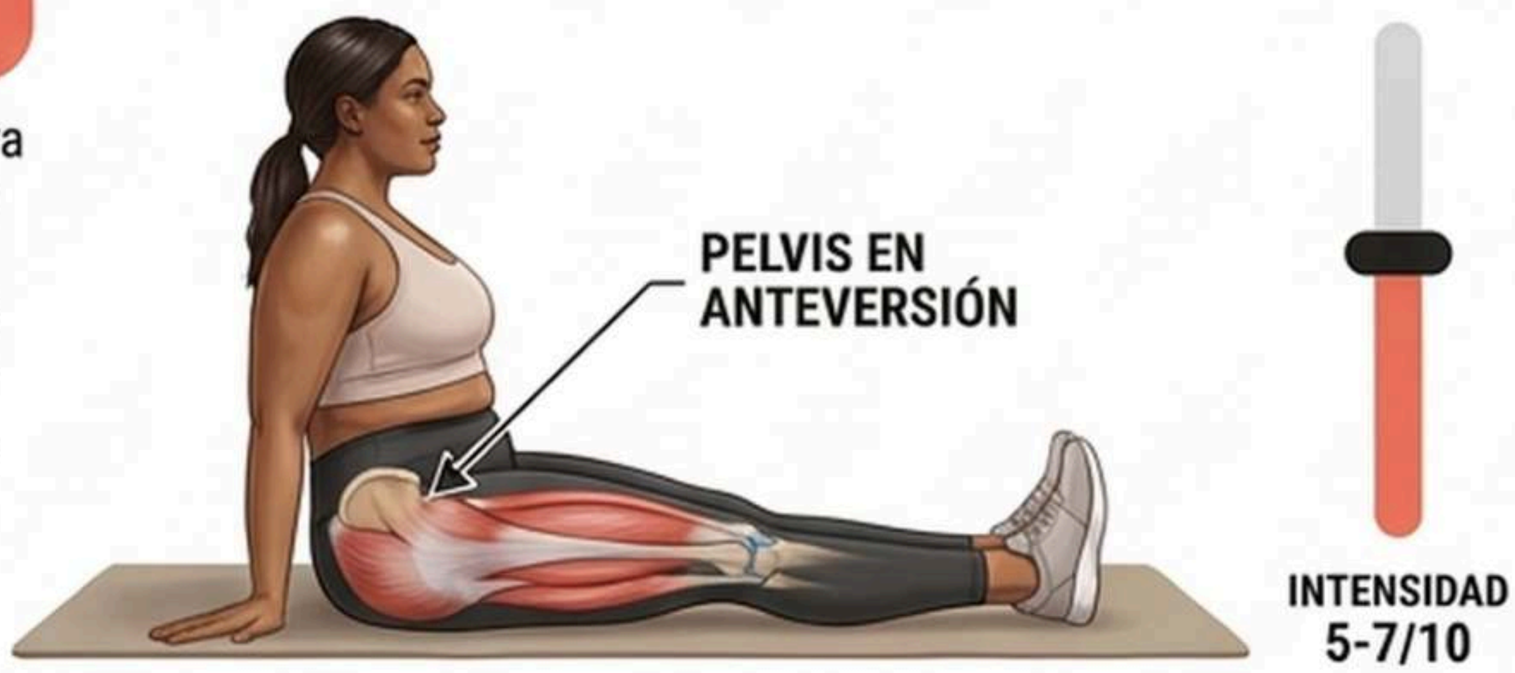
DÓNDE ESTÁN: Cara posterior del muslo, desde el isquion (hueso de la cola) hasta detrás de la rodilla.

QUÉ HACEN: Extienden la cadera y flexionan la rodilla.

QUÉ FRENAN CUANDO ESTÁN CORTOS: La flexión de cadera con la rodilla extendida, como al tocarse los pies.

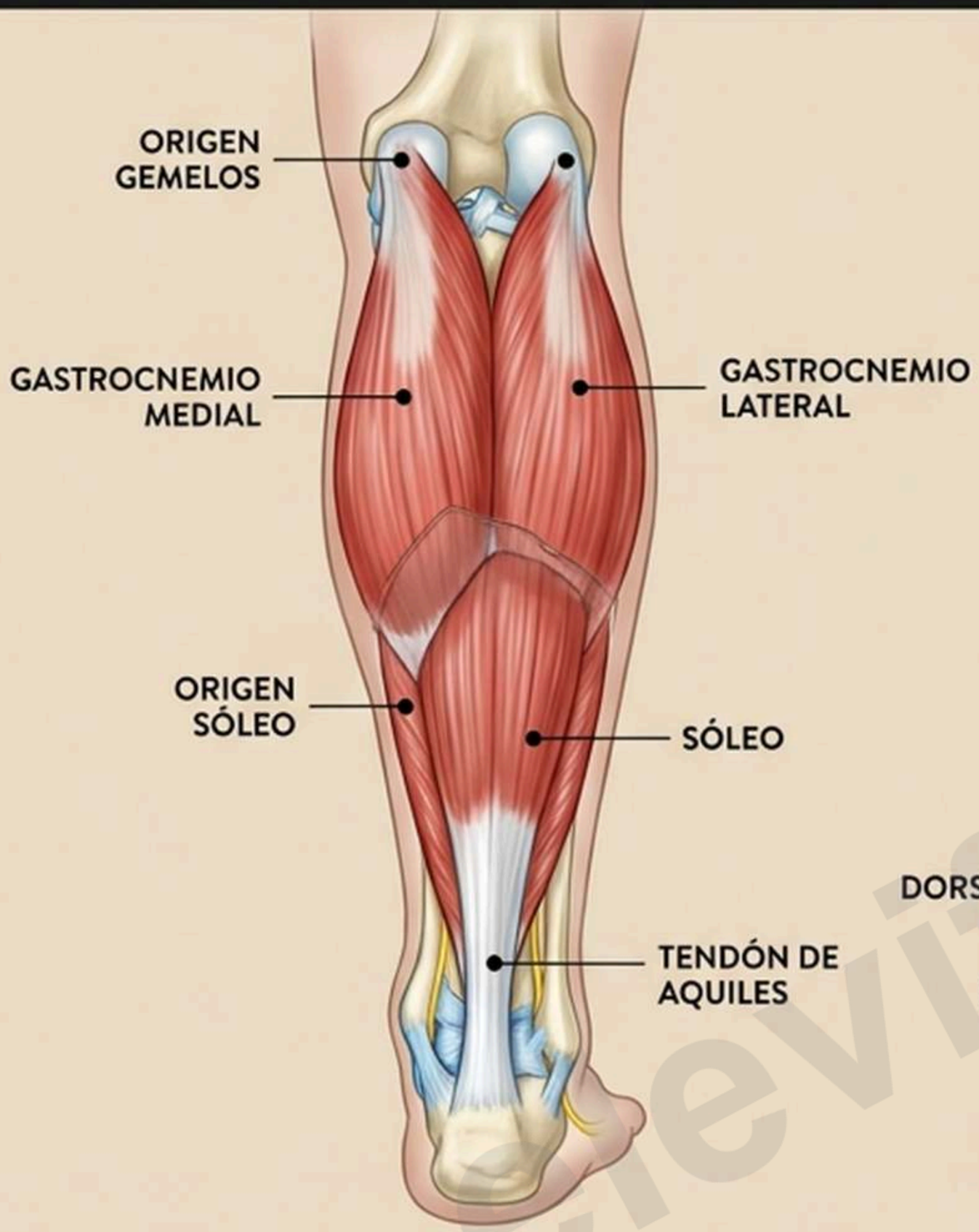
CÓMO SE ESTIRA

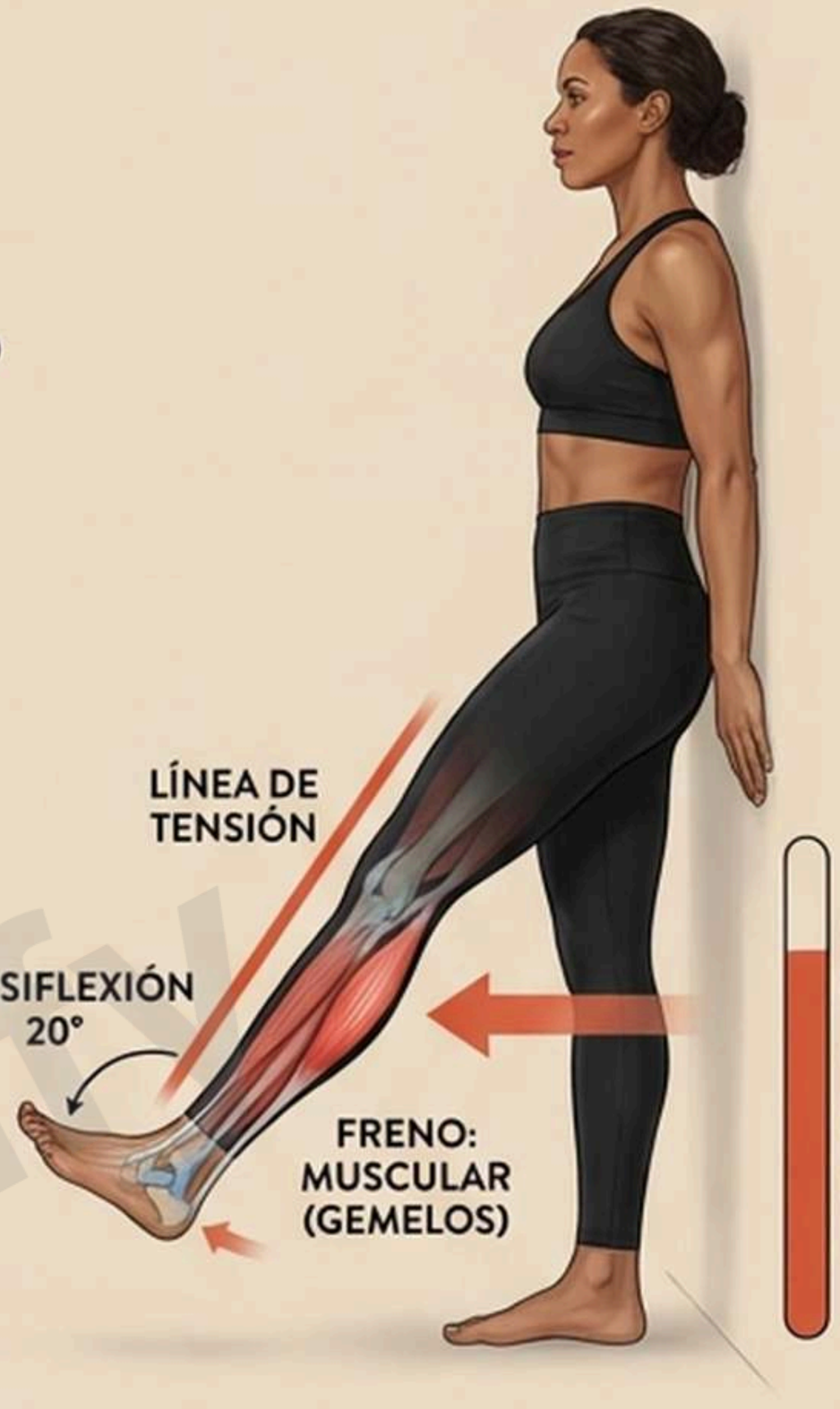
Se estiran flexionando la cadera mientras se mantiene la rodilla extendida. La clave es fijar la pelvis en **anteversión** para que el estiramiento se origine en el isquion y no en la espalda lumbar. La sensación debe ser de tirantez limpia en la parte posterior del muslo, sin dolor ni compensaciones.



CUE DE LA FORMADORA: "Imaginá que los isquiones quieren apuntar al techo para no redondear la espalda".

GEMELOS Y SÓLEO: EL TOBILLO





DÓNDE ESTÁN En la pantorrilla. Los gemelos van del fémur al talón; el sóleo, de la tibia al talón.

QUÉ HACEN Hacen la flexión plantar del tobillo (ponerse en punta de pie).

QUÉ FRENAN CUANDO ESTÁN CORTOS La dorsiflexión del tobillo, crucial para la sentadilla profunda y la caminata.

CÓMO SE ESTIRA

Gemelos: con la rodilla extendida, llevando el talón hacia el suelo.
Sóleo: igual, pero con la rodilla flexionada. La diferencia es clave porque los gemelos cruzan la rodilla y el sóleo no. Hay que sentir la tirantez en la pantorrilla, no en el arco del pie. **Intensidad 6-8/10**.

CUE DE LA FORMADORA "Para el sóleo, pensá en bajar la rodilla hacia la pared, no solo el cuerpo".

EL NERVIO CIÁTICO: TIRANTEZ NO MUSCULAR

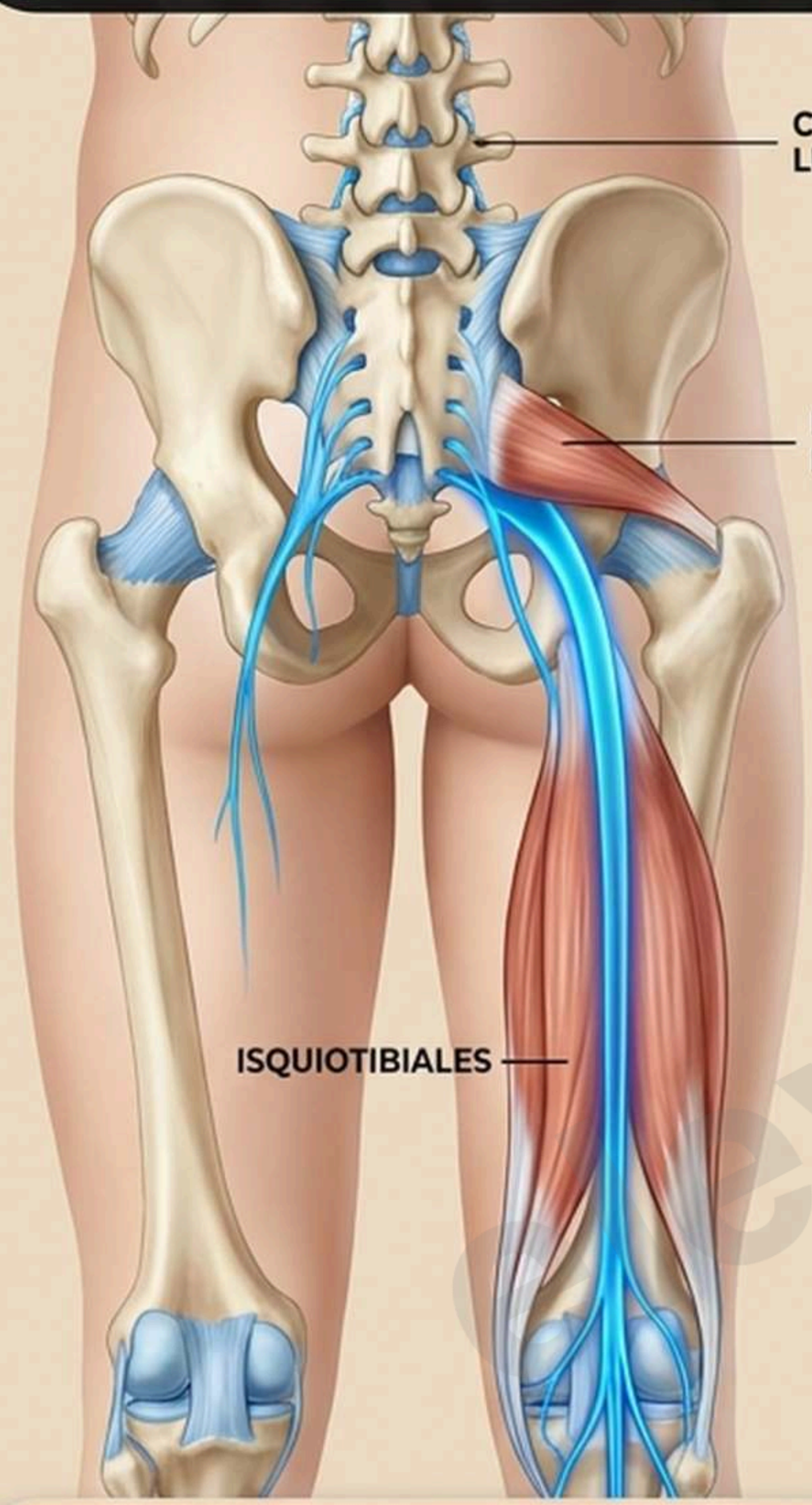


LÁMINA ANATÓMICA DEL MÚSCULO O ESTRUCTURA:
El nervio ciático dentro de la cadena posterior.

DÓNDE ESTÁ

Es el nervio más largo del cuerpo. Nace en la zona lumbosacra y baja por toda la pierna hasta el pie.

QUÉ HACE

Conduce impulsos nerviosos (sensibilidad y movimiento) a la pierna.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

No se 'acorta', pero puede irritarse o adherirse, generando una tirantez eléctrica o quemante que se confunde con la muscular.

INTENSIDAD 5-7

CARD "CÓMO SE ESTIRA"

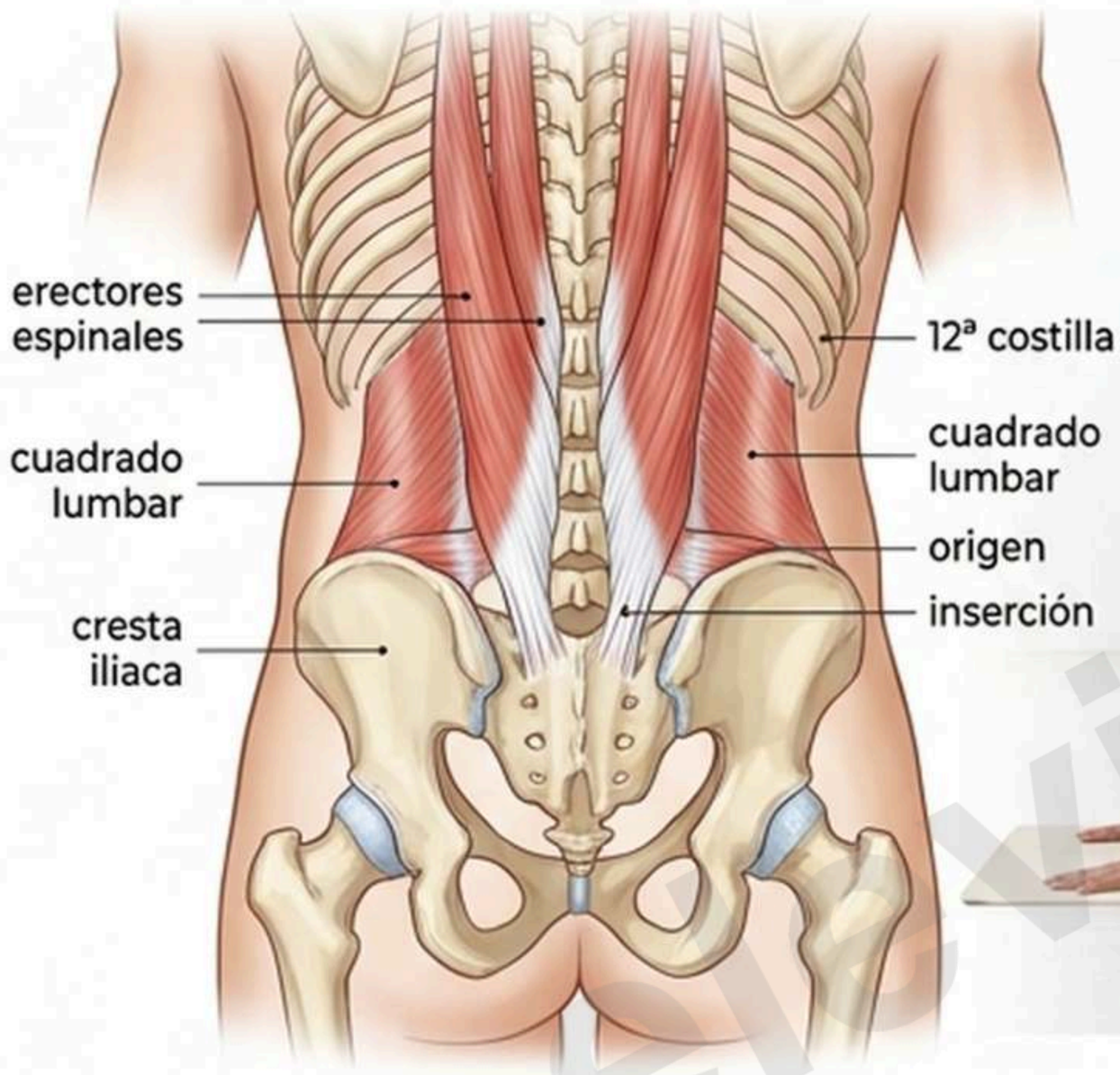
Un nervio no se estira como un músculo, se moviliza (deslizamiento neural). Se busca un movimiento suave y rítmico que lo haga deslizarse por sus interfaces, sin mantener una tensión máxima. Si la alumna siente hormigueo, quemazón o un dolor agudo que baja por la pierna, no es muscular y hay que parar.

DESLIZAMIENTO NEURAL · INTENSIDAD 6
45 SEG · 3 SERIES

CUE DE LA FORMADORA

"Si la tirantez cambia al mover la cabeza o el pie, es muy probable que sea neural".

ERECTORES ESPINALES Y CUADRADO LUMBAR



DÓNDE ESTÁN: A los lados de la columna lumbar.

QUÉ HACEN: Extienden e inclinan la columna.

QUÉ FRENAN CUANDO ESTÁN CORTOS: La flexión de la columna lumbar, haciendo que la espalda se sienta 'dura' y se mueva en bloque.

CÓMO SE ESTIRA

Se estiran mediante la flexión controlada de la columna (redondeando la espalda), como en la postura del niño o del gato.

- Es fundamental que el movimiento sea suave y se coordine con la exhalación para relajar la musculatura.
- A diferencia de los isquiotibiales, aquí sí buscamos redondear, pero desde una intención de crear espacio entre las vértebras.

CUE DE LA FORMADORA
Exhalá profundo e imaginá que el aire empuja tus lumbares hacia el techo.

INTENSIDAD 5-7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ERECTORES/CUADRADO · INTENSIDAD 5-7 · 45 SEG · 3 SERIES

GRADOS: ~40-50° (flexión lumbar)

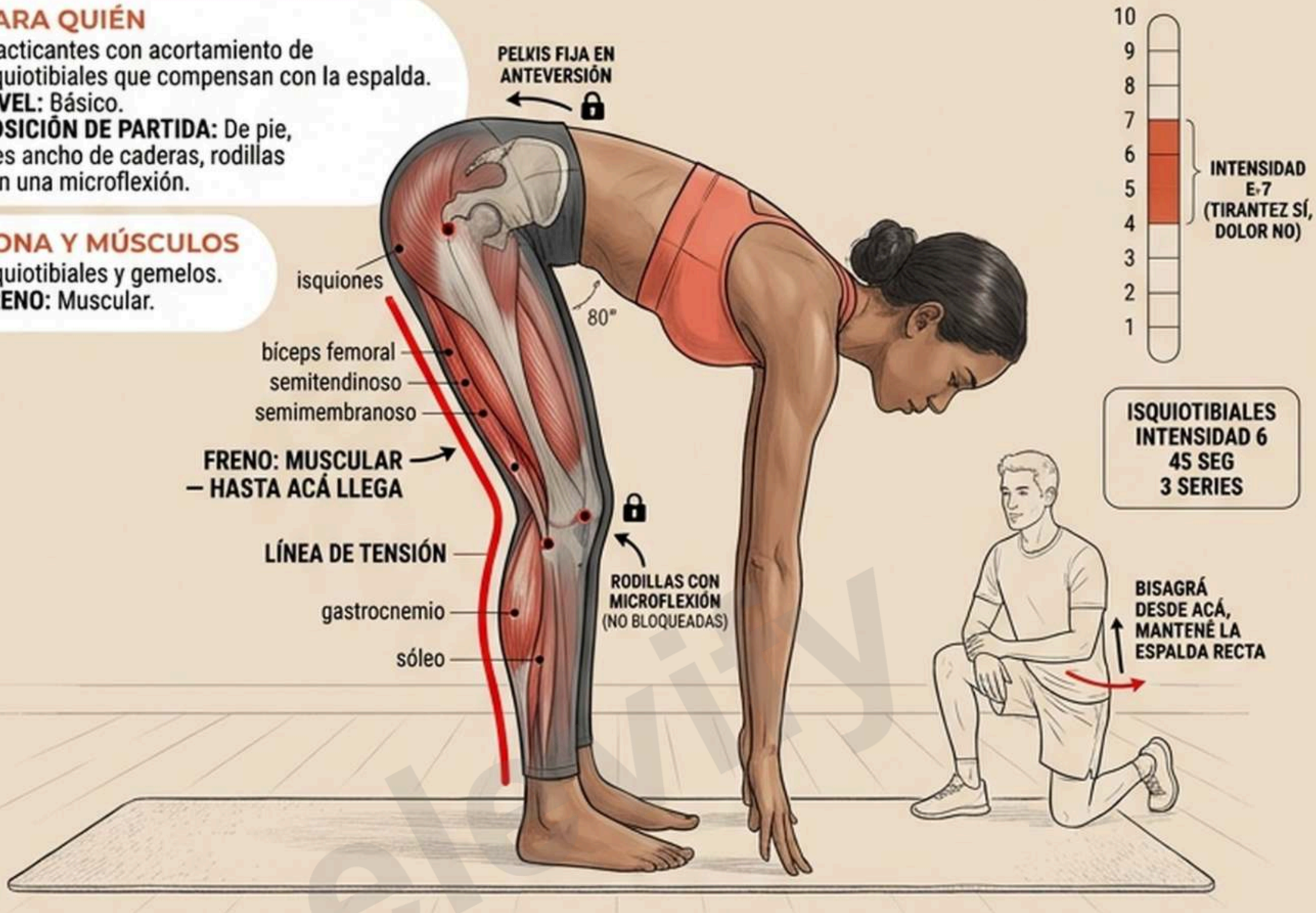
FLEXIÓN DE TRONCO DE PIE

PARA QUIÉN

Practicantes con acortamiento de isquiotibiales que compensan con la espalda.
NIVEL: Básico.
POSICIÓN DE PARTIDA: De pie, pies ancho de caderas, rodillas con una microflexión.

ZONA Y MÚSCULOS

Isquiotibiales y gemelos.
FRENO: Muscular.



EL ESTIRAMIENTO

Método estático activo. La alumna baja el tronco desde la cadera, manteniendo la espalda recta. **Intensidad:** 5-7/10. **Tiempo:** 3 series de 30-45 segundos. **Respiración:** Lenta y profunda, exhalando al bajar. **Fijo:** La pelvis en anteversión y las rodillas sin hiperextender.

PASO A PASO

1. De pie, separá los pies al ancho de tus caderas. Poné las manos en la cintura.
2. Microflexioná las rodillas para que no estén bloqueadas.
3. Inhalá y alargá la columna.
4. Exhalando, bisagrá desde la cadera, llevando los isquiones hacia atrás y arriba. Bajá con la espalda recta hasta sentir tirantez en los isquiotibiales (30-45 seg).
5. Mantené la posición, respirando.
6. Para volver, flexioná más las rodillas y subí con la espalda redonda.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Redondear la lumbar: El estiramiento se pierde.
CORRECCIÓN: Flexioná más las rodillas y concentrate en sacar cola.

2. Hiperextender las rodillas: Pone en tensión la articelacatin.
CORRECCIÓN: Mantené siempre una microflexión.

3. Dejar caer la cabeza: Genera tensión en el cuello.
COBRECCIÓN: Mantené el cuello alineado con la columna.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✕ **Hipermovilidad** (Cruz roja): No hiperextender rodillas.
- ✕ **Hernia lumbar** (Cruz roja): Consultar al médico; si está autorizado, mantener columna neutra.
- ✕ **Rodilla operada** (Cruz roja): Respetar rangos indicados.
- ✓ **Embarazo** (Check verde): Con piernas separadas y apoyo en una silla.
- ✓ **Adulto mayor** (Check verde): Con apoyo de manos en silla o pared.
- ✕ **Lesión reciente** (Cruz roja): No si hay dolor agudo.

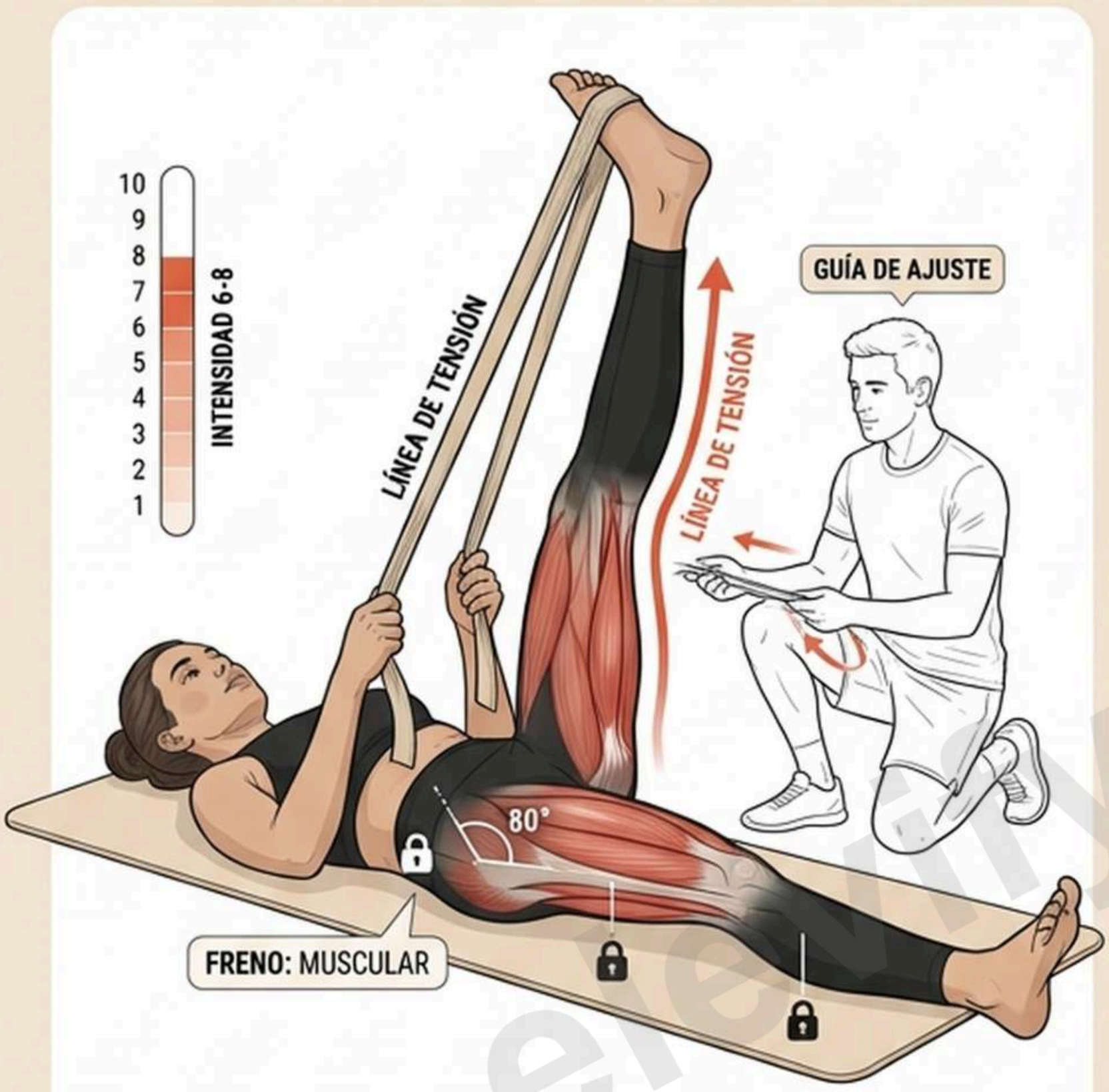
REGRESIÓN: Menos flexión de tronco, mayor flexión de rodillas, manos en una silla.

PROGRESIÓN: Bajar más manteniendo la espalda recta.

PARA SU CASA: "Enfocate en la sensación de que el pliegue nace en tu ingle, no en tu cintura".

CAP 6 · CADENA POSTERIOR: ISQUIOTIBIALES, GEMELOS Y ESPALDA

ISQUIOTIBIALES ACOSTADO CON CINTA



ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 6-8 · 45-60 SEG · 3 SERIES

PARA QUIÉN

Alumnos que necesitan aislar el isquiotibial sin cargar la espalda. Ideal para principiantes o personas con dolor lumbar.

NIVEL: Básico.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático pasivo con asistencia.
INTENSIDAD: 6-8/10.
TIEMPO: 3 series de 45-60 segundos por pierna.
RESPIRACIÓN: Lenta, exhalando para acercar la pierna.
FIJO: El sacro apoyado en el suelo.

PASO A PASO

1. Acostate boca arriba. Colocá una cinta en el metatarso del pie derecho y elevalo.
2. Sostené la cinta con ambas manos, hombros relajados.
3. Extendé la rodilla derecha sin bloquearla. El sacro debe permanecer apoyado.
4. Exhalando, usá la cinta para acercar suavemente la pierna hasta sentir una tirantez clara (45-60 seg).
5. Mantené la posición.
6. Aflojá la cinta y bajá la pierna con control. Repeti del otro lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Levantar el sacro del suelo:** Se falsea el estiramiento. **CORRECCIÓN:** Bajá un poco la pierna hasta que el sacro se apoye.
2. **Tirar con los hombros:** Genera tensión. **CORRECCIÓN:** Relajá los hombros.
3. **Flexionar la rodilla de la pierna elevada:** Reduce la tensión. **CORRECCIÓN:** Priorizá la extensión de rodilla antes que la altura.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

- ✓ **Hernia lumbar:** Muy seguro si se mantiene el sacro apoyado.
- ✓ **Adulto mayor:** Muy recomendable.
- ✓ **Embarazo:** Seguro en primeras etapas.

QUÉ NO

- ✗ **Hipermovilidad:** No buscar el máximo rango.
- ✗ **Rodilla operada:** Cuidado con la extensión completa.
- ✗ **Lesión reciente:** No con desgarro agudo.

REGRESIÓN

Flexionar la pierna que está en el suelo.

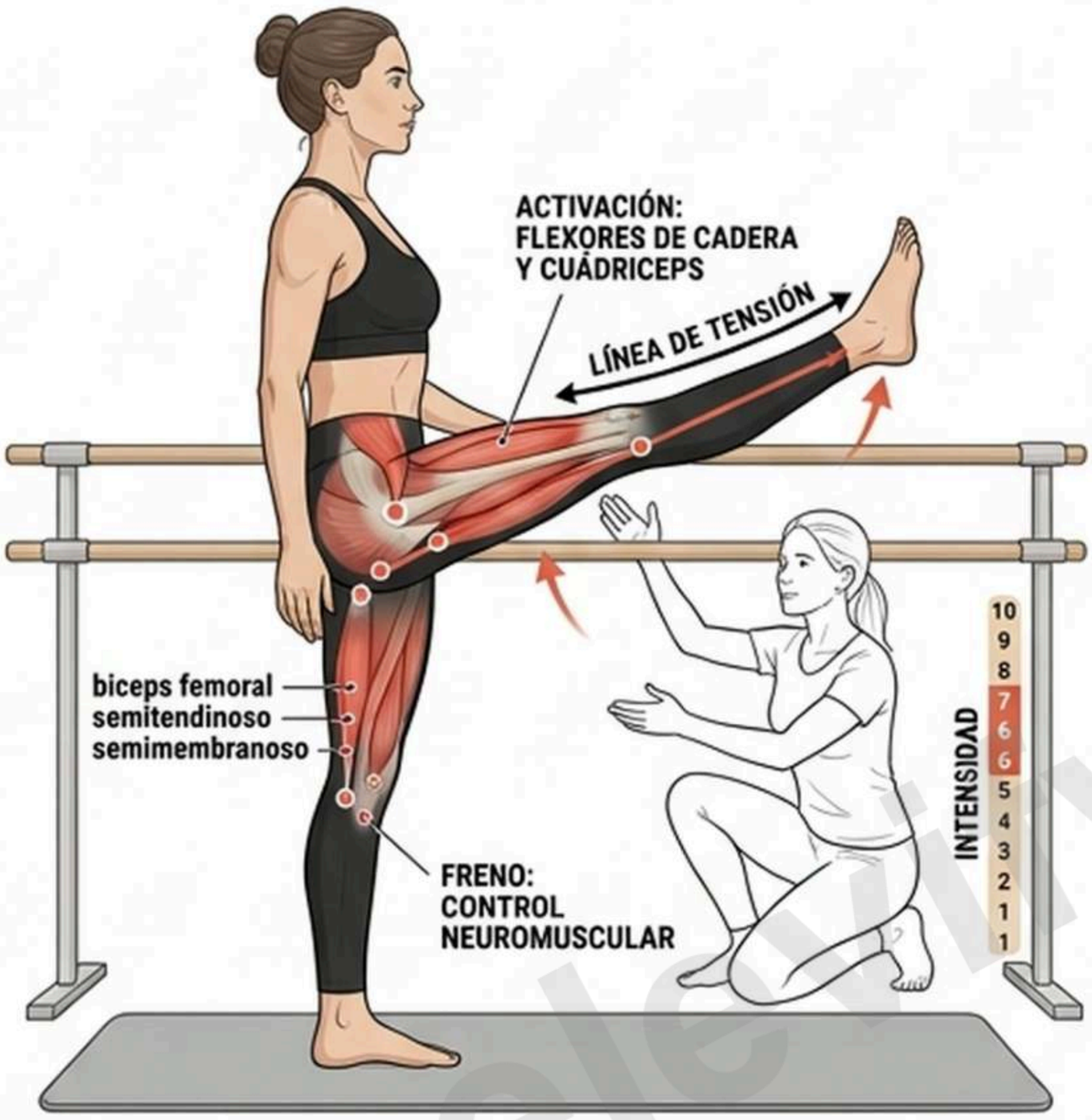
PROGRESIÓN

Activar el cuádriceps de la pierna elevada.

PARA SU CASA: 'La cinta es una ayuda, no una soga para forzar. La respiración es la que te da el rango'

CAP 6 · CADENA POSTERIOR: ISQUIOTIBIALES, GEMELOS Y ESPALDA

ISQUIOTIBIALES ACTIVO CON PIERNA ELEVADA



FICHA DE ESTIRAMIENTO

- **PARA QUIÉN:** Practicantes intermedios/avanzados que buscan ganar rango activo de movimiento.
- **NIVEL:** Intermedio.
- **POSICIÓN DE PARTIDA:** De pie, frente a una silla, pared o espaldar.
- **ZONA Y MÚSCULOS:** Isquiotibiales (estiramiento), flexores de cadera y cuádriceps (activación).
- **FRENO:** Control neuromuscular.

EL ESTIRAMIENTO

Método dinámico y activo.

Intensidad: 6-7/10 en isquiotibial, esfuerzo en cuádriceps.

Repeticiones: 2-3 series de 8-12 elevaciones lentas por pierna.

Respiración: Exhalar al elevar.

Fijo: La pelvis neutra y la columna erguida.

PASO A PASO

1. Parate erguida, abdomen activo.
2. Mantené la pierna de base con microflexión de rodilla.
3. Inhalá. Exhalando, elevá lentamente la pierna derecha extendida al frente, sin redondear la espalda.
4. El movimiento lo hacen tus flexores de cadera y cuádriceps, no un impulso.
5. Sostené un segundo arriba y bajá con control. Hacé 8-12 repeticiones.
6. Cambiá de lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Tomar impulso o "patear":** No trabaja la fuerza.
   CORRECCIÓN: Hacé el movimiento lento y consciente.
2. **Redondear la espalda para subir más:** La flexión viene de la lumbar.
   COKRECCIÓN: Mantené el torso erguido.
3. **Flexionar la rodilla que sube:** Esoapa al estiramiento.
   CORRECCIÓN: Mantené el cuádriceps activo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hipermovilidad:** Excelente para ganar control.
- **Hernia lumbar:** Hacer con mucho control y sin buscar altura máxima.
- **Rodilla operada:** Consultar.
- **Embarazo:** Evitar si hay dolor en sinfisis púbica.
- **Adulto mayor:** Con apoyo y menor rango.
- **Lesión reciente:** No si hay lesión en isquiotibiales o flexores de cadera.

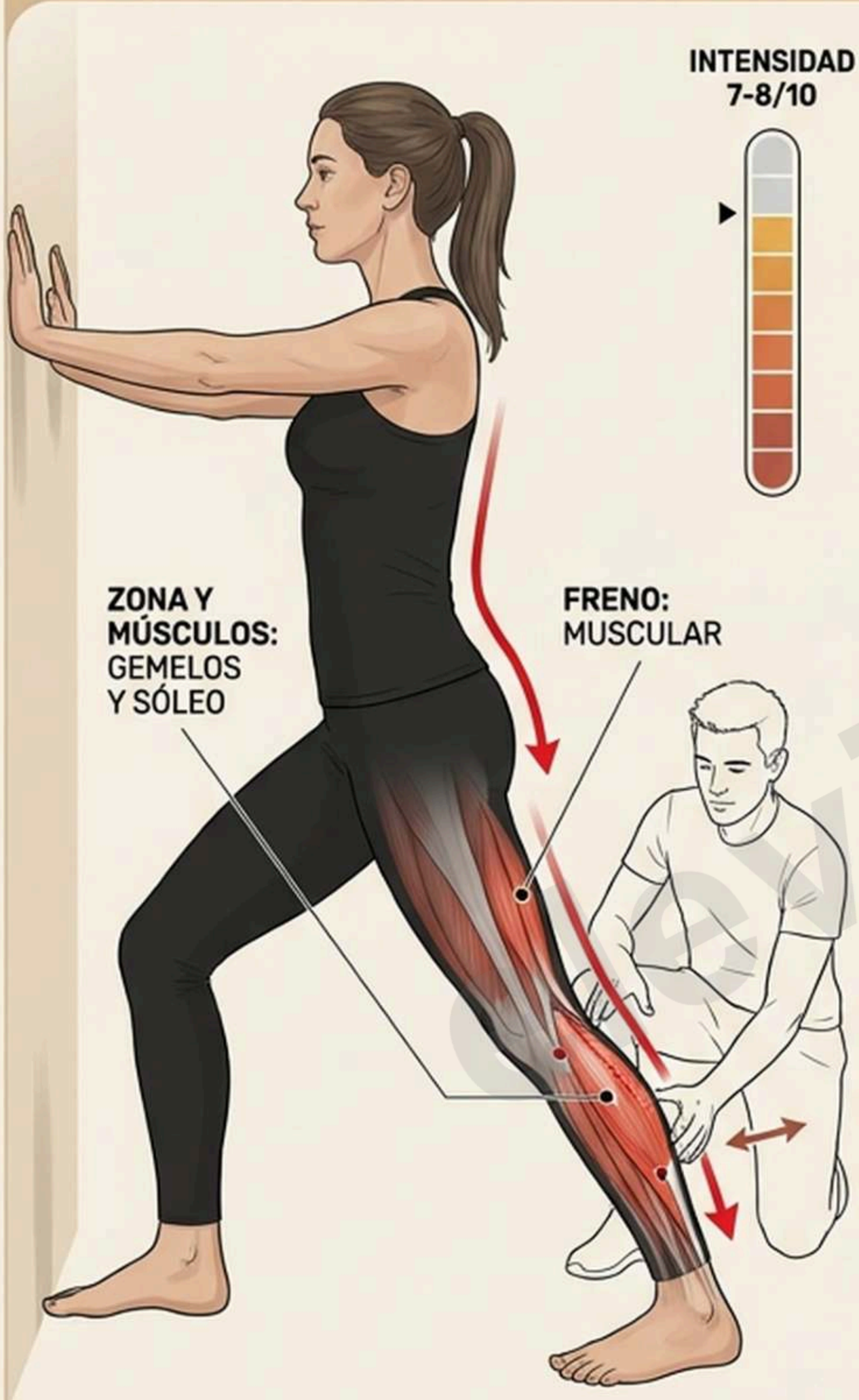
REGRESIÓN:
Acostado boca arriba, elevando y bajando la pierna.

PROGRESIÓN:
Sostener la pierna arriba por 5-10 segundos.

PARA SU CASA:
"No importa qué tan alto llegues, sino cómc llegás. Buscá calidad de movimiento"

GEMELOS Y SÓLEO CONTRA LA PARED

FICHA DE ESTIRAMIENTO



EL ESTIRAMIENTO: Método estático.
Intensidad: 7-8/10.
Tiempo: 2-3 series de 30-45 segundos por músculo y pierna.
Respiración: Fluida.
Fijo: El talón de la pierna de atrás en el suelo.

PARA QUIÉN: Corredores, personas que usan tacos o cualquiera con tobillos rígidos.
NIVEL: Básico.
POSICIÓN DE PARTIDA: De pie, frente a una pared.

PASO A PASO

Estiramiento de Gemelos:
1. Apoyá las manos en la pared.
2. Llevá la pierna derecha hacia atrás, bien extendida.
3. Mantené la rodilla derecha extendida y el talón derecho pegado al suelo.
4. Incliná el cuerpo hacia adelante hasta sentir tirantez en la pantorrilla (30-45 seg).

Estiramiento de Sóleo:
5. Desde la misma posición, flexioná la rodilla derecha, acercándola al suelo.
6. El talón derecho debe seguir apoyado. Sentirás que la tirantez baja (30-45 seg).
Repetí con la pierna izquierda.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Levantar el talón del suelo:** Se pierde la tensión.
CORRECCIÓN: Acortá la distancia, pero mantené el talón apoyado.
2. **Rotar el pie hacia afuera:** Se compensa.
CORRECCIÓN: Asegurate de que los dedos apunten al frente.
3. **No diferenciar los dos estiramientos:** Se trabaja solo el gemelo.
CORRECCIÓN: Recordá flexionar la rodilla para el sóleo.

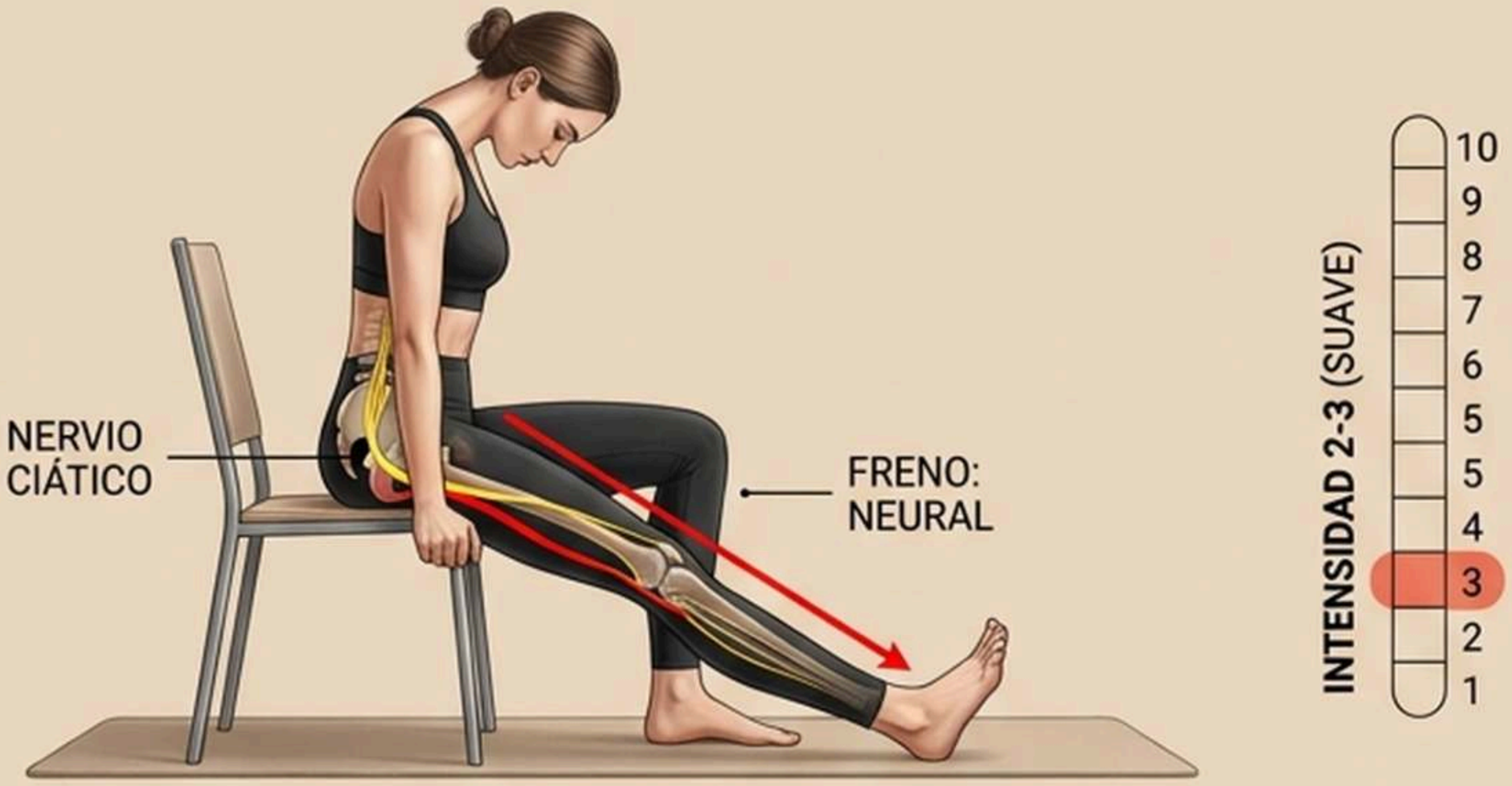
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** Seguro (✓).
- ✗ **Tendinopatía de Aquiles:** Intensidad muy baja (3-4/10), sin dolor (✓).
- ✗ **Lesión de rodilla:** Adaptar el rango de flexión (✓).
- ✓ **Embarazo:** Seguro y beneficioso (✓).
- ✓ **Adulto mayor:** Excelente, con silla para más estabilidad (✓).
- ✗ **Lesión reciente:** No con desgarro agudo (✗).

REGRESIÓN: Menor inclinación.
PROGRESIÓN: Metatarso en un escalón y dejar caer el talón.
PARA SU CASA: "Son dos músculos distintos. Para una buena dorsiflexión, necesitás liberar a los dos".

REGRESIÓN: Menor inclinación.
PROGRESIÓN: Metatarso en un escalón y dejar caer el talón.
PARA SU CASA: "Son dos músculos distintos. Para una buena dorsiflexión, necesitás liberar a los dos".

DESLIZAMIENTO NEURAL DEL CIÁTICO



MOVILIZACIÓN NEURAL · INTENSIDAD 2-3 · 10-15 REPS · 2 SERIES

PARA QUIÉN

Alumnos con tirantez 'eléctrica', quemante o que irradia, que no cede con estiramientos musculares. Busca movilizar el nervio, no estirarlo. **NIVEL:** Básico (con supervisión).

EL ESTIRAMIENTO

Método de movilización neural rítmica y suave. Intensidad 2-3/10, sin dolor ni hormigueo. 2 series de 10-15 repeticiones fluidas por lado. Respiración natural. **Fijo:** La pelvis neutra.

PASO A PASO

1. Sentate en el borde de una silla, espalda recta.
2. **Extendé** la pierna derecha, talón apoyado, dedos al techo.
3. ... Lentamente, flexioná el tobillo (dedos hacia vos) y la cabeza (mentón al pecho) al mismo tiempo.
4. **Invertí el movimiento de forma fluida**: extendé el tobillo (pie en punta) mientras extendés el cuello (mirada al frente).
5. **Repetíí** este movimiento de "tira y afloja" de forma suave y continua (10-15 reps).
6. Si sentis hormigueo o dolor, reducí el rango o detenete. Cambiá de pierna.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- ✗ Mantener la tensión estática.
  ✓ **CORRECCIÓN:** El movimiento debe ser fluido y rítmico.
- ✗ Demasiada intensidad (buscar dolor).
  ✓ **CORRECCIÓN:** "Menos es más". Debe ser muy suave.
- ✗ Confundirlo con un estiramiento de isquiotibiales.
  ✓ **CORRECCIÓN:** El foco es la coordinación pie-cabeza, no el músculo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Ciática aguda/diagnosticada:** INDISPENSABLE CONSULTA MÉDICA/KINESIOLÓGICA ANTES.
- ✗ **Hormigueo o adormecimiento:** Si aparece, detenerse inmediatamente.
- ✗ **Embarazo:** Consultar al médico antes.
- ✗ **Lesión reciente:** No en fase aguda.

PARA SU CASA

Decile: "Esto no es un estiramiento, es como pasar hilo dental por el nervio. Hacelo suave, rítmico y sin forzar nunca".

PINZA SENTADO CON BLOQUE BAJO LA PELVIS

ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 6 · 45 SEG · 3 SERIES

PARA QUIÉN

Practicantes con mucha rigidez en isquiotibiales, a quienes se les redondea la espalda al sentarse en el suelo.
NIVEL: Básico.

EL ESTIRAMIENTO

Método estático. La elevación de la pelvis facilita la anteversión.
Tiempo: 3 series de 45-60 segundos.
Respiración: Exhalar para profundizar.
Fijo: Isquiones apoyados en el bloque, espalda larga.

PASO A PASO

1. Sentate sobre un bloque justo debajo de los isquiones.
2. Extendé las piernas al frente.
3. Inhalá y alargá la columna.
4. Exhalando, flexioná el tronco desde la cadera, con la espalda lo más recta posible.
5. Apoyá las manos en el suelo o tibias. No tires de los pies.
6. Sostené por 45-60 segundos, respirando.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Sentarse detrás de los isquiones:
Pelvis en retroversión.

CORRECCIÓN:
El bloque debe estar justo bajo los huesos de la cola.

2. Redondear la espalda para bajar más:
Tensión en ligamentos.

CORRECCIÓN:
Priorizá la espalda recta.

3. Tirar del cuello:
Tensión cervical.

CORRECCIÓN:
Relajá el cuello.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** Flexionar ligeramente las rodillas.
- ✓ **Hernia lumbar:** Crucial mantener espalda neutra.
- ✓ **Rodilla operada:** Un rollo bajo las rodillas si molesta.
- ✓ **Embarazo:** Piernas separadas.
- ✗ **Adulto mayor:** Rodillas flexionadas y menor rango.
- ✗ **Lesión reciente:** No con desgarro agudo.

CUE DE LA FORMADORA

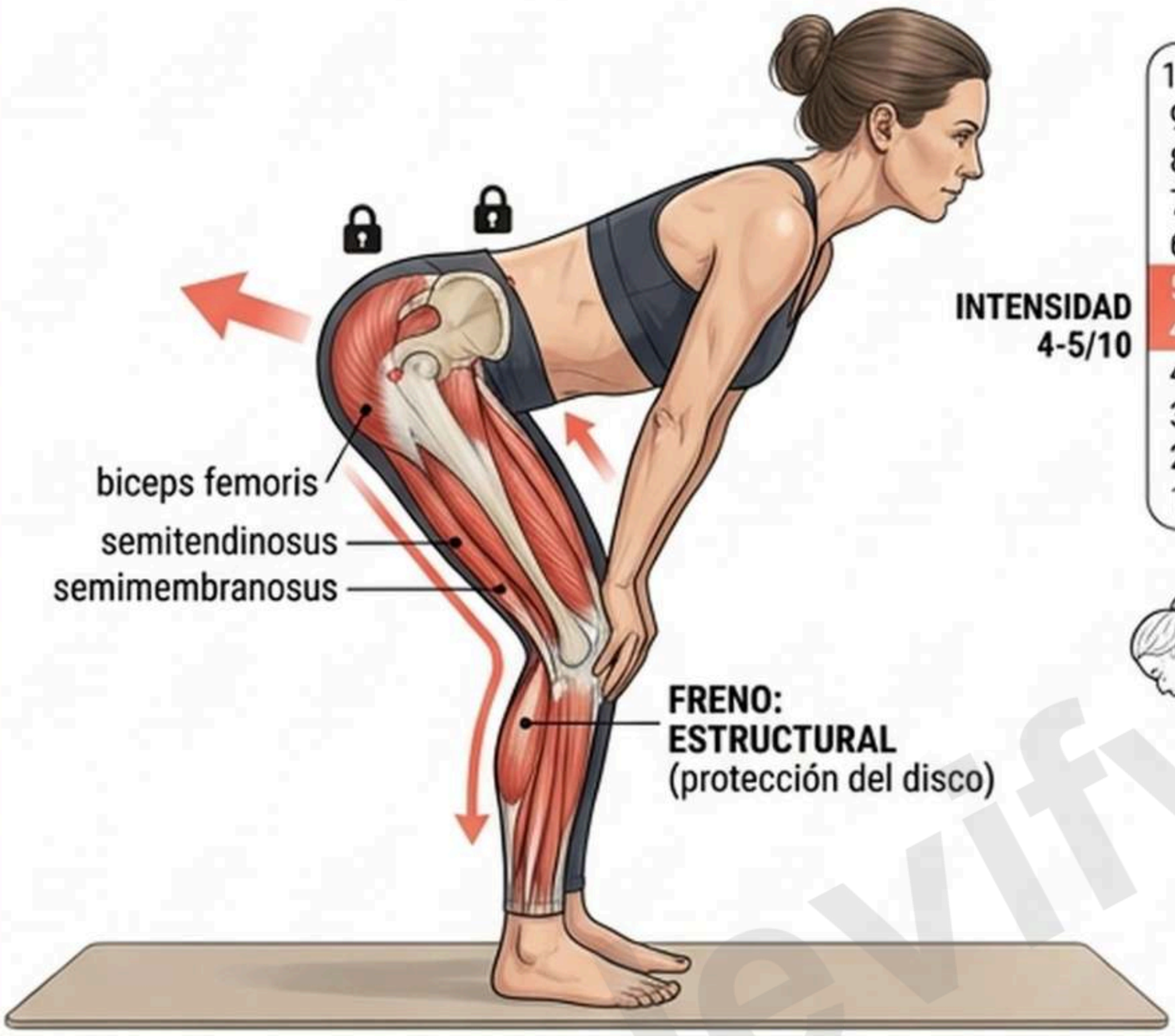
El bloque es tu mejor amigo aquí. Te ayuda a empezar el movimiento desde donde corresponde: la cadera.

REGRESIÓN
Bloque más alto, flexionar más las rodillas

PROGRESIÓN
Bajar o quitar el bloque, manteniendo la anteversión

FLEXIÓN DE TRONCO CON HERNIA

FICHA DE ESTIRAMIENTO: FLEXIÓN DE TRONCO ADAPTADA



INTENSIDAD 4-5/10

CERO DOLOR LUMBAR

ISQUIOTIBIALES
· INTENSIDAD 4-5
· DINÁMICO (8-10 REPS)
O ESTÁTICO (20-30 SEG)

CAPÍTUL 6

PARA QUIÉN

Alumnos con diagnóstico de hernia discal lumbar con autorización médica. Busca estirar isquiotibiales sin comprometer la columna. **AVISO: NO REEMPLAZA LA INDICACIÓN MÉDICA/KINESIOLÓGICA.**
NIVEL: Adaptación.

EL ESTIRAMIENTO

Método de bisagra de cadera controlada, evitando la flexión lumbar.
Intensidad: 4-5/10 en isquiotibiales, cero dolor lumbar.
Tiempo/Repeticiones: Dinámico (8-10 reps) o estático suave (20-30 seg).
Respiración: Exhalar al bajar. **Fijo:** La columna lumbar neutra.

PASO A PASO SEGURO (QUÉ SÍ)

1. Párate con rodillas semiflexionadas, abdomen activo.
2. Colocá una mano en tu abdomen y otra en tu lumbar para monitorear.
3. Inhalá. Exhalando, flexioná desde las caderas, llevando la cola hacia atrás.
4. Bajá solo hasta el punto en que tu espalda pueda permanecer neutra.
5. Volvé empujando desde los glúteos.

REGRESIÓN:
Menor rango. Manos en una pared.

PROGRESIÓN:
Bajar más, siempre con columna neutra.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Redondear la espalda.
   CORRECCIÓN: Pensá en "sacar cola".
2. Bajar hasta el suelo o forzar.
   CORRECCIÓN: Mantené una leve contracción del core.
3. Hacer rebotes.
   CORRECCIÓN: Si hay molestia, detenete. **IGNORAR EL DOLOR.**

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Este protocolo es para hernias crónicas estabilizadas, no para crisis aguda.

PARA SU CASA: "Con una hernia, tu objetivo no es tocarte los pies. Es moverte de forma segura, disociando la cadera de la lumbar. Calidad sobre cantidad".

ERRORES FRECUENTES EN CADENA POSTERIOR

Compensación lumbar

Bloqueo articular

Tensión cervical

EL OBJETIVO DE ESTIRAR LA CADENA POSTERIOR ES DEVOLVERLE LONGITUD A LOS ISQUIOTIBIALES Y GEMELOS.

Sin embargo, el error más común es buscar el rango a cualquier costo.

Cuando los isquiotibiales están muy cortos, el cuerpo busca el camino de menor resistencia y compensa redondeando la espalda lumbar. Esto no solo no estira el músculo deseado, sino que pone una tensión innecesaria y riesgosa en los discos intervertebrales.

Lo mismo ocurre al hiperextender las rodillas o al tirar del cuello: son atajos que no generan una ganancia real.

EN LA SALA

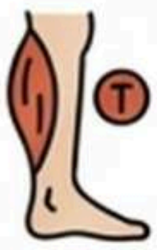
"Veo todo el tiempo alumnos obsesionados con tocarse los pies, sacrificando toda la técnica y la salud de su espalda en el intento".

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ **QUÉ SÍ:**
Priorizar la anteversión pélvica.
Microflexionar rodillas.
Mantener la columna larga.

❌ **QUÉ NO:**
Redondear la lumbar.
Hiperextender rodillas.
Forzar desde el cuello.

TABLA: MOLESTIA POSTERIOR Y QUÉ HACER

	SENSACIÓN Y UBICACIÓN	ESTRUCTURA PROBABLE	QUÉ HACER (ORIENTATIVO)
	Tirantez limpia y difusa atrás del muslo, aumenta al flexionar cadera	Acortamiento de **isquiotibiales** (muscular)	**Estiramientos estáticos** (p. 86, 90) y **activos** (p. 87). Foco en anteversión pélvica.
	Tirantez en la pantorrilla, limita flexión de tobillo	Acortamiento de **gemelos/sóleo** (muscular)	Diferenciar estiramiento de gemelos y sóleo (p. 88).
	Dolor agudo, eléctrico, quemante, hormigueo que baja por la pierna	Irritación del **nervio ciático** (neural)	**Detener el estiramiento muscular.** Probar deslizamientos neurales suaves (p. 89) y **consultar a un profesional.**
	Dolor sordo o rigidez en espalda baja, a los lados de la columna	Tensión en **erectores espinales** o **cuadrado lumbar**	Flexiones de columna suaves y controladas (Gato/Vaca). Evitar flexiones de tronco forzadas.
	Dolor agudo y localizado en lumbar que aumenta al flexionar el tronco, a veces irradia	Posible **compromiso discal** (hernia)	**Detener la actividad y derivar al médico.** No estirar en flexión. Ver adaptaciones (p. 91) solo con alta médica.

CADENA ANTERIOR

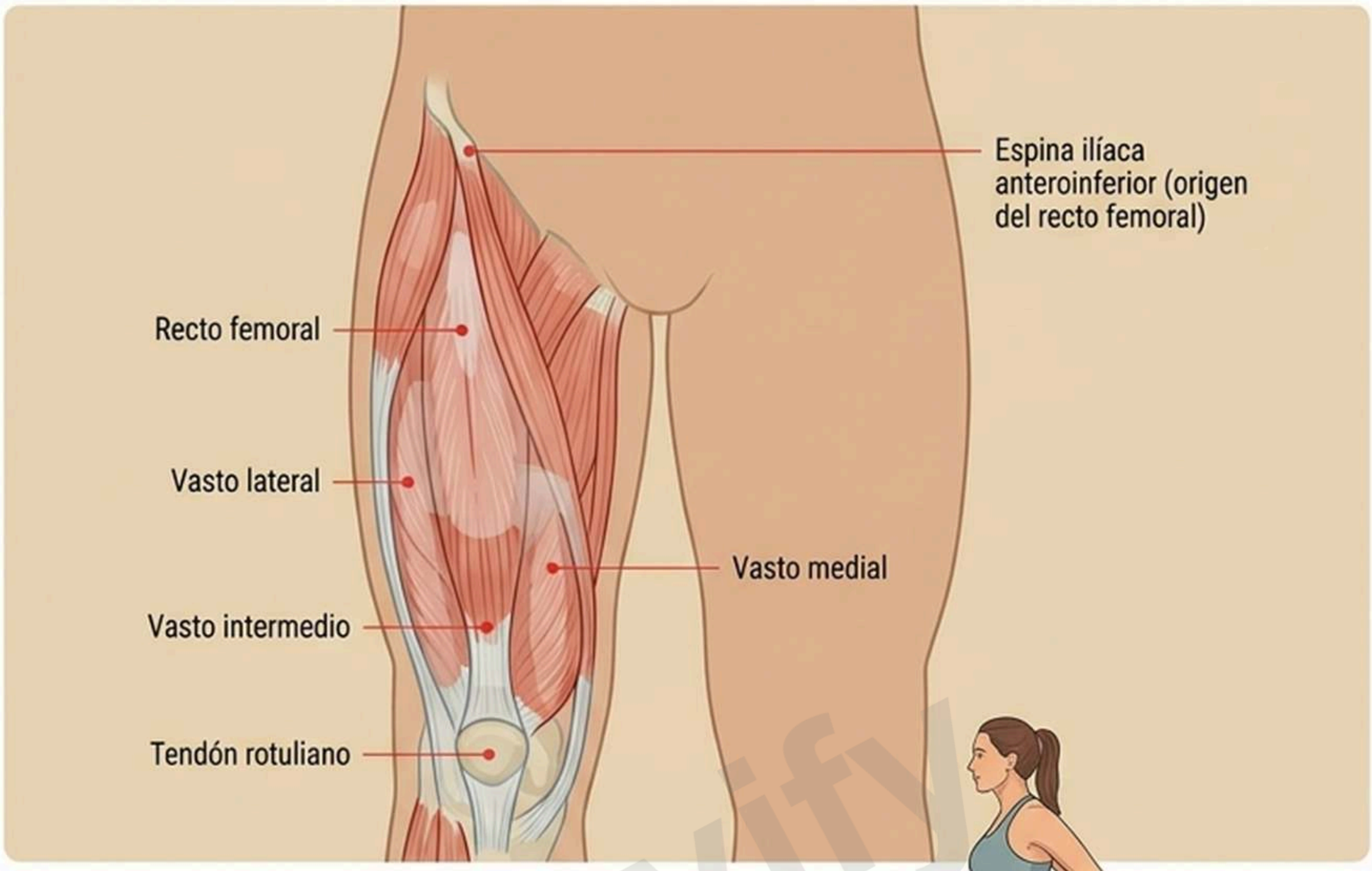
Lo que te frena en la extensión de cadera y columna.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vamos a desarmar la **cadena anterior**, esa línea de tejido que va desde tus rodillas hasta tu pecho y que, cuando está corta, limita todos los movimientos hacia atrás.

Vas a aprender la **anatomía** del **cuádriceps** y los **abdominales**, a **testear** tu movilidad y a **estirarlos con técnica y seguridad**, desde lo más básico hasta lo más avanzado.

CUÁDRICEPS Y RECTO FEMORAL



QUÉ ES

En la cara anterior del muslo, desde la pelvis hasta la tibia.

QUÉ HACE

Extiende la rodilla. El recto femoral, además, flexiona la cadera.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

La extensión de la cadera, sobre todo si se combina con una flexión de rodilla.

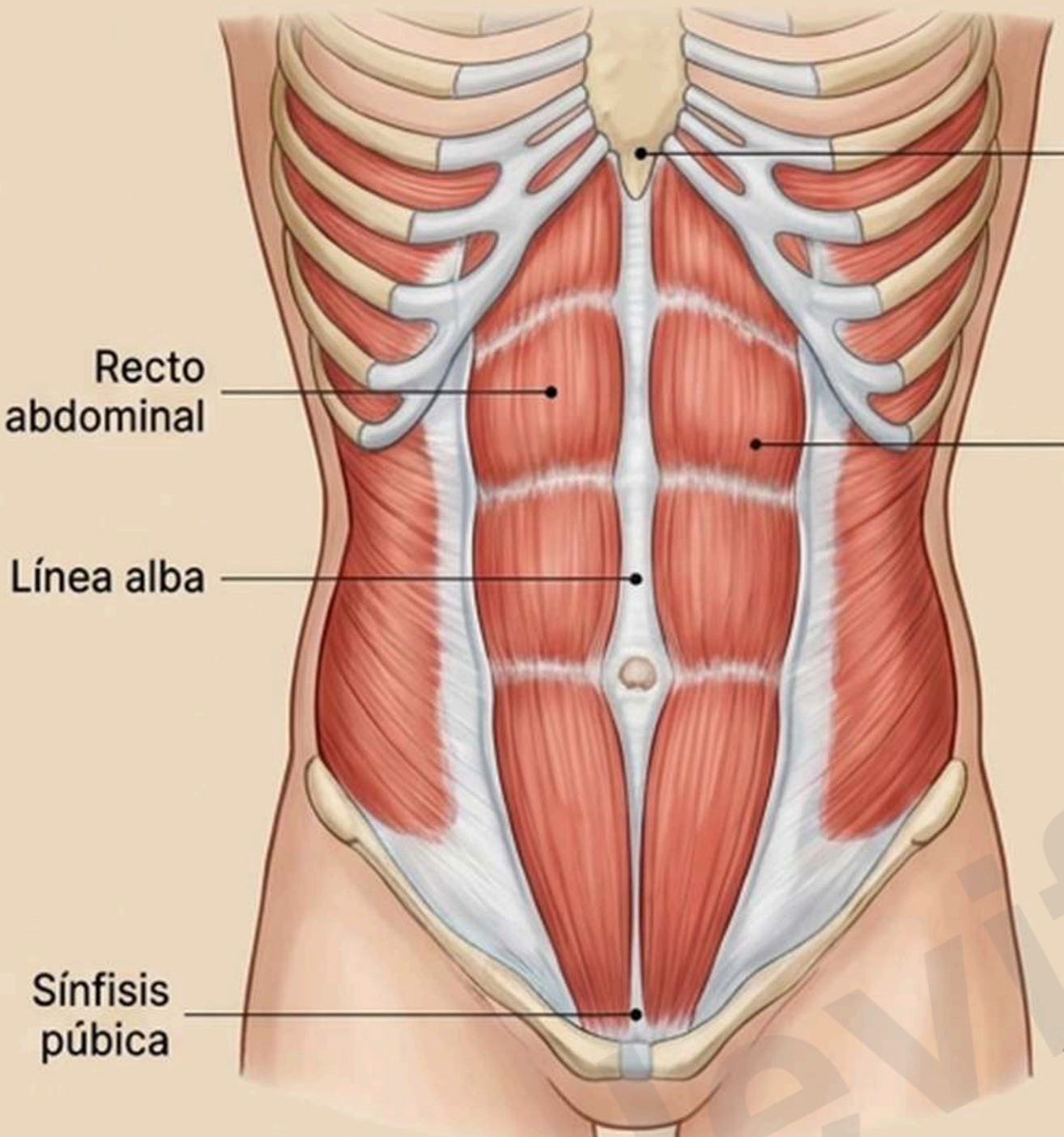
CÓMO SE ESTIRA

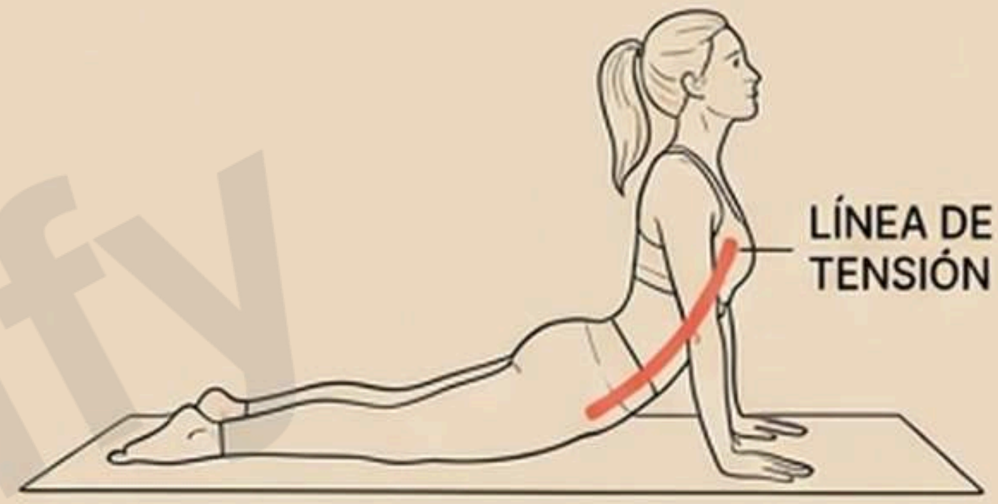
- Para estirar el recto femoral de forma aislada, es clave hacer dos cosas a la vez: **extender la cadera** (llevarla hacia atrás) y **flexionar la rodilla** (llevar el talón a la cola).
- Es fundamental **fijar la pelvis en retroversión** para que la columna lumbar no compense el movimiento, porque si no, el estiramiento se pierde.
- La intensidad debe ser moderada y sostenida.

CUE DE LA FORMADORA

Si solo llevás el talón a la cola sin extender la cadera, estirás los vastos, pero casi nada el recto femoral.

ABDOMINALES Y FASCIA ANTERIOR





DÓNDE ESTÁ: En la pared anterior del abdomen, entre el pubis y las costillas.

QUÉ HACE: Flexiona el tronco y aumenta la presión intraabdominal.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO: La extensión de la columna (el arqueo hacia atrás) y la expansión de la caja torácica.

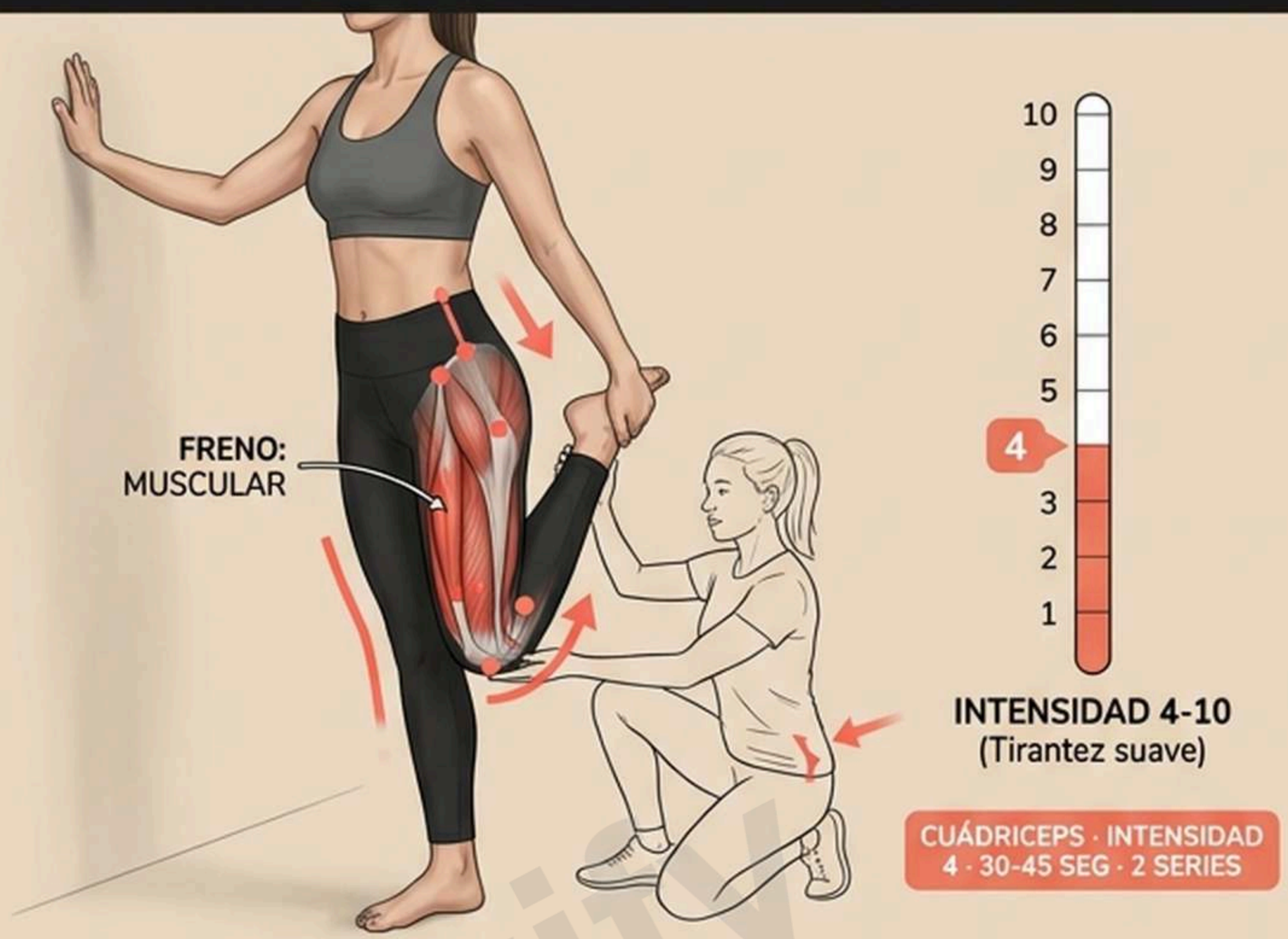
CÓMO SE ESTIRA

El recto abdominal se estra en posiciones de extensión de columna, como el puente o la cobra. Para que el estiramiento sea efectivo y seguro, necesitás anclar la pelvis o las costillas y crear longitud. El foco no es “quebrar” la cintura, sino alargar toda la pared anterior, activando los glúteos para proteger la zona lumbar.

CUE DE LA FORMADORA

Esa sensación de que “tira la panza" en un puente no es debilidad, es la tensión de esta musculatura y su fascia.

CUÁDRICEPS DE PIE Y DE COSTADO



PARA QUIÉN

Nivel: Básico. Para todo el mundo, especialmente principiantes. Fundamental antes o después de correr, caminar o como entrada en calor general. La versión de costado es ideal para quien tiene poco equilibrio.

Zona: Cara anterior del muslo (cuádriceps, con foco en los vastos).

EL ESTIRAMIENTO

Método: estático pasivo.
Intensidad: 4/10.
Tiempo: 30-45 segundos por lado, 2 series.
Respiración: fluida y constante.
Qué se mantiene fijo: pelvis en retroversión y rodillas juntas.

PASO A PASO

1. De pie, apoyá una mano en la pared.
2. Llevá el talón derecho hacia el glúteo y tomá el empeine con la mano derecha (3s).
3. Activá el abdomen y llevá el pubis hacia adelante (retroversión pélvica).
4. Mantené las rodillas alineadas, que no se separe la derecha.
5. Sostené la posición sintiendo el estiramiento en el muslo durante 30-45s.
6. Repetí del otro lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Arquear la espalda:** se corrige llevando la pelvis a retroversión.
2. **Separar la rodilla hacia el costado:** se corrige juntando activamente las rodillas.
3. **Tirar del pie bruscamente:** se corrige haciendo el movimiento lento y controlado.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad: activar glúteo de la pierna que se estira para estabilizar la cadera.
Embarazo: la versión de costado es más cómoda y segura.
Adulto mayor: siempre con apoyo.

Hernia: controlar la retroversión para no generar tensión lumbar.
Rodilla operada: respetar el rango de flexión indicado por el profesional.
Lesión reciente de cuádriceps: no realizar.

REGRESIÓN

Usar una banda o toalla para tomar el pie si no llegás con la mano.

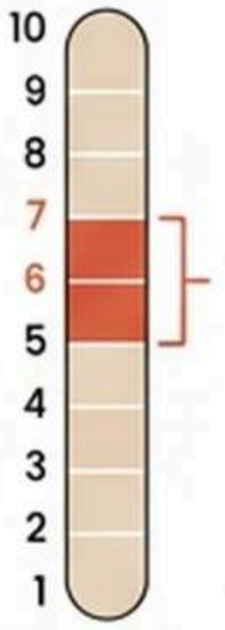
PROGRESIÓN

Desde la posición final, llevar la cadera a una leve extensión para sumar al recto femoral.

PARA SU CASA

No te concentres en llevar el talón a la cola a toda costa, sino en empujar la cadera hacia adelante mientras sostenés el pie.

RECTO FEMORAL EN ZANCADA



INTENSIDAD: 6/10 (TIRANTEZ CLARA PERO SIN DOLOR)

EL ESTIRAMIENTO: ESTÁTICO ACTIVO · 30-60 SEG / LADO · 2-3 SERIES

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para la alumna que pasa mucho tiempo sentada o para corredores y ciclistas. Es clave para liberar la cadera anterior y prevenir la anteversión pélvica. Busca más rango y menos tirantez.

ESTIRIEPAN' DUMADO

Al Arrodillate y a aluyo un y ɾcadado para proyera desienés el antencio emterior y prevenendo anteverr la anteversiòn pélvica.

PASO A PASO

1. Arrodillate y adelantá un pie, formando una zancada (3s).
2. Colocá las manos en la cadera. Activá el glúteo de la pierna de atràs para llevar la pelvis a retroversión.
3. Sin perder esa contracción, desplazã el peso del cuerpo lentamente hacia adelante (5s).
4. Vas a sentir que tira en la parte alta del muslo de atràs. Sostenè ahi 30-60s.
5. Para más intensidad, elevá el brazo del mismo lado de la pierna de atrás.
6. Volvé lento y cambiá de lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Quebrar la cintura (anteversión): se corrige activando el glũteo y pensando en subir el ombligo.
2. La base es muy corta y la rodilla de adelante sobrepasa el tobillo: se corrige alargando la zancada.
3. Rotar la pelvis hacia el lado de la pierna de adelante: se corrige manteniendo las dos crestas iliacas apuntando al frente.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

HIPERMOVILIDAD: No hiperextender la lumbar; foco en la activación.

HERNIA: Crucial el control pélvico; rango menor.

RODILLA OPERADA: Usar una almohadilla gruesa; cuidado con la flexión de la rodiila de atrás si hay progresiòn.

EMBARAZO: Con menos profundidad, puede aliviar la tensiòn lumbar.

ADULTO MAYOR: Con apoyo de las manos en una silla.

LESIÓN RECIENTE DE PSOAS O CUÃDRICEPS: No realizar.

REGRESIÓN: Menor desplazamiento hacia adelante.

PROGRESIÓN: Tomar el pie de atrás con la mano contraria.

PARA SU CASA: "El secreto no está en ir lejos hacia adelante, sino en mantener el glũteo de atrás contraido todo el tiempo".

ACTIVACIÓN EN PUENTE CORTO

NIVEL INICIAL

PARA QUIÉN: CONTROL MOTOR Y DISOCIACIÓN

Para todo el mundo. Fundamental para aprender a disociar la extensión de cadera de la extensión lumbar. Indispensable antes de puentes completos o arcos.

EL ESTIRAMIENTO: MÉTODO ACTIVO · FUERZA

Intensidad: 5-7 (trabajo de fuerza).
Repeticiones: 2 series de 8-12 lentas.
Respiración: exhalar al subir la pelvis.
Mantené fija: la columna lumbar, sin arquear.

PASO A PASO

1. Acostate boca arriba, pies cerca de glúteos.
2. Inhalá. Exhalá, presioná pies y contraé glúteos para elevar
3. Subí solo hasta alinear rodillas, caderas y hombros.
4. Sostené arriba 2s, apretando glúteos.
5. Inhalá y bajá lento vértebra por vértebra (4s).
6. Repeti 8-12 veces.

❌ ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Subir demasiado y quebrar cintura**
(Corrección: bajar altura, enfocar en glúteo).
2. **Dejar que las rodillas se abran**
(Corrección: imaginar pelota entre rodillas).
3. **Hacerlo con impulso y rápido**
(Corrección: cada subida y bajada 4s).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

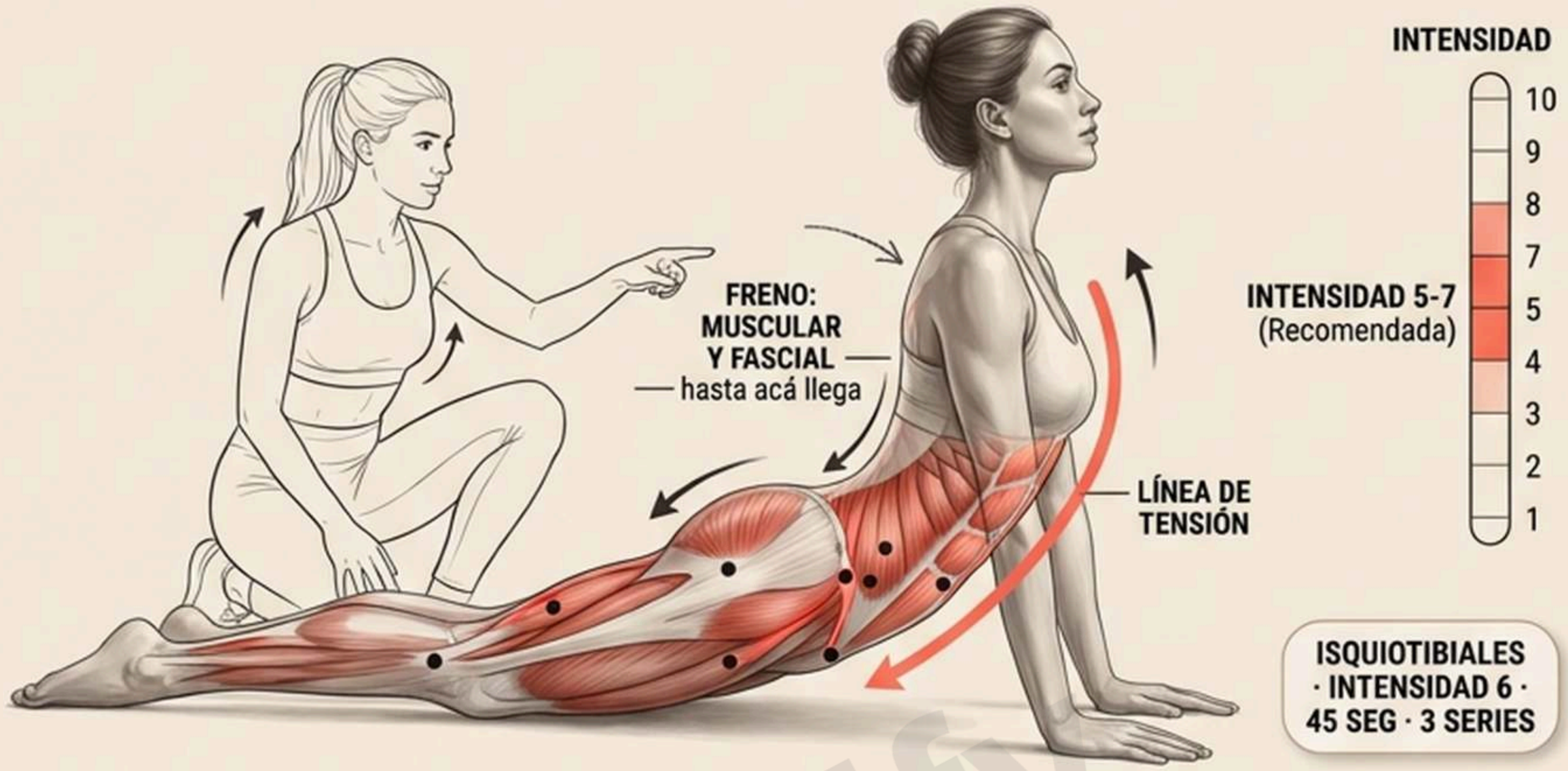
✓ **Hipermovilidad:** (✕) no pasar la línea recta.
✕ **Hernia:** (✕) rango corto y controlado.
✓ **Rodilla operada:** (✓) generalmente seguro.
✓ **Embarazo:** (✓) seguro hasta 2° trimestre.
✓ **Adulto mayor:** (✓) excelente para fuerza.
✕ **Lesión lumbar aguda:** (✕) consultar profesional.

REGRESIÓN: reducir el rango de movimiento.

PROGRESIÓN: puente a una sola pierna.

PARA SU CASA: "Sentí que la fuerza sale 100% de tus glúteos. La espalda baja solo acompaña, no trabaja".

APERTURA EN ESFINGE Y COBRA



PARA QUIÉN: Para la alumna que siente rigidez en la columna o necesita estirar la pared abdominal después de un entrenamiento intenso. La esfinge es una opción muy segura para empezar.

EL ESTIRAMIENTO:
Método: Estático activo.
Intensidad: 5/10 (Esfinge) a 7/10 (Cobra).
Tiempo: 30-60 segundos o 5-8 respiraciones profundas.
Qué se mantiene fijo: El pubis presionado contra el suelo.
Respiración: Fluida.

PASO A PASO

1. **ESFINGE:** Desde boca abajo, apoyá los antebrazos en el suelo, paralelos, con los codos debajo de los hombros.
2. **Presioná el pubis** contra el suelo y activá suavemente los glúteos.
3. **Inhalá** y, al **exhalar, alargá la columna** y **elevá el pecho**, como si tiraran de tu esternón hacia adelante y arriba (5s).
4. **Sostené** por 5-8 respiraciones.
5. **COBRA (PROGRESIÓN):**

   Desde boca abajo, colocá las manos a los lados del pecho.
6. **Anclá el pubis** en el suelo, activá glúteos y empujá el suelo con las manos para elevar el torso. Los codos quedan flexionados.
7. **Llevá los hombros atrás y abajo**. Sostené la posición.

ERRORES QUE VES EN LA SALA (CRUZ ROJA)

- ✕ **Comprimir la lumbar:** Se corrige activando más los glúteos y el abdomen, y bajando la altura del arco.
- ✕ **Encoger los hombros hacia las orejas:** Se corrige activando la espalda alta para separar hombros y orejas.
- ✕ **Levantar la pelvis del suelo:** Se corrige bajando la altura hasta que la pelvis pueda permanecer apoyada.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** No colgarse; mantener tono muscular.
- ✕ **Hernia:** Esfinge segura si no hay dolor; cobra con control.
- ✓ **Embarazo:** Contraindicado.
- ✓ **Adulto mayor:** Esfinge excelente opción.
- ✕ **Lesión reciente:** No realizar.

PARA SU CASA:

"La clave no es qué tan alto subís, sino qué tan largo te sentís. Creá espacio entre cada vértebra".

EXTENSIÓN DE CADERA DE RODILLAS

PARA QUIÉN

Solo para practicantes con experiencia, buena extensión de cadera y torácica controlada, y sin patología lumbar.
Busca aumentar el rango de extensión de cadera y reducir tirantez anterior.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático activo o dinámico controlado.
INTENSIDAD: 7-8/10.
TIEMPO: 15-30 seg (estático) o 3-5 reps dinámicas lentas.
RESPIRACIÓN: Fluida y controlada.
FIJO: Contracción isométrica de glúteos y abdomen.

PASO A PASO

1. De rodillas, rodillas al ancho de caderas, empeines apoyados. Manos en el sacro, dedos hacia abajo.
2. Activá fuertemente glúteos y transverso abdominal. Sentí el coxis bajar.
3. Elevá el esternón hacia el techo. Extensión torácica inicial (5s).
4. Manteniendo la línea larga, inclinate hacia atrás como un bloque desde las rodillas. No quiebres la cintura (Ss).
5. Mantené el cuello largo, en linea con la columna. Sostené la posición.
6. Volvé usando la fuerza del cuádriceps y el abdomen.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Quebrar la zona lumbar:** Activá glúteos, empezá desde el pecho.
2. **Dejar caer la cabeza sin control:** Mantené el mentón recogido y cuello activo.
3. **No usar los glúteos:** Enfocate en la contracción del glúteo como motor principal.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **HIPERMOVILIDAD:** Muchísimo control, rangos cortos, foco en activación.
- **REGRESIÓN:** Manos en sacro todo el tiempo.

- **HERNIA LUMBAR/CERVICAL:** Contraindicado.
- **RODILLA OPERADA:** Depende de tolerancia.
- **EMBARAZO:** Contraindicado.
- **ADULTO MAYOR:** No recomendado.
- **LESIÓN RECIENTE:** Contraindicado.
- **PROGRESIÓN:** Manos a los talones (si hay control total).

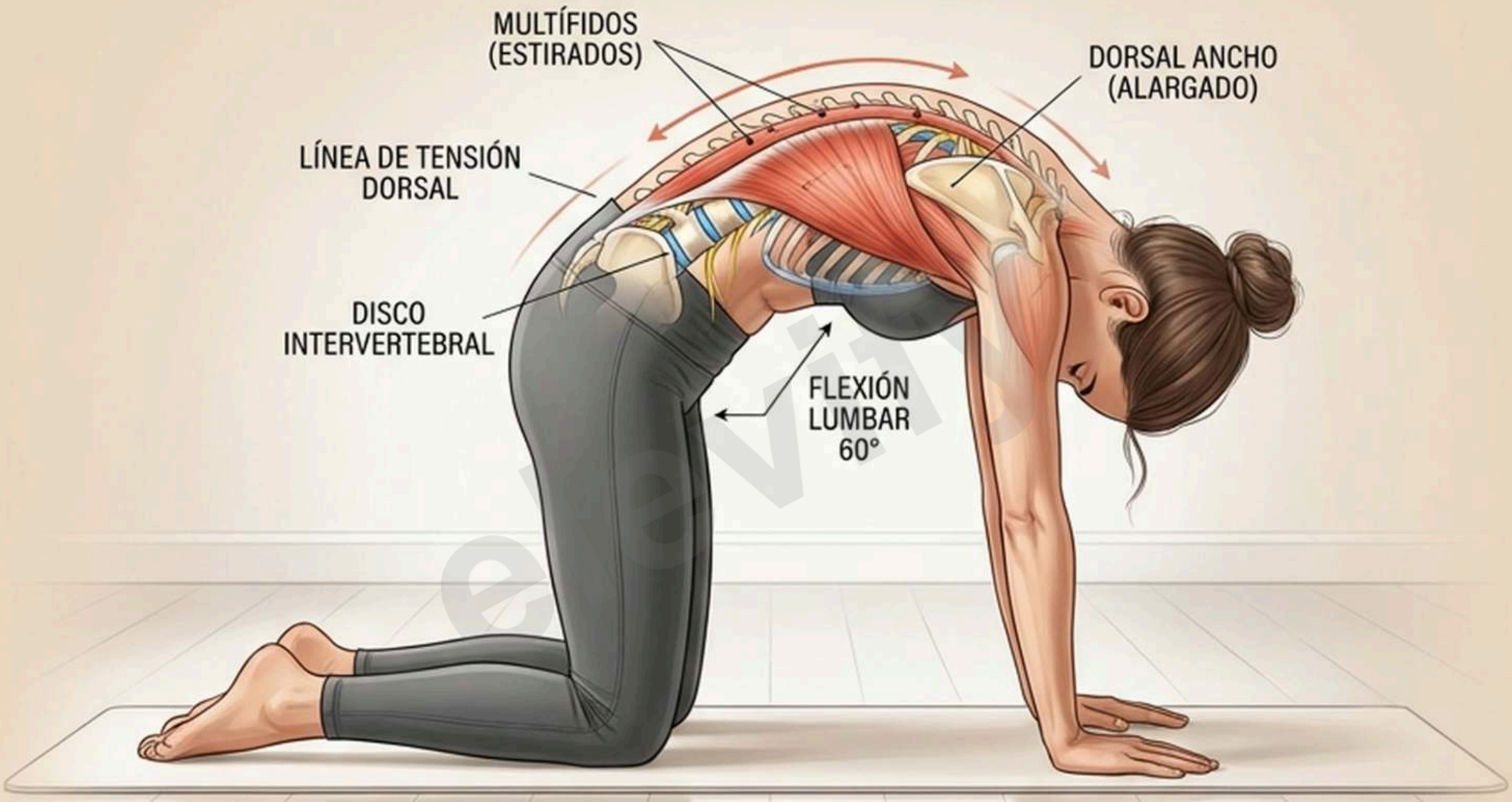
> **CUE DE LA FORMADORA:** "Este ejercicio no es para experimentar. Si no dominás la zancada con retroversión y el puente con control, todavía no es el momento."

RESUMEN: CADENA ANTERIOR Y SOLUCIONES

Molestia frecuente	Posible causa (músculo corto)	Estiramiento clave (página)
'Tirantez en la parte delantera del muslo al caminar rápido o correr'.	Cuádriceps (especialmente los vastos)	Cuádriceps de pie y de costado (p. 97)
'Ligero dolor lumbar al estar mucho tiempo de pie'.	Psoas ilíaco y recto femoral (generan anteversión pélvica)	Recto femoral en zancada (p. 98)
'Siento que mi espalda baja se 'quiebra' en los puentes'.	Falta de control para extender la cadera desde el glúteo.	Activación en puente corto (p. 99)
'Sensación de 'tope' al intentar llevar la pierna hacia atrás'.	Recto femoral	Recto femoral en zancada, progresión tomando el pie (p. 98)
'Me tira el abdomen al intentar hacer un arco'.	Recto abdominal y fascia anterior	Apertura en esfinge y cobra (p. 100)
'Calambres en los isquiotibiales al hacer el puente'.	Glúteos débiles o inhibidos; los isquiotibiales compensan	Activación en puente corto (p. 99)
'Postura con la pelvis hacia adelante (anteversión)	Acortamiento general de los flexores de cadera	Recto femoral en zancada (p. 98)
'Me cuesta respirar profundo cuando hago extensiones'.	Rigidez en la pared abdominal y los músculos intercostales	Apertura en esfinge (p. 100)

COLUMNA

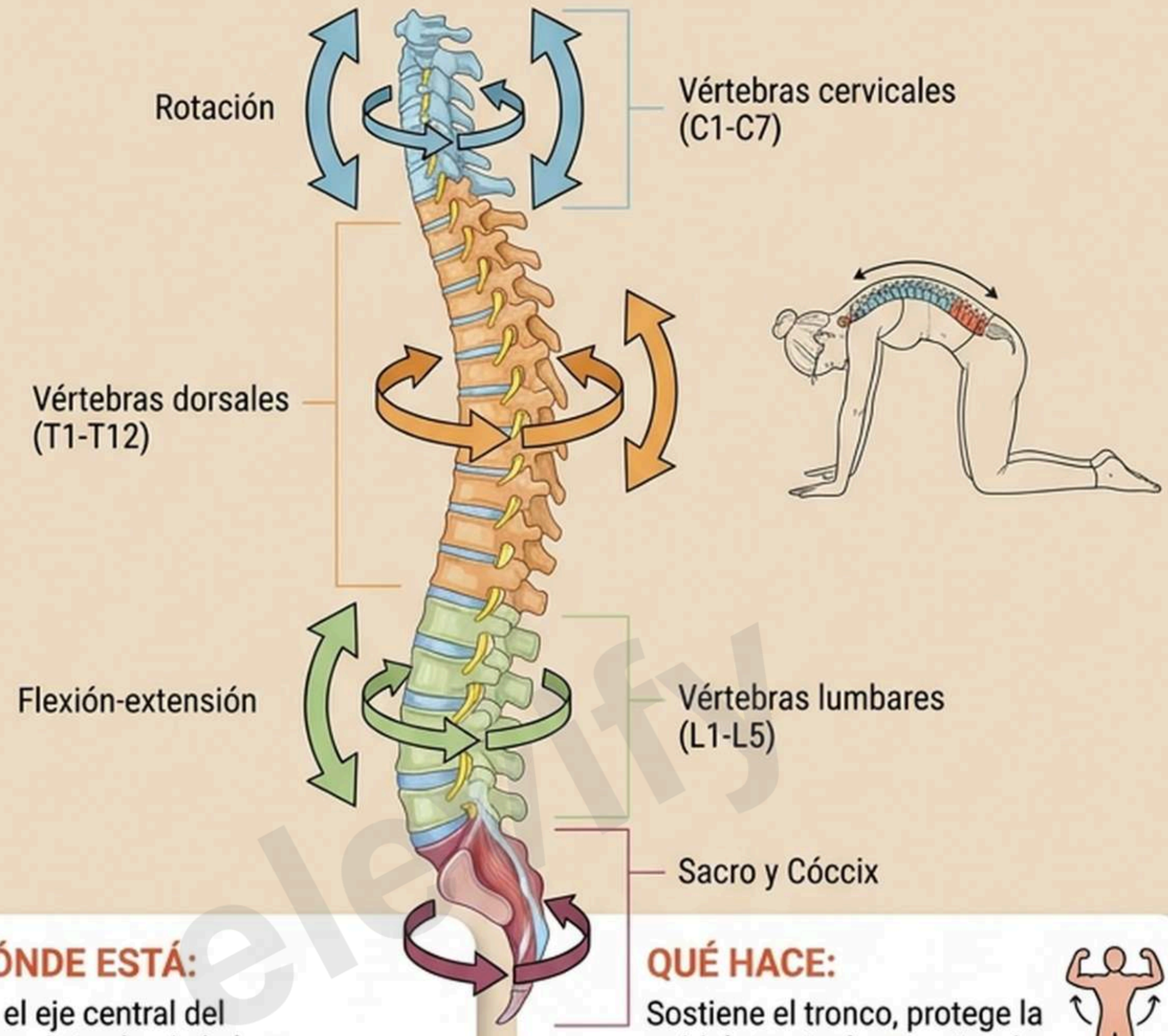
Doblarnos y girar es vital, **pero la clave está en saber desde dónde y cómo para proteger los discos y las vértebras.**

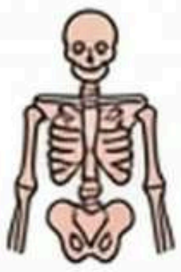


QUÉ VAS A ENCONTRAR

- Anatomía clave: discos, multífidos y dorsal ancho.
- Cómo disociar los tramos de la columna para mover cada parte con control.
- Ejercicios seguros para flexión, extensión y rotación.
- Qué hacer y qué no si tenés escoliosis o hernia discal (fuera de crisis).

LOS TRAMOS DE LA COLUMNA





DÓNDE ESTÁ:

Es el eje central del esqueleto, desde la base del cráneo hasta la pelvis.

QUÉ HACE:

Sostiene el tronco, protege la médula espinal y permite el movimiento en los tres planos.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO:

La rigidez en un tramo (típicamente dorsal) obliga a los otros (lumbar y cervical) a compensar, sobrecargándolos.

CÓMO SE ESTIRA:

La columna no se estira como un músculo, se moviliza. Buscamos recuperar la capacidad de movimiento articulado en cada tramo. La clave es disociar: aprender a mover la zona dorsal sin quebrar la lumbar, o rotar sin mover la pelvis. Se trabaja con movimientos suaves y controlados.

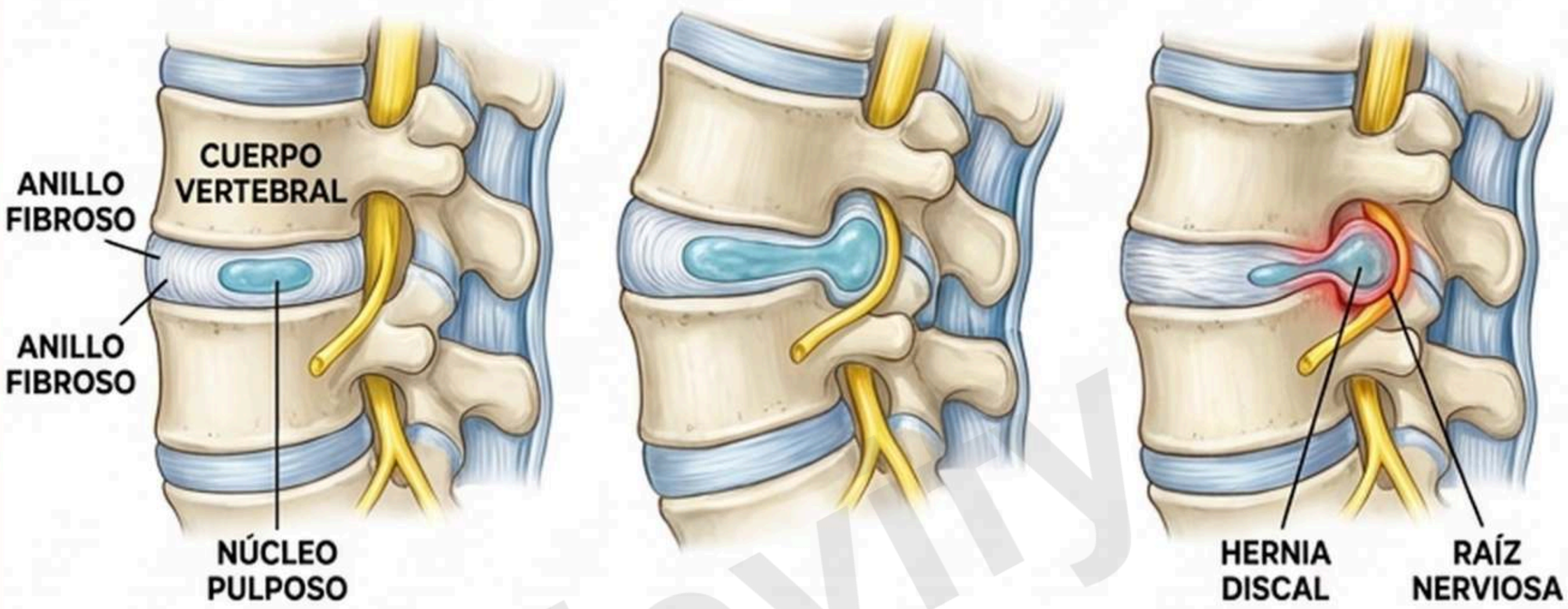
CUE DE LA FORMADORA

Recordale a tu alumna que piense en mover “vértebra por vértebra”, como un collar de perlas.

EL DISCO Y LA HERNIA

LÁMINA ANATÓMICA DEL MÚSCULO O ESTRUCTURA

EL DISCO INTERVERTEBRAL



DÓNDE ESTÁ:

Entre cada par de vértebras, desde C2 hasta L5.

QUÉ HACE:

Amortigua la carga y permite el **movimiento** entre las vértebras.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO:

No se acorta. Se **degenera y deshidrata** con el tiempo y las malas cargas, perdiendo **altura y capacidad de amortiguación**.

CÓMO SE ESTIRA

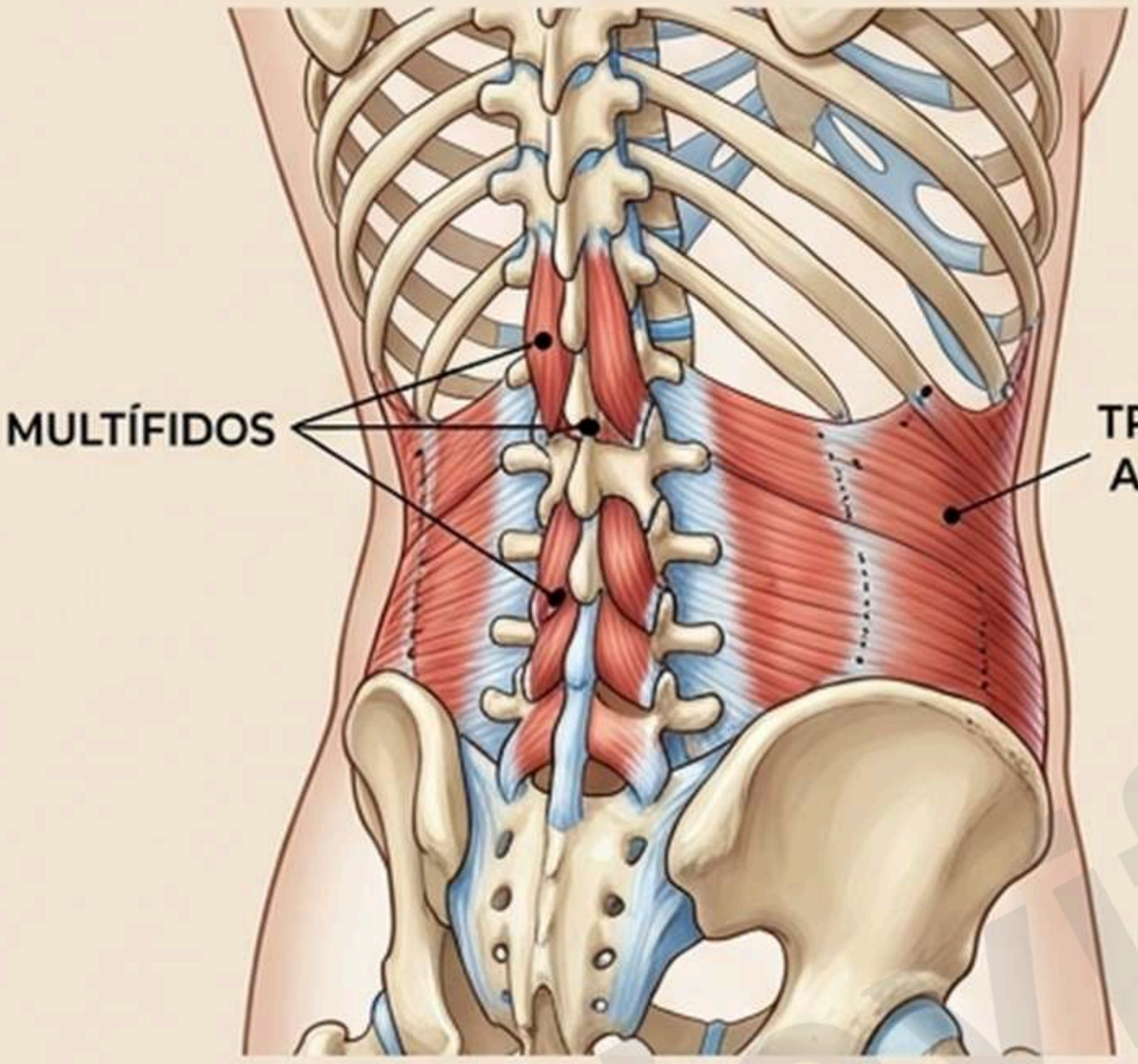
El **disco no se estira**: se cuida. La flexión de columna con carga empuja el núcleo hacia atrás, aumentando el riesgo de hernia. Por eso, para levantar peso, flexionamos las caderas y rodillas manteniendo la columna neutra.

CUE DE LA FORMADORA

→ La frase clave es **"bisagra de cadera"**, no **"bisagra de lumbar"**.

MULTÍFIDOS Y TRANSVERSO ABDOMINAL

ANATOMÍA CLAVE PARA LA ESTABILIDAD LUMBAR



ACTIVACIÓN EN PLANCHA

DÓNDE ESTÁN

Los multifidos, pegados a las vértebras lumbares por detrás, de apófisis a apófisis. El transverso, en la pared abdominal profunda, envolviendo el tronco como un corset natural.

QUÉ HACEN

Juntos, actúan como una faja natural que estabiliza la columna lumbar, controlando el movimiento segmentario entre cada vértebra. Son clave para proteger los discos intervertebrales.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

No suelen acortarse; el problema principal es su debilidad o falta de activación, lo que deja la columna lumbar inestable y vulnerable a lesiones.

CÓMO SE ESTIRA

LA CLAVE ES ACTIVAR

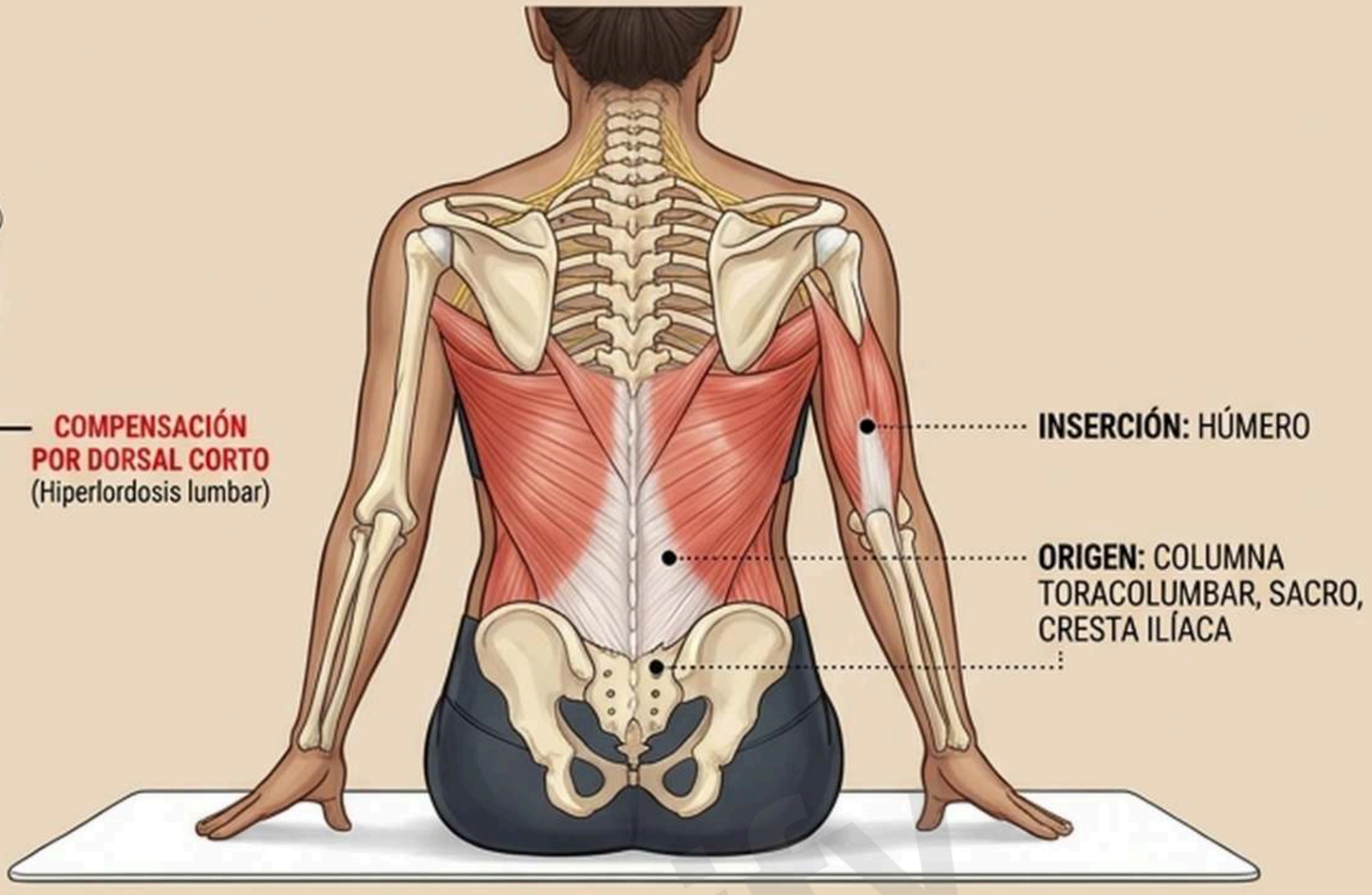
Estos músculos profundos no se estiran de forma tradicional, se activan y fortalecen. El objetivo es que aprendan a contraerse para dar soporte constante. Ejercicios de control motor como el **"gato y vaca" segmentado** o la **plancha con respiración consciente** son excelentes para despertarlos. Se busca la sensación de **"ajustar un cinturón interno"** sin bloquear la respiración.

CUE DE LA FORMADORA

Pedile al alumno que tosa suavemente y ponga atención en su bajo vientre: el músculo que siente contraerse profunda e internamente es el transverso abdominal. Esa es la sensación a buscar.

EL DORSAL ANCHO

COMPENSACIÓN POR DORSAL CORTO
(Hiperlordosis lumbar)



INSERCIÓN: HÚMERO

ORIGEN: COLUMNA TORACOLUMBAR, SACRO, CRESTA ILÍACA

DÓNDE ESTÁ

Es un músculo muy grande que conecta el brazo con la pelvis y la columna, formando la forma de "V" en la espalda.

QUÉ HACE

Extiende, aduce y rota internamente el brazo. Es el músculo principal para movimientos de tracción como "trepar".

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

La flexión completa del hombro (levantar el brazo por encima de la cabeza). Para compensar, el alumno suele arquear la zona lumbar, lo que genera pinzamiento y dolor.

CÓMO SE ESTIRA

INTENSIDAD: 5-7
(Tirantez, no dolor)

EL ESTIRAMIENTO

DORSAL ANCHO · INTENSIDAD 6 · 45 SEG · 3 SERIES

CUE DE LA FORMADORA
Si al levantar los brazos se le arquea la lumbar, su dorsal ancho probablemente esté corto y está compensando con la columna.

GATO Y VACA CONTROLADO

GATO Y VACA CONTROLADO: MOVILIDAD DE COLUMNA

NIVEL BÁSICO

PARA QUIÉN:
Ideal para empezar a movilizar la columna de forma segura y para calentar antes de cualquier práctica.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Dinámico controlado.
Intensidad: 2-3/10.
Tiempo: 8-12 repeticiones lentas.
Respiración: Exhalar al redondear (gato), inhalar al arquear (vaca).
Fijo: Caderas sobre rodillas, hombros sobre muñecas.

PASO A PASO

1. Desde cuatro apoyos, inhalá.
2. Al exhalar, redondeá la columna desde el cóccix hasta la cabeza (5 seg).
3. Sostené el "gato" 2 seg.
4. Al inhalar, arqueá desde el cóccix hasta la cabeza, abriendo el pecho (5 seg).
5. Sostené la "vaca" 2 seg.
6. Repetí el ciclo 8-12 veces.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

Mover todo en bloque (**corregir:** iniciar desde pelvis).

Quebrar el cuello (**corregir:** alargar nuca).

Flexionar codos (**corregir:** brazos extendidos).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ Hipermovilidad (sí, con control), hernia fuera de crisis (sí, suave), rodilla operada (sí, con almohadón), adulto mayor (sí, o en silla)

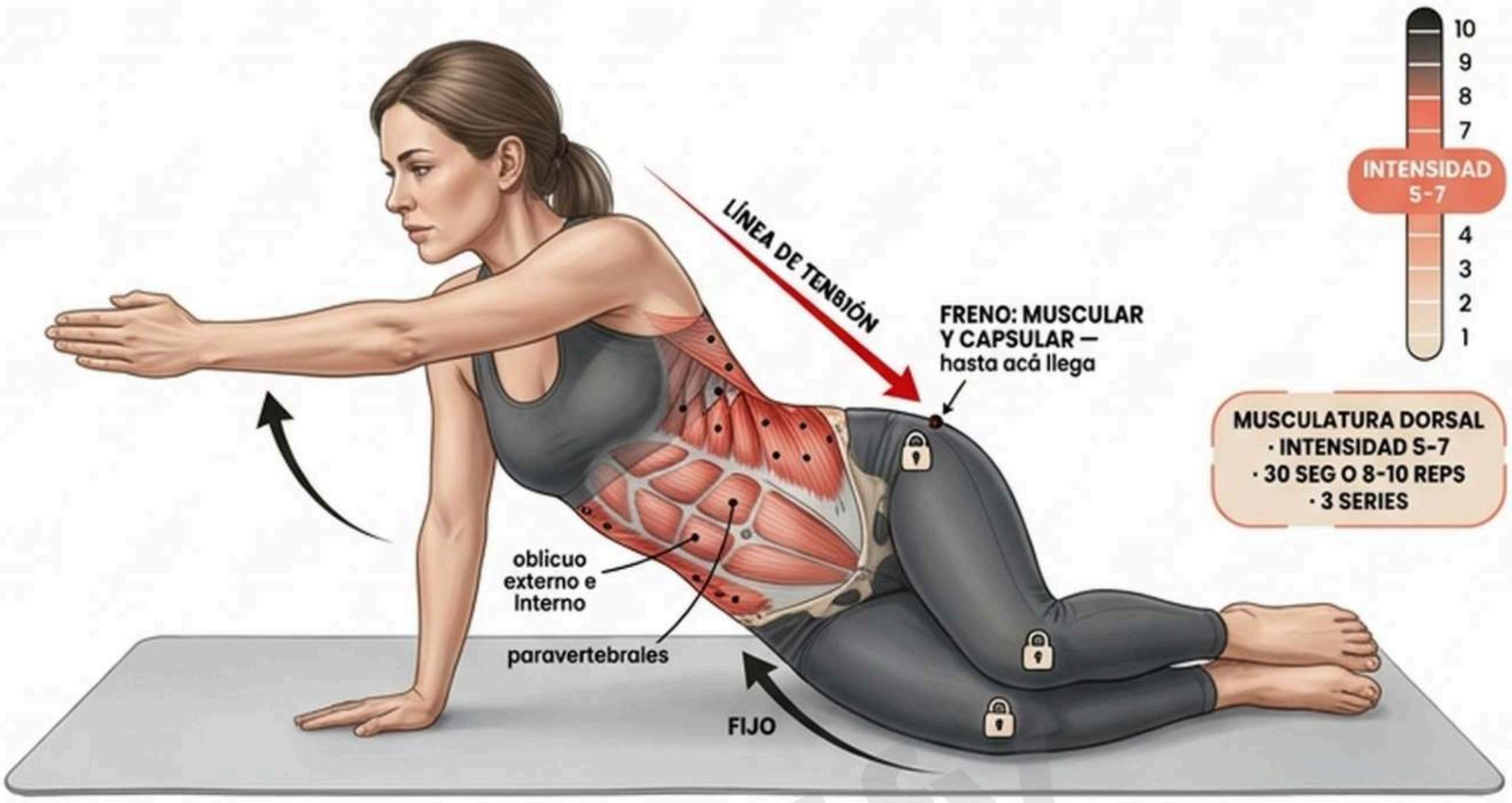
✗ Embarazo (evitando extensión máxima), lesión reciente (no sin alta médica).

REGRESIÓN: Rango de movimiento más pequeño.

PROGRESIÓN: Disociar por tramos (solo lumbar, solo dorsal).

PARA SU CASA: Hacelo todas las mañanas al levantarte para despertar la columna.

ROTACIÓN DE COLUMNA



PARA QUIÉN:

Alumnos con rigidez dorsal, especialmente quienes pasan mucho tiempo sentodos.

Nivel Básice. Busca mejorar el rango de rotación, reducir la tensión y favorecer la movilidad de la columna torácica. La limitación principal es ia rigidez articular y el acortamiento articular y el acortamiento muscular y fascial en la zona dorsal y los oblicuos.

EL ESTIRAMIENTO:

Método: Estático activo o dinámico.
Intensidad: 4-6/10.
Tiempe: Sostener 30 segundos o realizar 8-10 repeticiones por lado.
Respiraciân: Exhalar profundo al entrar en la rotación para permitir la liberaciòn de la musculatura respiratoria.
Flje: La pelvis debe permanecer estable, con las rodillas mantenidas juntas en contacto con el suelo.

PASO A PASO:

1. Acostate de lado con las rodillas flexionadas a 90ª y los brazos extendidos al frente, palmas juntas. (30 seg)
2. Inhalâ profundamente y, al exhalar, abri el brazo de arriba como si abrieras un libro, llevando el dorso de la mano hacia el suelo detrâs tuyo. (5 seg)
3. Seguí el movimiento con el pecho y la cabeza, intentando que el hombro se acerque al suelo, no solo el brazo. (5 seg)
4. Asegurate de que las rodillas no se separen ni se levanten del suelo; si lo hacen, el movimiento está limitado por la pelvis. (Constante)
5. Sostené la posición de máxima apertura cómodamente por 30-45 segundos. (30-45 seg)
6. Regresá el brazo de forma lenta y controlada hasta la posición inicial y repetí del otro lado. (5 seg)

ERRORES QUE VES EN LA SALA:

1. **Levantar las rodillas del suelo:** La rotación se compensa en la pelvis y la lumbar.
   CORRECCIÓN: Mantener las rodillas juntas y en contacto con el suelo durante todo el movimiento.
2. **Forzar el giro desde el cuello:** El movimiento se genera solo en las cervicales, sin rotar la columna dorsal.
   CORRECCIÓN: La cabeza solo acompaña suavemente el movimiento del tronco y el brazo.
3. **Hacerlo con impulso o rebotande:** Aumenta el riesgo de lesión y no permite la relajación muscular necesaria.
   CORRECCIÓN: Kealizar el movimiento de manera lenta y controlada, utllizando la exhalaciòn para profundizar.

QUÉ SÍ / QUÉ NO:

- **Hipermovilidad** (Sí, con control y sin forzar ei rango final)
- **Hernia discal** (5Í, con cuidado en ia zona lumbar, dorsal posible si no duele; consultar profesional)
- **Rodilla operada** (Sí, no afecta directamente)
- **Embarazo** (Sí. se puede adoptar con almohadas o realizar en silla)
- **Adulto mayor** (Sí, con rango limitado y preferentemente en
- **Lesiòn reciente** (NO, evitar si es costal o en ia columna; consultar médico)

REGRESIÓN:

Realizar el movimiento con un rango de movimiento más pequeño, sin intentar llegar al suelo con el hombre.

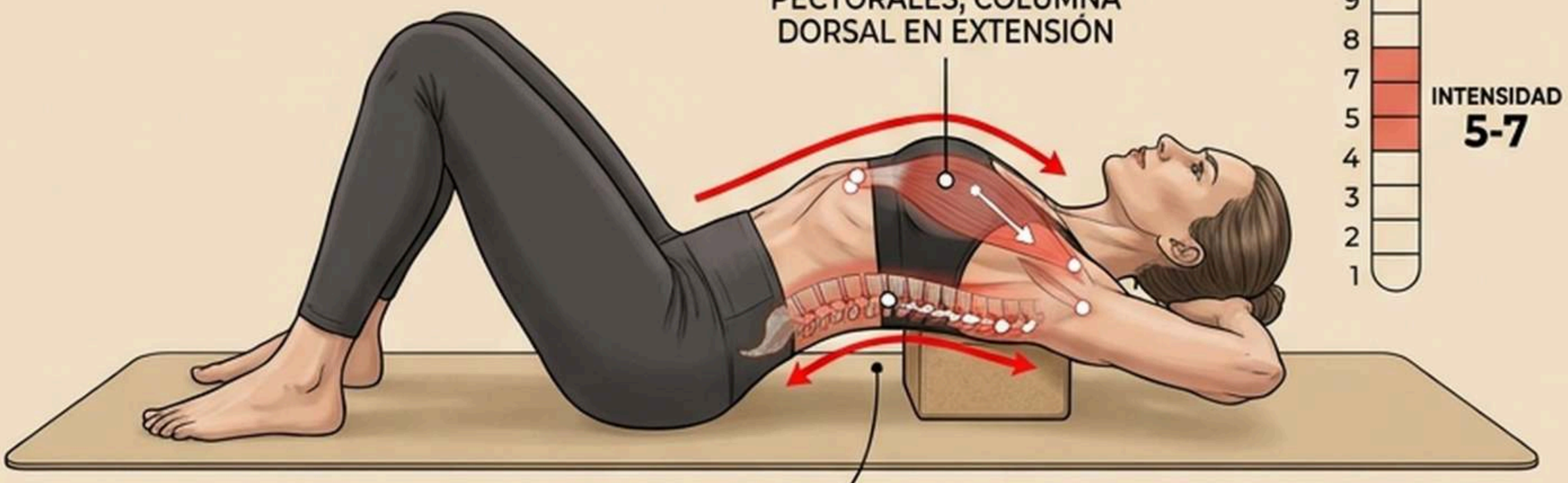
PROGRESIÓN:

En lo versión sentada, tomarse del respaldo de la silla con una mano paro asistir suovemente en ia rotaclén, aumentando el rango.

PARA SU CASA:

Podés hacerlo sentado en tu silla de trabajo vorias veces al dio paro allviar io tensién. Rtecordô siempre hacerlo lento y sin dolor.

EXTENSIÓN DORSAL SOBRE BLOQUE



PARA QUIÉN: Alumnos con hipercifosis dorsal ("espalda encorvada"). Nivel Intermedio.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático pasivo.
Intensidad: 5-7/10.
Tiempo: Sostener 60-90 seg.
Respiración: Larga y profunda, al pecho.
Fijo: Pelvis en el suelo.

PASO A PASO

1. **Colocá el bloque.** Sentate delante, rodillas flexionadas. (10 seg)
2. **Manos detrás de la nuca** para sostener la cabeza. (5 seg)
3. **Exhalando, recostate** lento hacia atrás. (10 seg)
4. **Cabeza sostenida,** cuello largo. (5 seg)
5. **Ajustá la posición** del bloque. (5 seg)
6. **Mantené 60-90 seg.** Salí rodando. (90 seg)

ERRORES QUE VES EN LA SALA (✕)

- ✕ Colocar en la lumbar (**CORREGIR:** siempre dorsal)
- ✕ Dejar caer la cabeza (**CORREGIR:** sostenerla)

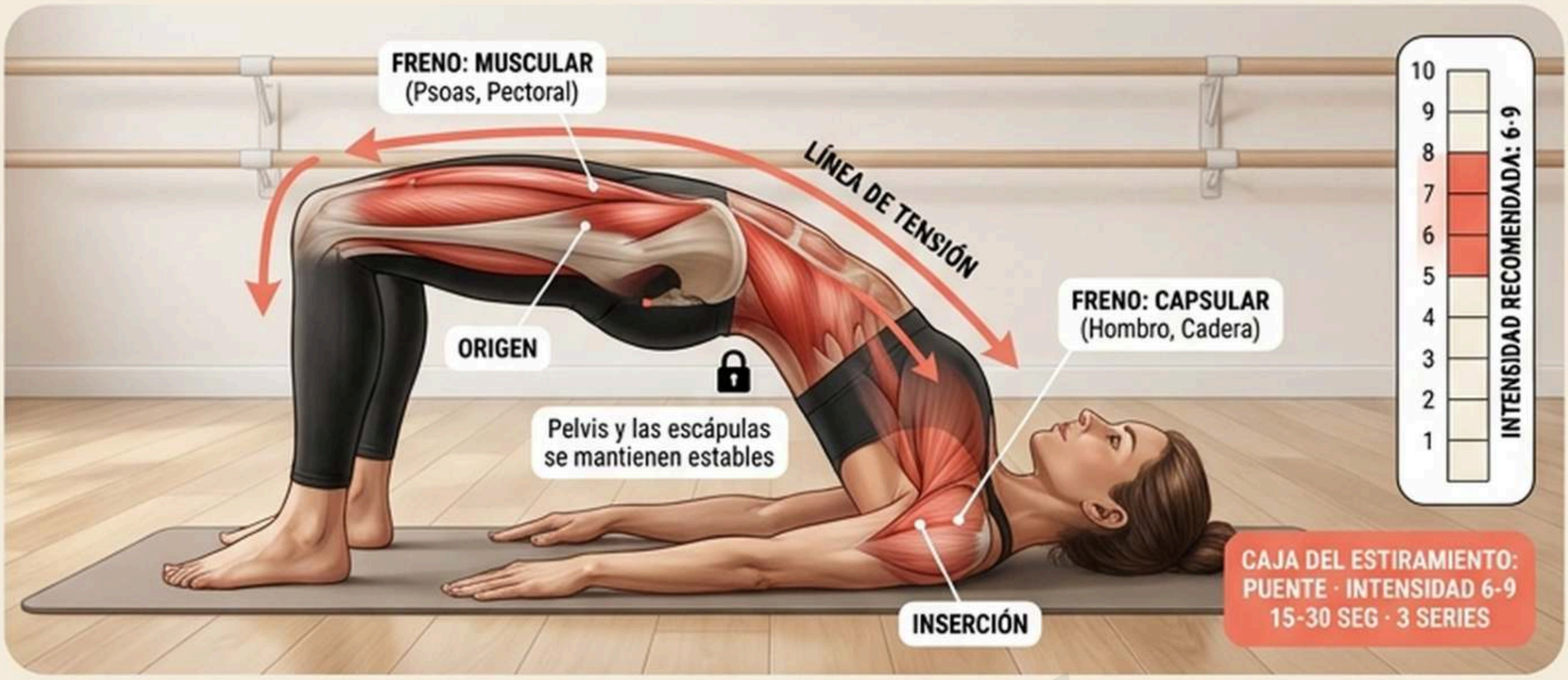
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ Hipermovilidad (✓ con bloque bajo)
- ✕ Hernia (✕ dorsal si duele)
- ✓ Rodilla operada
- ✓ Abcomenrada (✓)
- ✕ Embarazo
- ✓ Adulto mayor (✓ con toalla)
- ✕ Lesión reciente

REGRESIÓN: Usar una toalla enrollada. **PROGRESIÓN:** Extender los brazos por encima.
PARA SU CASA: Hacelo al final del día para revertir la postura de la computadora.

CAP 8 · COLUMNA:
FLEXIÓN, EXTENSIÓN Y ROTACIÓN

PUENTE PROGRESIVO



PARA QUIÉN

Alumnos que buscan mejorar la extensión de columna y apertura de hombros y flexores de cadera.
Nivel: Progresión de Básico a Avanzado.
Freno que se trabaja: Rigidez dorsal, acortamiento de flexores de cadera y cadena anterior del hombro.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático activo. **Intensidad:** 6-9/10. **Tiempo:** Sostener 15-30 seg.
Respiración: Fluida. **Posición de partida:** Varía según el nivel.

PASO A PASO (PROGRESIÓN)

1. **Nivel 1 (Mesa invertida):** Sentado, levantá la pelvis con apoyo de manos y pies. (15-30 seg).
2. **Nivel 2 (Medio puente):** Acostado, levantá la pelvis y espalda hasta apoyar en hombros. (15-30 seg)
3. **Nivel 3 (Apoyo en cabeza):** Desde el medio puente, apoyá las manos y luego la coronilla suavemente. (5-10 seg)
4. **Nivel 4 (Puente completo):** Empujá desde el suelo o paso 3 para extender codos y rodillas. (15-30 seg)

ERRORES QUE VES EN LA SALA

Pies o manos abiertos.
Pies y manos paralelos al ancho de hombros.

Quebrar la lumbar excesivamente.
Empujar el pecho hacia adelante para abrir la dorsal.

Colapsar en hombros (hombros hacia orejas)
Volver a la regresión anterior si no se puede sostener la apertura.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✅ Hipermovilidad (con mucho control, sin colapsar)
- ❌ Hernia discal (no se recomienda)
- ✅ Rodilla operada (sí, variantes bajas con cuidado)
- ❌ Embarazo (no)
- ✅ Adulto mayor (no el completo, sí mesa y medio puente)
- ❌ Lesión reciente (muñecas/hombros/espalda, no)

REGRESIÓN: Quedarse en mesa o medio puente.

PROGRESIÓN: Acercar pies a manos o levantar una pierna.

PARA SU CASA: "No te apures. La fuerza y flexibilidad que construís en las regresiones te van a proteger. Escuchá a tu cuerpo."

FLEXIÓN LATERAL CON BRAZO

FLEXIÓN LATERAL CON BRAZO NIVEL BÁSICO

PARA QUIÉN

Para todos los niveles. Útil para liberar tensión en los costados del tronco. Busca alargar la cadena lateral y mejorar la movilidad torácica.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático activo. **Intensidad:** 4-6/10 (tirantez suave).
Tiempo: Sostener 30-45 seg por lado. **Respiración:** Inhalar para alargar, exhalar para profundizar la flexión. **Fijo:** La pelvis.

PASO A PASO

1. De pie, pies ancho de caderas, inhalá y elevá el brazo derecho.
2. Exhalando, flexioná el tronco hacia la izquierda, formando una "C". **3.** Mantené el pecho abierto, sin rotar
4. Sostené 30-45 seg, respirando hacia las costillas derechas. **5.** Inhalando, regresá al centro con control.
6. Repetí del otro lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Desplazar la cadera (corregir:** activar glúteo para estabilizar).
- **Colapsar hacia adelante (corregir:** imaginar estar entre dos paredes).
- **Encoger el hombro (corregir:** relajarlo lejos de la oreja).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

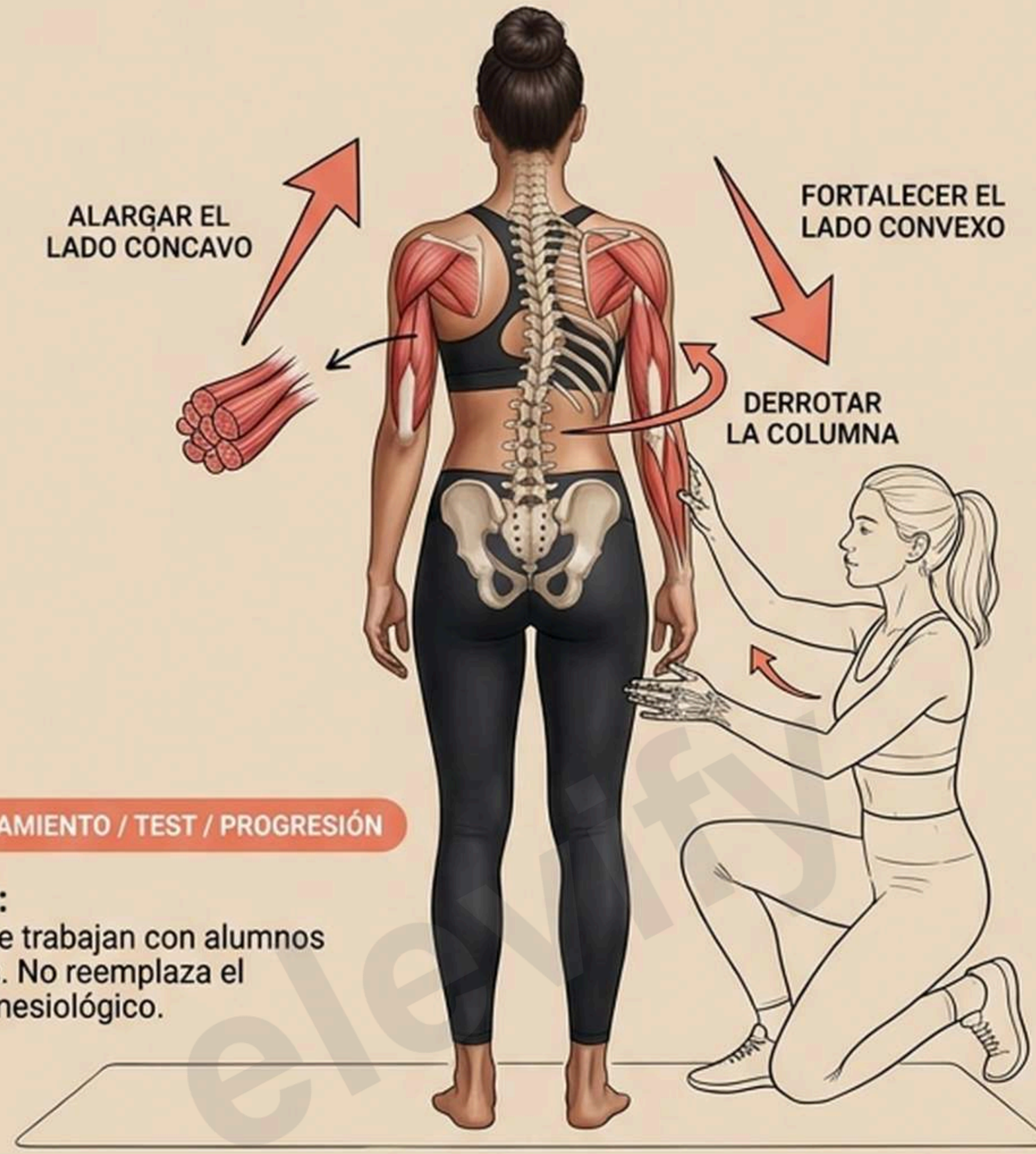
Hipermovilidad (sí, con control) ✅. **Hernia lumbar** (con cuidado) ✅. **Rodilla operada** (sí) ✅.
Embarazo (sí, es excelente) ✅. **Adulto mayor** (sí, sentado en silla) ✅. **Lesión reciente costal/hombro** (no) ❌.

REGRESIÓN: Hacerlo sentado en una silla.

PROGRESIÓN: Tomarse la muñeca del brazo elevado con la otra mano y traccionar suavemente.

PARA SU CASA: "Hacelo en cualquier pausa activa para liberar la zona lumbar y dorsal. Escuchá tu cuerpo, no fuerces."

COLUMNA CON ESCOLIOSIS



FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN

PARA QUIÉN:
Profesores que trabajan con alumnos con escoliosis. No reemplaza el tratamiento kinesiológico.

QUÉ SÍ (EN GENERAL)

✓ Alargamiento axial; trabajo asimétrico (estirar el lado cóncavo, fortalecer el convexo); ejercicios de respiración para expandir el lado cóncavo; fortalecimiento del core (planchas); rotaciones suaves y controladas.

QUÉ NO (EN GENERAL)

✗ Flexiones y extensiones profundas y simétricas sin control; ejercicios de alto impacto sin una buena base de fuerza; ignorar el dolor; pretender "enderezar" la curva. El objetivo es mejorar la función y reducir el dolor.

SIEMPRE DERIVAR: La escoliosis requiere un diagnóstico y seguimiento médico. Como profesor, tu rol es ayudar a la alumna a moverse mejor, siguiendo las pautas de su kinesiólogo o fisioterapeuta.

CLAVE EN LA SALA

TEST DE ADAMS: GIBA = ROTACIÓN

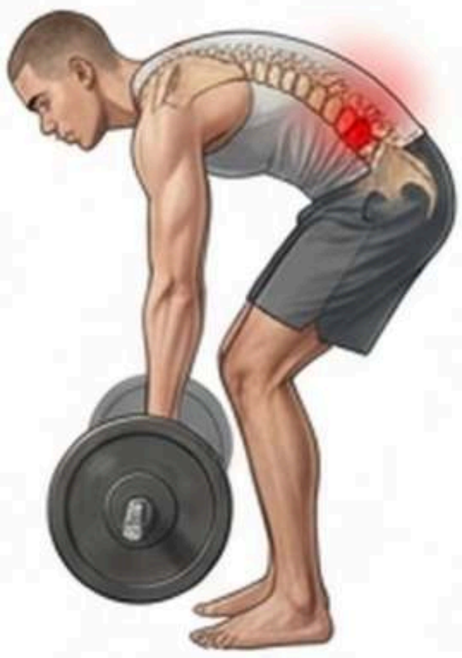
Observá a tu alumna en una flexión de tronco (test de Adams). La aparición de una giba te indica la rotación vertebral. Trabajá en "derrotar" esa giba durante los ejercicios, por ejemplo, pidiéndole que "baje" la costilla que sobresale en una plancha.

COLUMNA CON HERNIA

PARA QUIÉN

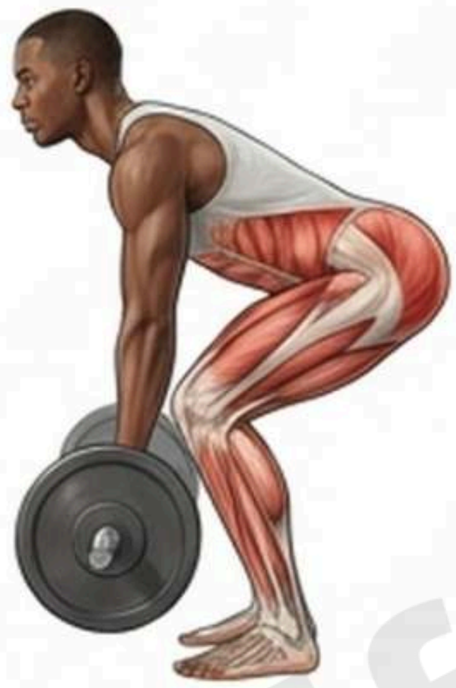
Profesores que trabajan con alumnos con diagnóstico de hernia discal (lumbar o cervical) fuera de fase aguda.

MAL (INCORRECTO)



Espalda redonda, compresión discal

BIEN (CORRECTO)



Bisagra de cadera correcta, columna neutra

PROGRESIÓN

Cobra suave (extensión controlada)

QUÉ SÍ (FUERA DE CRISIS)

Fortalecimiento del core (transverso, multífidos, glúteos); movilidad neural suave (neurodinamia) sin dolor; extensiones controladas como la esfinge si no causan dolor; alargamiento axial; enseñar la bisagra de cadera.

QUÉ NO (O CON EXTREMA PRECAUCIÓN)

Flexión de columna (abdominales crunch, pinzas profundas), especialmente con carga; rotación combinada con flexión; posiciones de compresión prolongada; ignorar la ciática (dolor, hormigueo que irradia).

SIEMPRE DERIVAR

Una hernia discal es una condición médica. Trabajá siempre con el alta del médico o kinesiólogo. No sos un terapeuta.

CLAVE EN LA SALA

La prioridad es "no hacer daño". Enseñale a tu alumno a reconocer las señales de su cuerpo. El objetivo es que gane confianza para moverse, no que logre posturas extremas. La consistencia en los ejercicios de estabilización es más importante que la flexibilidad.

ERRORES FRECUENTES DE COLUMNA

ERRORES COMUNES: LA COLUMNA NO PERDONA

ERROR: PERRO BOCA ABAJO CON LUMBAR ARQUEADA

COMPRESIÓN LUMBAR: La falta de flexibilidad isquiotibial se compensa arqueando la zona lumbar, creando riesgo de lesión discal y contractura.

CORRECCIÓN: CON RODILLAS FLEXIONADAS Y ESPALDA LARGA

ALINEACIÓN DORSAL-LUMBAR: Flexionar rodillas permite alargar la columna, priorizando la salud vertebral sobre llegar al piso con los talones.

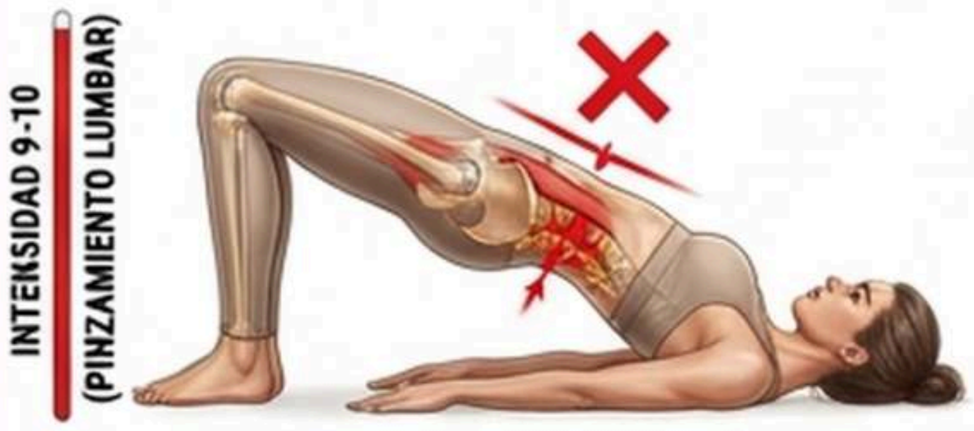
ERROR: PINZA CON CUELLO EN HIPEREXTENSIÓN

TENSIÓN CERVICAL: La mirada adelante comprime las vértebras del cuello, bloquea la respiración y genera dolores de cabeza.

CORRECCIÓN: CUELLO RELAJADO

RELAJACIÓN CERVICAL: Soltar el peso de la cabeza alarga las cervicales y libera tensión en hombros y mandibula.

ERROR: PUENTE QUEBRADO EN LA LUMBAR



BISAGRA LUMBAR: Falta de apertura de hombros y cadera fuerza la columna lumbar a una extensión extrema y peligrosa.

CORRECCIÓN: PUENTE CON CURVA HOMOGÉNEA

ARCO ARMÓNICO: La extensión se distribuye equitativamente; la apertura de pecho y flexores de cadera protege la lumbar.

EN LA SALA: EL PATRÓN MÁS FRECUENTE ES LA AMNESIA DORSAL

Como la espalda alta suele estar rígida, el alumno compensa moviendo en exceso la zona lumbar y cervical, que son más vulnerables. Esto lleva a una sobrecarga lumbar ("quebrar la cintura") y tensión cervical. Enseliar a movilizar la zona dorsal es clave para proteger las otras. Otro error común es forzar el rango en extensiones como el puente sin tener la apertura de hombros necesaria, lo que termina comprimiendo las vértebras lumbares. Cuando un alumno dice "me duele la cintura" después de una clase, casi siempre es porque compensó con la lumbar la falta de flexibilidad en otra parte.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ: Priorizar calidad y seguridad.

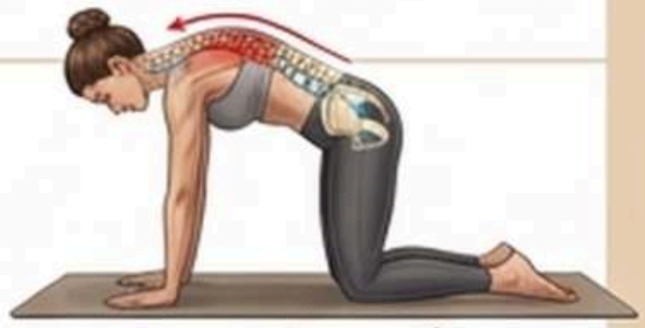
- ✓ Priorizar la calidad del movimiento sobre el rango.
- ✓ Doblar las rodillas para proteger la lumbar en flexiones.
- ✓ Mantener la columna larga y el cuello relajado.
- ✓ Escuchar la sefial de "freno óseo" o pinzamiento y parar.

QUÉ NO: Forzar y compensar.

- ✕ Forzar para llegar "más lejos" sacrificando la forma.
- ✕ Ignorar la sensación de pinzamiento o dolor agudo.
- ✕ Compensar la falta de flexibilidad con la zona lumbar o cervical.
- ✕ Rebotar para alcanzar una posición.

MAPA DE LIMITACIONES DE LA COLUMNA

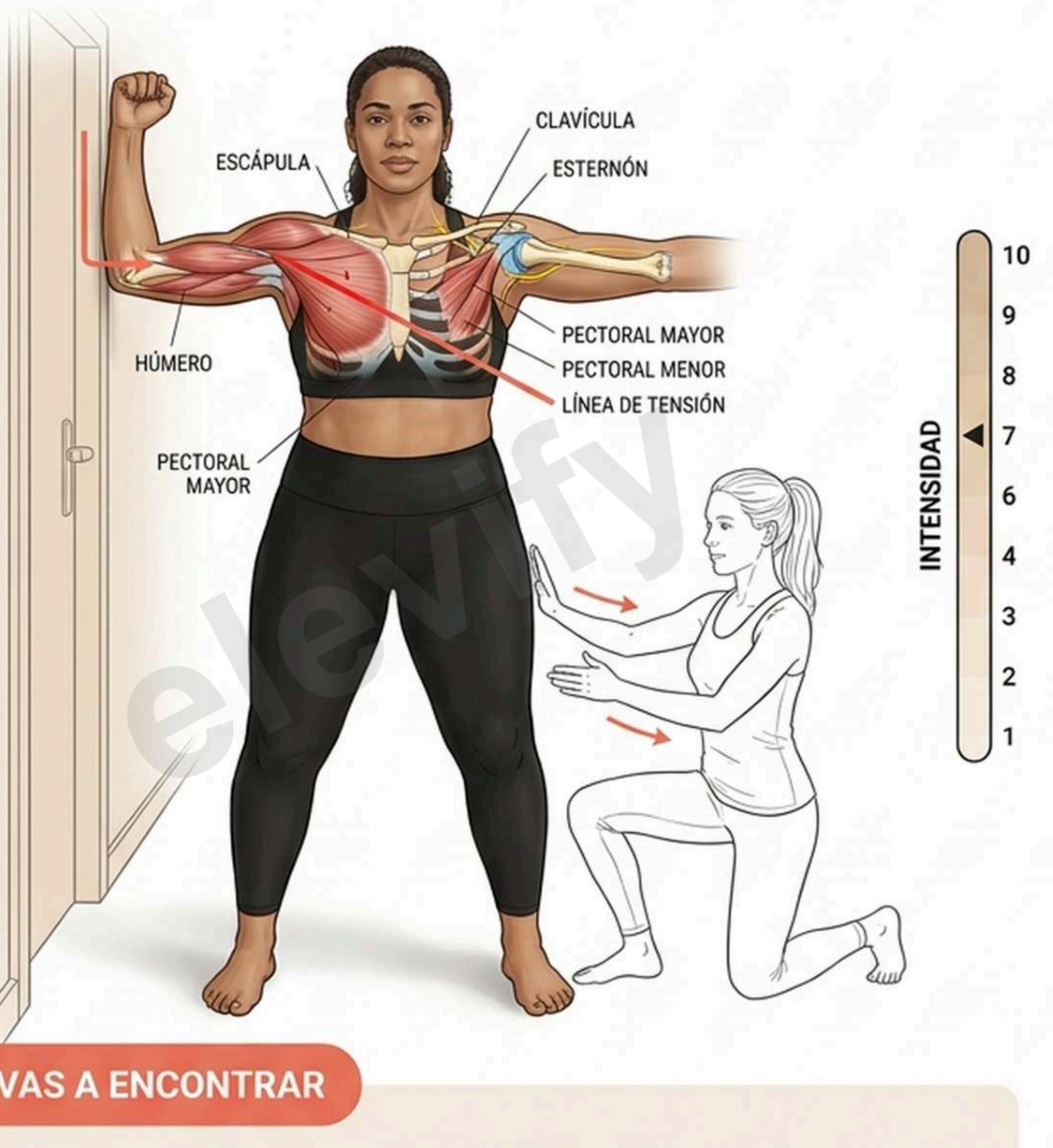
MAPA DE LIMITACIONES DE LA COLUMNA

LIMITACIÓN OBSERVADA	ESTRUCTURA PROBABLEMENTE CORTA O RÍGIDA	EJERCICIO SUGERIDO DEL LIBRO	
1. No puede redondear espalda alta	Rigidez articular dorsal	Gato y vaca (p. 108)	
2. Al levantar brazos, arquea lumbar	Dorsal ancho, Pectoral	Flexión lateral (p. 112), Extensión dorsal (p. 110)	
3. No puede rotar sin mover pelvis	Oblicuos, Rigidez dorsal	Rotación de columna (p. 109)	
4. Se levantan talones en cuclillas	Sóleo, Dorsiflexión de tobillo	*Referir a cap. Tobillo y Pie*	
5. En pinza, redondea mucho la lumbar	Isquiotibiales	*Referir a cap. Cadera Posterior*	
6. Dificultad para extender columna	Psoas ilíaco, Recto femoral, Pectorales	Puente progresivo (p. 111)	
7. "Tope" en flexión lateral	Cuadrado lumbar, Dorsal ancho	Flexión lateral (p. 112)	
8. Cuesta mantener espalda recta al sentarse	Isquiotibiales, Falta control postural	*Referir a cap. Cadera Posterior*	
9. Cuello y hombros adelantados	Pectorales, Musc. suboccipital	Extensión dorsal (p. 110)	

elevify

HOMBROS, PECHO Y BRAZOS

Anatomía y estiramientos para una cintura escapular libre y fuerte.

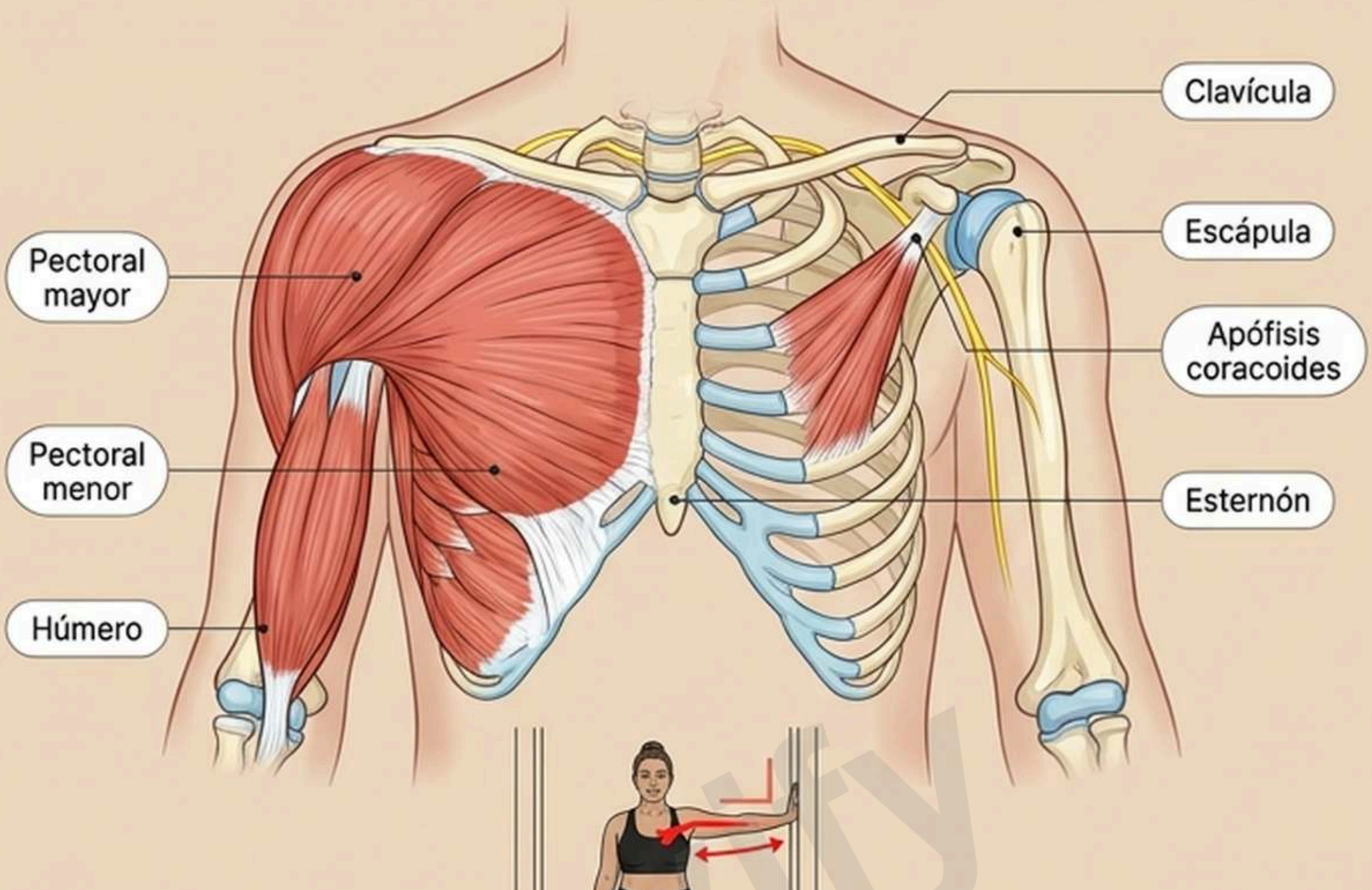


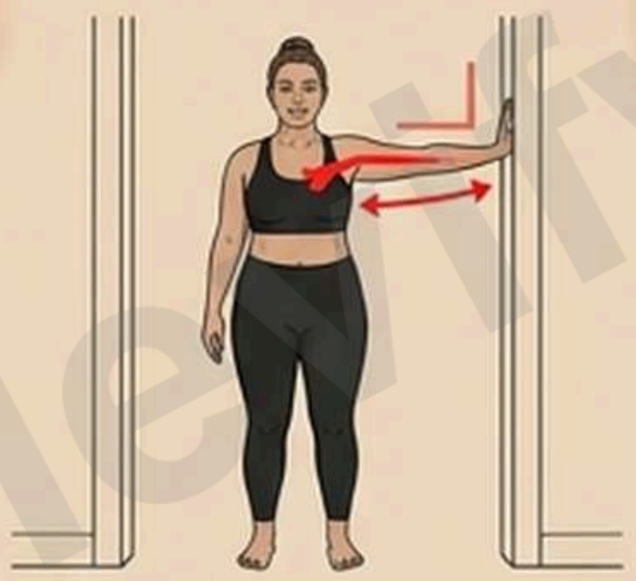
QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vamos a desarmar la complejidad del hombro. Analizaremos los músculos que lo cierran hacia adelante (pectorales) y los que limitan la elevación de los brazos (dorsal ancho). También vamos a cuidar las estructuras más delicadas, como el manguito rotador y la cápsula, y a preparar las muñecas para los apoyos.

Incluye ejercicios específicos para condiciones como el hombro congelado y la hiperlaxitud.

PECTORAL MAYOR Y MENOR





DÓNDE ESTÁ

Del esternón, clavícula y costillas hasta el húmero (mayor) y la escápula (menor)

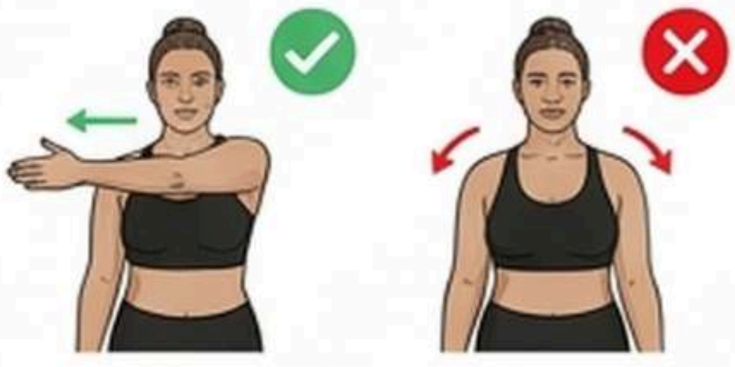
QUÉ HACE

Cierra el hombro: lo lleva hacia adelante, adentro y en rotación interna

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

La apertura del pecho y la capacidad de llevar los brazos hacia atrás y arriba

CÓMO SE ESTIRA



Para estirar el pectoral mayor, se abduce y rota externamente el brazo. Para el menor, es clave llevar la escápula hacia atrás (retracción).

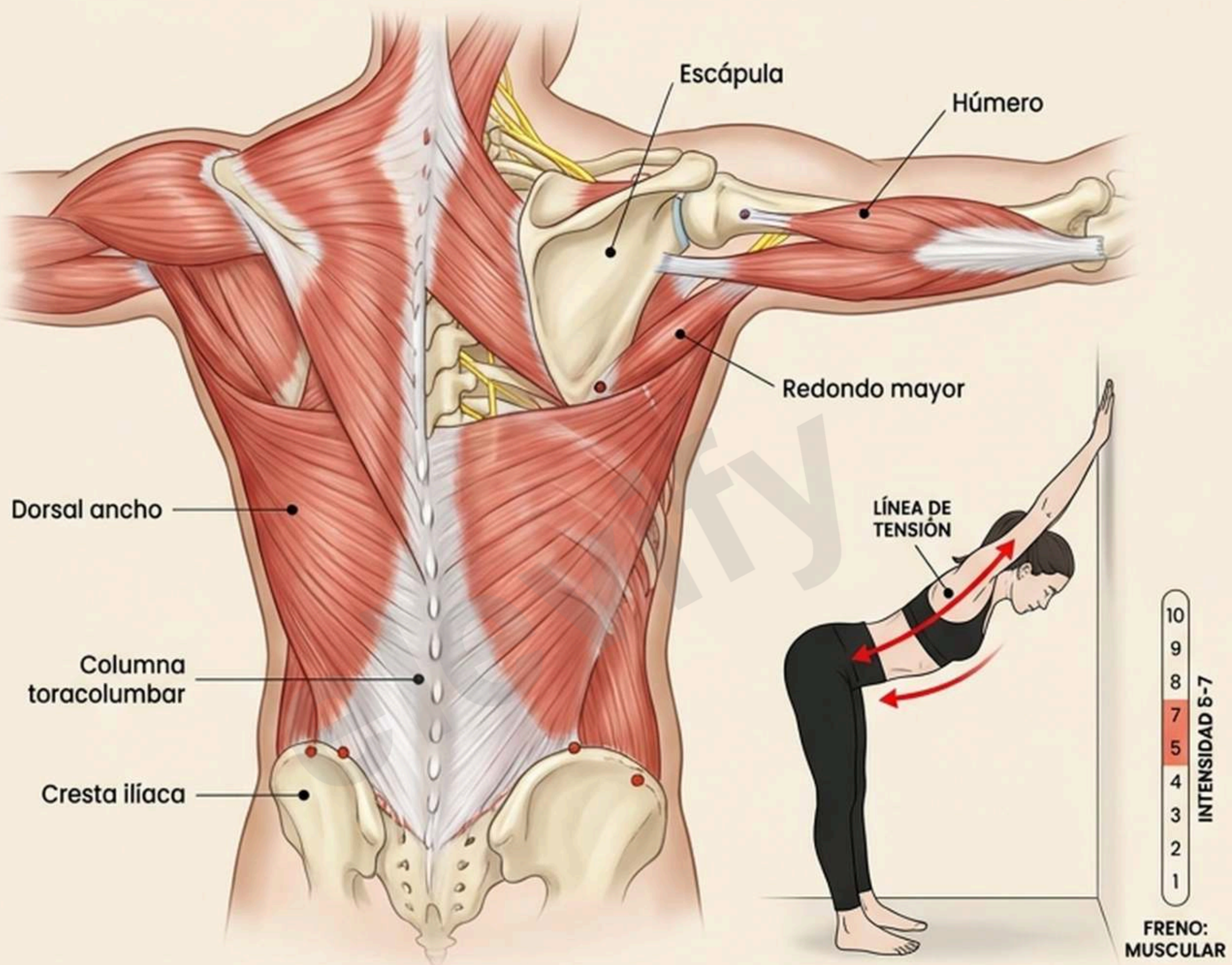
Es fundamental fijar la escápula y evitar que el hombro se vaya hacia adelante, porque si no, el estiramiento pierde efectividad y puede pinzar la articulación. Se busca una tirantez limpia en el pecho, sin dolor en la cara anterior del hombro

CUE DE LA FORMADORA

Decile a tu alumna: "Imaginá que tu omóplato se desliza hacia la columna mientras abrís el pecho"

DORSAL ANCHO Y REDONDO MAYOR: los brazos que no suben

Lámina anatómica y estiramiento clave



DÓNDE ESTÁ

Cubre casi toda la espalda, desde la zona lumbar, sacro y cresta iliaca hasta el húmero

QUÉ HACE

Es un extensor, aductor y rotador interno muy potente del brazo (el gesto de trepar)

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

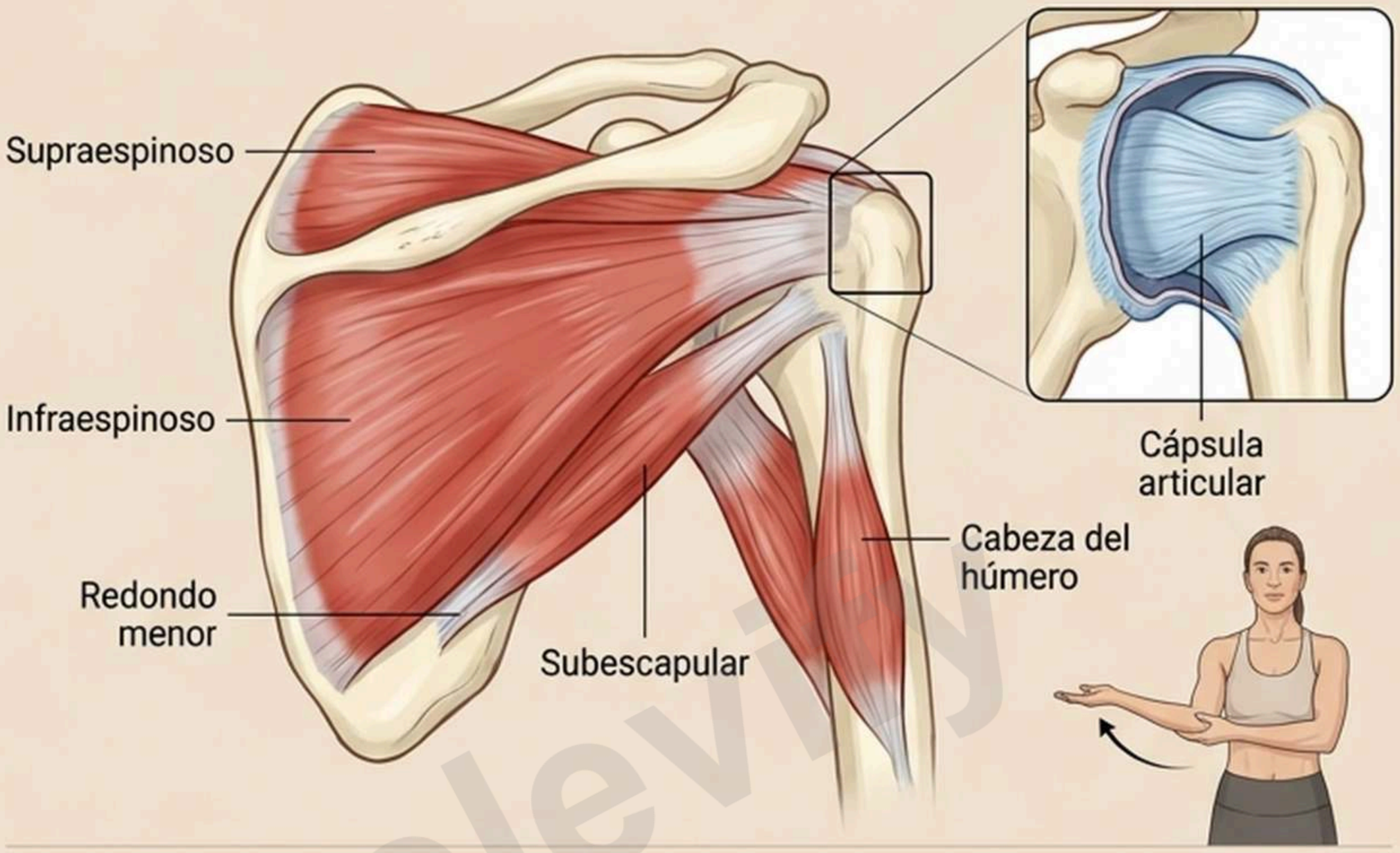
La flexión completa del hombro; es el principal responsable de que a un alumno no le suban los brazos

CÓMO SE ESTIRA

- Se estira llevando el brazo a su máxima flexión (hacia arriba y adelante). Es crucial mantener la columna lumbar neutra y el abdomen activo, porque la tendencia natural del cuerpo será compensar la falta de rango del hombro con una hiperextensión lumbar.
- Se busca sentir la tensión en el costado del torso y la axila

CUE DE LA FORMADORA: Recordale al alumno: "Cerrá las costillas y activá el abdomen para que el estiramiento vaya al dorsal y no a tu cintura"

Manguito rotador y cápsula: la rotación que se fuerza



DÓNDE ESTÁ

Son cuatro músculos profundos que van de la escápula a la cabeza del húmero.

QUÉ HACE

Su función principal es estabilizar la cabeza del húmero en su cavidad. Inician la abducción y producen las rotaciones.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Limita las rotaciones interna y externa, a menudo generando pinzamientos si se fuerza el rango.

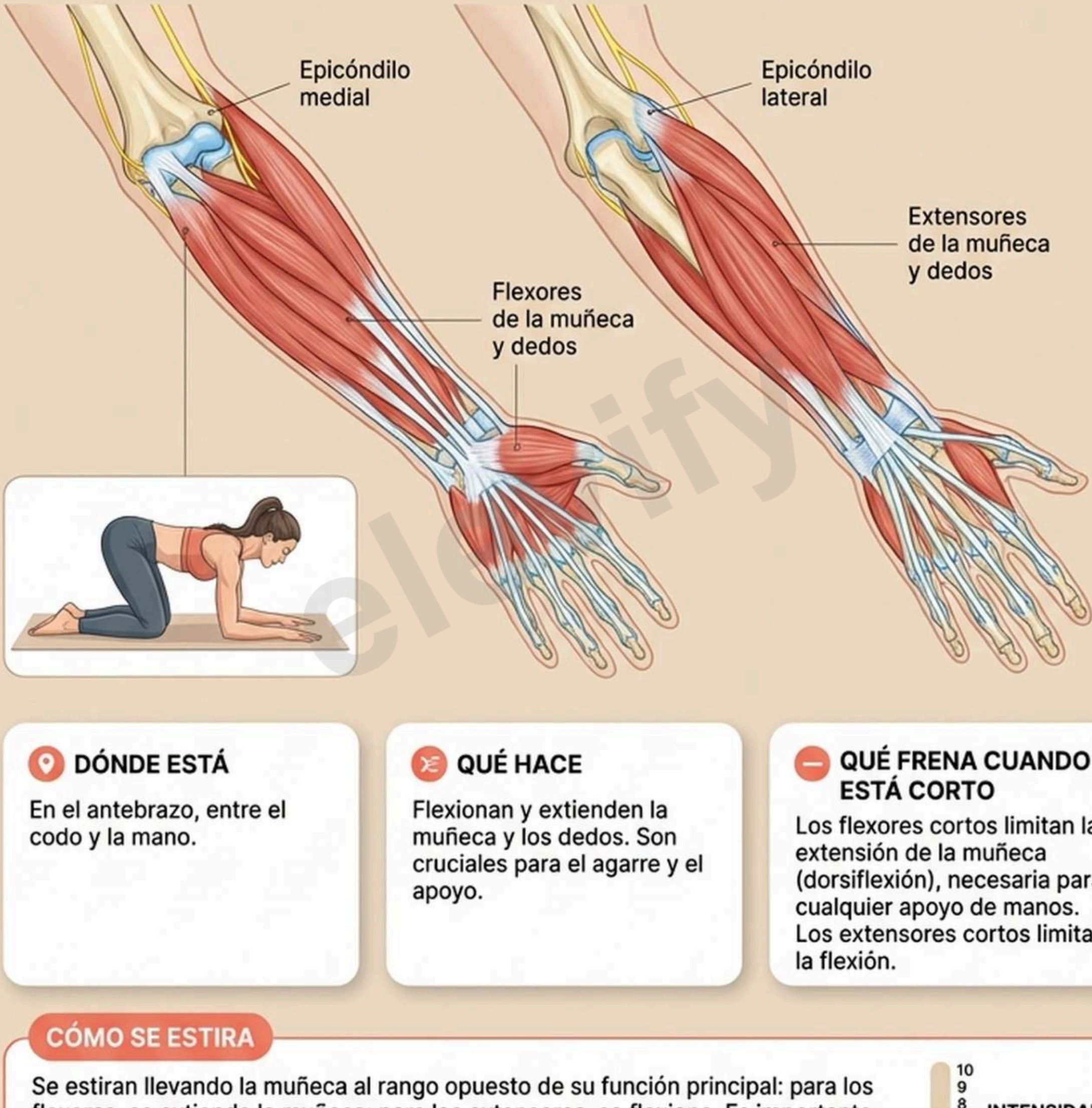
CÓMO SE ESTIRA

Estas estructuras no se estiran con alta intensidad. Se trabajan con movilidad suave y controlada, sin forzar nunca el final del rango. El objetivo es mantener la salud articular, no ganar rangos extremos. Cualquier dolor agudo o sensación de pinzamiento es una señal para detenerse. Se prioriza la activación y el control motor sobre el estiramiento pasivo.

CUE DE LA FORMADORA

La clave aquí es la sutileza: "Buscá el primer punto de tensión y trabajá ahí, sin pelear con la articulación".

Antebrazo y muñeca: el apoyo de manos que duele



DÓNDE ESTÁ

En el antebrazo, entre el codo y la mano.

QUÉ HACE

Flexionan y extienden la muñeca y los dedos. Son cruciales para el agarre y el apoyo.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

Los flexores cortos limitan la extensión de la muñeca (dorsiflexión), necesaria para cualquier apoyo de manos. Los extensores cortos limitan la flexión.

CÓMO SE ESTIRA

Se estiran llevando la muñeca al rango opuesto de su función principal: para los flexores, se extiende la muñeca; para los extensores, se flexiona. Es importante hacerlo de forma progresiva, primero sin peso y luego transfiriendo gradualmente el peso del cuerpo, como en una posición de cuatro apoyos. Nunca se debe sentir dolor agudo en la articulación.

CUE DE LA FORMADORA

Para cuidar las muñecas, decile: “Distribuí el peso en toda la mano, no solo en el talón de la muñeca”.

APERTURA DE PECHO EN MARCO

PARA QUIÉN: alumnos con hombros adelantados por postura de oficina o por entrenamiento de empuje.

Posición de partida: de pie en el marco de una puerta, con un pie adelantado.
Zona y músculos: pecho y parte anterior del hombro (pectoral mayor y menor, deltoides anterior).
Freno que se trabaja: muscular y fascial.

EL ESTIRAMIENTO

Método: estático pasivo.
Intensidad: 5-7/10, una tensión clara sin dolor en el hombro.
Tiempo: 30-60 segundos por lado, 2-3 series.
Respiración: profunda, exhalando para avanzar en el estiramiento.
Qué se mantiene fijo: la escápula retraída y el abdomen activo para no arquear la zona lumbar.

PASO A PASO

1. Colocá el antebrazo en el marco de la puerta, con el codo a 90 grados y a la altura del hombro.
2. Retraé la escápula de ese lado (juntala a la columna). **3.** Adelantá la pierna contraria y dejá que el torso avance a través del marco.
4. Mantené 30-60 seg. respirando.
5. Para variar las fibras, probá con el brazo más arriba o más abajo.
6. Cambiá de lado.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

❌ El hombro se va para adelante (corrección: retraer la escápula antes de empezar).
❌ Arquear la espalda baja (corrección: activar el abdomen).
❌ Aguantar la respiración (corrección: respirar profundo y usar la exhalación).

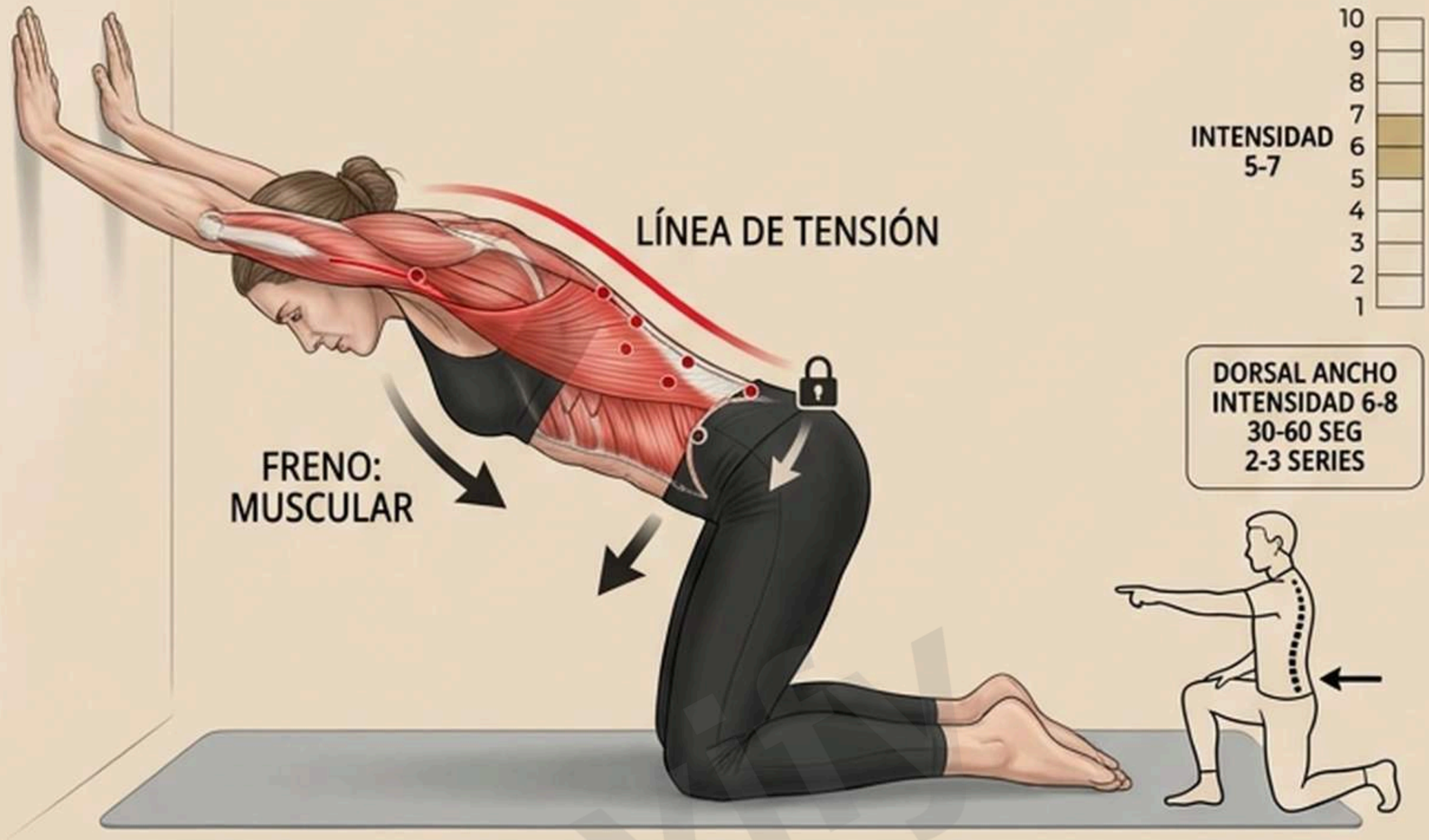
QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ Hipermovilidad: no hiperextender el codo.
❌ Lesión reciente de hombro: consultar con un profesional; si hay dolor, no hacer.
✅ Adulto mayor: usar menos intensidad y un apoyo más bajo.
REGRESIÓN: hacer el mismo ejercicio contra una pared.
PROGRESIÓN: realizarlo con ambos brazos a la vez en un marco ancho.

CUE DE LA FORMADORA: "Hacelo varias veces al día si pasás mucho tiempo sentada. Tres respiraciones profundas por lado son suficientes para resetear la postura".

DORSAL EN PARED O BLOQUE

ESTIRAMIENTO CLAVE PARA HOMBROS Y POSTURA



PARA QUIÉN

Alumnos a los que les cuesta levantar los brazos rectos por encima de la cabeza, como en verticales o posturas de yoga.

Zona objetivo: toda la cadena lateral y posterior del brazo (dorsal ancho, redondo mayor, triceps)

EL ESTIRAMIENTO

Método: estático pasivo.
Intensidad: 6-8/10, tensión profunda en la axila y el costado del torso.
Tiempo: 30-60 segundos, 2-3 series.
Respiración: exhalar largo mientras el pecho baja.
Qué se mantiene fijo: la pelvis en posición neutra y el abdomen activo para proteger la zona lumbar

PASO A PASO

1. Arrodillate y apoyá las manos o los codos en la pared o sobre un bloque/silla.
2. Mantené los brazos al ancho de tus hombros.
3. Inhalá y al exhalar, flexioná la cadera y dejá que tu pecho baje hacia el suelo.
4. Mantené la cabeza alineada con la columna.
5. Sostené la posición 30-60 seg., respirando hacia la zona que se estira.
6. Volvé lento

ERRORES QUE VES EN LA SALA ✕

- ✕ **1.** Quebrar la cintura (corrección: mantener el abdomen contraído como si te fueran a dar un golpe).
- ✕ **2.** Dejar que los codos se abran demasiado (corrección: mantener los brazos paralelos).
- ✕ **3.** Elevar los hombros hacia las orejas (corrección: relajar el cuello y pensar en alejar los hombros)

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Pinzamiento de hombro:** si hay dolor agudo en la parte superior, no bajar tanto o no hacer.
- ✕ **Hernia lumbar:** realizar con mucho control abdominal y menos rango.
- ✓ **Embarazo:** sí, con adaptaciones y sin forzar

REGRESIÓN: hacer el ejercicio de pie, con las manos en la pared a la altura de la cadera

PROGRESIÓN: usar un solo brazo a la vez para intensificar el estiramiento sobre un lado

PARA SU CASA

Este es clave para mejorar tus posturas sobre la cabeza. Concentrate más en cerrar las costillas que en bajar el pecho a cualquier costo

ROTACIÓN DE HOMBRO CON BANDA

EL EJERCICIO:
MOVILIDAD ACTIVA RESISTIDA
ZONA: MANGUITO ROTADOR
TIPO: CONTROL NEUROMUSCULAR
REPETICIONES: 10-15 POR LADO
RESPIRACIÓN: EXHALAR AL ROTAR

PARA QUIÉN

Para todos, especialmente para quienes tienen hombros inestables o dolorosos, y como preparación para movimientos de lanzamiento o levantamiento.

PASO A PASO (ROTACIÓN EXTERNA)

1. Anclá la banda a la altura de tu codo.
2. Tomá la banda con la mano del brazo a trabajar; la tensión viene del lado opuesto.
3. Mantené el codo a 90 grados, pegado a tus costillas.
4. Exhalá y rotá el brazo hacia afuera, lentamente, sin despegar el codo.
5. Inhalá y volvé al inicio de forma controlada.
6. Hacé 10-15 reps y cambiá de lado.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- ✗ Despegar el codo del cuerpo (Colocar una toalla pequeña entre el codo y el torso).
- ✗ Mover el tronco o la muñeca para compensar (Aislar el movimiento solo en el hombro).
- ✗ Usar una banda muy pesada (Elegir una resistencia que permita un movimiento fluido y sin dolor).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ Hipermovilidad: Excelente para dar estabilidad. Hacerlo con mucho control.
- ✗ Lesión aguda del manguito rotador: No hacer sin supervisión médica/kinesiológica.

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA PARA SU CASA

"Esto no es para cansar el músculo, es para despertarlo. Hacelo lento y sentí cómo el movimiento nace desde la parte de atrás de tu hombro".

MUÑECAS PARA APOYO DE MANOS

PARA QUIÉN

- Practicantes de yoga, pilates, calistenia.
- Quien apoya peso en manos.
- Siente rigidez o molestia.
- Busca mejorar soporte y movilidad.

EL ESTIRAMIENTO

- **Método:** Movilidad y estático progresivo.
- **Intensidad:** 3-5 (tirantez suave).
- **Tiempo:** Dinámicos (10 reps), Estáticos (20-30 seg).
- **Respiración:** Fluida y constante.
- **Fijo:** Codos extendidos (no hiperextendidos).

PASO A PASO

1. Cuadrupedia, dedos adelante. Balanceá suave adelante y atrás (10 reps).
2. Rotá manos afuera. Balanceá lado a lado (10 reps).
3. Rotá dedos hacia rodillas (sin dolor). Sostené 20-30 seg.
4. Dorso de una mano al suelo, dedos a rodilla. Aplicá peso minimo, sostené 20 seg. Cambiá.
5. Cerrá con círculos de muñecas en el aire.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Cargar peso de golpe. (Corrección: Transferir muy gradual).
2. Hiperextender codos. (Corrección: Microflexión).
3. Sentir dolor agudo y seguir. (Corrección: Reducir rango o peso).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

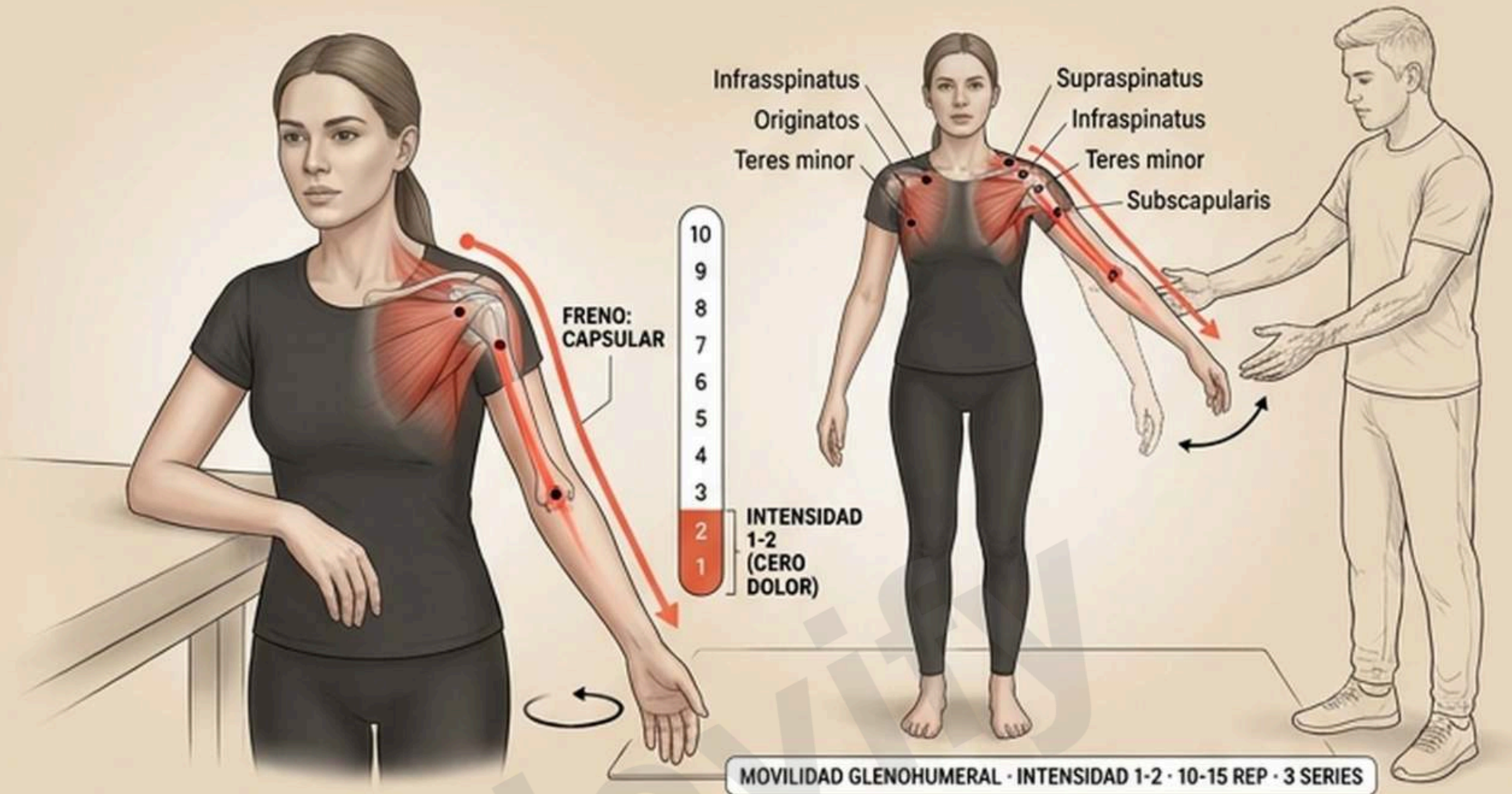
- **SÍNDROME TÚNEL CARPIANO:** Con muchísimo cuidado, rangos pequeños, sin hormigueo.
- **LESIÓN RECIENTE:** NO sin alta médica.
- **HIPERMOVILIDAD:** Enfocar en activación (apretar suelo), no solo estirar.

PARA SU CASA: "Hacé esta secuencia siempre antes de tu práctica. Son 2 minutos que le ahorran años a tus muñecas."

HOMBRO CONGELADO (FASE RÍGIDA)

NIVEL INICIAL

PARA QUIÉN Alumnos con diagnóstico médico de capsulitis adhesiva (hombro congelado) en su fase 2 (rígida), que tienen el alta para realizar movimiento suave. **Importante:** no es para la fase 1 (inflamatoria/dolorosa).

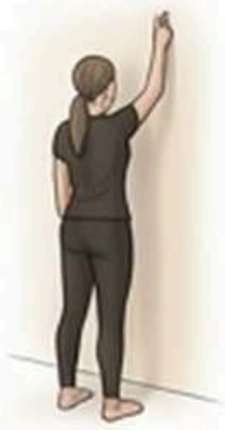


EL ESTIRAMIENTO

Método: movilidad activa-asistida y pendular. **Intensidad**: 1-2/10, el cbjetivo es CERO DOLOR. El movimiento busca lubricar, no forzar. **Tiempo**: movimientos suaves, 10-15 repeticiones. **Respiración:** relajada y natural. **Qué se mantiene fijo:** el tronco, para que el movimiento salga del hombro.

PASO A PASO

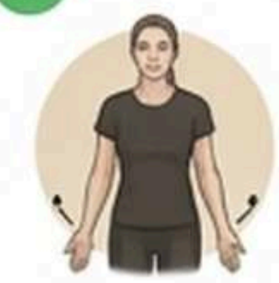
1. Péndulos de Codman (10-15 rep): Inclinate hacia adelante apoyando la mano sana en una mesa. Dejá que el brazo afectado cuelgue relajado como un péndulo. Hacé circulos pequefios, en un sentido y en el otro, usando el impulso del cuerpo, no la fuerza del hombro.



2. Flexión en la pared (10-15 seg): De pie frente a una pared, usá los dedos para "caminar" hacia arriba por la pared hasta que sientas una tirantez muy suave. Sostené 10-15 segundos y bajá.

3. Rotación externa asistida (Hasta el primer limite): Con el codo afectado a 90 grados y pegado al cuerpo, usá un palo o bastón sostenido con la mano sana para empujar suavemente la mano del lado afectado hacia afuera. Solo hasta el primer limite.

QUÉ SÍ / QUÉ NO



Movimiento suave y sin dolor.
Respetar el llmite de la articulación.
Trabajar en equipo con su kinesiólogo.
Calentar la zona con calor húmedo antes de mover.

Forzar el rango.
Hacer movimientos bruscos o balísticos.
Estiramientos pasivos intensos.
Sentir dolor agudo o pinzamiento (es contraproducente y puede inflamar más la cápsula).

PARA SU CASA

Tu lema es 'poco y a menudo'. El objetivo no es ganar rango hoy, sino invitar al hombro a moverse en un espacio seguro y sin dolor. La paciencia es tu mejor herramienta.

REGRESIÓN: Movimientos más pequeños, sin peso

PROGRESIÓN: Aumentar suavemente el rango, siempre sin dolor

HOMBRO HIPERLAXO: RANGO CON CONTROL

PARA QUIÉN

Alumnos con hiperlaxitud o inestabilidad, que necesitan aprender a controlar su rango de movimiento en lugar de ampliarlo.
Foco: Estabilizadores (serrato anterior, manguito rotador, trapecio inferior).

EL EJERCICIO

Activación isométrica y en rango corto.
Intensidad baja (3-4/10).
Repeticiones: 8-12 o isométricos de 10-15 seg.
Respiración coordinada. Mantené la articulación estable, sin llegar al tope pasivo.

PASO A PASO: RETRACCIÓN/PROTRACCIÓN ESCAPULAR

1. En cuadrupedia, manos bajo hombros, codos extendidos (sin bloquear).
2. Brazos rectos. Inhalá y juntá escápulas, pecho baja un poco (retracción).
3. Exhalá y empujá el suelo, separando escápulas y redondeando la parte alta de la espalda (protracción). Sentí el serrato.
4. Repetí 8-12 veces lento y controlado. Movimiento solo de omóplatos.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- 1. Flexionar los codos
  (Corrección: brazos como columnas fijas).
- 2. Mover cabeza o lumbares
  (Corrección: cuello y espalda baja estables).
- 3. Colgarse en los extremos del rango
  (Corrección: moverse en rango activo con tensión).

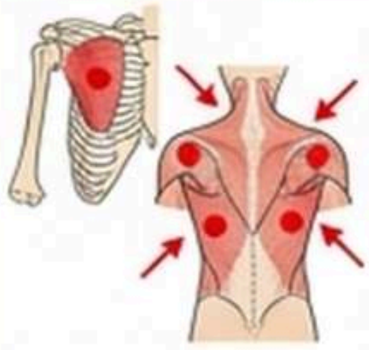
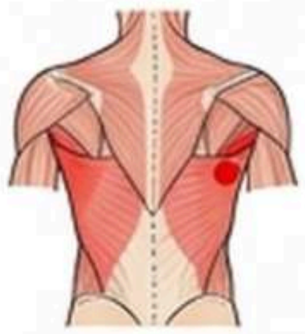
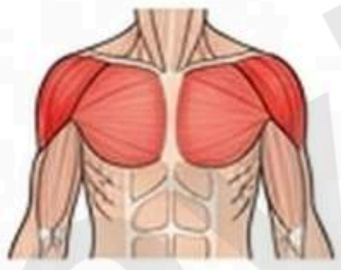
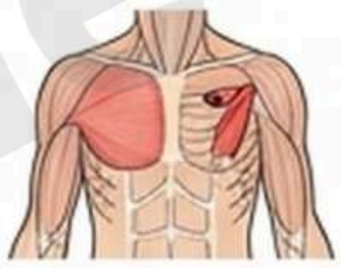
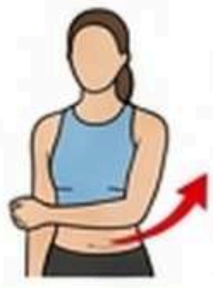
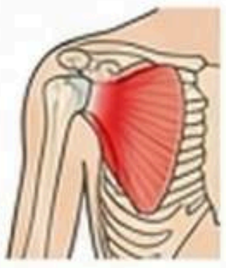
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **QUÉ SÍ:** Ejercicios de estabilización en cadena cerrada. Activar manguito con bandas suaves. Foco en propiocepción.
- **QUÉ NO:** Estiramientos pasivos profundos. Dejarse caer en las articulaciones. Movimientos balísticos sin control.

PARA SU CASA

"Tu objetivo no es ser más flexible en el hombro, sino más fuerte y estable. Pensá en tus músculos como un sistema de riendas inteligentes que guían y protegen tu articulación en cada movimiento."

TABLA: LIMITACIÓN DE HOMBRO, MÚSCULO PROBABLE Y ESTIRAMIENTO

SI A TU ALUMNA LE CUESTA...	EL FRENO MUSCULAR PROBABLE ES...	PROBÁ ESTE ESTIRAMIENTO (PÁG. X)
Juntar las manos por detrás de la espalda (una por arriba y otra por abajo)	 Rotadores internos (subescapular, dorsal) si no llega la mano de abajo. Rotadores externos (infraespinoso) si no llega la de arriba.	Rotación de hombro con banda (pág. 124)
Levantar los brazos rectos junto a las orejas (ej: en Adho Mukha Svanasana)	 Dorsal ancho y redondo mayor.	Dorsal en pared o bloque (pág. 123)
Llevar los brazos hacia atrás con el pecho abierto (ej: en Setu Bandhasana)	 Pectoral mayor y deltoides anterior.	Apertura de pecho en marco (pág. 122)
Mantener una rotación externa con el brazo abducido (ej: en posturas de Guerrero)	 Pectoral menor y subescapular.	Apertura de pecho en marco (pág. 122)
Apoyar las manos en el suelo con comodidad, sin dolor de muñeca	Flexores del antebrazo.	Muñecas para apoyo de manos (pág. 125)
 Rotar el brazo hacia afuera con el codo pegado al cuerpo	 Subescapular (rotador interno).	Rotación de hombro con banda (pág. 124)
Realizar cualquier movimiento con sensación de pinzamiento en el hombro	Posible desbalance del manguito rotador.	Consultar a un profesional. Priorizar la activación sobre el estiramiento (pág. 124 y 127).
Siente inestabilidad o que el hombro "se le sale"	Hiperlaxitud ligamentaria, falta de control motor.	Hombro hiperlaxo: rango con control (pág. 127)

ANATOMÍA APLICADA
A LA FLEXIBILIDAD

TOBILLO, PIE Y RODILLA

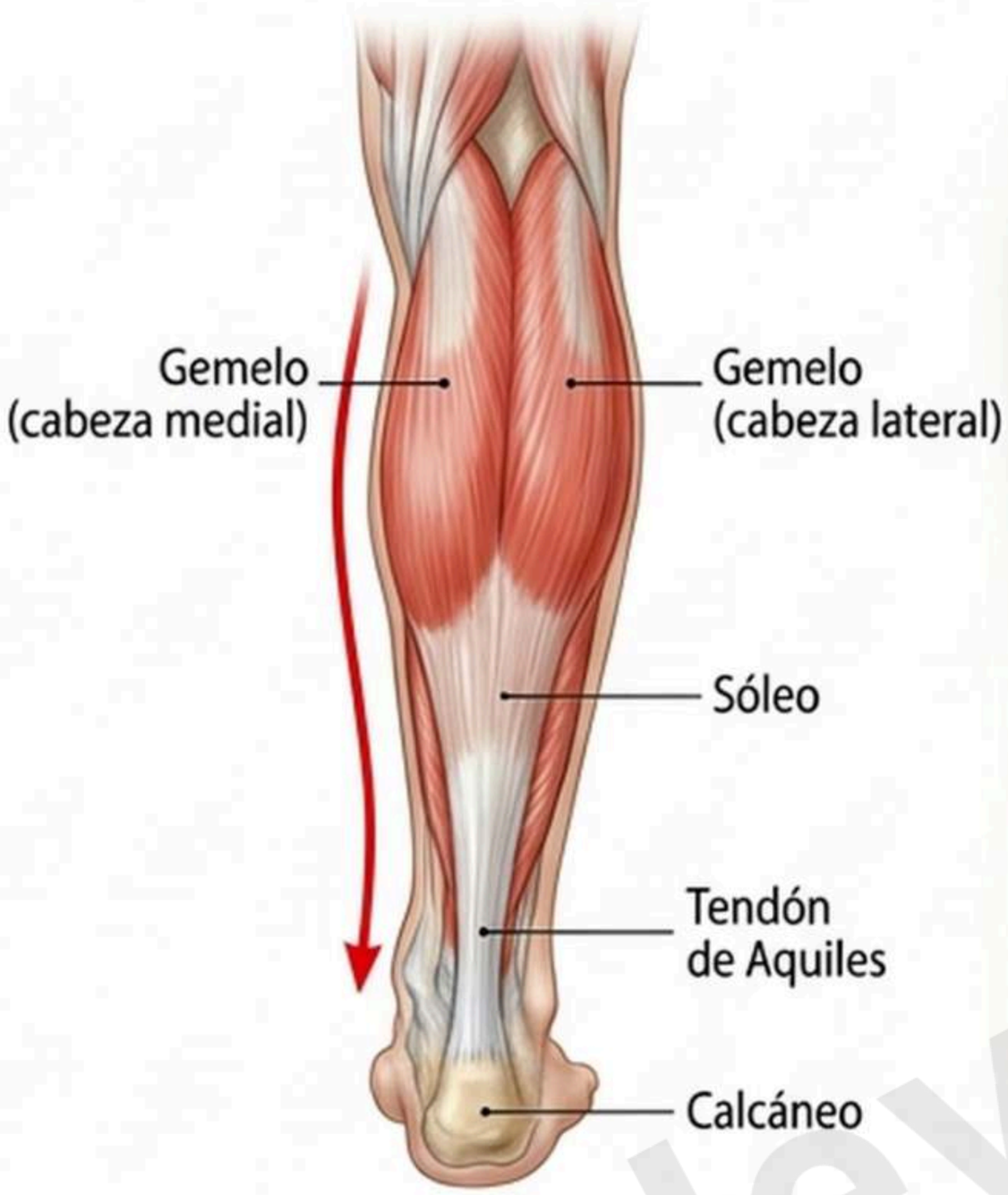
QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vamos a **desarmar la mecánica del tobillo y el pie**, que **son los cimientos de todo tu cuerpo.**

Vas a aprender a identificar y trabajar los **frenos de la dorsiflexión**, a liberar la **tensa fascia plantar** y, sobre todo, a **proteger la rodilla** en cada estiramiento, entendiendo cómo funciona para no lastimarla nunca.

GEMELO Y SÓLEO

LÁMINA ANATÓMICA DEL MÚSCULO O ESTRUCTURA: GEMELO Y SÓLEO (TRÍCEPS SURAL)



DÓNDE ESTÁ: Pantorrilla, desde arriba de la rodilla (gemelo) y debajo de ella (sóleo) hasta el talón.

QUÉ HACE: Flexión plantar del tobillo (pararse en punta de pie). El gemelo también ayuda a flexionar la rodilla.

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO: La dorsiflexión del tobillo, clave para la sentadilla profunda, la zancada y caminar.

CÓMO SE ESTIRA

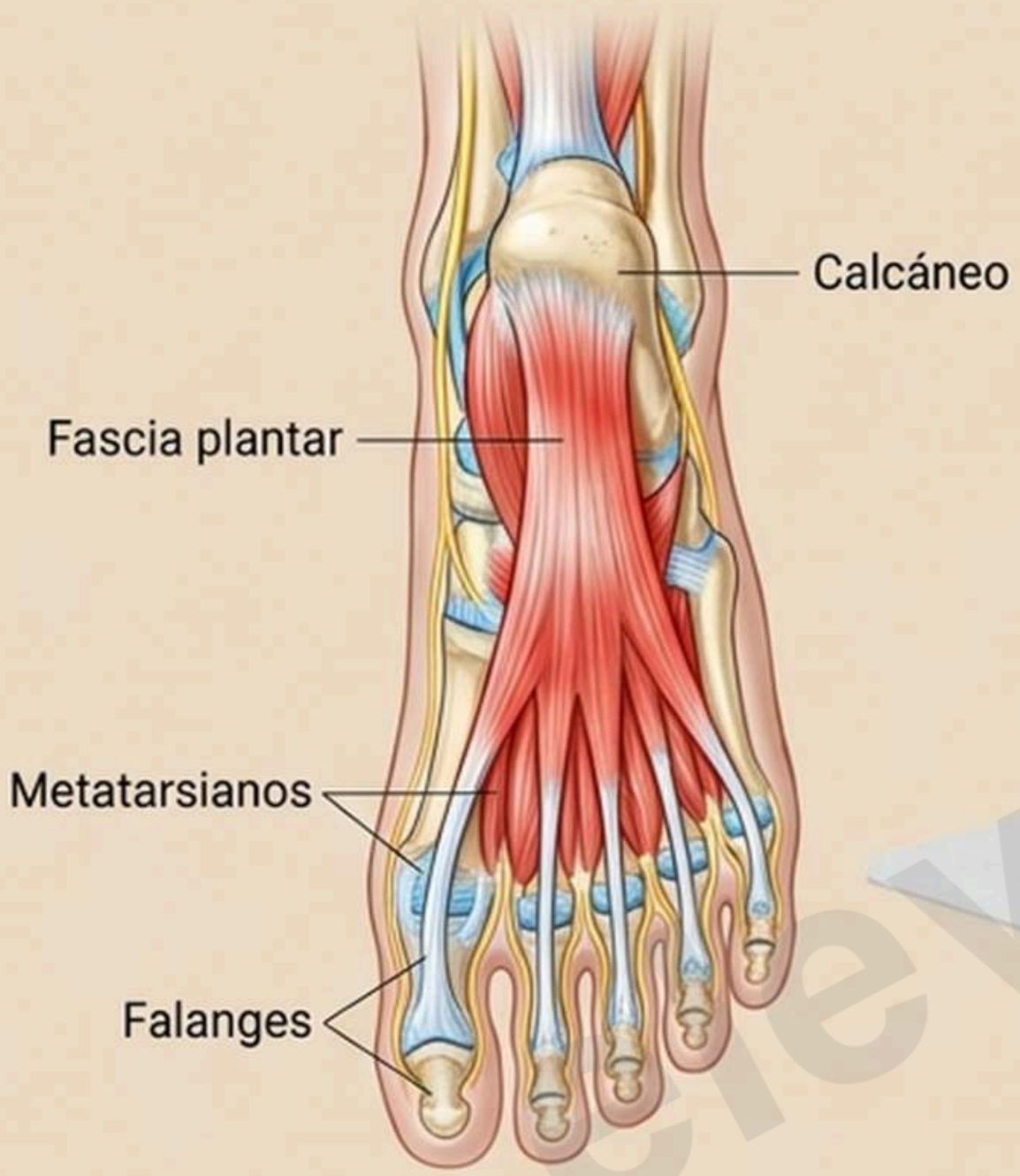
- Para estirar el gemelo, se necesita la rodilla extendida, porque cruza esa articulación.
- Para aislar el sóleo, que es más profundo, flexionamos la rodilla. En ambos casos, fijamos el talón en el suelo y llevamos la tibia hacia adelante. La sensación debe ser de tirantez en la pantorrilla, no de pinzamiento adelante.

CUE DE LA FORMADORA

El sóleo es el gran olvidado; estiralo siempre con la rodilla flexionada.

FASCIA PLANTAR Y FLEXORES DE LOS DEDOS

Lámina Anatómica de la Planta del Pie



INTENSIDAD 5-7
(moderada)

DÓNDE ESTÁ

En la planta del pie, desde el talón hasta la base de los dedos, formando el arco longitudinal.

QUÉ HACE

Mantiene el arco del pie, absorbe el impacto y ayuda en el despegue al caminar o correr (mecanismo de windlass).

QUÉ FRENA CUANDO ESTÁ CORTO

La extensión de los dedos y la capacidad del pie para aplanarse y adaptarse al suelo, limitando el impulso.

CÓMO SE ESTIRA

La **fascia plantar**, al ser tejido conectivo denso, responde mejor a una liberación sostenida que a un estiramiento clásico. Se puede masajear con una pelota firme o estirar pasivamente llevando los dedos y el antepié en extensión máxima hacia la tibia. La clave es la constancia y una presión moderada, sin generar dolor agudo. Mantener por al menos 60-90 segundos.

💬 CUE DE LA FORMADORA

Liberar la fascia plantar tiene un efecto en toda la cadena posterior, hasta las cervicales, debido a la continuidad de las fascias.

LA RODILLA: QUÉ PROTEGER

LA RODILLA: UNA BISAGRA INTELIGENTE

VALGO DE RODILLA

ALINEACIÓN CORRECTA

DÓNDE ESTÁ

Articulación entre el fémur y la tibia, con la rótula por delante.

QUÉ HACE

Principalmente flexión y extensión. Permite una rotación mínima y solo cuando está flexionada.

QUÉ LA LESIONA

Fuerzas de torsión, de lado (valgo/varo) o hiperextensión. No está diseñada para eso.

CÓMO SE PROTEGE

La rodilla es una articulación "de paso", sufre las consecuencias de lo que pasa en la cadera y el tobillo.

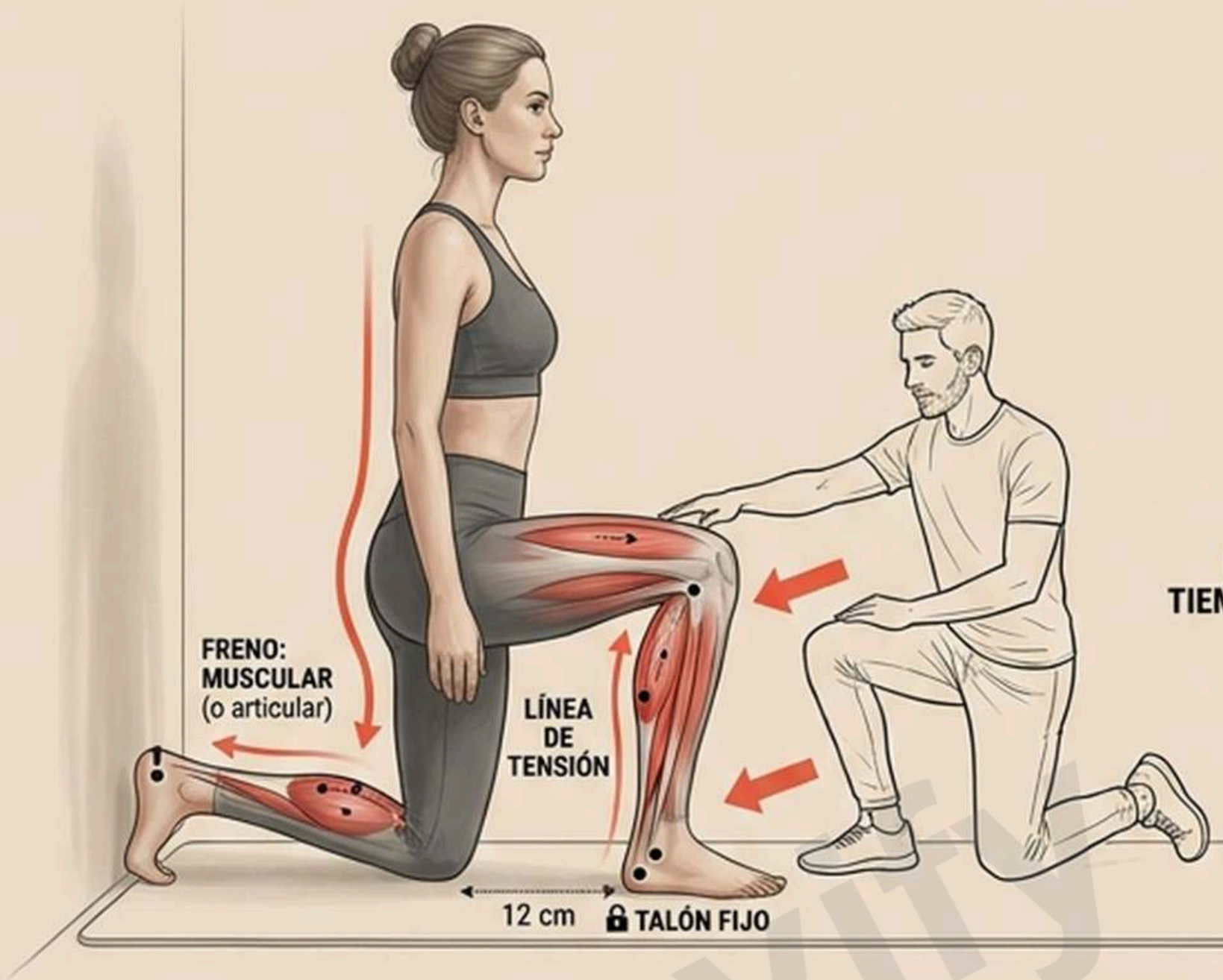
- **Para protegerla, la regla número uno es mantenerla alineada con la punta del pie en casi todos los movimientos.** Evitá forzarla en rotación o que se vaya hacia adentro (valgo).

Si un estiramiento genera dolor puntual en la rodilla, no es para esa alumna; hay que buscar una variante.

CUE DE LA FORMADORA

Una rodilla que duele está pidiendo que mires qué pasa en el pie y en la cadera.

TEST Y ESTIRAMIENTO DE DORSIFLEXIÓN



INTENSIDAD
4-6/10

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático y test
TIEMPO: 30-60 seg por serie
RESPIRACIÓN: Fluida
MANTIENE FIJO: Talón siempre apoyado

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para el alumno que levanta los talones en una sentadilla o que siente que no puede bajar en una zancada.

PASO A PASO

1. En posición de partida, apoyá las manos en la pared.

2. Llevá la rodilla de adelante a tocar la pared sin levantar el talón.

3. **TEST:** Si la rodilla toca fácil, alejá el pie 1 cm y repetí hasta encontrar tu máxima distancia. Medí los cm entre los dedos y la pared.

4. **ESTIRAMIENTO:** Sostené esa posición máxima sin dolor por 30-60 seg.

VALORES DE REFERENCIA (TEST):
Menos de 5 cm es muy limitado. 10-13 cm es un rango funcional.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Levantar el talón**
  (El estiramiento se anula, hay que mantenerlo abajo).
- **Pronar el pie**
  (El arco se cae para compensar, mantenelo alineado).
- **Sentir un pinzamiento adelante**
  (Es un posible tope óseo, no lo fuerces).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **HIPERMOVILIDAD:** SÍ, con control.
- ✓ **HERNIA:** SÍ.
- ✓ **RODILLA OPERADA:** SÍ, con alta médica y sin dolor.
- ✓ **EMBARAZO:** SÍ.
- ✓ **ADULTO MAYOR:** SÍ, con buen apoyo.
- ✗ **LESIÓN RECIENTE:** NO si hay dolor agudo.

PROGRESIÓN Y REGRESIÓN

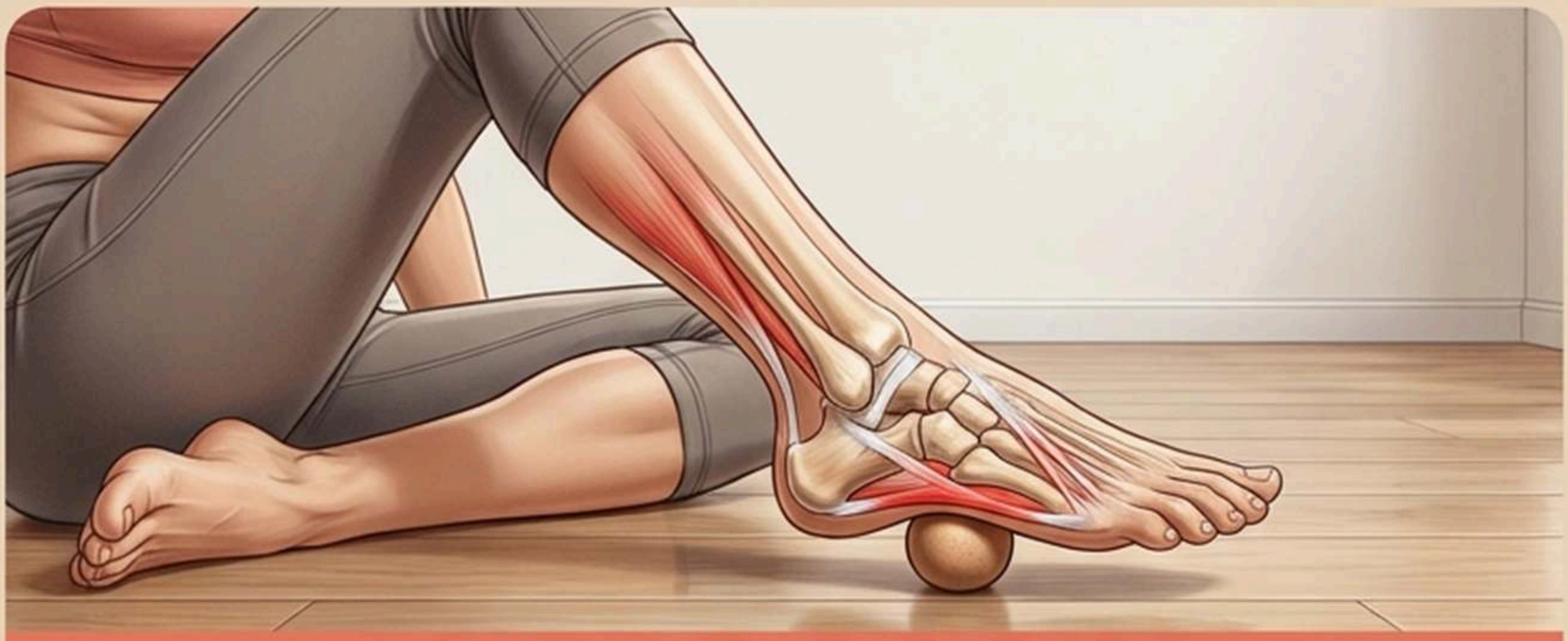
REGRESIÓN: Sentado con una banda elástica en el antepié.
PROGRESIÓN: Añadir un peso ligero sobre la rodilla.

CUE DE LA FORMADORA PARA SU CASA

"Buscá sentir que estira la pantorrilla, no que pincha adelante. Medí tu distancia a la pared una vez por semana para ver cómo progresás".

NIVEL: BÁSICO

LIBERACIÓN DE FASCIA PLANTAR



FICHA DE ESTIRAMIENTO / LIBERACIÓN MIOFASCIAL

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para alumnas con pies cansados, rígidos o con tirantez en el arco, pero sin diagnóstico de fascitis plantar aguda.

POSICIÓN DE PARTIDA

Sentada en una silla, pies en el suelo y una pelota pequeña y firme (tipo tenis) bajo un pie.

ZONA Y MÚSCULOS QUE SE ESTIRAN

Planta del pie (fascia plantar, musculatura intrínseca).

FRENO QUE SE TRABAJA

Fascial.

EL ESTIRAMIENTO

Liberación miofascial.
Intensidad 5-7/10. Tiempo 1-2 minutos por pie.
Respiración profunda para ayudar a relajar.
Qué se mantiene fijo: una presión tolerable, sin dolor agudo.

PASO A PASO

1. 1. Sentada, ubicá la pelota bajo el arco del pie.
2. 2. Hacé rodar la pelota muy lentamente desde el talón a la base de los dedos, aplicando algo de peso (10-12 pasadas).
3. 3. Cuando encuentres un punto más tenso, detenete y mantené una presión constante por 20-30 segundos, respirando.
4. 4. Masajeá los bordes interno y externo del arco.
5. 5. Terminá con pasadas de lado a lado en la zona del metatarso.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

Ir muy rápido (no da tiempo a que el tejido responda, hay que moverse lento); usar demasiada presión (si duele, el cuerpo se defiende y se contrae más); empezar de pie (sentada se controla mucho mejor la carga).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad: sí.
Hernia: sí.
Rodilla operada: sí.
Embarazo: sí.

Adulto mayor: sí, siempre sentada.
Lesión reciente: no si hay fascitis aguda, fractura por estrés o herida.

REGRESIÓN: Usar una pelota más blanda o hacerlo sobre una alfombra.

PROGRESIÓN: Hacerlo de pie con apoyo en una pared.

PARA SU CASA: "Hacelo descalza al final del dia. Es normal que haya puntos sensibles, pero nunca un dolor eléctrico o punzante. Al terminar, mové los dedos y sentí la diferencia".
NIVEL: Básico.

SENTADILLA PROFUNDA (MALASANA)

NIVEL: Intermedio

PARA QUIÉN

Para quien busca mejorar la movilidad funcional de tobillo, rodilla y cadera de forma integrada.

ISQUIOTIBIALES · INTENSIDAD 6 · 45 SEG · 3 SERIES

EL ESTIRAMIENTO

Método estático activo.
Intensidad 4-7/10.
Tiempo 30-90 segundos.
Respiración diafragmática.
Fijo: talones en el suelo y columna larga.

PASO A PASO

1.
Desde la posición de partida, **flexioná rodillas y caderas** como si te sentaras en una silla baja.

2.
Bajá la cadera por debajo de las rodillas, manteniendo talones apoyados.

3.
Ubicá los codos en la cara interna de rodillas y juntá palmas al pecho.

4.
Usá los codos para abrir rodillas y alargá la columna hacia el techo. Sostené.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

✗ **Levantar talones** (falta dorsiflexión, usar un realce); **redondear espalda baja** (hay que activar abdomen); dejar caer **rodillas** adentro (empujar con codos).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad**: con control;
- ✓ **Rodilla operada**: si no duele;
- ✓ **Embarazo**: sí (salvo contraind);
- ✗ **Lesión reciente**: no si duele.
- ✗ **Hernia**: espalda neutra;
- ✓ **Embarazo**: sí (salvo
- ✗ **Adulto mayor**: con silla;

REGRESIÓN

Sostenerse de un poste o colocar bloque bajo isquiones.

PROGRESIÓN

Soltar el apoyo de las manos y buscar el equilibrio.

PARA SU CASA

Si tus talones no llegan, poné una manta doblada. Con práctica diaria, cada vez vas a necesitar menos altura.

MOVILIDAD POST ESGUINCE

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

NIVEL: Especial

Para alumnas que tuvieron un esguince de tobillo hace tiempo, tienen el alta médica pero notan el tobillo rígido o inestable.

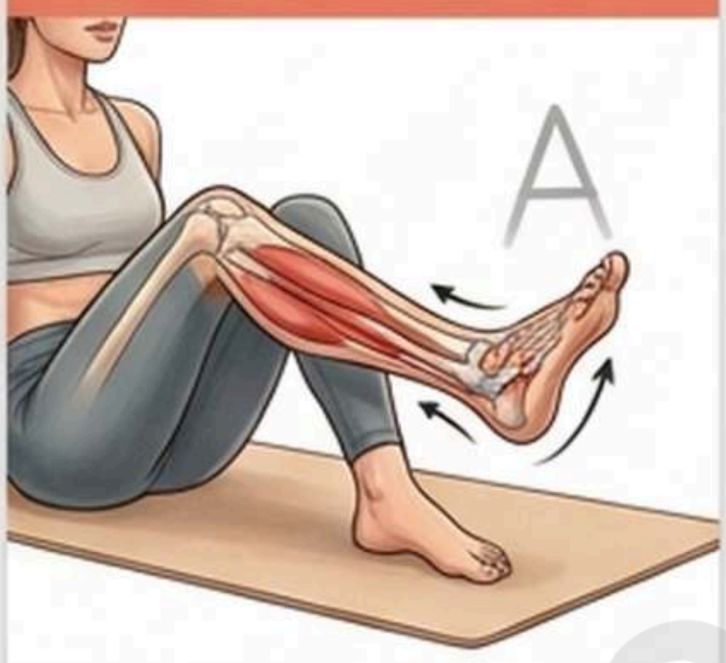
ZONA Y MÚSCULOS QUE SE ESTIRAN: Articulación del tobillo, peroneos, tejido cicatricial de los ligamentos.

FRENO QUE SE TRABAJA: Cicatricial y propioceptivo (control motor).

EL FOCO: El objetivo no es solo estirar, sino recuperar el movimiento funcional y reeducar la propiocepción para evitar que vuelva a suceder.

QUÉ SÍ (3 EJERCICIOS CLAVE)

ALFABETO CON EL PIE



Sentada, dibujar las letras del abecedario en el aire con el pie. 2 series. Recupera el movimiento en todos los planos de forma suave.

ESTIRAMIENTO DE PANTORRILLA

Con mucho cuidado y sin dolor, estirar gemelo y sóleo (pág. 133), porque la inmovilización los acorta. 2x30 seg.

EQUILIBRIO MONOPODAL

Pararse sobre el pie afectado en suelo firme por 30-60 seg. Esto reprograma los sensores de la articulación.

QUÉ NO (3 COSAS A EVITAR)

- **ESTIRAMIENTOS BALÍSTICOS**
  Nada de rebotes. El tejido cicatricial no es elástico y se puede irritar.
- **IGNORAR LA INESTABILIDAD**
  Si el tobillo 'falla', el foco tiene que ser fortalecer y mejorar el equilibrio, no solo estirar.
- **FORZAR LA INVERSIÓN**
  No fuerces de forma pasiva el movimiento que causó la lesión (llevar la planta del pie hacia adentro).

CUÁNDO CONSULTAR

Si hay dolor agudo, hinchazón, un 'clic' doloroso o sensación de bloqueo, la alumna debe volver a consultar a su médico o kinesiólogo. Esto no es un protocolo de rehabilitación, sino de optimización post-alta.

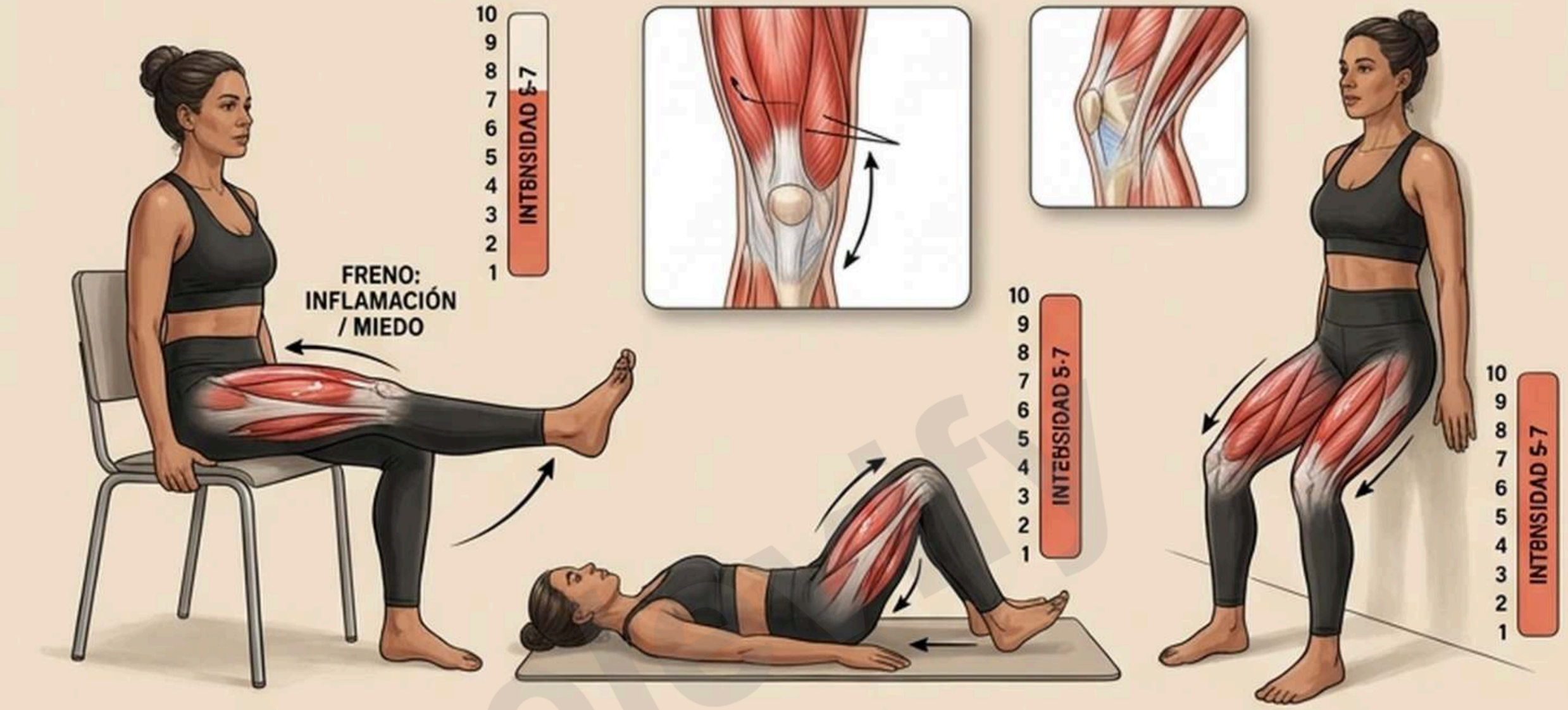
QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA

"La clave es la constancia y la suavidad. Un poco de movilidad todos los días y algo de equilibrio mientras te cepillás los dientes".

MOVILIDAD EN RODILLA OPERADA

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN: PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para alumnos con alta kinesiológica tras una cirugía de rodilla (meniscos, LCA) que necesitan reintegrarse a la práctica de forma segura.
ZONA Y MÚSCULOS QUE SE ESTIRAN: Articulación de la rodilla, cuádriceps, isquiotibiales.
FRENO QUE SE TRABAJA: Dolor, inflamación, fibrosis cicatricial y miedo al movimiento.
EL FOCO: Recuperar el rango funcional (extensión completa y flexión útil) sin dolor ni inflamación. El cómo es más importante que el cuánto.



FLEXO-EXTENSIÓN ACTIVA
INTENSIDAD 5-7 · 2x15 REP

DESLIZAMIENTOS DE TALÓN
INTENSIDAD 5-7 · 10 REP SUAVES

MINI-SENTADILLA ISOMÉTRICA
INTENSIDAD 5-7 · SOSTENER 20-30 SEG

QUÉ SÍ (3 EJERCICIOS CLAVE)

✅ **1. FLEXO-EXTENSIÓN ACTIVA:** Sentado al borde de una silla, extender y flexionar la pierna lentamente, contrayendo el cuádriceps al final de la extensión. 2x15 rep.

✅ **2. DESLIZAMIENTOS DE TALÓN:** Acostado, deslizar el talón por el suelo hacia el glúteo para ganar flexión de forma controlada. 10 rep. suaves.

✅ **3. MINI-SENTADILLA ISOMÉTRICA:** Espalda en la pared, bajar solo unos 30 grados y sostener 20-30 seg. para activar la musculatura sin impacto.

QUÉ NO (3 COSAS A EVITAR)

❌ **1. FLEXIÓN PROFUNDA FORZADA:** No sentarse sobre los talones ni hacer posturas de flexión máxima si hay dolor o bloqueo.

❌ **2. HIPEREXTENSIÓN PASIVA:** No empujar la rodilla hacia atrás. La extensión se recupera activando el cuádriceps.

❌ **3. EJERCICIOS CON TORSIÓN O IMPACTO:** Saltos o giros bruscos están contraindicados hasta que la fuerza y el control sean óptimos.

LA REGLA DE ORO

El dolor y la hinchazón son el semáforo. Si un ejercicio genera dolor (no tirantez) o inflama la rodilla, hay que retroceder. La recuperación no es lineal. Este material no reemplaza el seguimiento profesional.

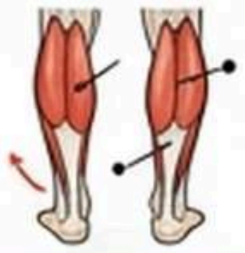
QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO PARA SU CASA

'Tu trabajo diario es mover la rodilla en el rango que hoy tenés disponible y sin dolor. La constancia en lo suave es lo que te va a devolver la función'

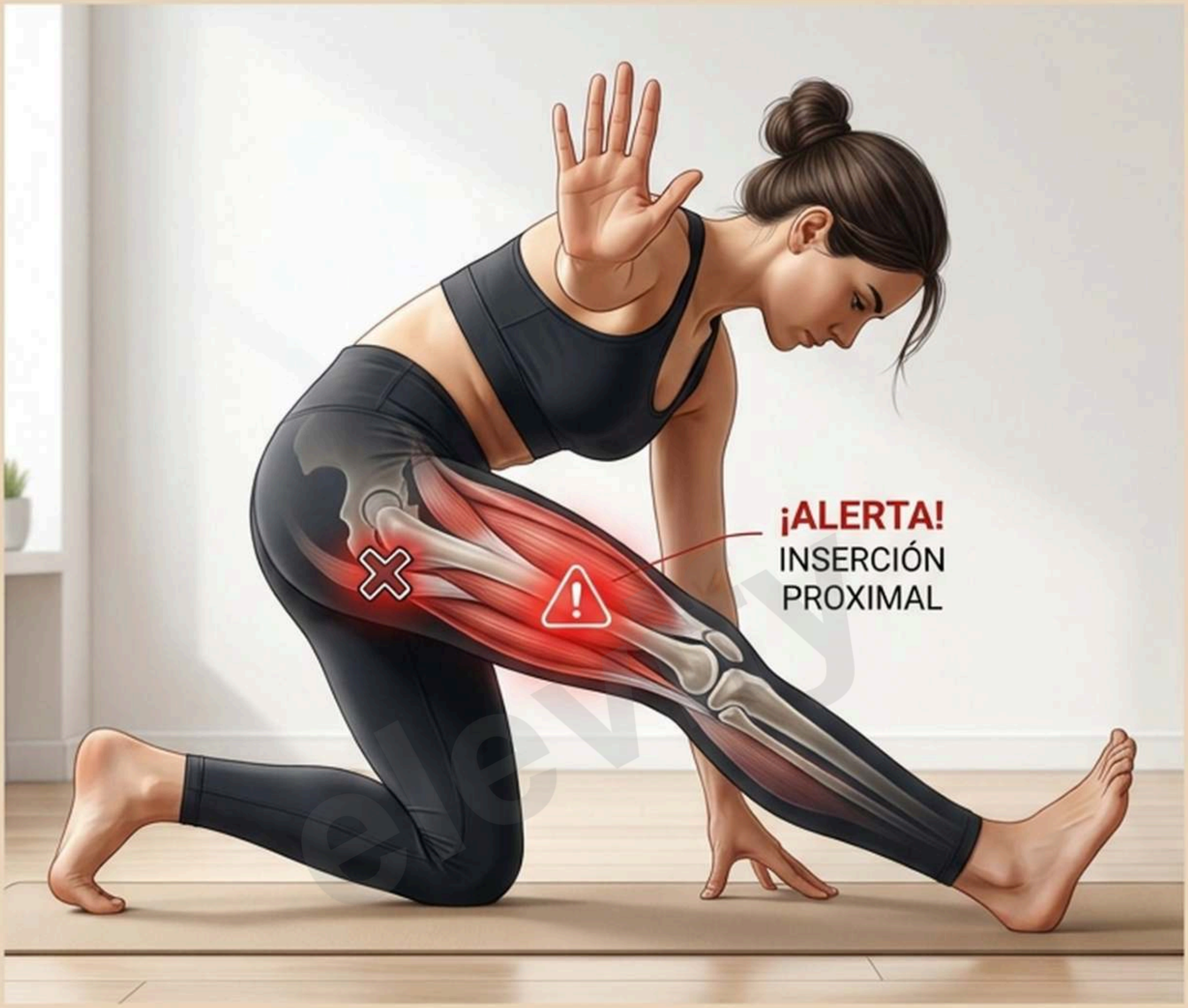
NIVEL: ESPECIAL

GUÍA RÁPIDA: MOLESTIA Y POSIBLE SOLUCIÓN

Esta tabla es una guía orientativa para profesionales. No reemplaza un diagnóstico. Ante una molestia persistente o un dolor agudo, derivá siempre a un médico o kinesióiogo.

SENSACIÓN O MOLESTIA COMÚN	QUÉ ESTIRAR O MOVILIZAR (Y PÁGINA)
El talón se me levanta en la sentadilla.	Dorsiflexión de tobillo (gemelo y sóleo). Pág. 133. 
Siento tirantez en la planta del pie por la mañana.	Liberación de fascia plantar y flexores de los dedos. Pág. 134.
Me cuesta ponerme en cuclillas.	Sentadilla profunda asistida (Malasana). Pág. 135.
Siento rígida la parte de adelante de la tibia.	Movilidad de tobillo y estiramiento del tibial anterior (sentada sobre empeines).
Tensión en el tendón de Aquiles.	Estiramiento excéntrico de gemelos y sóleo (bajar el talón de un escalón).
Molestia en la cara externa de la rodilla al correr.	Puede ser la banda iliotibial. Liberación de TFL y glúteo medio.
Rigidez general en la rodilla (sin dolor agudo).	Movilidad activa en rango sin dolor (flexo-extensión). Pág. 137.
Pies cansados y acalambrados.	Liberación con pelota (pág. 134) y movilidad activa de los dedos.

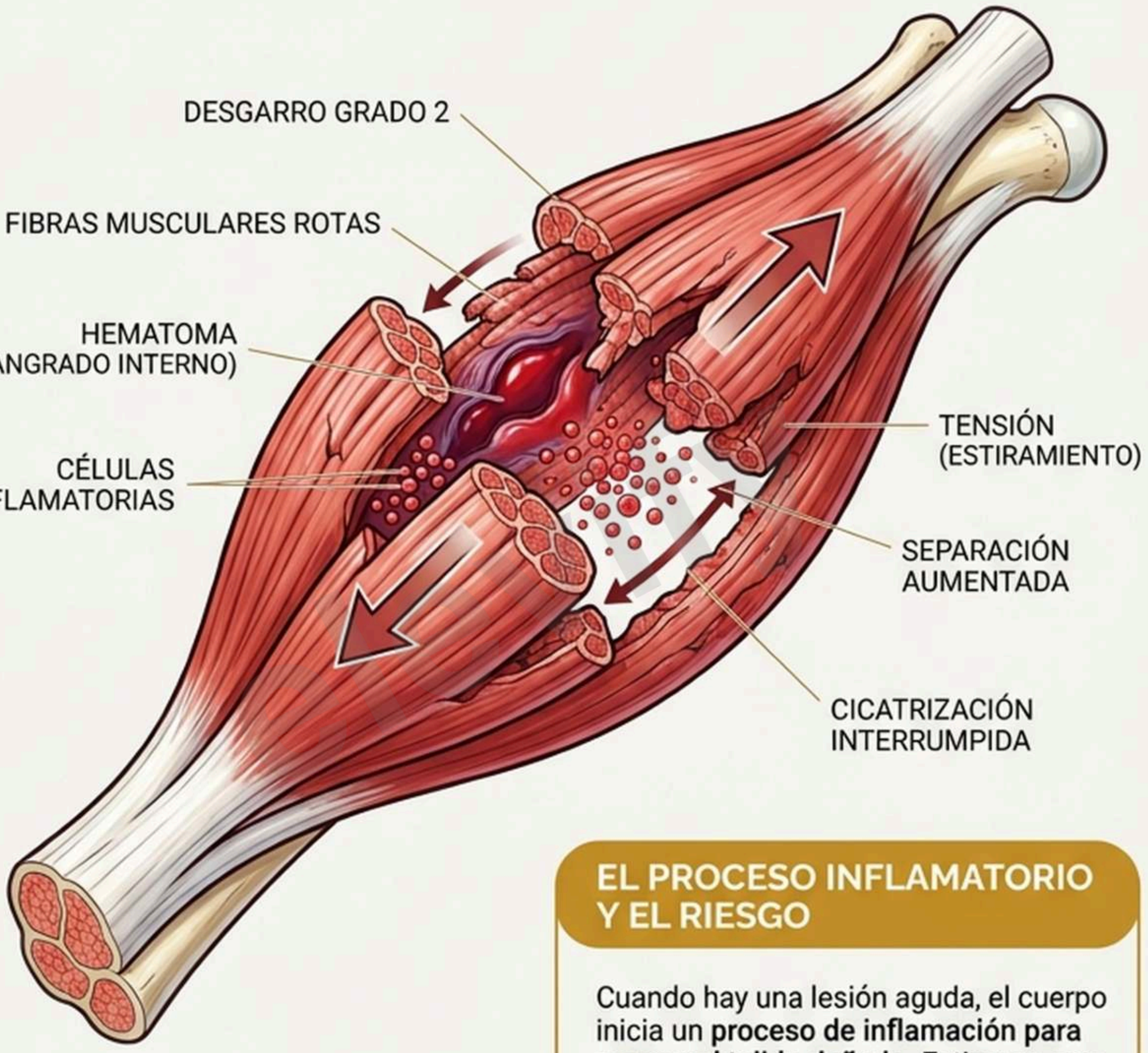
CUÁNDO NO ESTIRAR



Seguridad y banderas rojas para un trabajo consciente.

EN ESTE CAPÍTULO: Aprenderás a identificar las situaciones en las que estirar puede ser contraproducente o peligroso. Veremos las contraindicaciones absolutas y relativas, cómo diferenciar el dolor bueno del malo y qué hacer ante señales de alarma como hormigueo o chasquidos. Tu rol como profe es cuidar, y eso a veces significa no forzar.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS



EL PROCESO INFLAMATORIO Y EL RIESGO

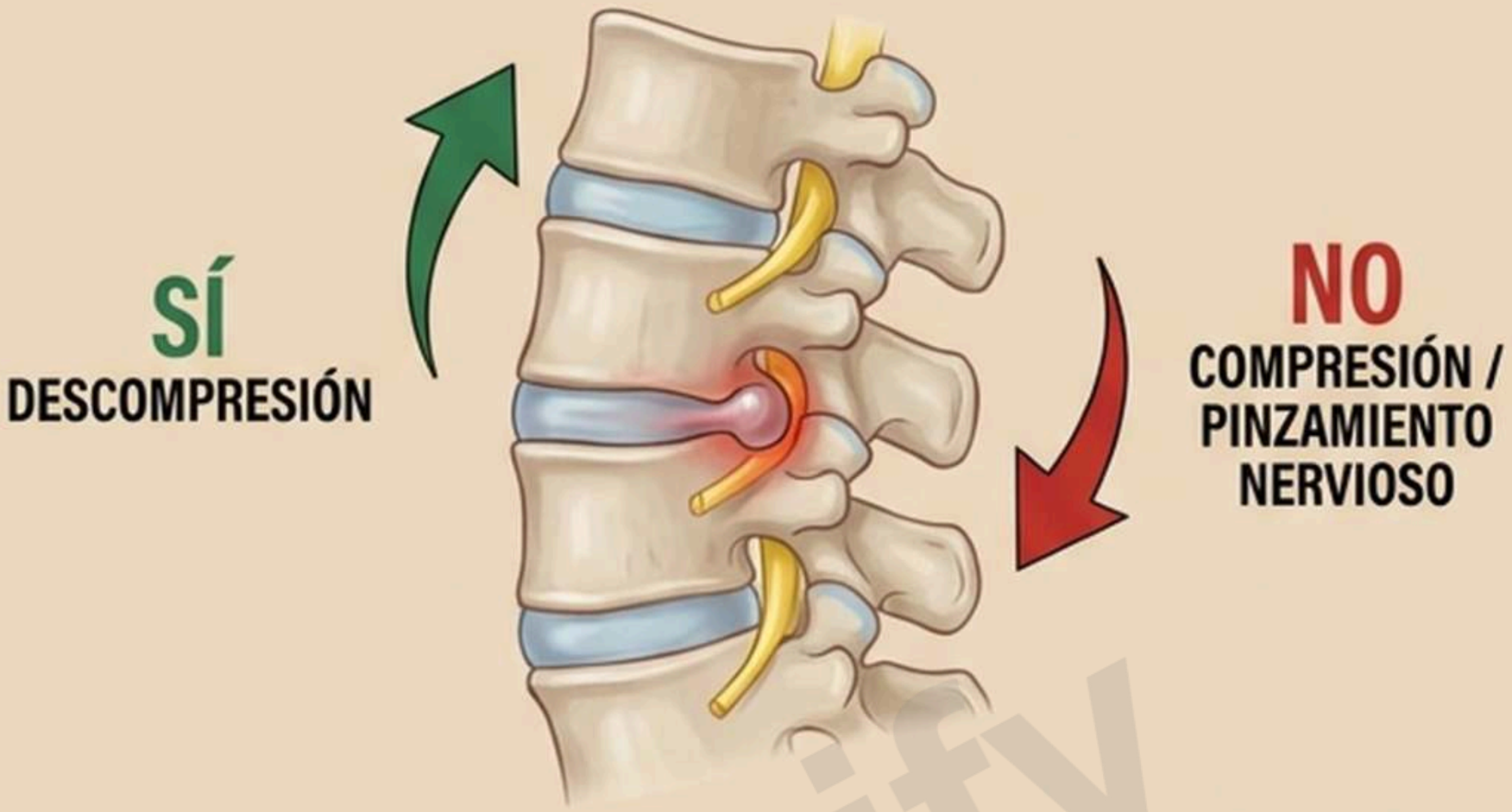
Cuando hay una lesión aguda, el cuerpo inicia un **proceso de inflamación para reparar el tejido dañado.** Estirar en esta fase es como volver **a abrir una herida: aumenta el sangrado, interrumpe la formación del nuevo tejido cicatricial y puede agravar la lesión, retrasando la recuperación.**

Esto aplica a **desgarros recientes, fracturas no consolidadas, esguinces agudos, tendinitis activas o cualquier cirugía que no tenga el alta médica para movilizar.**
El reposo relativo y la consulta profesional son la única vía.

EN LA SALA

Tu alumna llega con un **cabestrillo por una luxación de hombro de ayer.**
No se estira el brazo afectado bajo **ningún concepto.**

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS



PRINCIPIOS Y ADAPTACIONES

A diferencia de las absolutas, las **contraindicaciones relativas** no prohíben el estiramiento, pero exigen adaptaciones y un conocimiento profundo.

Condiciones como la **hernia discal**, la **hipermovilidad**, la **osteoporosis** o el **embarazo** modifican la forma en que el cuerpo responde a la tensión. En estos casos, estirar sin criterio puede desestabilizar una articulación o agravar una condición existente.

El objetivo no es ganar rango porque sí, sino mejorar la función y la calidad del movimiento, siempre dentro de un marco de seguridad y, a menudo, con la aprobación de su médico.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

- Adaptar el ejercicio, bajar la intensidad.
- Usar soportes y enfocarse en la estabilidad.
- Respetar el límite de dolor o molestia.
- Consultar siempre ante la duda o síntoma.

QUÉ NO

- Aplicar recetas genéricas y estandarizadas.
- Buscar rangos máximos o forzar la postura.
- Ignorar la condición de base del alumno.
- Generar dolor agudo, hormigueo o chasquidos.

DOLOR BUENO VS. DOLOR MALO

SENSACIÓN DE ESTIRAMIENTO

El estiramiento seguro es una **tensión tolerable, difusa y localizada** en el **músculo** que se está trabajando. Cede al soltar la postura.

SEÑAL DE LESIÓN

El **dolor agudo, punzante, quemante o que se irradia** es una **bandera roja**. Indica posible daño a tendones, ligamentos o nervios.

FUNDAMENTAL: DISTINGUIR ENTRE TIRANTEZ Y LESIÓN

Es fundamental que vos y tus alumnos aprendan a distinguir entre la **tirantez productiva de un estiramiento** y el **dolor** que avisa de una **lesión**. La sensación de estiramiento debe ser tolerable (máximo 7/10), sentirse en el vientre muscular y aliviarse al soltar la postura.

Un dolor **agudo, punzante**, quemante, **que se irradia o que se localiza muy cerca de una articulación es una bandera roja**. Este dolor indica que podrías estar comprimiendo un nervio, pinzando una estructura o dañando la inserción de un tendón.

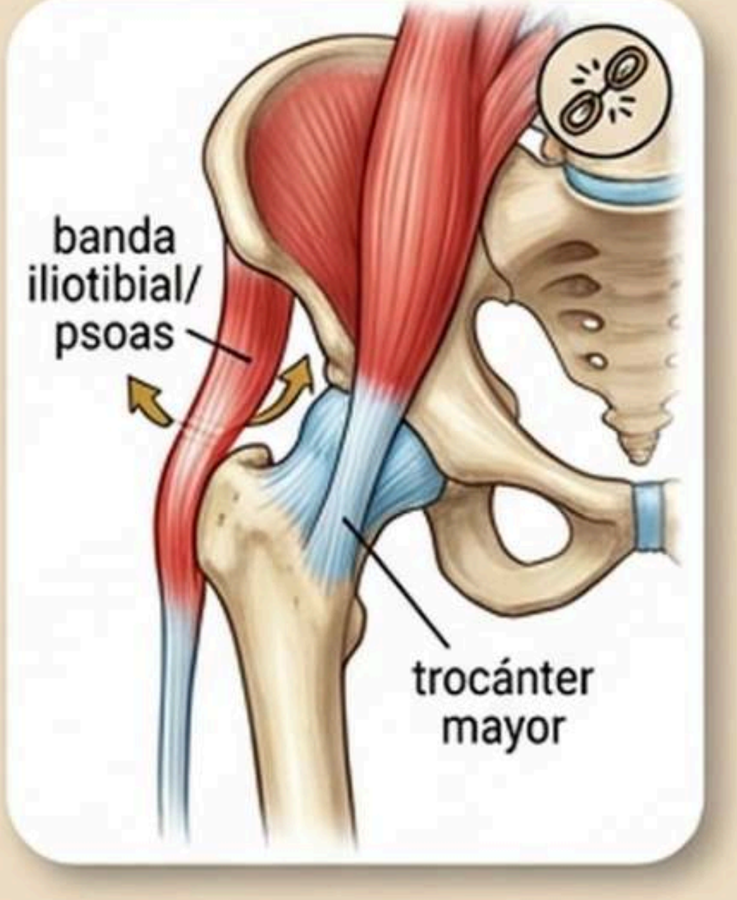
Ante cualquier duda, dolor intenso o síntoma neurológico (hormigueo, pérdida de sensibilidad), **se debe interrumpir el ejercicio y consultar a un profesional.**

EN LA SALA: CUE DE LA FORMADORA

Cuando un alumno pone cara de dolor, le preguntás: *"¿Dónde lo sentís exactamente? ¿Es una tirantez muscular en el medio del muslo o es algo más, como un pinchazo o quemazón en la cadera?"*. Si es lo segundo, paramos.

TRES SEÑALES PARA FRENAR

CHASQUIDO



Un chasquido audible y doloroso puede indicar que un tendón está rozando contra un hueso o que hay inestabilidad articular.

HORMIGUEO

El hormigueo, adormecimiento o sensación eléctrica sugiere que estás comprimiendo o irritando un nervio.

DEBILIDAD

La pérdida súbita de fuerza en el músculo que estás estirando o en la zona es una señal de alarma neurológica.

Hay tres sensaciones que nunca deben ser ignoradas durante un estiramiento. Ante cualquiera de estas tres, se detiene el ejercicio inmediatamente. No fuerces el cuerpo más allá de sus límites seguros.
La prevención es clave para evitar lesiones graves.

EN LA SALA

Siento como electricidad que me baja por la pierna cuando estiro el piramidal.

Ok, aflojá ya mismo. Vamos a probar otra variante que no comprometa ese nervio.

HIPERMOVILIDAD Y EHLERS-DANLOS

HIPERMOVILIDAD: MÁS NO ES MEJOR.

COMPRENSIÓN Y ENFOQUE

Las personas con hipermovilidad articular o síndromes como Ehlers-Danlos tienen un colágeno más laxo. Sus articulaciones se mueven más allá del rango normal, pero porque sus "frenos" pasivos (ligamentos, cápsula) son débiles. Para ellos, estirar pasivamente en rangos extremos no trae beneficios; al contrario, aumenta la inestabilidad, el riesgo de luxaciones y el dolor crónico.

El objetivo con estos alumnos es enseñarles a controlar su rango y a fortalecer la musculatura estabilizadora para proteger sus articulaciones.

QUÉ SÍ: ENFOQUE CORRECTO

- Ejercicios de activación y fuerza en rangos medios y finales para dar soporte muscular.
- Trabajo de control motor y propiocepción para reconocer los límites.
- Fortalecimiento de la musculatura profunda estabilizadora (core, manguito rotador, glúteos).

QUÉ NO: BANDERAS ROJAS

- Forzar la flexibilidad pasiva más allá del rango funcional.
- Colgarse de las articulaciones o usar el peso del cuerpo para aumentar el estiramiento.
- Buscar posturas de contorsionismo o trucos extremos.

EL CUE DE LA FORMADORA

Con hipermovilidad, la sensación de 'tope' no es el límite real. No busques llegar al máximo, buscá el punto donde sentís trabajo muscular sin colgarte de la articulación. Priorizá la estabilidad sobre la profundidad.

ESTIRAR DURANTE EL EMBARAZO

I⁴ IN EFECTO E⁵ LA RELAXINA

EL EFECTO RELAXINA: FALSA FLEXIBILIDAD

Durante el embarazo, la hormona relaxina **aumenta la laxitud de los ligamentos, especialmente en la pelvis,** para preparar el **cuerpo para el parto.** Esto significa que la alumna puede sentir que tiene más flexibilidad de lo habitual, pero es una 'falsa' flexibilidad que puede llevar a la **inestabilidad** de la sinfisis púbica o las articulaciones sacroiliacas si se fuerza. **Se deben evitar los estiramientos profundos y asimétricos de la pelvis, así como las flexiones y torsiones abdominales intensas que pueden agravar la diástasis de los rectos. El foco es la movilidad suave y el fortalecimiento.**

QUÉ SÍ / QUÉ NO EN EL EMBARAZO

QUÉ SÍ

- Movilidad articular suave
- Estiramientos controlados (corto rango)
- Fortalecimiento de suelo pélvico y core profundo
- Posturas simétricas y estables
- Respiración diafragmática consciente

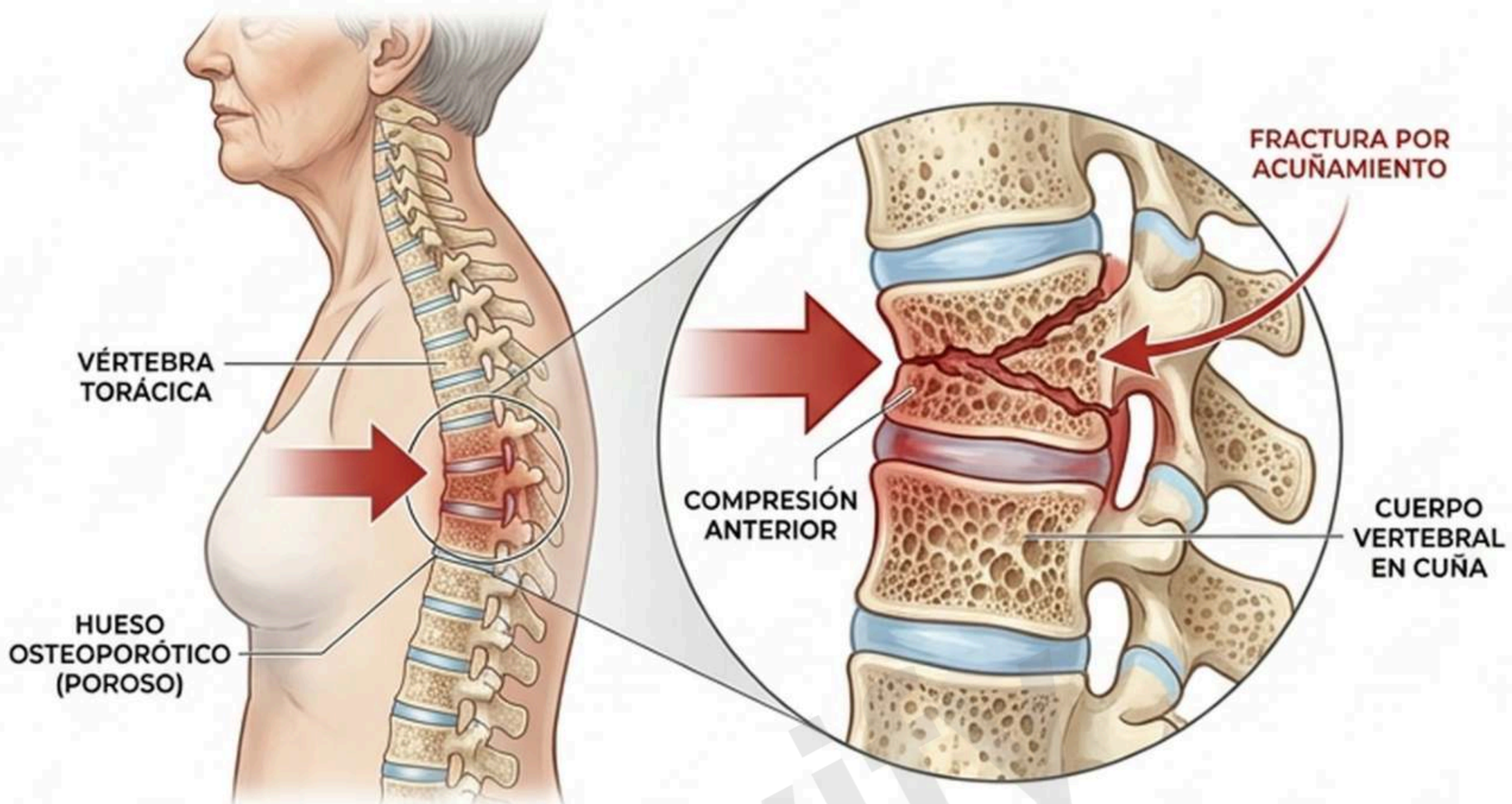
QUÉ NO

- Estiramientos profundos y forzados
- Aperturas extremas de cadera
- Torsiones intensas de columna
- Flexiones abdominales fuertes (crunches)
- Posturas boca abajo o con presión en el abdomen

EN LA SALA: DIÁLOGO CON LA ALUMNA EMBARAZADA

Una alumna embarazada te dice que ahora llega mucho más lejos en las aperturas de cadera. Le explicás el efecto de la relaxina y la invitás a trabajar en un rango más corto y controlado, priorizando la estabilidad y la escucha del cuerpo sobre la profundidad de la postura. Le sugeris enfocarse en la movilidad suave y el fortalecimiento seguro para prepararse para el parto y la recuperación posparto.

OSTEOPOROSIS: CUIDADO CON LA FLEXIÓN



LA OSTEOPOROSIS DEBILITA LOS HUESOS

LA OSTEOPOROSIS DEBILITA LOS HUESOS

La **osteoporosis** debilita los huesos, volviéndolos frágiles y susceptibles a **fracturas**, especialmente los **cuerpos vertebrales**.
Los movimientos de **flexión de columna**, como enrollarse hacia adelante para tocarse los pies o hacer abdominales tradicionales, **aumentan drásticamente la presión sobre** la parte anterior de las vértebras.

En un hueso osteoporótico, esta presión puede causar una **fractura por compresión** o **acuñamiento**, provocando dolor, pérdida de altura y aumento de la cifosis (joroba). Por eso, en alumnos con osteoporosis u osteopenia, estos movimientos están contraindicados.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

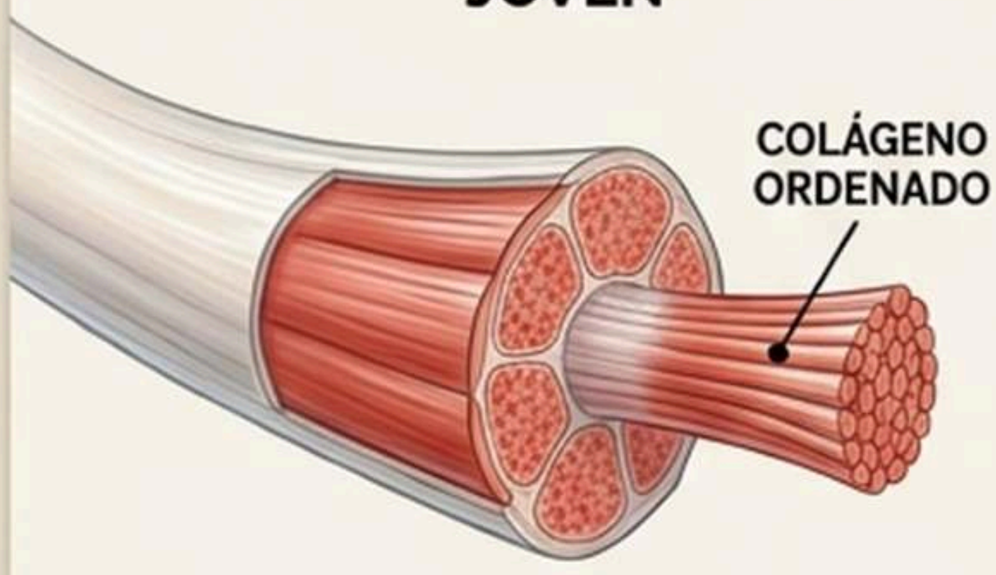
Ejercicios de extensión de columna para fortalecer la espalda, trabajo de equilibrio y movilidad de caderas y hombros.

QUÉ NO

Flexión de columna, rotaciones con carga o cualquier movimiento que implique un riesgo de caída.

ESTIRAR EN EL ADULTAR ADAPTAR

'JOVEN'



Fibras bien hidratadas, elásticas y flexibles. Resistencia óptima.

'MAYOR'

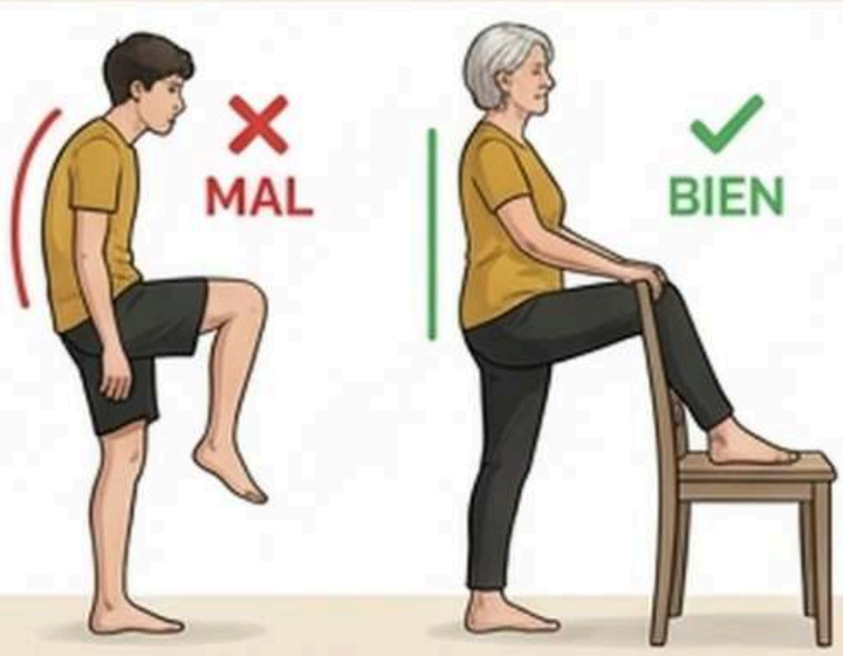
Fibras desorganizadas, menos hidratación, mayor rigidez. Riesgo aumentado.

TEORÍA: EL CAMBIO EN EL TEJIDO CONECTIVO

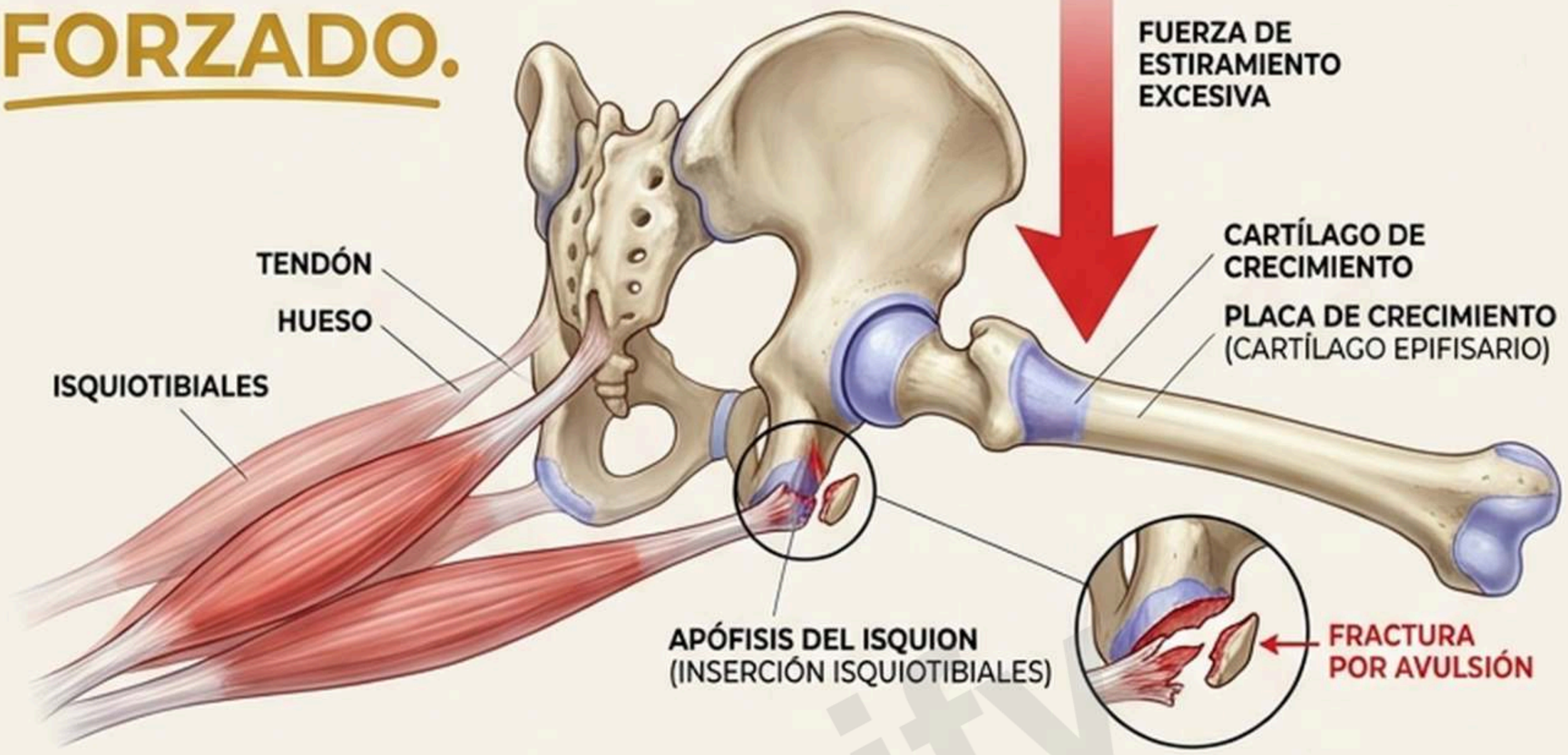
Con la edad, los tejidos conectivos como tendones y ligamentos pierden agua y elasticidad, volviéndose más rígidos y fráglles. Esto significa que responden más lentamente al estiramiento y tienen un mayor riesgo de lesión. Además, el equilibrio y la propiocepción suelen disminuir. Por eso, el trabajo de flexibilidad en adultos mayores debe ser más suave, progresivo y seguro. Los estiramientos dinámicos suaves son a menudo preferibles a los estáticos intensos, y siempre se deben usar soportes como sillas o paredes para evitar caídas.

EN LA SALA: LA SEGURIDAD PRIMERO

En lugar de una flexión de cadera de pie sin apoyo, le das a tu alumno de 80 años una silla para que se sostenga. La seguridad y la confianza son lo primero.



NIÑOS: NO ES GOMA
FORZADO.



EL ESQUELETO EN DESARROLLO

El esqueleto de los niños y adolescentes no está completamente osificado. Tienen zonas de cartilago de crecimiento (placas epifisarias y apófisis) que son mucho más débiles que los tendones y ligamentos.

Cuando se aplica una fuerza de estiramiento excesiva o un movimiento balístico, el tendón puede arrancar el trozo de hueso al que está anclado en lugar de desgarrarse él mismo. Esto se llama fractura por avulsión.

Forzar a un niño a un split o a rangos extremos no solo es innecesario, sino que puede causar lesiones graves y permanentes en sus placas de crecimiento.

EN LA SALA

QUÉ NO

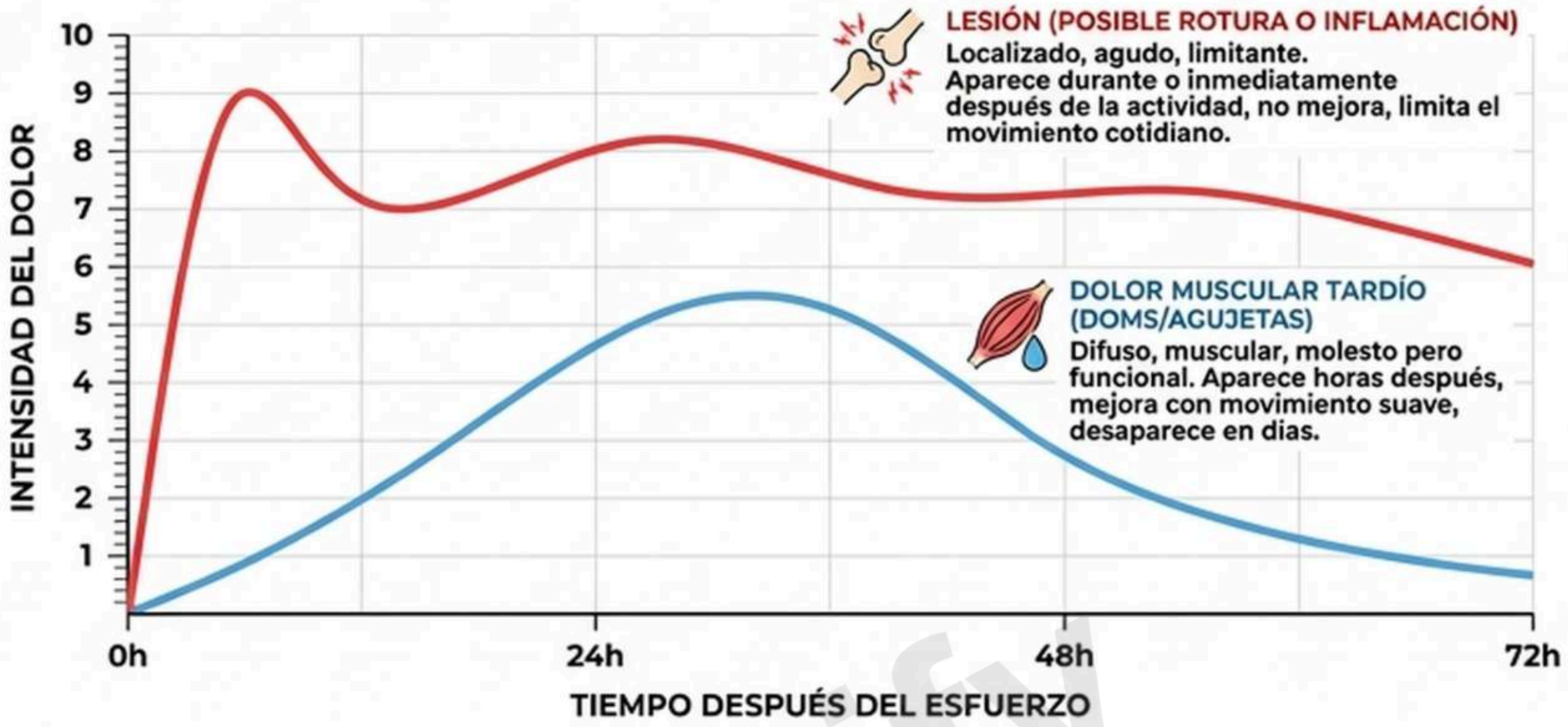
En la clase de danza, una madre empuja la espalda de su hija para que baje más en el "spagat". La niña muestra incomodidad.

QUÉ SÍ

Intervenís con calma: explicás el riesgo para sus cartilagos de crecimiento. Priorizás la seguridad y el desarrollo saludable sobre la flexibilidad extrema.

SEGURIDAD PRIMERO

¿DOLOR NORMAL O LESIÓN?



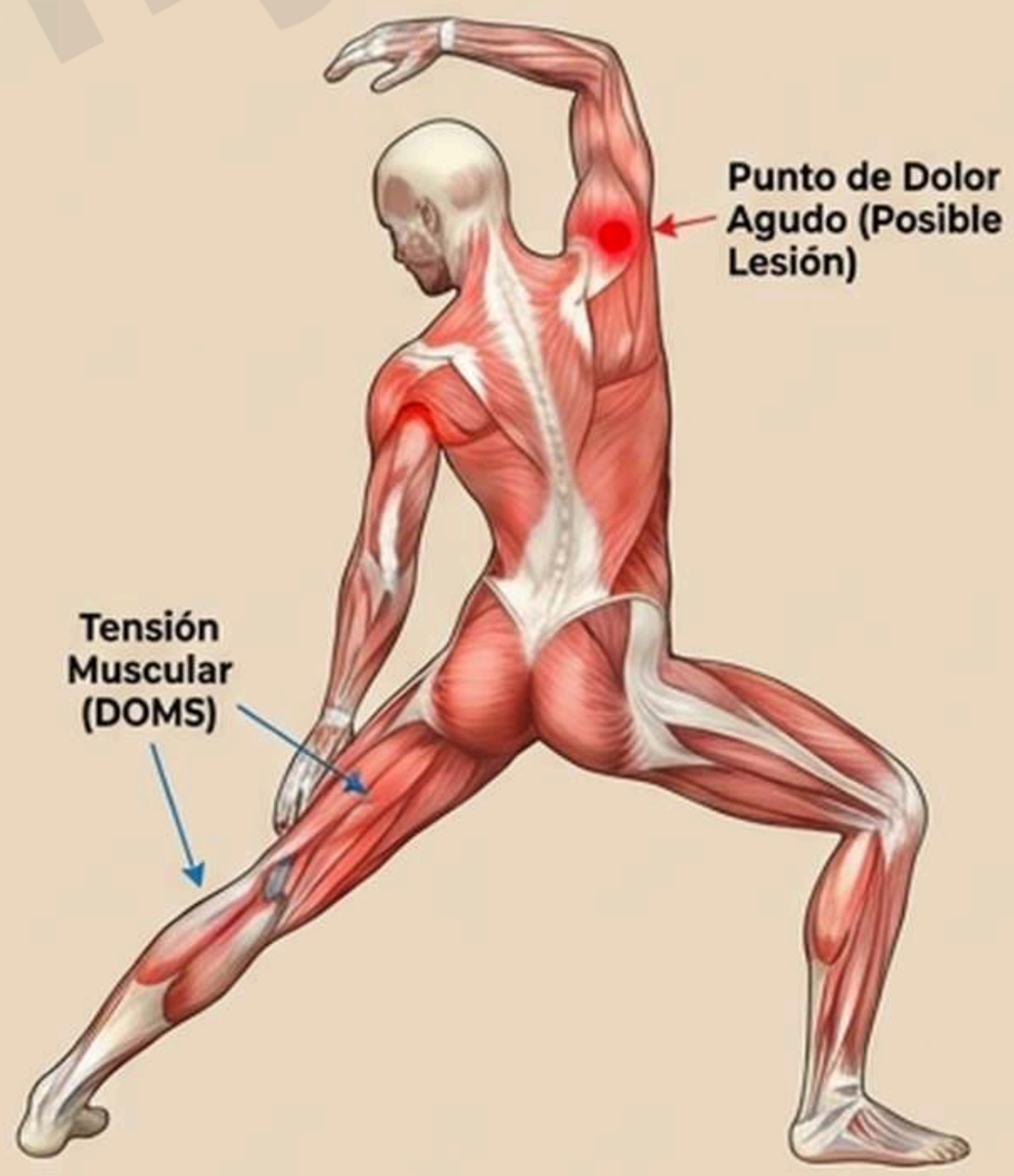
COMPRENDER LA DIFERENCIA: CLAVES PARA TU CUERPO

Es común y esperable sentir una molestia muscular difusa uno o dos dias después de una sesión intensa o nueva. Esto se conoce como Dolor Muscular de Aparición Tardía (DOMS o "agujetas"). Es causado por microrroturas en las fibras musculares y el tejido conectivo que estimulan la reparación, adaptación y el crecimiento muscular.

Este tipo de dolor es generalizado, bilateral si se trabajaron ambos lados, y suele mejorar con movimiento suave, calor y estiramientos ligeros, desapareciendo por completo en unos pocos días.

En cambio, un **dolor agudo, punzante y localizado** en un punto especifico, que apareció de repente durante la clase, que no mejora con el reposo, que causa hinchazón visible o limita significativamente tu rango de movimiento cotidiano, probablemente no sea DOMS sino una lesión más seria.

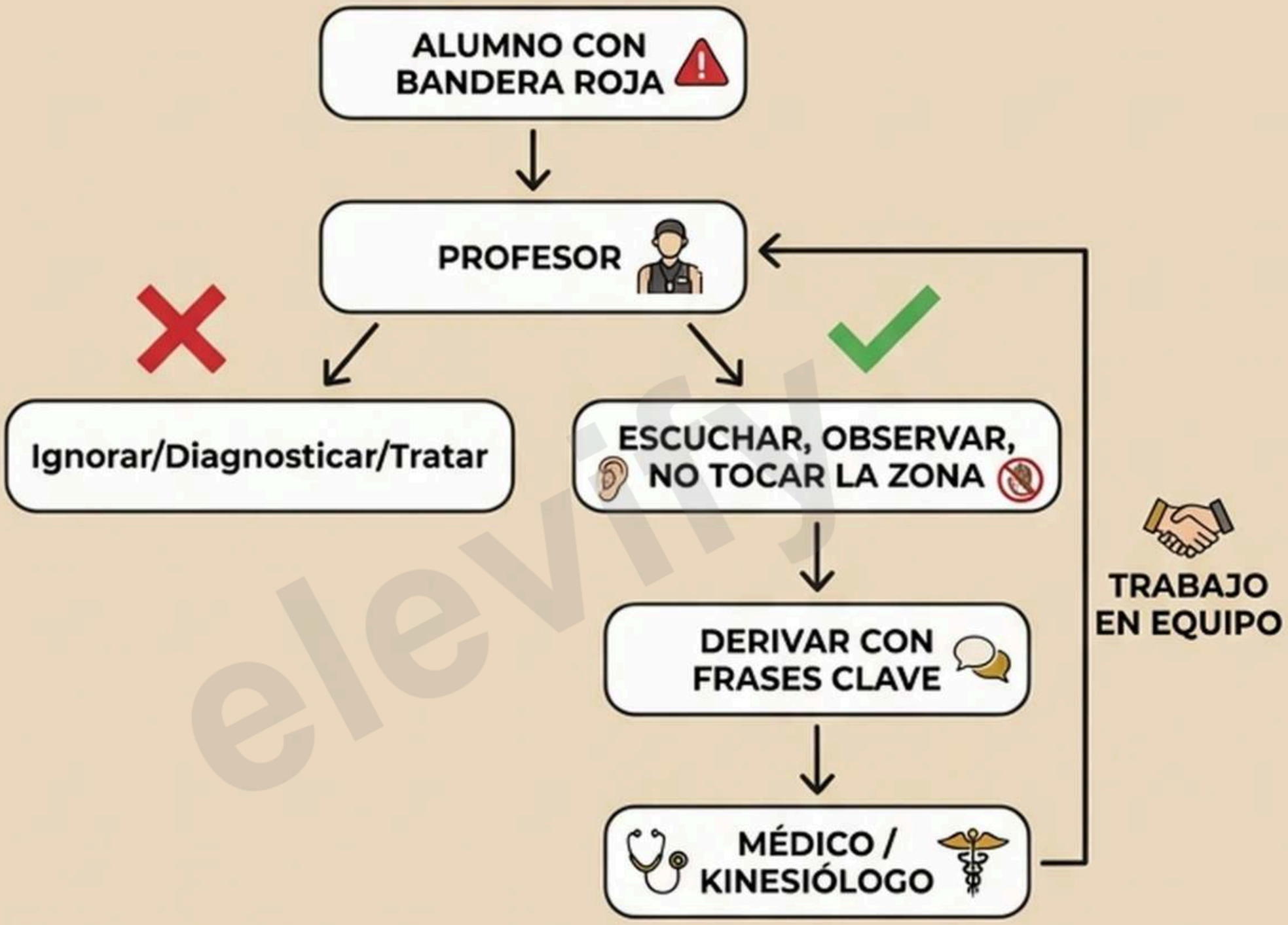
Ante la duda, siempre es mejor pecar de precavido, reducir la actividad y buscar asesoramiento profesional. No ignores las señales de tu cuerpo.



EN LA SALA: DIÁLOGO DE SEGURIDAD

Un alumno te escribe: "Me duele todo desde la clase de ayer, no me puedo mover". Vos le preguntás: "¿Es una molestia muscular general que sentis en varios grupos o un dolor agudo en un punto especifico que te impide moverte?". Y le recomendás hidratación adecuada, descanso activo y movimiento suave si es lo primero, o reposo absoluto y consulta con un profesional de la salud si es lo segundo. **Escuchar y diferenciar es clave.**

CÓMO DERIVAR SIN PERDER AL ALUMNO



PROFESIONALISMO Y EMPATÍA

Derivar a un profesional de la salud no es una señal de incompetencia, sino de máxima profesionalidad. Tu rol no es diagnosticar ni tratar lesiones.

Cuando un alumno presenta una bandera roja (dolor agudo, hormigueo, etc.), debés derivarlo. La clave es cómo lo comunicás: con empatía y sin alarmar. Explicá que lo que describe excede tu campo de acción y que un diagnóstico médico o kinesiológico es necesario para poder adaptar su práctica de forma segura.

Ofrécete a hablar con su profesional para trabajar en equipo. Así, el alumno se siente cuidado, no abandonado.

EN LA SALA: FRASE CLAVE

Frase para usar con el alumno:

"Lo que me describís necesita la evaluación de un kinesiólogo. Cuando tengas un diagnóstico, avisame así adaptamos juntas los ejercicios para que puedas seguir entrenando de forma segura".

CHECKLIST DE BANDERAS ROJAS

CHECKLIST DE SEGURIDAD PREVIO A LA CLASE. Usá esta plantilla para hacer una breve anamnesis con alumnos nuevos o antes de una sesión individual. Te ayuda a identificar posibles contraindicaciones y a adaptar la clase de manera segura y profesional. Es una herramienta de cuidado, no un interrogatorio. Una página de formulario limpia, lista para imprimir, con el logo de Elevify.

Elevify

Nombre del alumno: _____

Fecha: _____

ANTES DE EMPEZAR, CONVERSEMOS UN MINUTO

Por favor, marcá si tenés o tuviste recientemente alguna de las siguientes condiciones.

DOLOR O MOLESTIA ACTUAL

Zona del cuerpo (hombro, lumbar, rodilla, etc.)	**Intensidad del dolor** (escala 0-10)	**Descripción** (agudo, sordo, etc.)

CONDICIONES A CONSIDERAR (marcar con una X)

- ☐ Lesión aguda o reciente (desgarro, esguince)
- ☐ Cirugía en los últimos 6 meses
- ☐ Fractura que no tiene el alta
- ☐ Hernia de disco diagnosticada
- ☐ Osteoporosis u osteopenia
- ☐ Hipermovilidad o Síndrome de Ehlers-Danlos
- ☐ Prótesis articular (cadera, rodilla)
- ☐ Embarazo
- ☐ Condición cardiaca o hipertensión
- ☐ Hormigueo, adormecimiento o ciática
- ☐ Otra condición médica relevante

_____

NOTAS Y ADAPTACIONES PARA LA CLASE DE HOY:

_____

_____

_____

_____

_____

LLEGA CON...

Adaptaciones, progresiones y criterio para las situaciones más comunes de la sala.

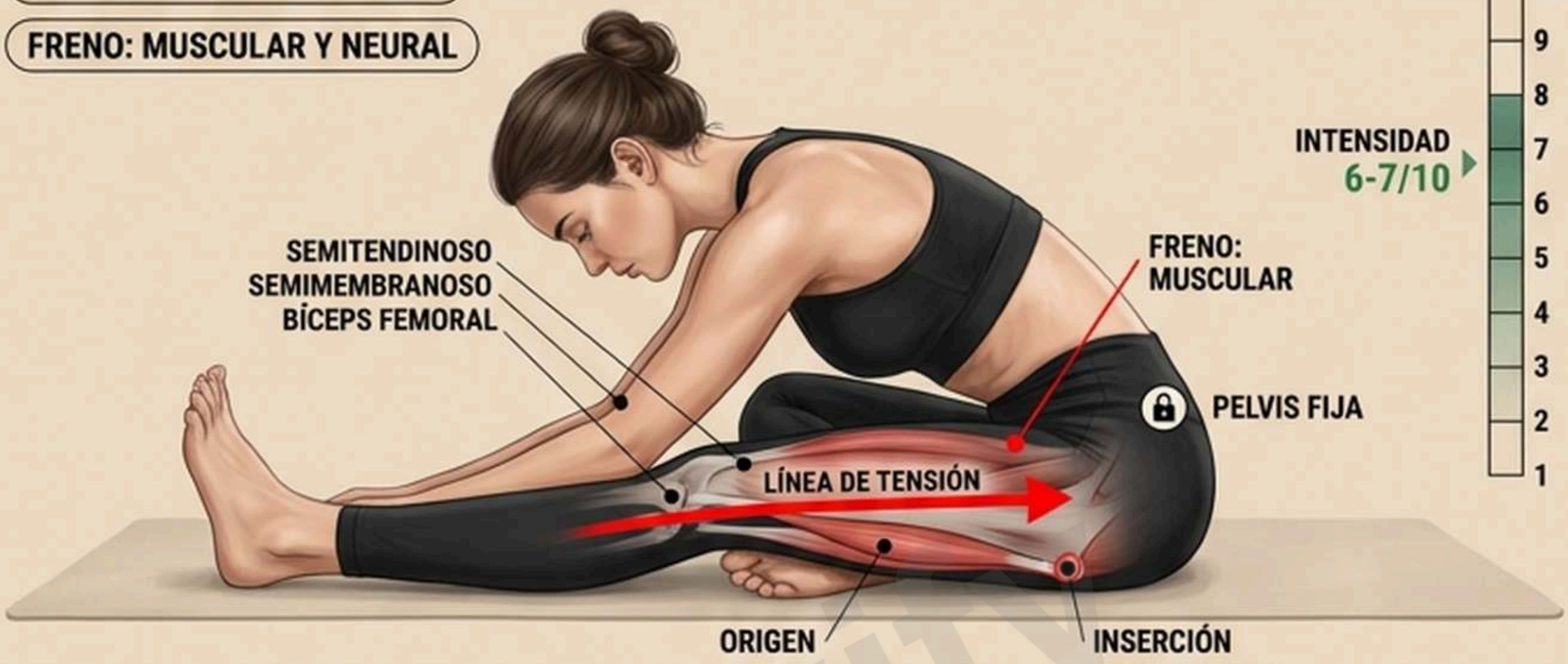
QUÉ VAS A ENCONTRAR

- Estrategias para abordar los 12 motivos de consulta más frecuentes que escuchamos los profes.
- Fichas de estiramientos y test con adaptaciones claras para cada caso.
- Criterio profesional para saber cuándo una molestia requiere la derivación a un médico o kinesiólogo.

FICHA DE ESTIRAMIENTO:
ISQUIOTIBIALES CON MÉTODO PNF

NIVEL: INICIAL / INTERMEDIO

FRENO: MUSCULAR Y NEURAL



EL ESTIRAMIENTO: ISQUIOTIBIALES (PNF) · INTENSIDAD 6-7 · 3 CICLOS

PARA QUIÉN

Alumnos que sienten muchísima tirantez detrás del muslo y compensan con la espalda lumbar al intentar flexionarse hacia adelante. Esta técnica ayuda a ganar rango de forma segura mediante la contracción y relajación muscular.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: PNF (Técnica de aguantar-relajar).
Intensidad: 6-7/10.
Tiempo: 3 ciclos de (30 seg pasivo + 6 seg contracción).
Respiración: Exhalar al relajar y profundizar.
Se mantiene fija la pelvis en anteversión.

PASO A PASO

1. Desde la posición de partida, inhalá y alargá la columna.
2. Exhalando, flexioná la cadera (no la columna) hacia adelante hasta sentir la primera tirantez (30 seg).
3. Inhalá y, sin moverte, presioná el talón de la pierna extendida contra el suelo como si quisieras doblar la rodilla (contracción isométrica, 6 seg).
4. Exhalá, relajá por completo la presión y permití que el torso avance un poco más en la flexión de cadera (30 seg). Repetí el ciclo 2-3 veces.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Flexionar la columna lumbar en vez de la cadera.
Corrección: Usar un bastón en la espalda como guía.
2. Perder la contracción del cuádriceps.
Corrección: Indicar que active el muslo de adelante.
3. Forzar el rango con un tirón brusco.
Corrección: Moverse lento y al ritmo de la exhalación.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad:	✓	Enfocar en la contracción y el control, no en el rango máximo.
Hernia lumbar:	✓	Sí, pero con control extremo de la columna neutra; ante la duda, no hacerlo.
Rodilla operada:	✓	Sí, si no hay dolor; cuidar la hiperextensión.
Embarazo:	✓	Sí, con las adaptaciones necesarias para el abdomen.
Adulto mayor:	✓	Sí, con menos intensidad y quizás en una silla.
Lesión reciente:	✗	No, derivar.

REGRESIÓN

Hacerlo con la rodilla de la pierna extendida ligeramente flexionada, apoyada sobre una toalla enrollada.

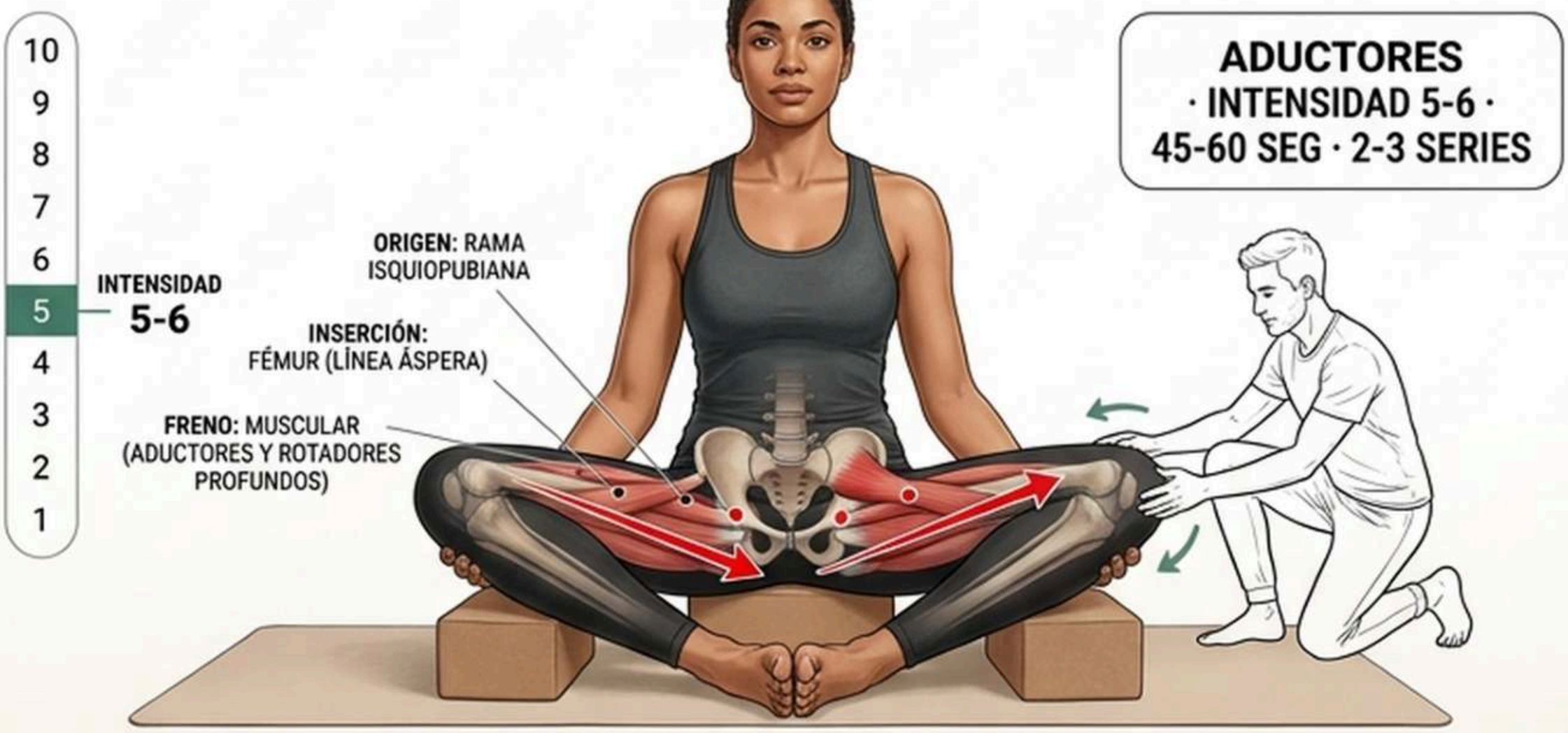
PROGRESIÓN

Realizar el mismo ejercicio con ambas piernas extendidas (Paschimottanasana) manteniendo el control pélvico.

PARA SU CASA

Enfocarse en sentir cómo la pelvis rota hacia adelante, como si el ombligo quisiera llegar al muslo, no la frente a la rodilla.

CADERA CERRADA, NO SE SIENTA CÓMODO



PARA QUIÉN: El alumno que no puede sentarse en el suelo con las piernas cruzadas o en mariposa porque las rodillas le quedan muy altas y siente tensión en la ingle o en la zona del glúteo.
POSICIÓN DE PARTIDA: Sentada en el suelo sobre uno o dos bloques de yoga para elevar la cadera por encima de las rodillas. Plantas de los pies juntas, talones a una distancia cómoda de la pelvis.

EL ESTIRAMIENTO

Método estático pasivo con asistencia.
Intensidad: 5-6/10.
Tiempo: 2-3 series de 45-60 segundos.
Respiración: Larga y profunda, buscando relajar la musculatura con cada exhalación.
Se mantiene fija la columna erguida.

PASO A PASO

1. Sentada sobre el soporte, tomá los tobillos con las manos y alargá la columna como si un hilo tirara de tu coronilla hacia el techo.
2. Inhalá profundo.
3. Exhalando, permití que el peso de las piernas las haga descender hacia el suelo, sin forzar.
4. Podés aplicar una suave presión con las manos o los codos sobre los muslos si necesitás más intensidad.
5. Mantené la posición sintiendo una tirantez suave y sostenible en la cara interna de los muslos (45-60 seg).
6. Para salir, ayudate con las manos a juntar las rodillas.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **1. Encorvar la espalda para aparentar más flexión.** **Corrección:** Recordarle que la espalda se mantiene larga, el movimiento nace en la cadera.
- **2. Rebotar con las rodillas.** **Corrección:** Explicarle que el rebote activa el reflejo de estiramiento y es contraproducente.
- **3. Llevar los talones demasiado cerca de la pelvis.** **Corrección:** Alejar los pies para reducir la tensión y permitir la rotación.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** realizar una contracción isométrica de los aductores (apretar las rodillas contra las manos) para generar estabilidad antes de relajar.
- ✓ **Hernia lumbar:** sí, es seguro si se mantiene la columna erguida.
- ✓ **Rodilla operada:** sí, con cuidado; si hay molestia en la cara interna de la rodilla, alejar más los pies.
- ✗ **Embarazo:** sí, es un excelente ejercicio para preparar la pelvis.
- ✗ **Adulto mayor:** sí, es muy seguro y beneficioso.
- ✗ **Lesión reciente en aductores:** no.

REGRESIÓN:
Hacer el mismo estiramiento acostada boca arriba, para que la gravedad asista y la espalda esté apoyada.

PROGRESIÓN:
Quitar los bloques de apoyo e inclinar el torso hacia adelante con la espalda recta.

PARA SU CASA:
Le decis que practique sentarse en el suelo sobre un almohadón para ver la tele, permitiendo que la cadera se acostumbre a la posición de forma pasiva y funcional.

REEDUCACIÓN DEL PATRÓN DE BISAGRA DE CADERA CON BASTÓN

PARA QUIÉN

Alumna que siente molestia lumbar, pinzamiento o fatiga al flexionar el tronco (atarse cordones, peso muerto). El foco es activar glúteos e isquiotibiales y estabilizar la columna con multifidos y transverso.

EL EJERCICIO: BISAGRA CON BASTÓN

Reeducación de patrón.
Intensidad: 2-3/10.
Repeticiones: 3 series de 8-10 lentas.
Respiración: Exhalar al flexionar, inhalar al volver.
Mantener los tres puntos de contacto del bastón: sacro, dorsal, nuca.

PASO A PASO

1. Colocá el bastón en la espalda. Sujetalo con una mano detrás del cuello y otra detrás de la zona lumbar.

2. Iniciá llevando la cadera hacia atrás, como si quisieras tocar una pared con los glúteos. El torso se inclina manteniendo la columna neutra y los tres contactos.

3. Flexioná hasta donde puedas sin separar el bastón. Empujá el suelo y activá glúteos para volver a la posición inicial.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Perder contacto lumbar (flexiona columna).
CORRECCIÓN: Disminuir rango, enfocar en cadera atrás.

2. Llevar peso a la punta de los pies.
CORRECCIÓN: Sentir peso en los talones.

3. Convertirlo en sentadilla (mucha flexión de rodillas).
CORRECCIÓN: Solo microflexión, movimiento en cadera.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ **Hipermovilidad:** excelente para control. ✅ **Hernia lumbar (no aguda):** pilar de reeducación, sin dolor. ✅ **Rodilla operada:** sí.
✅ **Embarazo (etapas iniciales):** sí. ✅ **Adulto mayor:** clave para función, puede apoyarse en silla. ❌ Lesión lumbar aguda: no, derivar.

REGRESIÓN: Rango de movimiento muy pequeño. **PROGRESIÓN:** Sin bastón con conciencia corporal, luego peso muerto liviano.
PARA SU CASA: Practicar este gesto al levantar cualquier objeto del suelo para re-programar.

EJERCICIO: **GATO-VACA DE DESCOMPRESIÓN**

NIVEL: **BÁSICO / TERAPÉUTICO**

PARA QUIÉN

Alumnos con diagnóstico médico de hernia discal (fase no aguda, sin dolor irradiado) que buscan alivio y espacio en la zona lumbar.

Objetivo: descompresión, no estiramiento.

EL EJERCICIO

Gato-Vaca controlado.
Intensidad: 2-4/10.
2-3 series de 6-8 ciclos. Exhalar en flexión (Gato), inhalar en extensión (Vaca).
Foco: Alargar columna.

③ PASO A PASO

1. Desde neutra, exhalá y redondeá espalda desde coxis a cabeza, empujando suelo, separando omóplatos. Imaginá separar vértebras. 2. Pequeña pausa.
3. Inhalá y revertí desde coxis, arqueando suavemente, pecho adelante, mirada al frente, sin quebrar cuello. 4. Foco en crear longitud, cabeza y coxis se alejan.
5. Movimiento lento y fluido, sin rangos máximos.

✕ ERRORES QUE VES EN LA SALA (❌)

1. Forzar el rango, especialmente en extensión (quebrar cintura). **Corrección:** Movimiento corto y sutil, enfocado en alargar en alargar.
2. Moverse rápido y sin conciencia. **Correceién:** Guiar con respiración lenta.
3. Dejar caer la cabeza. **Corrección:** Cuello como prolongación de columna.

✓ QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ Hipermovilidad (✅)
✅ Hernia (✅ solo con diagnóstico y sin dolor)
✅ Rodilla operada (✅ con almohadón)
✅ Embarazo (✅ excelente)
✅ Adulto mayor (✅)
❌ Flexiones profundas (❌)
❌ Torsiones intensas (❌)
❌ Dolor irradiado (❌)
❌ Lesión aguda (❌)

REGRESIÓN: Rango mínimo, casi imperceptible.

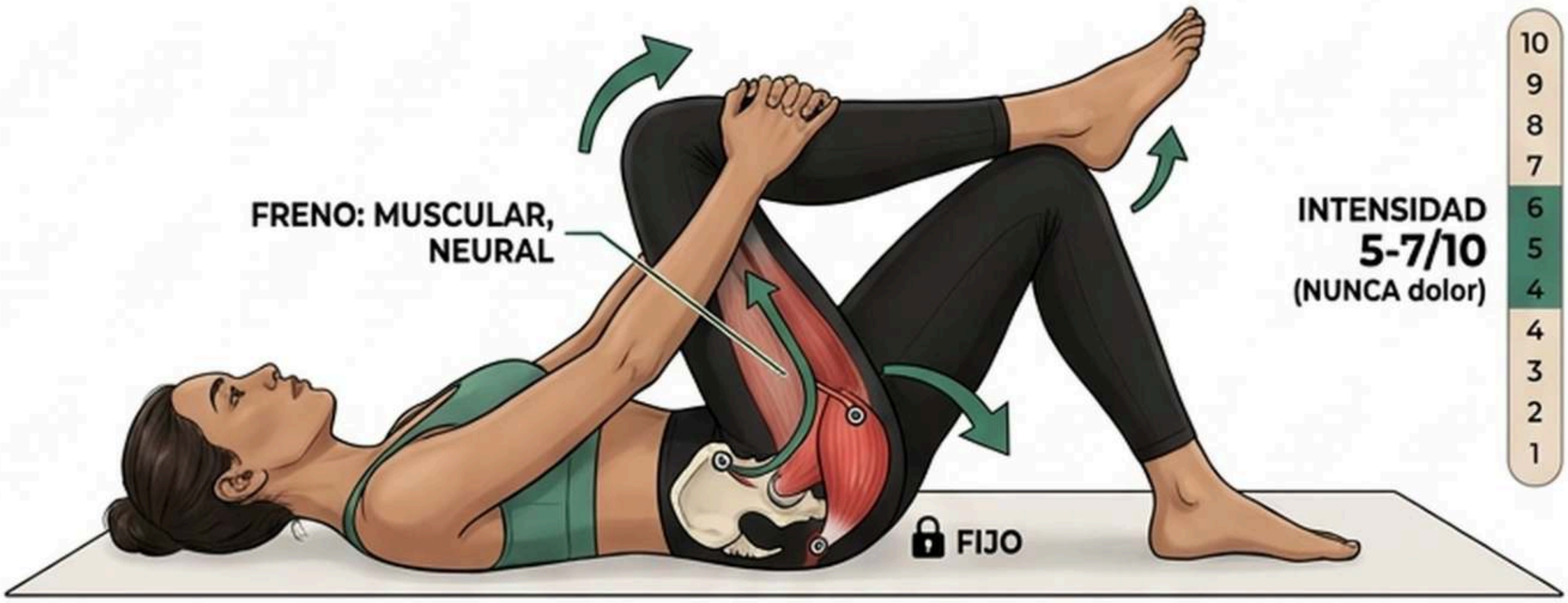
PROGRESIÓN: Desplazamiento de cadera a talones con espalda larga, sin dolor.

PARA SU CASA: Ejercicio de "higiene de columna" a la mañana o al sentir carga. Escuchar cuerpo, nunca forzar.

CIÁTICA O TIRANTEZ EN LA PIERNA

FICHA DE ESTIRAMIENTO

NIVEL: INICIAL / INTERMEDIO



PIRAMIDAL · INTENSIDAD 5-7 · 30-45 SEG · 2-3 SERIES

PARA QUIÉN

La alumna que refiere una tirantez, quemazón o dolor que se origina en el glúteo y a veces baja por la parte posterior de la pierna, compatible con un sindrome del piramidal.

EL ESTIRAMIENTO

Estiramiento estático del piramidal en supino (figura de 4). **NUNCA** debe generar hormigueo o aumentar el dolor irradiado. **Respiración:** Profunda, exhalando para relajar la zona. Se mantiene fija la pelvis, evitando que se balancee.

PASO A PASO

1. Desde la posición de partida, cruzá el tobillo derecho sobre el muslo izquierdo, justo por encima de la rodilla. Mantené el pie derecho en dorsiflexión para proteger la rodlila. **(20-30 SEG)**
2. Esta posición ya puede ser suficiente estiramiento para algunas personas. Si es así, mantenela.
3. Si necesitás más intensidad, levantá el pie izquierdo del suelo.
4. Pasá la mano derecha por el hueco que se formó y la izquierda por fuera, y entrelazá los dedos detrás del muslo izquierdo.
5. Suavemente, traccioná de la pierna izquierda hacia el pecho hasta sentir una tirantez clara en el glúteo derecho.
6. Mantené la cabeza y los hombros relajados en el suelo. **(30-45 SEG)**

3 ERRORES

1. **Levantar el sacro y la zona lumbar del suelo.** **Corrección:** Bajar un poco la pierna y enfocarse en mantener la pelvis neutra.
2. **Sentir un pinzamiento en la parte frontal de la cadera (Ingle). Corrección:** Alejar un poco el tobillo de la rodilla o disminuir la tracción.
3. **Forzar el estiramiento a pesar de sentir hormigueo o dolor agudo en la pierna.** **Corrección:** DETENERSE INMEDIATAMENTE. Esto indica irritación nerviosa.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

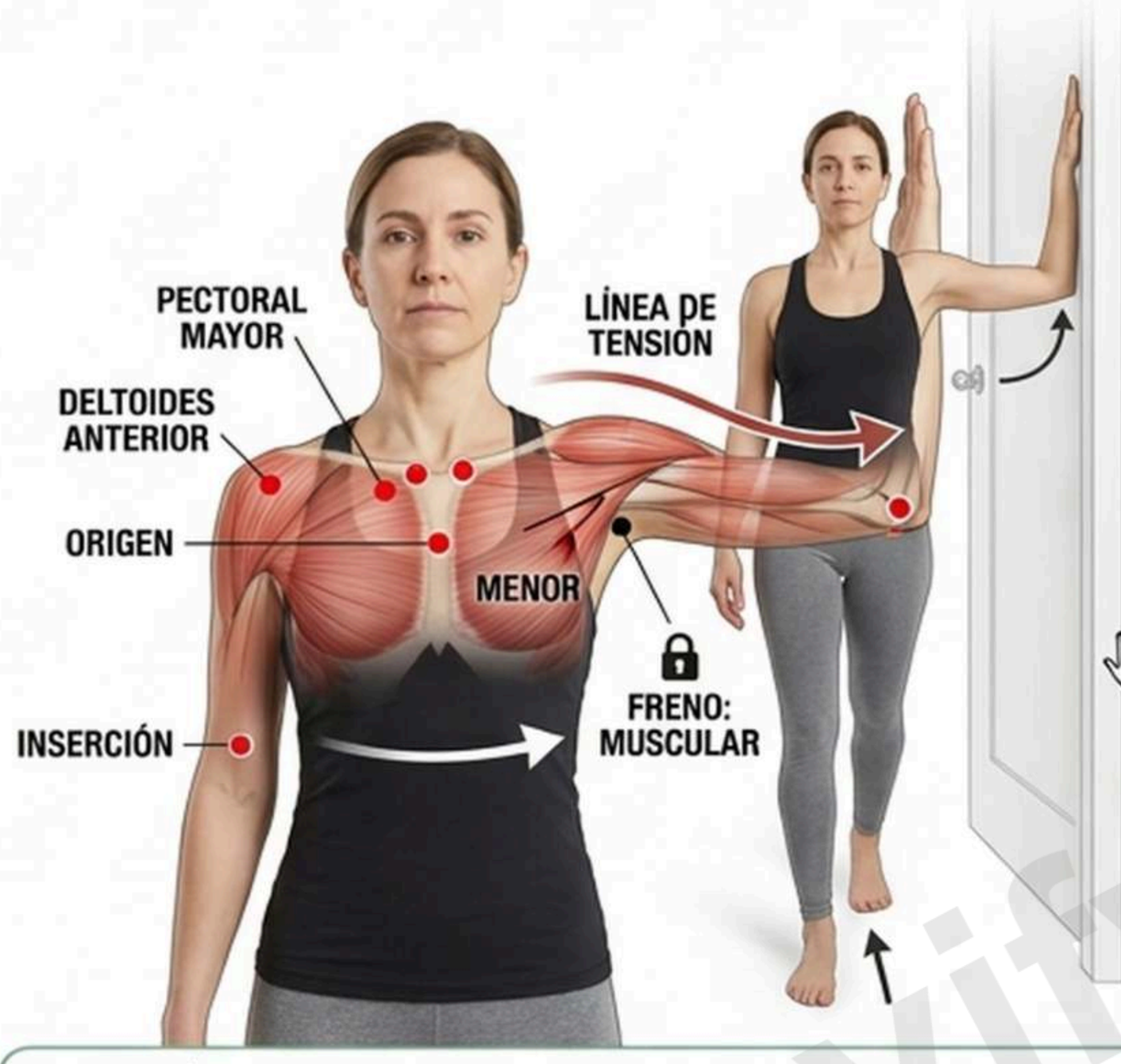
- **Hipermovilidad:** sí, con control. ✓
- **Hernia lumbar:** sí, es una posición segura para la columna. ✓
- **Rodilla operada:** sí, la dorsiflexión del pie ayuda a protegerla. ✓
- **Embarazo:** sí, es muy recomendable. ✓
- **Adulto mayor:** sí. ✓
- **Lesión aguda (diagnóstico de ciática por hernia):** no sin aprobación médica. ✗

REGRESIÓN: Hacer el mismo cruce de piernas sentada en una silla, inclinando el torso hacia adelante.

PROGRESIÓN: Realizar la postura de la paloma (Eka Pada Rajakapotasana) con las adaptaciones necesarias.

PARA SU CASA: Le explicás la diferencia: si el estiramiento alivia la tirantez del glúteo, es probable que sea el músculo. Si genera más hormigueo o dolor que baja, no es el camino y debe consultar a un médico o kinesiólogo.

HOMBROS CERRADOS POR ESCRITORIO



PECTORAL · INTENSIDAD 6 · 30-45 SEG · 2-3 SERIES

PARA QUIÉN: Alumnos que pasan muchas horas sentados frente a una computadora y presentan la tipica postura de hombros adelantados y redondeados, con sensación de acortamiento en el pecho.

EL ESTIRAMIENTO: Estiramiento estático activo del pectoral en el marco de la puerta. **Intensidad:** 5-6/10.
Tiempo: 2-3 series de 30-45 segundos por lado/altura.
Respiración: Fluida, exhalando al entrar en la posición. Se mantiene fijo el core para evitar que el arco lumbar se pronuncie.

PASO A PASO

1. Apoyá el antebrazo y la palma de la mano en el marco de la puerta, con el codo flexionado a 90 grados y a la altura del hombro.
2. El pie del mismo lado del brazo que se estira da un paso adelante, atravesando el umbral.
3. Girar suavemente el torso hacia el lado contrario hasta sentir una tirantez en la zona del pecho y el hombro.
4. Para enfatizar distintas fibras del pectoral, se puede variar la altura del codo: un poco más bajo, a la altura del hombro y un poco más alto.
5. Mantené la posición sin que el hombro se eleve hacia la oreja.

3 ERRORES

- **Arquear la espalda lumbar para compensar la falta de apertura. Corrección:** Activar el abdomen y mantener la pelvis neutra.
- **Dejar que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante en la articulación. Corrección:** Realizar una suave activación del manguito rotador, como si se quisiera 'enroscar' el hombro hacia atrás en su cavidad.
- **Aguantar la respiración. Corrección:** Respirar profundo, imaginando que el aire expande el pecho.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad:** sí, con mucho control. Contraer isométricamente antes.
- ✓ **Pinzamiento de hombro:** con cuidado, evitar dolor agudo; si duele, no se hace.
- ✗ **Rodilla:** no aplica.
- ✓ **Embarazo:** sí, muy beneficioso.
- ✓ **Adulto mayor:** si, excelente para la postura.
- ✗ **Lesión reciente de hombre:** no.

REGRESIÓN: Reliz recomenar un estiramiento acostado sobre umun rollo de espuma, sina brazos, abiertos en cruz.

REGRESIÓN: Realizar el estiramiento acostado sobre un rollo de espuma, con los brazos abiertos en cruz.

PROGRESIÓN: Añadir una rotación torácica activa al movimiento.

PARA SU CASA
Le recomendás hacer pausas activas coda hora de trabajo, levantarse y hacer este estiramiento por 30 segundos de cada lado.

120px

CAP 12 · EL ALUMNO QUE LLEGA CON...

RODILLAS QUE DUELEN EN LA PALOMA

MODIFICACIÓN: DOLOR EN RODILLA AL HACER PALOMA

NIVEL: TODOS

PARA QUIÉN

La alumna que siente pinzamiento o dolor en la rodilla (interna o externa) de la pierna flexionada al intentar la paloma.

FRENO: Falta de rotación externa en cadera genera torque en la rodilla.

EL EJERCICIO: ALTERNATIVA SEGURA EN SUPINO

Método: Estiramiento estático · **Intensidad:** 5-7 en glúteo, 0 en rodilla · **Tiempo:** 30-60 seg
Respiración: Profunda · Mantener pelvis fija.

PASO A PASO (ALTERNATIVA)

1. Acostada boca arriba, cruzar tobillo derecho sobre muslo Izquierdo. Pie derecho activo (dorsiflexión) para estabilizar rodilla.
2. Abrazar por detrás el muslo izquierdo y acercarlo al pecho hasta sentir el estiramiento en el glūteo derecho.
3. Mantener la pelvis plana en el suelo. Respirar profundamente.
4. Para volver a la paloma: El secreto es elevar la cadera.

3 ERRORES (EN LA PALOMA CLÁSICA)

- ✕ Dejar caer todo el peso sobre la cadera flexionada.
  Corrección: Usar bloques para nivelar
- ✕ Intentar llevar la canilla paralela al frente a toda costa.
  Corrección: Talón cerca de la ingle es más seguro
- ✕ Ignorar el dolor en la rodilla.
  Corrección: Salir y usar alternativa en supino

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **HIPERMOVILIDAD:** Sí, con control.
- ✕ **HERNIA LUMBAR:** Sí, alternativa en supino.
- ✕ **RODILLA OPERADA/MENISCOPATÍA:** NO paloma clásica, Sí alternativa en supino.
- ✓ **EMBARAZO:** Sí, alternativa ideal.
- ✕ **ADULTO MAYOR:** Sí, alternativa o en silla.

REGRESIÓN / PROGRESIÓN / PARA SU CASA

REGRESIÓN: Figura de 4 sin levantar la pierna base.

PROGRESIÓN: Reducir gradualmente altura de bloques en paloma (meses, no dias).

PARA SU CASA: El dolor es señal de que la cadera necesita más rotación externa. La rodilla es la mensajera, escuchala.

TOBILLOS RÍGIDOS EN LA SENTADILLA

FICHA DE TEST / ESTIRAMIENTO

NIVEL: INICIAL / INTERMEDIO

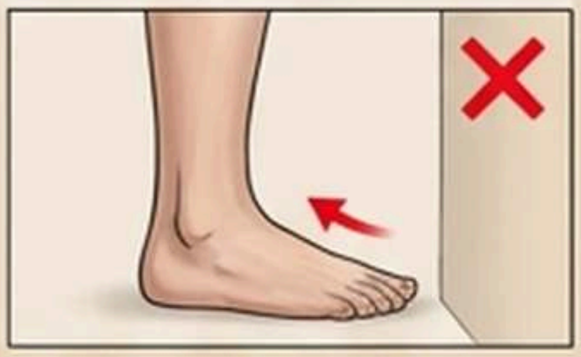
PARA QUIÉN
El alumno que, al intentar una sentadilla profunda (cuclillas), se le levantan los talones del suelo o tiene que inclinar excesivamente el tronco hacia adelante para no caerse.

TEST DE DORSIFLEXIÓN

1. Desde la posición de partida, intentá tocar la pared con la rodilla sin que el talón se levante del suelo.
2. Si lo lográs, alejá el pie un centímetro y volvé a probar.
3. La distancia máxima a la que podés tocar la pared sin levantar el talón mide tu rango de dorsiflexión. Menos de 10 cm puede considerarse limitado para una sentadilla profunda.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Levantar el talón del suelo. **Corrección:** Acercar un poco el pie a la pared.



2. Dejar que el arco del pie se venza hacia adentro. **Corrección:** Mantener el peso en el borde externo.

3. No flexionar la rodilla de atrás (estira gemelos, no sóleo). **Corrección:** La flexión de rodilla es la clave.

EL ESTIRAMIENTO: Estiramiento de sóleo en la pared

PASO A PASO

1. Parado frente a una pared, adelantá una pierna y apoyá las manos. La pierna de atrás es la que se va a estirar.
2. Mantené la planta del pie de atrás completamente apoyada.
3. FLEXIONÁ la rodilla de atrás, llevando el peso hacia adelante y abajo. Clave para el sóleo.
4. Sentirás la tirantez en el tendón de Aquiles y la parte baja de la pantorrilla. Mantené la posición. (Para gemelos, rodilla extendida).

QUÉ SÍ / QUÉ NO
Hipermovilidad: ✅ sí. Hernia lumbar: ✅ sí. Rodilla operada: ✅ sí (con cuidado en flexión). Embarazo: ✅ sí. Adulto mayor: ✅ sí (excelente para funcionalidad y equilibrio). Lesión reciente de tobillo/tendón de Aquiles: ❌ no.

REGRESIÓN: Hacer el estiramiento con menos flexión de rodilla.

PROGRESIÓN: Colocar la punta del pie sobre un escalón o libro y dejar caer el talón, manteniendo la rodilla flexionada.

PARA SU CASA: Le sugerís que, antes de su entrenamiento de piernas, realice este estiramiento y luego unas sentadillas al aire ccn los talones apoyados sobre un disco o libro pequeño, para trabajar el patrón completo mientras mejora su flexibilidad.

FICHA DE EJERCICIO / CONCEPTO.

Nivel: Reeducación.

PARA QUIÉN: La alumna con hipermovilidad articular (medida, por ejemplo, con la escala de Beighton) que, paradójicamente, se queja de sentirse 'dura', 'trabada' o con mucha tensión muscular.

POSICIÓN DE PARTIDA: Acostada boca arriba con rodillas flexionadas, pies ancho de caderas cerca de los glúteos. Brazos a los lados del cuerpo.

CONCEPTO CLAVE

La sensación de 'dureza' en personas hiperlaxas no suele provenir de un acortamiento del tejido conectivo, sino de una tensión muscular protectora. El sistema nervioso aumenta el tono de los músculos que rodean a una articulación inestable para darle un 'sostén' activo. Por eso, el abordaje no es el estiramiento pasivo en rangos extremos, sino el fortalecimiento y la propiocepción en rangos medios.

EL EJERCICIO: Activación en puente de glúteos isométrico.
Intensidad: 4-5/10 (foco en la conexión muscular, no en la fatiga).
Tiempo: 3-4 series de 20-30 segundos de sostén.
Respiración: Fluida durante la isometría. Se mantiene fija la alineación de la pelvis.

PASO A PASO

1. Inhalá en la posición de partida.
2. Exhalando, presioná los pies contra el suelo y elevá la pelvis hasta formar una línea recta desde las rodillas hasta los hombros.
3. Sostené la posición arriba, concentrándote en sentir la activación de los glúteos y los isquiotibiales. Imaginá que querés arrastrar los talones hacia vos.
4. Evitá hiperextender la zona lumbar; el trabajo es de la cadera.
5. Bajá lentamente, vértebra por vértebra.

3 ERRORES

1. Empujar la pelvis demasiado arriba, arqueando la espalda lumbar.
   Corrección: Bajar un poco la cadera y activar más el abdomen.
2. No sentir los glúteos y sentir toda la tensión en los isquiotibiales o la espalda.
   Corrección: Antes de subir, hacer una pre-activación de glúteos apretándolos.
3. Dejar que las rodillas se abran o se junten.
   Corrección: Mantener las rodillas alineadas con las caderas.

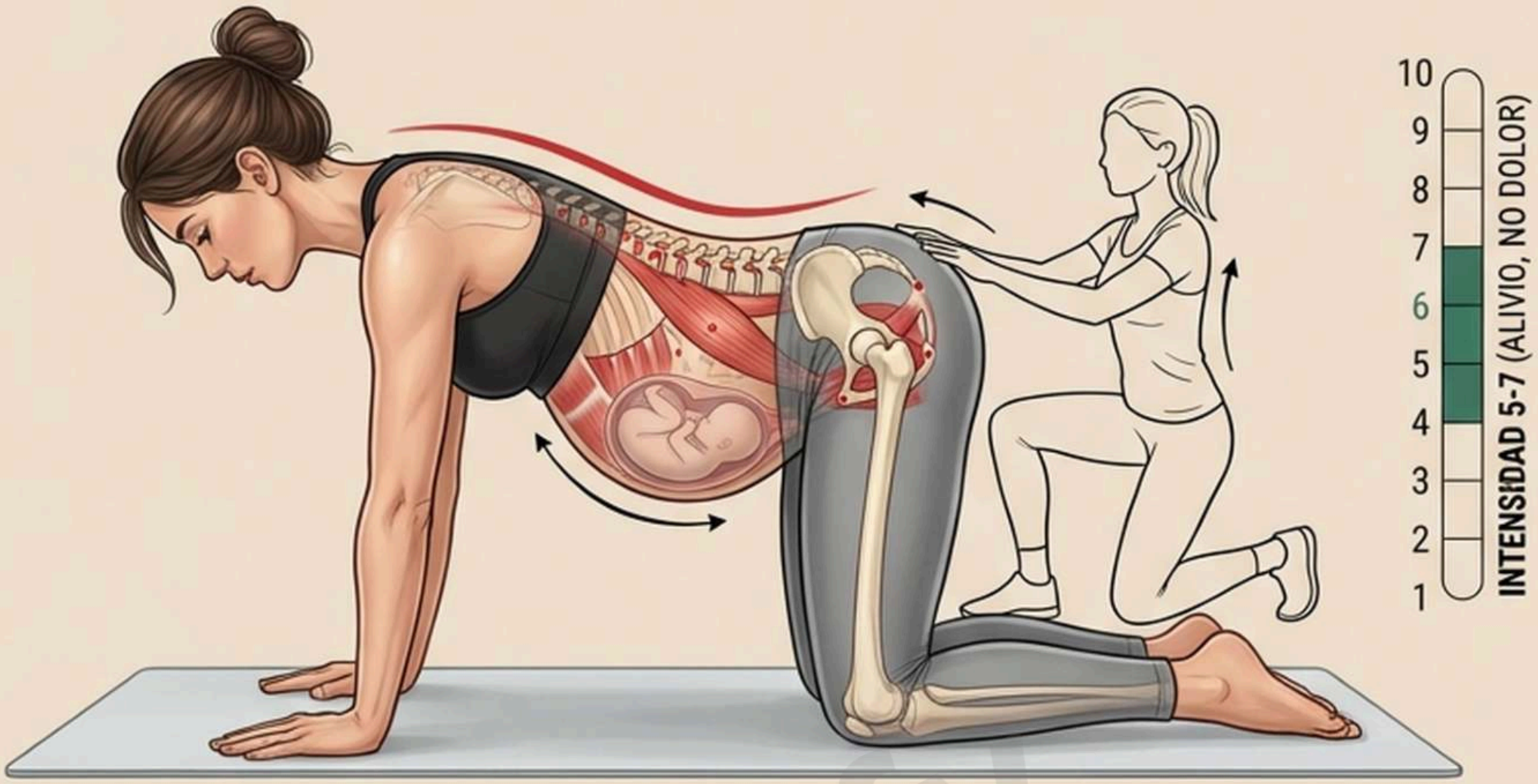
QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hipermovilidad**: este es el enfoque principal.
- ✗ Evitar estiramientos pasivos al límite.
- ✓ **Hernia lumbar**: sí, es un excelente estabilizador.
- ✓ **Rodilla operada:** sí.
- ✓ **Embarazo:** sí, hasta que estar boca arriba sea incómodo.
- ✓ **Adulto mayor**: sí, con menos altura.
- ✗ **Lesión articular reciente (esguince, subluxación)**: no en la fase aguda.

PARA SU CASA

Le explicás que su objetivo no es "ser más flexible", sino "ser más fuerte y estable" en el rango de movimiento que ya tiene. El alivio de la "dureza" vendrá de que su sistema nervioso deje de sentir la necesidad de protegerse con tensión.

EMBARAZADA (SEGUNDO TRIMESTRE)



MOVILIDAD DE COLUMNA · INTENSIDAD 6 · 1-2 MINUTOS · MOVIMIENTOS SUAVES

ADAPTACIONES: MOVILIDAD Y BIENESTAR SIN RIESGOS

PARA QUIÉN: Alumnas que cursan su segundo trimestre sin contraindicaciones médicas y buscan mantener la movilidad, aliviar molestias comunes y preparar el cuerpo para el parto, evitando rangos extremos.

QUÉ SÍ (RECOMENDADO)

1. GATO-VACA ADAPTADO: Movilizar la columna y aliviar tensión lumbar con control.

2. MOVILIDAD DE CADERA EN CUADRUPEDIA: Círculos amplios con una rodilla, pelvis estable.

3. ESTIRAMIENTO DE PIRAMIDAL EN SILLA: Sentada, tobillo sobre rodilla, inclinarse suave adelante.

4. APERTURA DE PECHO SENTADA: Entrelazar manos detrás, abrir el pecho para contrarrestar peso.

QUÉ NO (EVITAR O MODIFICAR)

1. POSICIÓN SUPINA PROLONGADA: Evitar comprimir la vena cava con el peso del útero.

2. TORSIONES PROFUNDAS: Evitar torsiones cerradas que compriman el abdomen.

3. FLEXIONES ABDOMINALES 'CRUNCH': Aumentan presión intraabdominal, empeoran diástasis.

4. ESTIRAMIENTOS PASIVOS MÁXIMOS: Evitar sobrecargar articulaciones laxas por relaxina.

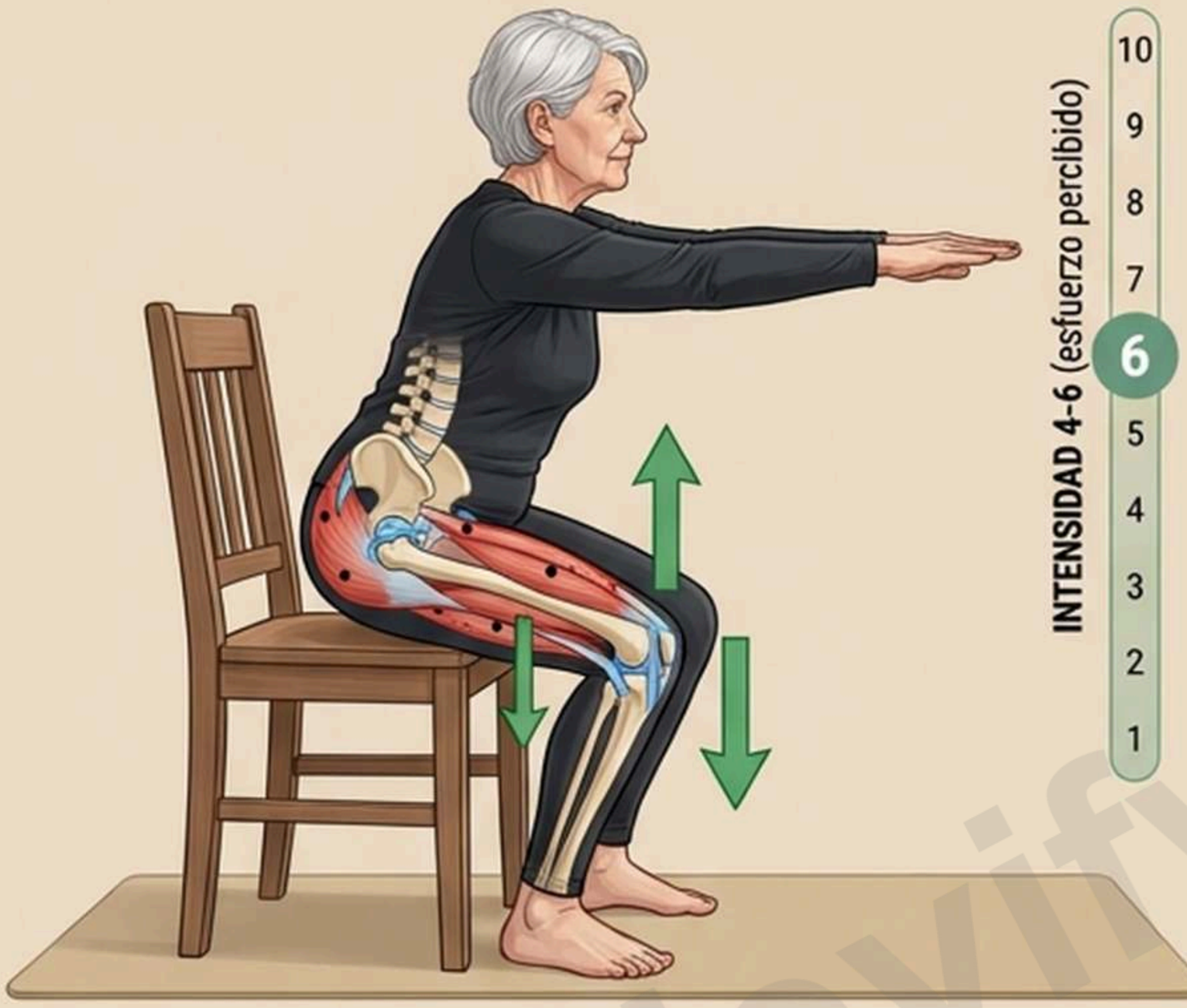
RESPIRACIÓN Fundamental enseñar la respiración diafragmática conectando con el suelo pélvico.

PARA SU CASA Recordar que la regla de oro es escuchar al cuerpo. El objetivo es el bienestar, no el rendimiento. Ante cualquier duda, consultar con el médico u obstetra.

ADULTO MAYOR Y VOLVER A AGACHARSE

FICHA DE EJERCICIO FUNCIONAL

Nivel: Básico / Funcional



PARA QUIÉN

El alumno adulto mayor que ha perdido la confianza o la capacidad para agacharse y levantarse del suelo o de una silla baja, una habilidad crucial para la independencia.

POSICIÓN DE PARTIDA

Sentado en el borde de una silla estable y sin apoyabrazos, con los pies firmemente plantados en el suelo, un poco más anchos que las caderas. Espalda erguida.

ZONA Y MÚSCULOS

El foco es la fuerza y el control de toda la cadena inferior (cuádriceps, glúteos, isquiotibiales) y la estabilidad del core.

FRENO: Falta de fuerza, miedo a caer, rigidez articular (cadera, rodilla, tobillo).

EL EJERCICIO

Sentarse y levantarse de la silla (Box Squat).

Repeticiones: 2-3 series de 5-10 repeticiones.

Respiración: Exhalar al levantarse (en el esfuerzo), inhalar al sentarse. Se mantiene fijo el control del movimiento, evitando desplomarse en la silla.

PASO A PASO

1. Desde la posición sentada, inclinar ligeramente el torso hacia adelante, llevando el peso a los pies.
2. Presionar con fuerza los pies contra el suelo, especialmente los talones.
3. Extender las rodillas y las caderas simultáneamente para ponerse de pie, activando los glúteos al final del movimiento. Los brazos pueden extenders al frente para hacer contrapeso. 4. Para sentarse, iniciar el movimiento llevando la cadera hacia atrás, como buscando la silla con los glúteos.
5. Controlar el descenso, flexionando rodillas y caderas de forma suave hasta que los glúteos toquen la silla. No dejarse caer.

EL EJERCICIO

Curara la posición sentada, revainars· e ítala Box Squat.

Repeticiones: 2-3 series de 5-10 repeticiones.

Respiración: Exhalar al levantarse (en el esfuerzo), inhalar al sentarse. Se mantiene fijo el control del movimiento, evitando desplomarse en la silla.

3 ERRORES

- 1. Usar el impulso del cuerpo o empujar con las manos sobre las rodillas para levantarse.
  Corrección: Cruzar los brazos sobre el pecho para anular su ayuda.
- 2. Dejar que las rodillas se vayan hacia adentro (valgo de rodilla) al subir.
  Corrección: Colocar una banda elástica suave alrededor de las rodillas y pedirle que la mantenga tensa.
- 3. Caerse en la silla sin control. **Corrección:** Realizar la fase de descenso mucho más lenta (ej. en 3-4 segundos).

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **Hernia lumbar:** sí, con la espalda neutra.
- ✓ **Rodilla operada/artrosis:** sí, el rango está limitado por la silla, lo que lo hace seguro. Si hay dolor, se usa una silla más alta.
- ✗ **Hipertensión:** si, controlando la respiración y evitando la maniobra de Valsalva.

REGRESIÓN: Usar una silla más alta o permitir una leve ayuda con las manos.

PROGRESIÓN: Usar una silla más baja. Luego, realizar la sentadilla al aire sin silla, pero con un apoyo cercano por seguridad. Finalmente, sostener un peso liviano.

PARA SU CASA: Le decís que este es el ejercicio más importante que puede hacer todos los dias. Que lo practique varias veces al dia, convirtiendo el acto de sentarse y levantarse en un momento de entrenamiento consciente.

CAP 12 · EL ALUMNO QUE LLEGA CON...

DEPORTISTA QUE ESTIRA MAL ANTES DE COMPETIR

FICHA DE RUTINA DINÁMICA

Nivel: Todos

PARA QUIÉN: El deportista (corredor, futbolista, tenista, etc.) que tiene el viejo hábito de realizar estiramientos estáticos largos (ej. 30 segundos tocándose la punta del pie) justo antes de entrenar o competir.

CONCEPTO CLAVE: La evidencia científica actual sugiere que el estiramiento estático prolongado (>60 seg) realizado justo antes de una actividad explosiva o de fuerza puede disminuir el rendimiento (la capacidad de generar fuerza rápida o 'stiffness' muscular). El calentamiento previo a la competición debe preparar al sistema neuromuscular para la acción, no relajarlo. Por eso, se prefiere la movilidad articular y los estiramientos dinámicos.

EL EJERCICIO: Rutina de movilidad dinámica pre-competitiva (5 minutos).
Intensidad: 4-5/10 (movimiento fluido y controlado, no forzado).
Repeticiones: 8-12 por articulación/movimiento.
Respiración: Rítmica y acompasada con el movimiento.
Se busca aumentar gradualmente el rango de movimiento.

PASO A PASO DE LA RUTINA:

1. CÍRCULOS DE TOBILLO Y MUÑECA (20 seg)

De pie, hacer círculos amplios en ambos sentidos.

2. BALANCEOS DE PIERNAS - FRONTALES (10-12 por pierna)

De pie, apoyado en una pared, balancear una pierna hacia adelante y hacia atrás como un péndulo, aumentando gradualmente la altura.

3. BALANCEOS DE PIERNAS - LATERALES (10-12 por pierna)

De cara a la pared, balancear la pierna de lado a lado, cruzando por delante del cuerpo.

4. ROTACIONES DE TORSO (10-12 totales)

De pie, con los pies ancho de hombros y las manos en la cintura, girar el torso a un lado y al otro, de forma controlada.

5. CÍRCULOS DE BRAZOS (10 hacia adelante, 10 hacia atrás)

Amplios y fluidos.

6. SENTADILLAS AL AIRE (8-10 reps)

Bajar hasta una profundidad cómoda, enfocándose en la técnica.

3 ERRORES:

- 1. Realizar los movimientos de forma brusca o balística.
  Corrección: El movimiento es dinámico, pero siempre controlado. No es un rebote.
- 2. Aguantar la respiración. **Corrección:** Coordinar la respiración con el flujo del movimiento.
- 3. No calentar lo suficiente.
  Corrección: Esta rutina debe ir precedida de 5-10 minutos de actividad cardiovascular ligera (trote suave, saltar la soga).

CUÁNDO SÍ EL ESTIRAMIENTO ESTÁTICO: Es muy beneficioso, pero su mejor momento es después del entrenamiento o en una sesión separada, para mejorar la flexibilidad a largo plazo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO:

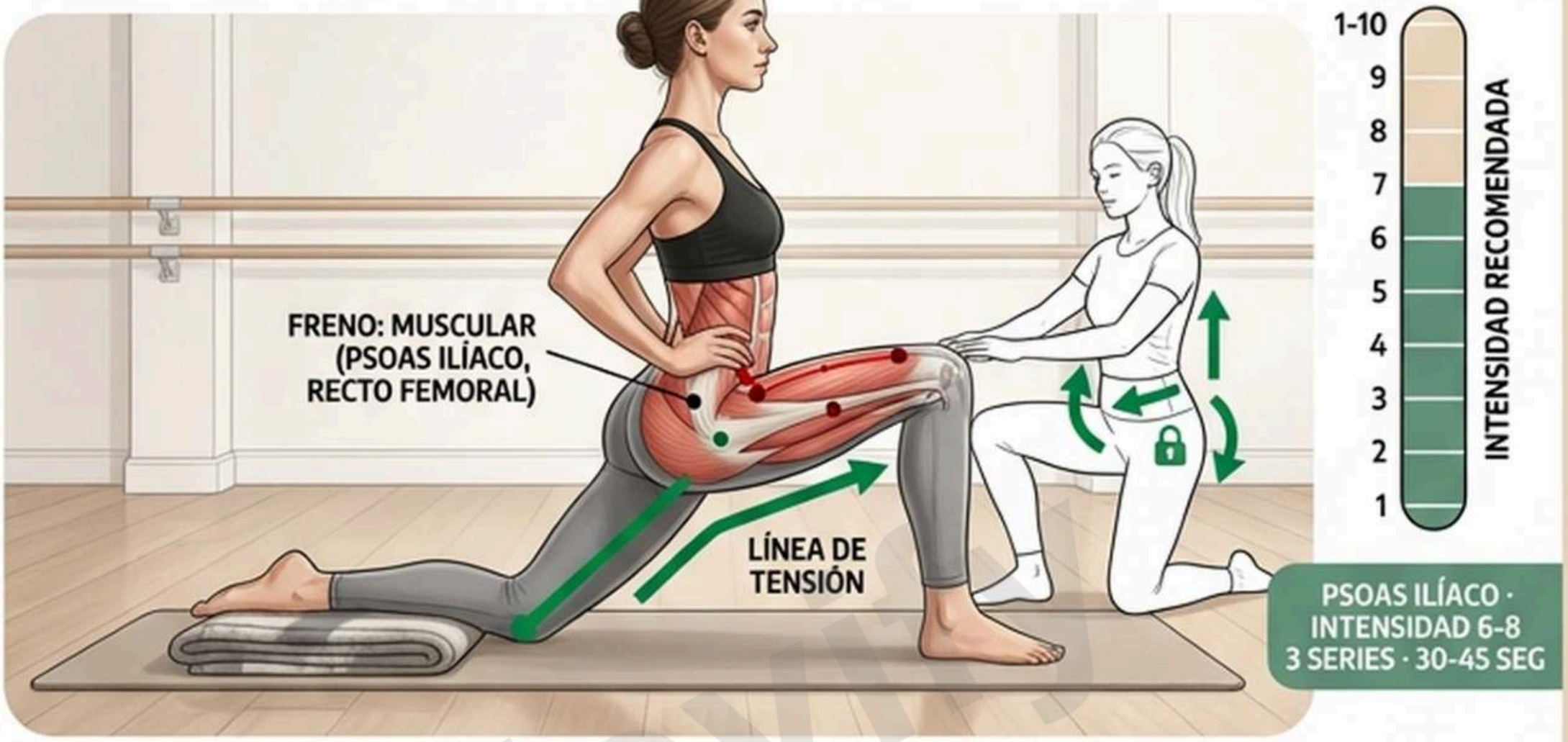
✅ Esta rutina es segura y beneficiosa para la mayoría de los deportistas sin lesiones agudas.
❌ Se deben adaptar los ejercicios al deporte especifico (ej. un nadador hará más énfasis en los hombros).

💬 **PARA SU CASA:**
Le explicás que el calentamiento es como "despertar" al cuerpo y avisarle qué movimiento viene. El estiramiento estático del final es como "agradecerle" y decirle que ya puede relajarse.

BAILARINA QUE QUIERE EL SPLIT

FICHA DE ESTIRAMIENTO:
FLEXORES DE CADERA CON RETROVERSIÓN

Nivel: Intermedio / Avanzado



PSOAS ILÍACO · INTENSIDAD 6-8
3 SERIES · 30-45 SEG

PARA QUIÉN

La alumna de danza, gimnasia o artes marciales que busca conseguir el split frontal (sagital) pero compensa la falta de extensión de cadera con una excesiva anteversión pélvica y arco lumbar.

PASO A PASO

1. Desde la posición de lunge, asegurate de que el torso esté vertical, no inclinado.
2. Colocá las manos en las caderas para tener una referencia táctil.
3. **REALIZÁ UNA RETROVERSIÓN PÉLVICA:** contraé el glúteo de la pierna de atrás y llevá el pubis hacia el ombligo. Aplaná lumbares.
4. Sentí que el estiramiento se intensifica en la parte alta y frontal del muslo de atrás.
5. Sostené la contracción del glúteo y la retroversión mientras respirás.

3 ERRORES COMUNES

1. Arquear la espalda lumbar para "bajar más".
   Corrección: El foco es la retroversión, no la profundidad.
2. Inclinar el torso hacia adelante.
   Corrección: Mantener el torso erguido.
3. No activar el glúteo de atrás.
   Corrección: Tocarse el glúteo para sentir la contracción.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **HIPERMOVILIDAD:** Sí, el enfoque activo es ideal.
- ✓ **HERNIA LUMBAR:** Sí, protege la zona.
- ✓ **RODILLA:** Sí, con apoyo cómodo.
- ✗ **EMBARAZO AVANZADO:** No.
- ✗ **LESIÓN DE PSOAS:** No.

REGRESIÓN: Menos profundidad en la zancada.

PROGRESIÓN: Inclinar torso lateralmente con brazo elevado.

PARA SU CASA: "El secreto no es bajar más, sino crear extensión real sin trampear con la lumbar."

GUÍA RÁPIDA: MOTIVO DE CONSULTA, ADAPTACIÓN Y CUÁNDO DERIVAR

Claves para identificar necesidades, ofrecer adaptaciones efectivas y reconocer banderas rojas en la sala de práctica

MOTIVO DE CONSULTA DEL ALUMNO	ADAPTACIÓN CLAVE EN LA SALA	CUÁNDO DERIVAR (BANDERAS ROJAS)
"Me tiran mucho los isquiotibiales"	Enseñar la flexión desde la cadera (anteversión), no desde la lumbar.	Dolor agudo, historia de desgarro reciente.
"No puedo sentarme en el piso, soy muy duro de caderas"	Elevar la pelvis sobre bloques o almohadones; alejar los talones.	Dolor agudo en la ingle o bloqueo articular.
"Me duele la lumbar cuando me agacho"	Reeducar la bisagra de cadera, disociar el movimiento lumbopélvico.	Dolor que no cede con el reposo o que interrumpe el sueño.
"Tengo una hernia de disco"	Priorizar la descompresión axial. Evitar flexión profunda, torsiones y compresión.	Dolor irradiado agudo (ciática), pérdida de fuerza o sensibilidad en la pierna.
"Tengo ciática, me baja un dolor por la pierna"	Estirar piramidal con cuidado. Si aumenta el hormigueo, parar.	Síntomas que no mejoran, pérdida de control de esfínteres (urgencia médica).
"Tengo los hombros cerrados por la compu"	Enfocar en abrir pectorales y movilidad torácica. Evitar posiciones de pinzamiento.	Dolor agudo al levantar el brazo, incapacidad para moverlo, historia de luxación.
"Me duele la rodilla en la postura de la paloma"	Usar la alternativa en supino (figura de 4) o elevar mucho la cadera con bloques.	Dolor mecánico agudo, inflamación, bloqueo o chasquido doloroso en la rodilla.
"Se me levantan los talones en la sentadilla"	Trabajar la dorsiflexión de tobillo (estirar sóleo con rodilla flexionada).	Dolor agudo en el tendón de Aquiles.
"Soy hiperlaxo pero me siento muy trabado"	Priorizar la estabilidad, la fuerza y el control motor sobre el estiramiento pasivo.	Dolores articulares recurrentes, subluxaciones frecuentes.
"Estoy embarazada, ¿qué puedo hacer?"	Evitar supinos prolongados, torsiones profundas y rangos máximos. Enfocar en movilidad.	Cualquier tipo de sangrado, mareos, dolor abdominal o indicación médica.
"Soy mayor y me cuesta agacharme"	Fortalecer piernas y glúteos con ejercicios funcionales como sentarse y pararse de una silla.	Mareos, pérdida de equilibrio severa, dolor articular incapacitante.
"Soy deportista, ¿cómo estiro antes de competir?"	Priorizar estiramientos dinámicos y movilidad articular. Dejar los estáticos para después.	Dolor agudo que aparece durante el calentamiento.

PROGRAMACIÓN

Cómo se gana rango de verdad.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

En este capítulo vas a aprender a pensar como un preparador físico de la flexibilidad. Vamos a ver las variables clave (frecuencia, volumen, intensidad), los tiempos reales de adaptación del tejido y cómo estructurar una sesión y un plan a mediano plazo para que vos o tus alumnos progresen de forma segura y sin estancarse.

FRECUENCIA, VOLUMEN E INTENSIDAD

LA DOSIS ADECUADA

Para ganar flexibilidad de forma consistente, necesitás una dosis adecuada de estímulo, igual que en el entrenamiento de la fuerza.

Esto se logra manipulando tres variables clave: la **frecuencia** (cuántas veces por semana), el **volumen** (cuántas series y por cuánto tiempo sostenés cada estiramiento) y la **intensidad** (qué tan profundo vas en la escala de percepción de tirantez).

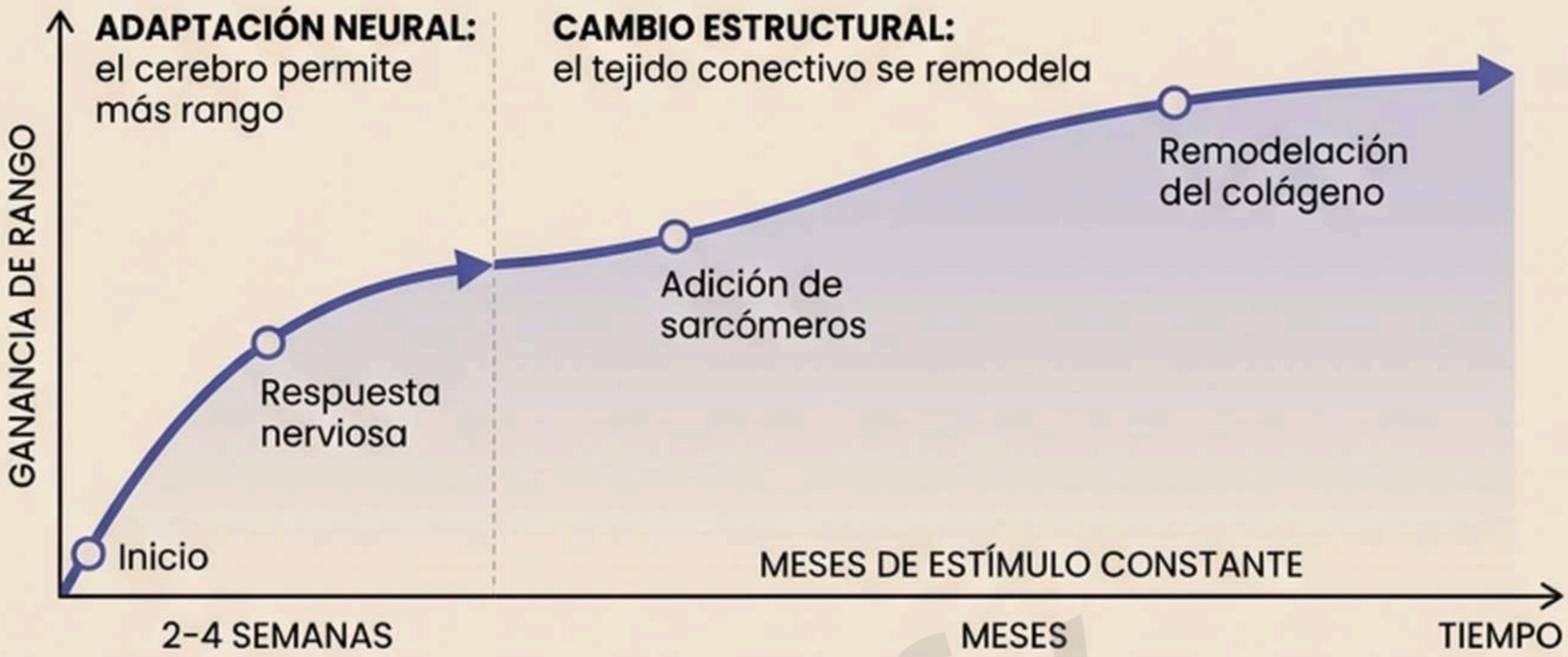
Si una variable sube mucho, las otras deberían bajar para permitir la adaptación y evitar lesiones. Por eso, no se puede estirar todos los días, a máxima intensidad y por mucho tiempo sin riesgo de sobrecargar el tejido. La clave es el equilibrio y la progresión gradual.

EN LA SALA

La típica pregunta del alumno: *"Profe, ¿tengo que estirar todos los días para mejorar?"*

No necesariamente. La constancia (frecuencia) es importante, pero la recuperación es igual de crucial. Es más efectivo estirar 3-4 veces por semana con buena intensidad y volumen, que todos los días sin permitir que el tejido se adapte. Calidad sobre cantidad, siempre.

CUÁNTO TARDA EN CAMBIAR EL TEJIDO



CARD PRINCIPAL

Las ganancias rápidas que sentís al empezar a estirar son, en su mayoría, una respuesta nerviosa. Tu sistema nervioso central aprende que ese rango es seguro y disminuye la señal de alarma del reflejo miotático. Es un cambio real, pero volátil.

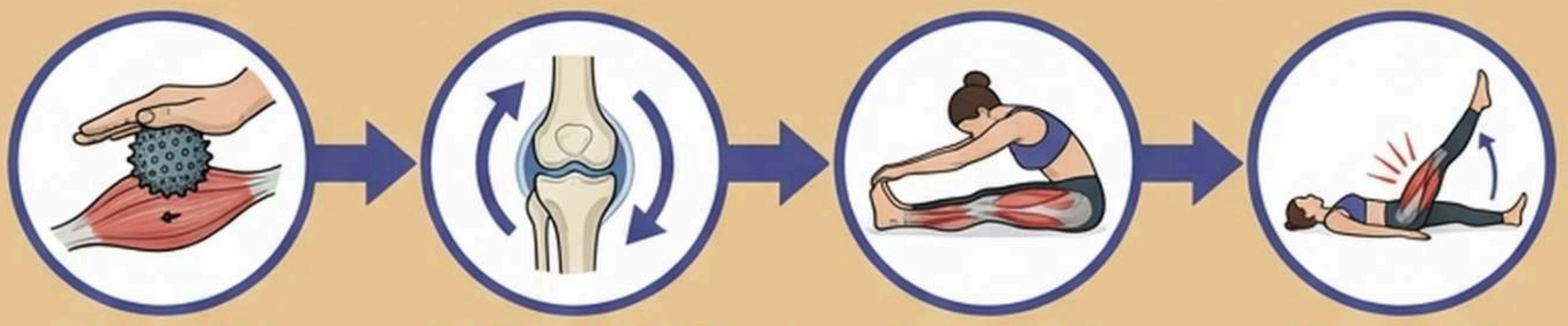
El cambio profundo y duradero, la adición de sarcómeros y la remodelación del colágeno en la fascia, es un proceso lento que lleva meses de estimulo constante.

Por eso, la paciencia y la consistencia son más importantes que forzar el rango en una sola sesión.

EN LA SALA

La alumna que después de un mes de trabajo intenso se frustra porque "todavía no le sale el split".

ORDEN DE LA SESIÓN



LIBERAR
Reducir densidad y adherencias

MOVILIZAR
Lubricar y preparar la articulación

ESTIRAR
Ganar longitud en tejido preparado

ACTIVAR
Integrar el nuevo rango ganado

El orden de los factores sí altera el producto en una sesión de flexibilidad.

Empezamos con **liberación miofascial** para reducir la densidad del tejido y mejorar el deslizamiento entre capas. Seguimos con **movilidad articular** para **lubricar la articulación** y prepararla para el movimiento sin carga.

Recién ahí, con el **tejido y la articulación listos,** aplicamos el **estiramiento principal** para ganar rango. Y, fundamental, cerramos con activación en ese nuevo rango para que el sistema nervioso lo registre como propio y útil.

Este orden **prepara, alarga e integra de forma segura y efectiva.**

EN LA SALA: El alumno que llega y se tira de una al piso a hacer el estiramiento más intenso que conoce.

QUÉ SÍ

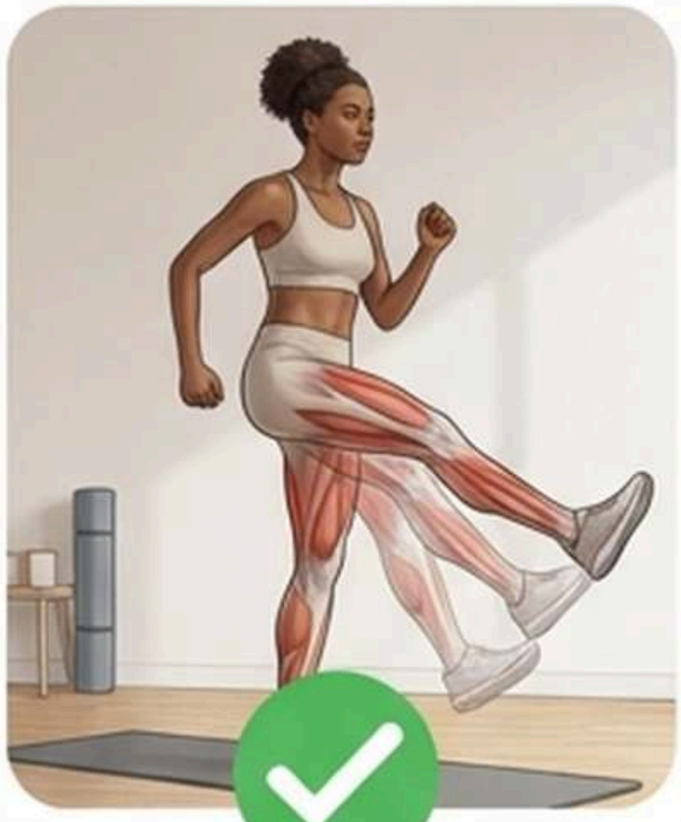
Preparar el cuerpo de **forma progresiva,** respetando cada fase para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones.

QUÉ NO

Ir directo al **estiramiento máximo en frío,** sin preparación previa, aumentando el riesgo de lesión y limitando el progreso real.

ANTES O DESPUÉS

CALENTAMIENTO
(antes de entrenar)



balanceos de pierna

estiramiento estático de isquiotibiales

VUELTA A LA CALMA
(después de entrenar)

El tipo de estiramiento depende del momento y del objetivo.

Antes de una actividad física (calentamiento), buscamos preparar el cuerpo: aumentar la temperatura, la circulación y la conexión neuromuscular. Para eso, los estiramientos dinámicos y la movilidad articular son ideales.

Los estiramientos estáticos largos antes de entrenar pueden disminuir temporalmente la capacidad de producir fuerza.

En cambio, para ganar rango de movimiento, el mejor momento es después de la actividad (vuelta a la calma), cuando los músculos están calientes y más receptivos a un estímulo de alargamiento.

EN LA SALA

El corredor que sigue haciendo estiramientos estáticos de 30 segundos justo antes de salir a correr, porque “es lo que se hacía antes”.

CÓMO PROGRESAR LA CARGA

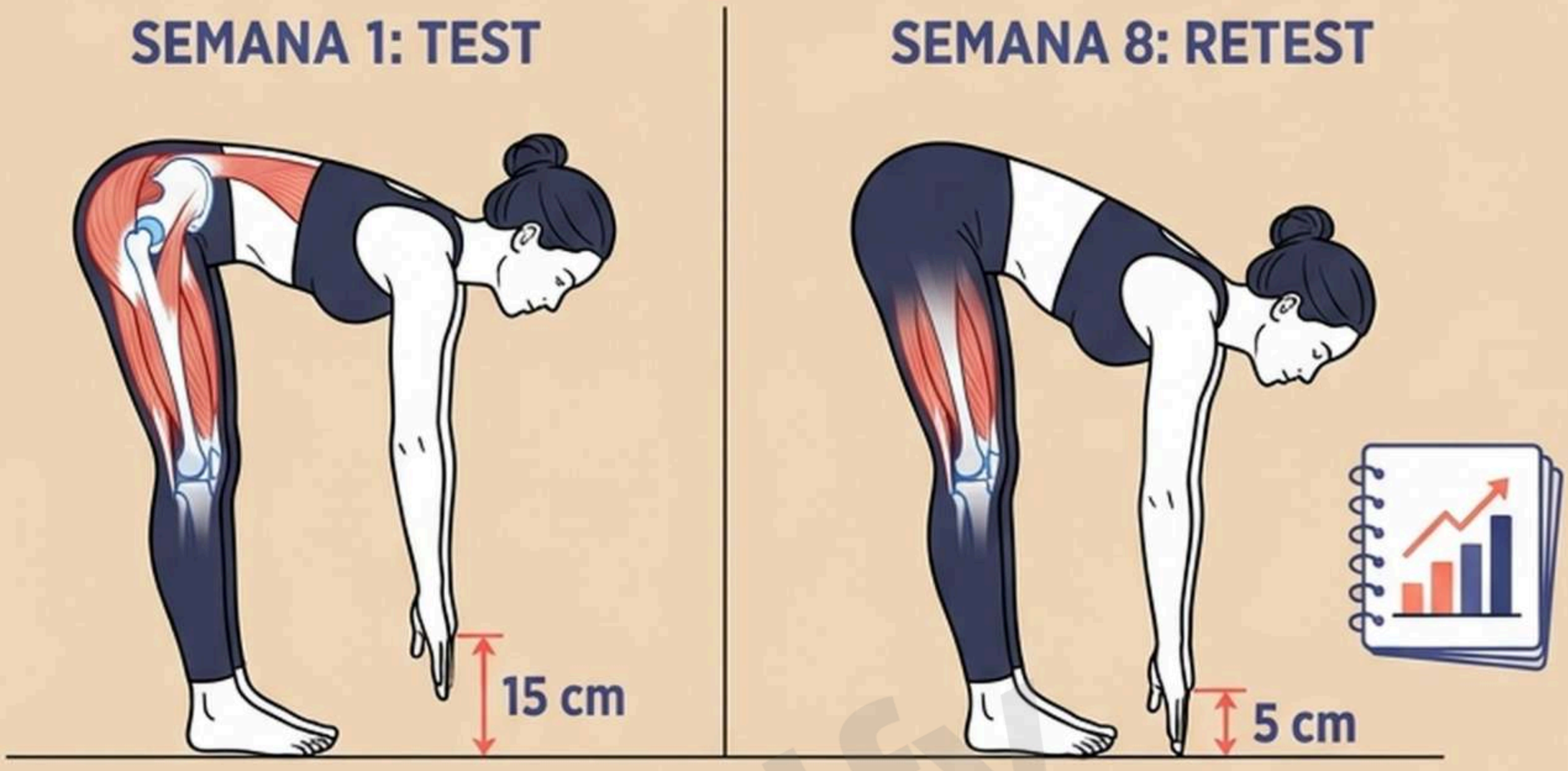
PARA QUE EL CUERPO SIGA ADAPTÁNDOSE, EL ESTÍMULO TIENE QUE AUMENTAR GRADUALMENTE

A esto se le llama **sobrecarga progresiva**. En flexibilidad, tenés cuatro formas principales de hacerlo: sostenés el estiramiento por **más tiempo**, aumentás la **intensidad de la tirantez** (siempre sin dolor), **profundizás un poco más el rango** de movimiento o agregás una **carga externa muy liviana** en el rango final. El secreto es elegir solo una de estas variables para modificar por un par de semanas, no todas a la vez. Así, el progreso es sostenible y se minimiza el riesgo de lesión.

EN LA SALA

La alumna que, para avanzar más rápido, sostiene más tiempo, va más profundo y encima le pide a una compañera que la empuje.

SABER SI PROGRESÁS



LA GUÍA DEL REGISTRO

La sensación de estar ‘más flexible’ es subjetiva y puede cambiar día a día. Para saber de verdad si tu plan está funcionando, necesitás datos objetivos.

Esto se logra con un **test** al inicio del proceso y un **retest** cada **4 u 8 semanas**. Puede ser una foto en la misma postura, medir con una cinta métrica la **distancia a un punto de referencia** o contar cuántos bloques de yoga usás.

Anotar estos datos en un **cuaderno de registro** es clave, porque ver el progreso numérico o visual es la mayor fuente de motivación, sobre todo cuando sentís que estás estancado.

EN LA SALA

El alumno que insiste ‘no mejoro nada’, hasta que le mostrás la foto del primer día y la compara con la actual.

MESETAS: POR QUÉ TE ESTANCÁS

POR QUÉ TE ESTANCÁS

Una meseta o estancamiento es una señal de que tu cuerpo se adaptó por completo al estímulo que le estás dando. Seguir haciendo exactamente lo mismo con más intensidad casi nunca funciona y puede llevar a la frustración o sobrecarga.

La solución es cambiar la naturaleza del estímulo. Si venías haciendo solo estiramientos estáticos, probá un ciclo de PNF. Si siempre estirás los mismos músculos, revisá si el freno no está en otro lado.

A veces, la clave para seguir ganando flexibilidad es, paradójicamente, pasar unas semanas enfocándote en la fuerza de los músculos antagonistas.

EN LA SALA

La alumna que lleva seis meses haciendo la misma rutina de YouTube y ya no ve ningún cambio.

FLEXIBILIDAD Y FUERZA JUNTAS

RANGO PASIVO

El rango que te da un compañero o la gravedad se llama **rango pasivo**.

RANGO ACTIVO

El rango que podés alcanzar y sostener usando tu propia fuerza muscular es el **rango activo**, y es el que realmente podés usar en el movimiento.

LA IMPORTANCIA DE CERRAR LA BRECHA

Una gran diferencia entre ambos es una bandera roja: indica una falta de control motor sobre tu flexibilidad.

El objetivo no es solo alargar un músculo, sino fortalecer los músculos opuestos (antagonistas) para que puedan llevar la articulación a ese nuevo rango y controlarla ahí. Por eso, un buen programa de flexibilidad siempre incluye ejercicios de fuerza.

EN LA SALA

La practicante de yoga super flexible que se acalambra al intentar sostener la pierna elevada en Utthita Hasta Padangusthasana.

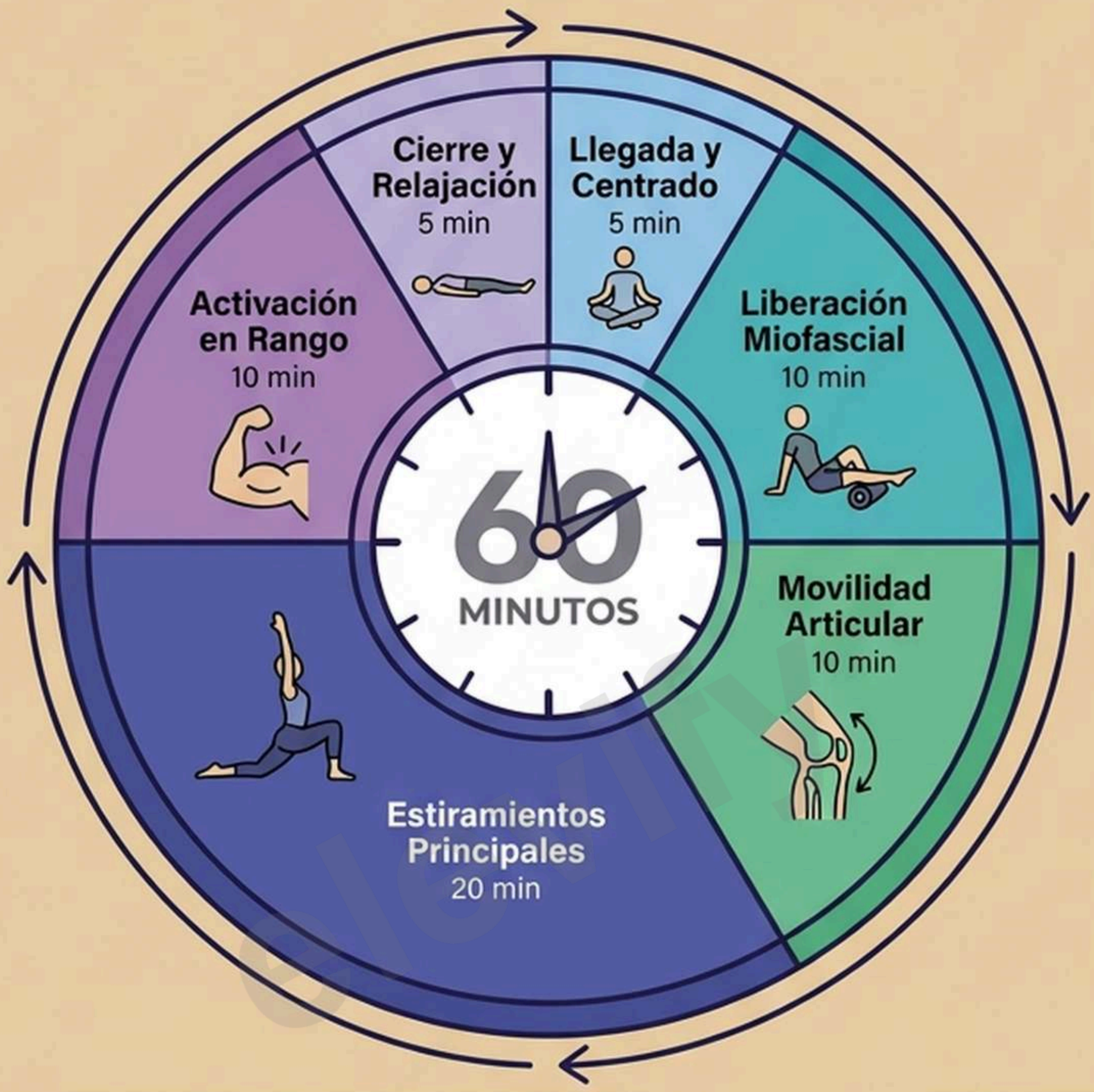
QUÉ SÍ

Complementar cada estiramiento con activación del músculo antagonista.

QUÉ NO

Buscar solo el rango pasivo sin desarrollar la fuerza para controlarlo.

CLASE DE FLEXIBILIDAD DE 60 MINUTOS



ESTRUCTURA SÓLIDA DE CLASE

Esta es una estructura sólida y probada para una clase de flexibilidad de una hora. Los tiempos son orientativos y se pueden ajustar según el foco del día y el nivel del grupo.

El orden es lo más importante: primero se prepara el tejido y las articulaciones, luego se trabaja el objetivo principal de rango de movimiento, después se integra ese rango con ejercicios de control motor y finalmente se baja la intensidad.

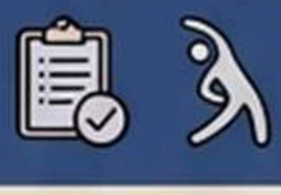
Usar una estructura como esta te da seguridad como profesor y le da al alumno una experiencia coherente y segura, donde cada parte de la clase construye sobre la anterior.

EN LA SALA

PLAN DE 8 SEMANAS

FASE 1: SEMANAS 1-2

BASE Y ADAPTACIÓN



Íconos de test y estiramientos suaves.

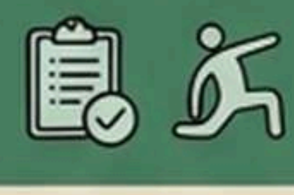
FASE 2: SEMANAS 3-6

SOBRECARGA PROGRESIVA

La línea asciende y aparecen íconos de más tiempo, más intensidad o PNF.

FASE 3: SEMANAS 7-8

PICO Y DESCARGA



La línea llega a un máximo en la semana 7 y baja un poco en la 8, con íconos de retest y movilidad suave.

EL PLAN: PERIODIZACIÓN Y FASES

Para un objetivo concreto, como mejorar la flexión de cadera, un plan de 8 semanas es un plazo realista para ver cambios significativos.

La clave es la **periodización**: no se entrena igual de duro todo el tiempo. Se empieza con una fase de adaptación, se progresa aumentando el volumen o la intensidad en las semanas centrales y se termina con una o dos semanas **de descarga activa** para permitir que el cuerpo asimile el trabajo antes de volver a medir el progreso.

Este enfoque por fases es mucho más efectivo que hacer siempre lo mismo y previene el estancamiento.

EN LA SALA

El alumno que quiere lograr el split para una performance y te pide que le armes "un plan de verdad".

PLANTILLA DE SESIÓN · FLEXIBILIDAD GENERAL (60 MIN)

FECHA: .....

FOCO DEL DÍA: .....

BLOQUE	EJERCICIOS / NOTAS	SERIES / TIEMPO	INT. (1-10)
LLEGADA (5')			
LIBERACIÓN (10')			
MOVILIDAD (10')			
ESTIRAMIENTOS PRINCIPALES (20')			
ACTIVACIÓN (10')			
CIERRE (5')			

CÓMO USAR ESTA PLANTILLA

Usá esta plantilla para diseñar tus clases o tus prácticas personales.

Planificar te ayuda a ser intencional y registrar te permite ver qué funciona.

Anotá los ejercicios de este libro y ajustá las variables según tus sensaciones o las de tu alumno.

elevify

PLANTILLA DE SESIÓN: CADERA Y POSTERIOR

PLANTILLA DE SESIÓN · CADERA Y CADENA POSTERIOR (45 MIN)

FECHA: _____ **ALUMNO/A:** _____

BLOQUE	EJERCICIOS / NOTAS	SERIES / TIEMPO	INT. (1-10)
LLEGADA (5')	**Respiración diafragmática**, ajuste del entorno. Conexión mental.	1 serie / 5 min	-
LIBERACIÓN (Miofascial) (10')	**Glúteos** (pelota lacr. – 2 min/lado), **TFL** (foam roller – 1 min/lado), **Isquiotibiales** (foam roller – 2 min/lado).	2-3 zonas / 10 min	5-7
MOVILIDAD (Articular) (10')	**Circunducción de cadera** (5 reps/lado), **Gato-camello** (10 reps), **Balanceos de pierna** (10 reps/lado), **Círculos pélvicos** (5 reps/lado).	2 series / 10 min	4-6
ESTIRAMIENTOS PRINCIPALES (15')	**Psoas** (estocada con bloque, 60s/lado), **Isquiotibiales** (flexión cadera supina c/cinta, 60s/lado), **Aductores** (mariposa c/bloques, 90s), **Piramidal** (paloma en caja, 60s/lado).	3 series / 15 min	6-8
ACTIVACIÓN (5')	**Puentes de glúteos** a una **pierna** (12 reps/lado), **Elevaciones laterales de cadera** con banda (15 reps/lado), **Plancha frontal con extensión de cadera** (30s).	1-2 series / 5 min	7-9

INSTRUCCIONES DE USO

Esta guía está pensada para sesiones enfocadas en la cadera. Elegí 1 o 2 estiramientos principales por sesión para trabajarlos a fondo. No te saltees la activación final; es lo que fija la ganancia.

REVISIÓN DEL KINESIÓLOGO — ERRORES DE LA VERSIÓN ANTERIOR (CORREGIDOS)

ANATOMÍA APLICADA A LA FLEXIBILIDAD

ANATOMÍA APLICADA A LA FLEXIBILIDAD

CORRECCIÓN ISQUIOTIBIALES

CORRECCIÓN PSOAS

PLANTILLA DE SESIÓN · HOMBROS Y COLUMNA (45 MIN)

FECHA: .....

ALUMNO/A: .....

BLOQUE	EJERCICIOS / NOTAS	SERIES / TIEMPO	INT. (1-10)
LLEGADA	.....	5'	____
LIBERACIÓN	Miofascial en dorsales, pectorales	10'	____
MOVILIDAD	Articular de hombro y columna torácica	10'	____
ESTIRAMIENTOS PRINCIPALES	Dorsal ancho, pectoral, rotadores	15'	____
ACTIVACIÓN	Retracciones escapulares, rotaciones externas	5'	____

INSTRUCCIONES

Usá esta estructura para tus prácticas de movilidad de tren superior. Recordá que la movilidad de la columna torácica es clave para la salud del hombro. La activación final ayuda a mejorar la postura.

MI PLAN DE 8 SEMANAS

OBJETIVO PRINCIPAL (Específico y medible): _____

TEST INICIAL (qué medí y resultado): _____

FECHA DE INICIO: _____

PLANIFICACIÓN SEMANAL

SEMANA	FOCO / VARIABLE A PROGRESAR	FRECUENCIA (/sem)	NOTAS Y SENSACIONES
SEMANA 1			
SEMANA 2			
SEMANA 3			
SEMANA 4			
SEMANA 5			
SEMANA 6			
SEMANA 7			
SEMANA 8			

RETEST FINAL (qué medí, resultado y conclusión):

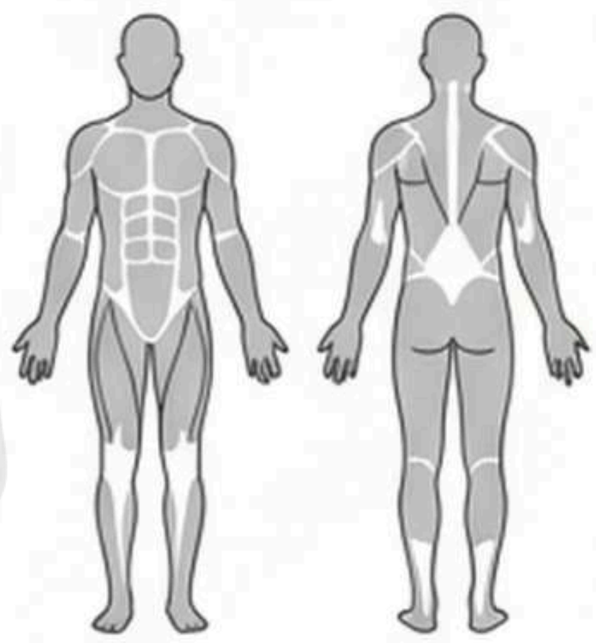
_____

_____

_____

FECHA FINAL: _____

ZONA OBJETIVO



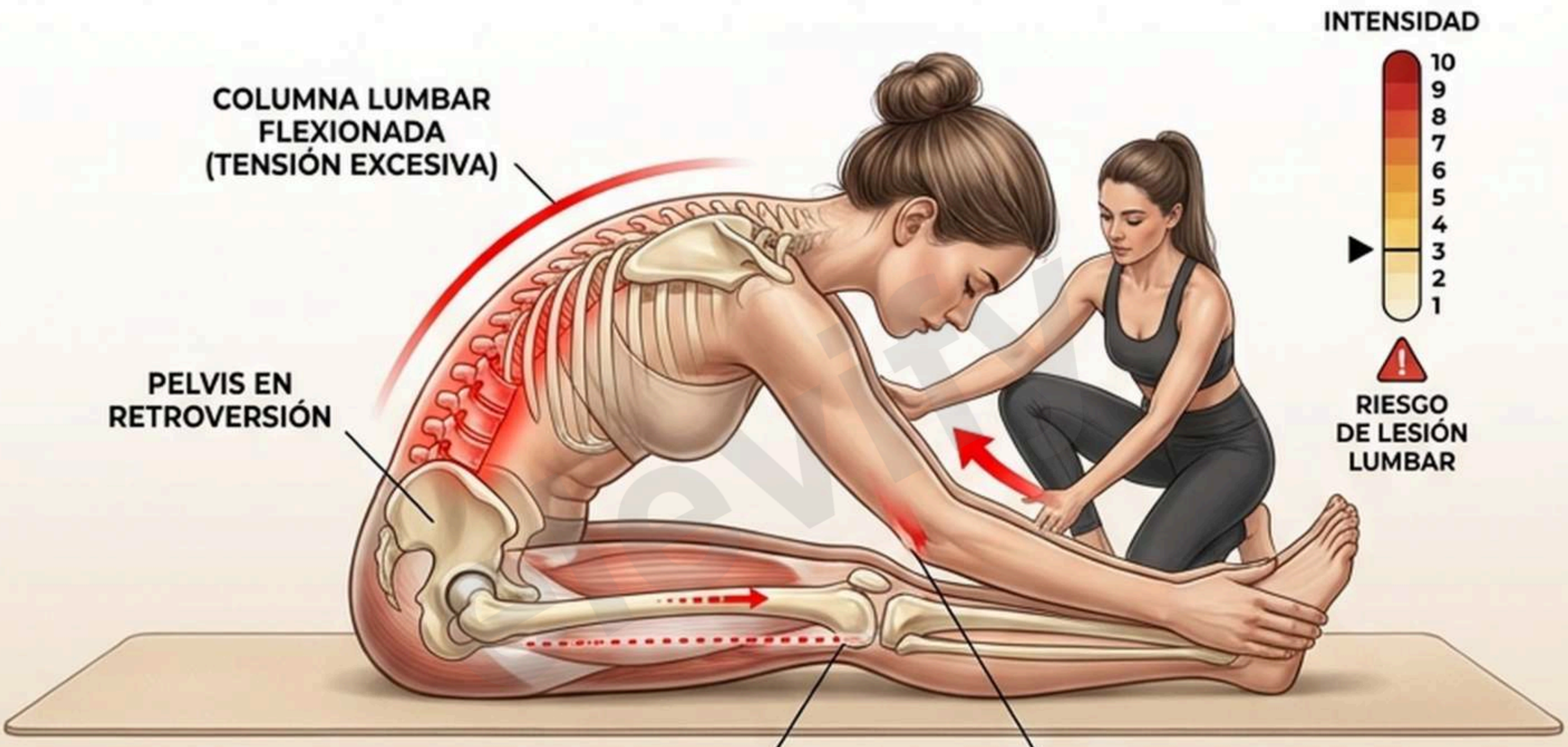
CÓMO USAR LA PLANTILLA

- **Definí un objetivo claro y medible** (ej: tocar la punta de los pies sin doblar rodillas).
- **Hacé un test inicial que puedas repetir exactamente igual.**
- **Planificá la progresión de una variable a la vez por semana o bloque** (ej: aumentar tiempo de sostén o series).
- **Registrá todo: la frecuencia semanal y cómo te sentís en cada sesión** (dolor, mejora, fatiga).
- **La clave es la constancia y el registro para ajustar el plan.**

elevify

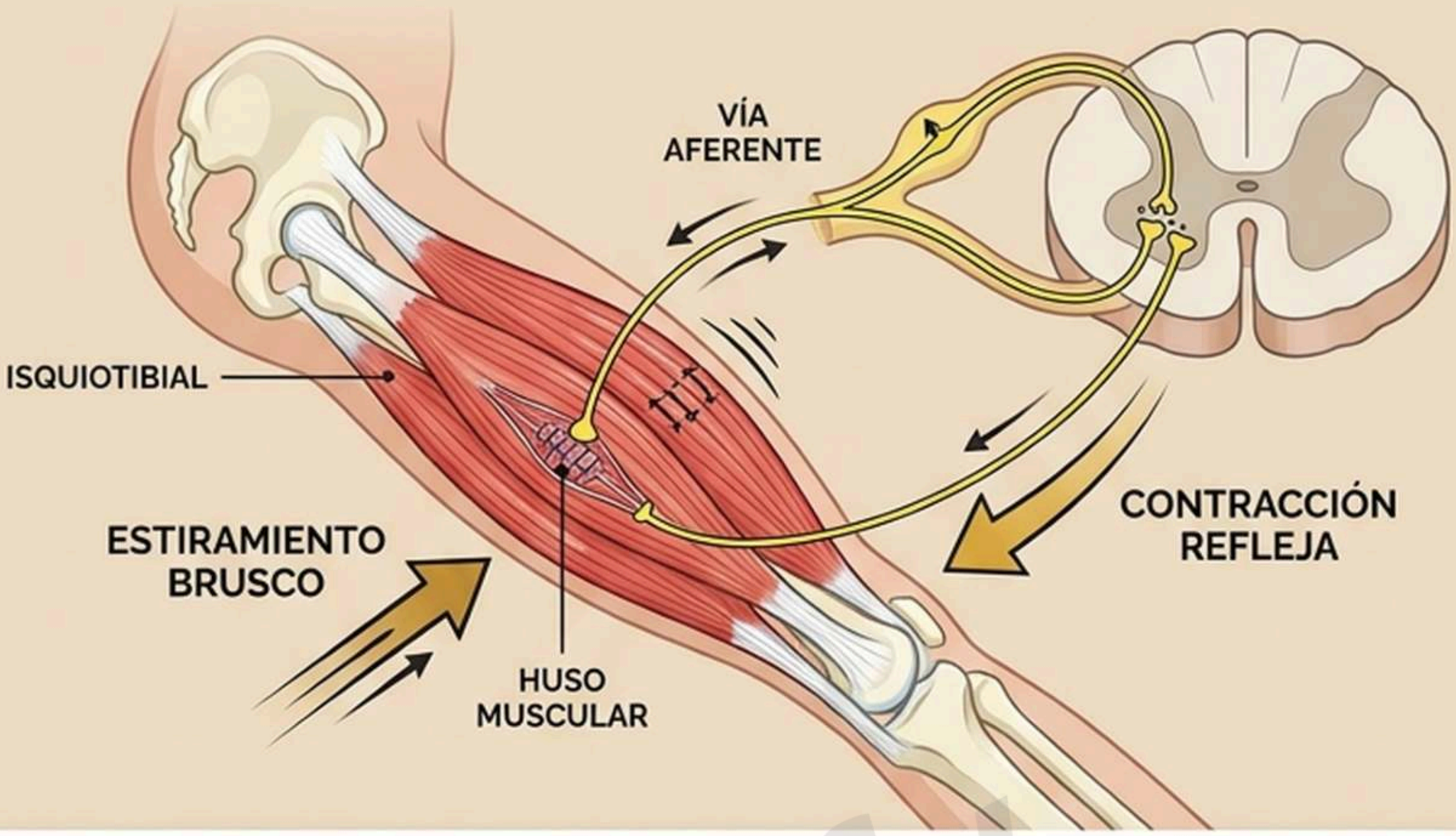
ERRORES FRECUENTES

Las compensaciones y los hábitos que frenan tu progreso y aumentan el riesgo de lesión.



QUÉ VAS A ENCONTRAR

- En este capítulo vamos a analizar los **nueve errores que más** veo en la sala. **Aprenderás a identificar por qué rebotar no sirve, cómo la respiración es tu aliada, dónde nacen las compensaciones más comunes y por qué estirar a una persona hiperlaxa es completamente diferente.**
- **IDENTIFICA COMPENSACIONES ANTES DE AVANZAR**
- **LA TÉCNICA CORRECTA PREVIENE LESIONES**



EL REFLEJO MIOTÁTICO

PROTECCIÓN, NO ALARGAMIENTO

Cuando estirás un músculo de forma brusca y rápida, como en un rebote, se activa un mecanismo de protección llamado reflejo miotático. El sistema nervioso interpreta ese estiramiento veloz como una amenaza de desgarro y, para evitarlo, manda una orden inmediata de contracción a ese mismo músculo. Por eso, rebotar es contraproducente: en lugar de relajar y alargar el tejido, lo estás poniendo más tenso y corto, luchando contra tu propio sistema nervioso.

EN LA SALA

- La alumna que hace pequeños impulsos en una pinza, convencida de que "así se afloja y llega más lejos", activando sin querer su reflejo de protección.

QUÉ SÍ

- ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS SOSTENIDOS (30-60 SEG)
- DINÁMICOS FLUIDOS Y CONTROLADOS

QUÉ NO

- REBOTES BALÍSTICOS SIN CONTROL

- EN EL RANGO FINAL DEL MOVIMIENTO

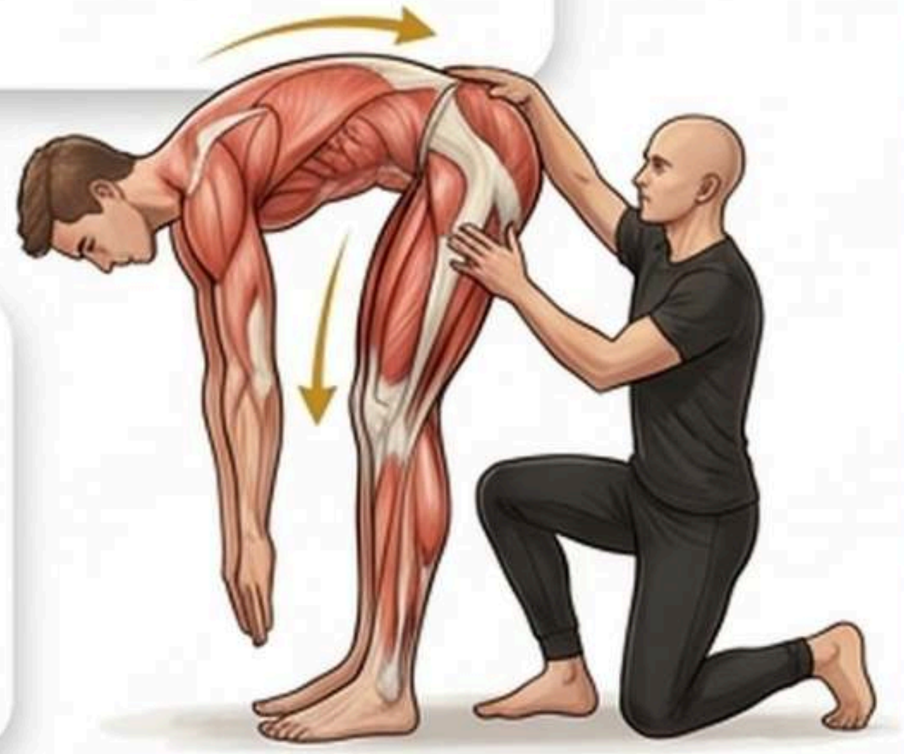
COMPENSAR CON LA LUMBAR

La verdadera flexión hacia adelante nace en la articulación de la cadera, no en la cintura. Cuando los isquiotibiales están cortos, no permiten que la pelvis rote libremente hacia adelante (anteversión). El cuerpo, para cumplir la orden de 'bajar', busca movimiento donde puede: en la columna lumbar.

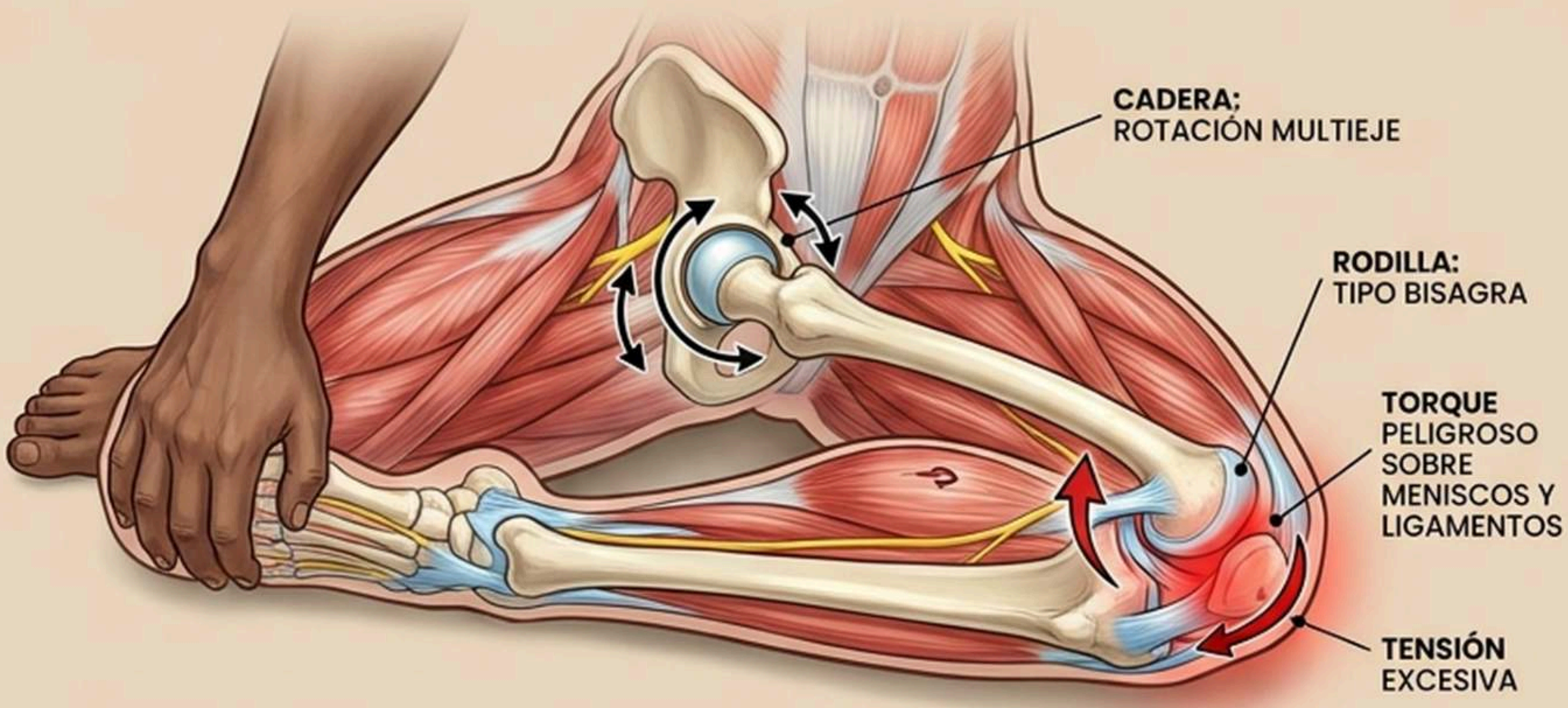
Esta compensación no solo hace que el estiramiento de isquiotibiales sea ineficaz, sino que además genera un estrés innecesario y potencialmente lesivo sobre los discos intervertebrales lumbares.

EN LA SALA

El alumno que, en un estiramiento de isquiotibiales de pie, curva toda su espalda para tocar el suelo pero sus caderas casi no se movieron.



FORZAR LA RODILLA



POR QUÉ ES UN ERROR GRAVE

En posturas que requieren una gran **rotación externa de cadera**, como la paloma o el loto, el movimiento debe originarse en la articulación coxofemoral, que es una esfera diseñada para rotar.

La rodilla, en cambio, es una articulación tipo bisagra; su **capacidad de rotación es mínima** y solo ocurre con la rodilla flexionada.

Si la **cadera no tiene el rango suficiente y se intenta forzar la postura** tirando desde el pie, toda esa fuerza de torsión se transmite directamente a la rodilla, poniendo en grave riesgo los meniscos y los ligamentos.

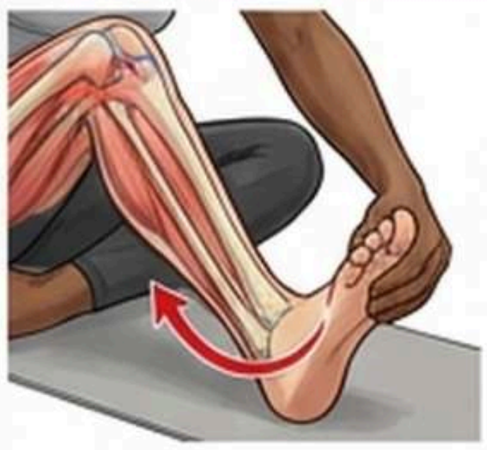
EN LA SALA

La alumna que se sienta y tira con fuerza de su tobillo para subirlo sobre el muslo contrario, sintiendo una "puntada" en la cara interna de la rodilla.

QUÉ SÍ

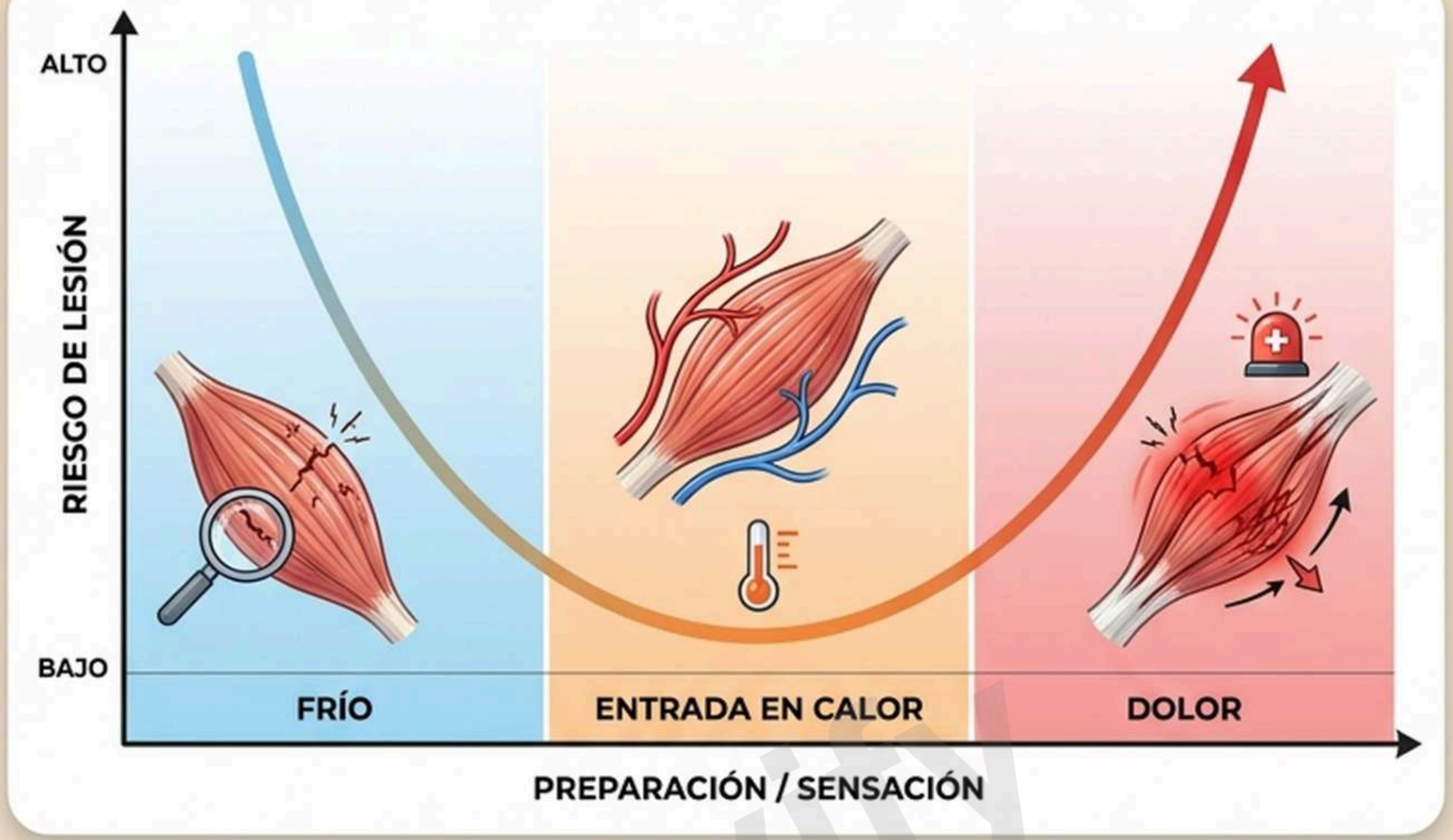
Activar los **rotadores externos de la cadera** para generar el movimiento desde el fémur.
La rodilla sigue el movimiento sin fuerza externa.

QUÉ NO



Usar el pie y el tobillo como una palanca para forzar la posición, generando torsión dañina en la rodilla.

ESTIRAR EN FRÍO Y CON DOLOR



LA TEORÍA: EL PELIGRO DE ESTIRAR FRÍO Y CON DOLOR

EL MÚSCULO FRÍO: UNA BANDA ELÁSTICA RÍGIDA

Un músculo frío es como una banda elástica recién sacada del congelador: rígido, frágil y poco maleable. Su viscoelasticidad está disminuida, lo que significa que no se deforma y recupera su forma con facilidad. Necesita una entrada en calor gradual para aumentar su temperatura interna, lo que mejora su elasticidad y lo vuelve más maleable, menos propenso a romperse y más resistente a la tensión.

EL DOLOR ES UNA ALARMA, NO PROGRESO

Por otro lado, el dolor agudo, punzante o una sensación intensa que te hace contener la respiración, NO es un indicador de progreso en la flexibilidad. Es una señal de alarma fundamental del sistema nervioso que te avisa que un tejido está llegando a su limite estructural peligroso.

Ignorar esa señal y seguir forzando el estiramiento no solo es inefectivo (el músculo activará un reflejo de protección y se contraerá para evitar daños, limitando aún más el rango de movimiento), sino es el camino más corto y seguro a una distensión, un desgarro muscular o una lesión tendinosa.

La clave es trabajar con una a tensión incómoda pero tolerable, sin llegar nunca al dolor agudo.

EN LA SALA: ERRORES TÍPICOS

El alumno que llega cinco minutos tarde, se saltea la movilidad articular y la entrada en calor, y va directamente al mat a intentar su split frontal máximo, sintiendo dolor y frustración. También, el practicante que asocia 'sentir mucho dolor' con un buen estiramiento y fuerza posiciones incómodas hasta sentir un 'tirón' agudo.

AGUANTAR LA RESPIRACIÓN

LA RESPUESTA FISIOLÓGICA

Cuando aguantás la respiración durante un estiramiento intenso (lo que se conoce como maniobra de Valsalva), tu cuerpo entra en estado de alerta. Se activa el sistema nervioso simpático ("lucha o huida"), lo que aumenta la tensión muscular general, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es una respuesta de protección, justo lo contrario a la relajación que necesitamos para que las fibras musculares cedan. En cambio, una exhalación lenta y profunda estimula el nervio vago y activa el sistema nervioso parasimpático ("descansar y digerir"), promoviendo la relajación muscular y permitiendo una ganancia de rango segura y efectiva.

QUÉ NO: APNEA

La figura contiene el aire. El diafragma está tenso y aplanado.

Cerebro en alerta (simpático)

Frecuencia cardíaca rápida

Músculos tensos

QUÉ SÍ: EXHALACIÓN

La figura exhala lentamente. El diafragma se relaja y asciende.

Cerebro calmo (parasimpático)

Ritmo cardiaco normal

Músculos relajados

EN LA SALA

Durante un estiramiento de cuádriceps, ves que el cuello y la mandíbula de la alumna están rígidos y su cara empieza a ponerse colorada. No está respirando. Una señal clara de tensión y falta de relajación.

El aire es clave para soltar la tensión y evitar lesiones.

ESTIRAR AL HIPERLAXO

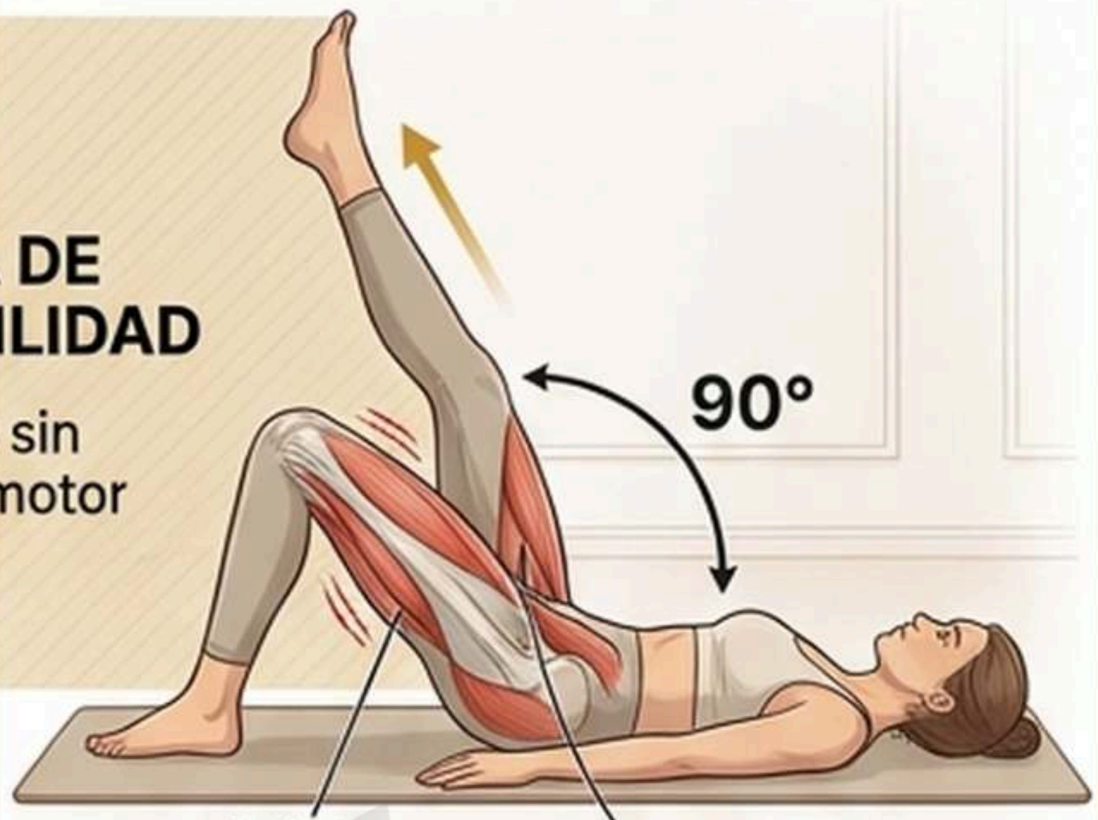
❌ RANGO PASIVO

Mucho rango, cero control

ZONA DE INESTABILIDAD

Rango sin control motor

✅ RANGO ACTIVO



Menos rango, control muscular

LA PERSONA HIPERLAXA

La persona hiperlaxa tiene un tejido conectivo que es genéticamente más flexible, dándole un rango de movimiento pasivo enorme.

El error es tratarla como a cualquier otra alumna y buscar que gane más flexibilidad.

Su problema no es la falta de rango, sino la falta de fuerza y control motor para estabilizar sus articulaciones en ese rango tan amplio.

El foco con ella debe ser el opuesto: fortalecer los músculos estabilizadores, trabajar la propiocepción y enseñarle a activar la musculatura en los rangos finales para proteger sus articulaciones de posibles luxaciones o lesiones.

❌ EN LA SALA

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ ✅

- ✓ Trabajo de fuerza y estabilidad.
- ✓ Control motor y propiocepción.
- ✓ Activación en rangos finales.
- ✓ Ejercicios isométricos.

QUÉ NO ❌

- ✗ Estiramientos pasivos sostenidos.
- ✗ Forzarla a ir 'más allá' del rango.
- ✗ Asistencias que aumenten el rango pasivo.

EMPUJAR al alumno desde la espalda

QUÉ NO

QUÉ SÍ

EL ERROR CLÁSICO Y SU SOLUCIÓN

Es una imagen clásica y peligrosa: el profesor aplicando presión sobre la ecspalda del alumno para que “baje más". Esta asistencia es incorrecta porque fuerza la flexión desde la columna vertebral, especialmente la zona lumbar, en lugar de la cadera. Esto no solo es ineficaz para alargar los isquiotibiales, sino que genera una compresión dañina sobre los discos intervertebrales.

La asistencia correcta y segura se enfoca en guiar a la pelvis. El objetivo es ayudar al alumno a iniciar el movimiento desde la cadera, promoviendo la mentaora el promovendo la anteversión pélvica mientras mantiene su columna en una posición neutra y segura.

EN LA SALA

El profesor bienintencionado que se sube literalmente sobre la espalda del alumno en una apertura de aductores para que ‘abra más’.

FLEXIBILIDAD POR DISCIPLINA

Cómo adaptar el entrenamiento a las demandas de cada actividad.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

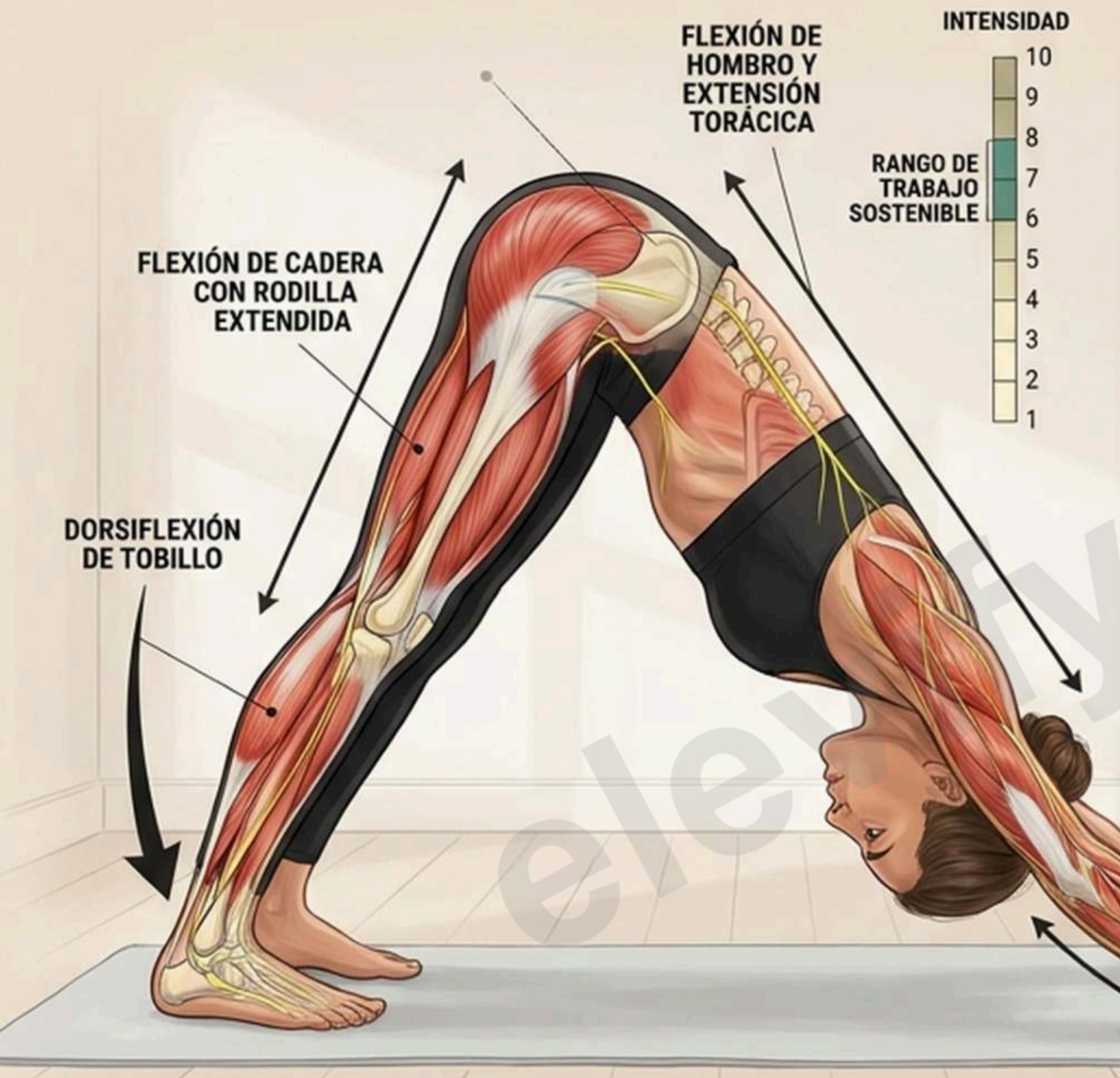
En este capítulo vamos a analizar las **necesidades específicas** de **rango de movimiento**, **estabilidad** y **control motor** para las disciplinas más comunes.

estabilidad

control motor

Vas a aprender: qué músculos se acortan más en una, dónde surgen las compensaciones típicas y cómo programar el estiramiento para potenciar el rendimiento sin aumentar el riesgo de lesión.

YOGA: RANGO Y CONCIENCIA



LA CLAVE: NO SOLO FLEXIBILIDAD

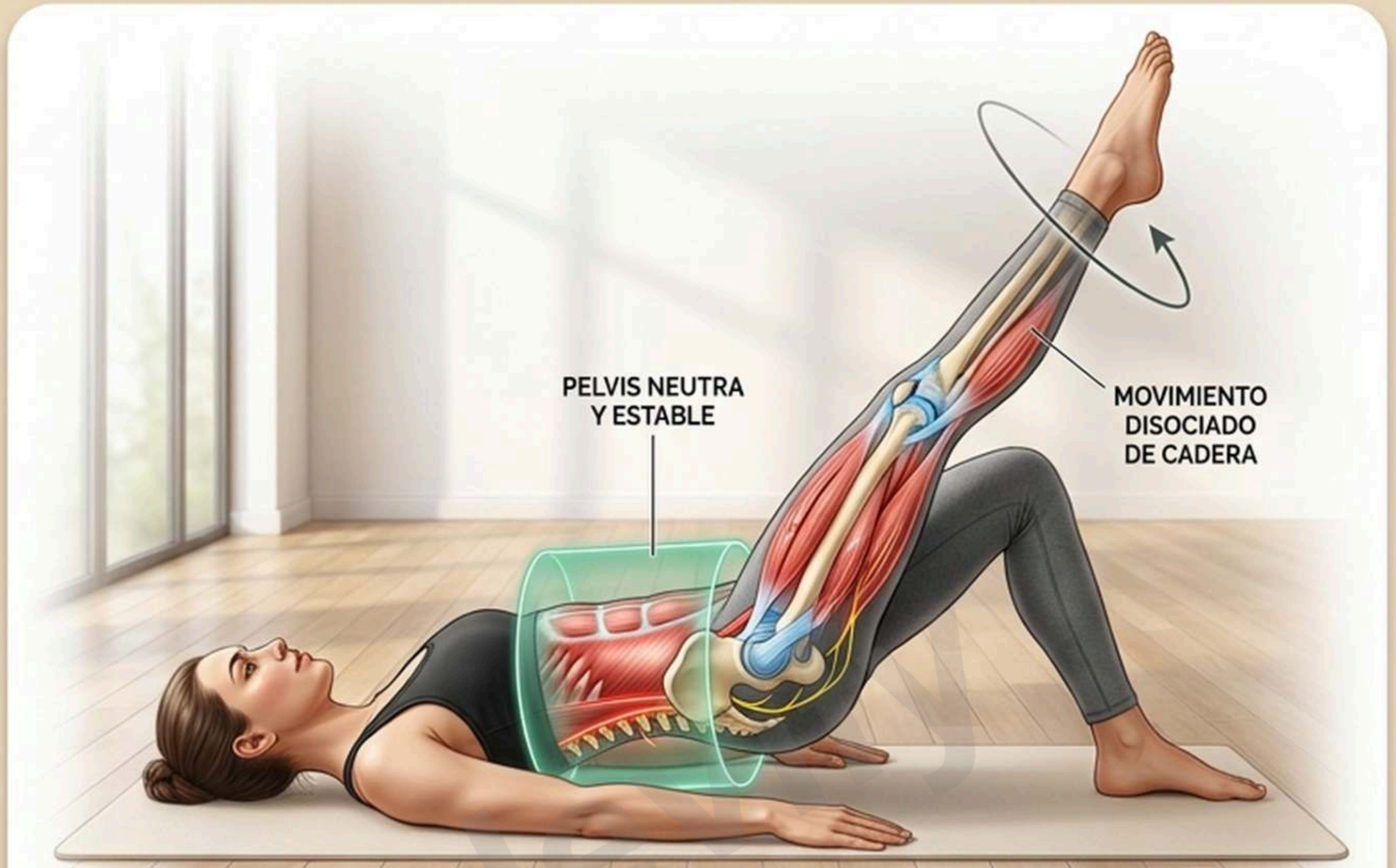
El yoga busca rangos de movimiento amplios y sostenidos. No se trata solo de 'ser flexible', sino de poder respirar y mantener el alineamiento en la postura. Por eso, una práctica segura prepara las articulaciones con movilidad activa antes de entrar en las asanas más demandantes. Por ejemplo, para un Adho Mukha Svanasana, la alumna necesita no solo isquiotibiales largos, sino también buena dorsiflexión de tobillo y una gran flexión de hombro para que la columna no se redondee compensando

CUE DE LA FORMADORA
Llevá el pecho hacia los muslos y los isquiones al cielo, alargando la columna. La prioridad es la espalda recta, no que los talones toquen el suelo

EN LA SALA: EL DIÁLOGO PROFE-ALUMNO

"Profe, no me llegan los talones al piso": revisá primero la movilidad del tobillo, no solo los isquiotibiales. Muchas veces la restricción está en la dorsiflexión y la fascia plantar, no solo en la cadena posterior

PILATES: CONTROL CENTRAL



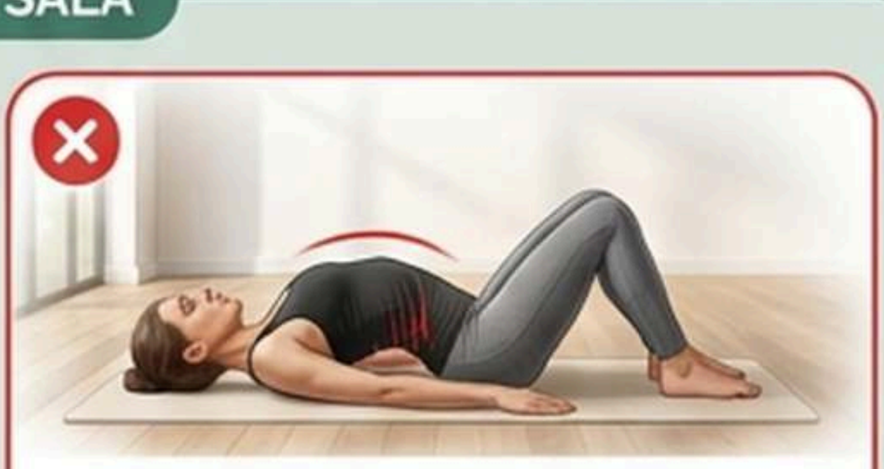
CONTROL CENTRAL

En Pilates, la flexibilidad nunca va sola: está al servicio del control motor desde el centro. El objetivo no es el rango máximo a cualquier costo, sino el mayor rango posible que se pueda estabilizar con la faja abdominal y la musculatura profunda de la columna.

Cuando el alumno busca más altura en una patada o un circulo de piernas, pero su pelvis se mueve o su lumbar se arquea, perdió el principio fundamental. Por eso, el foco está en disociar el movimiento de la cadera o del hombro respecto al de la columna vertebral.

EN LA SALA

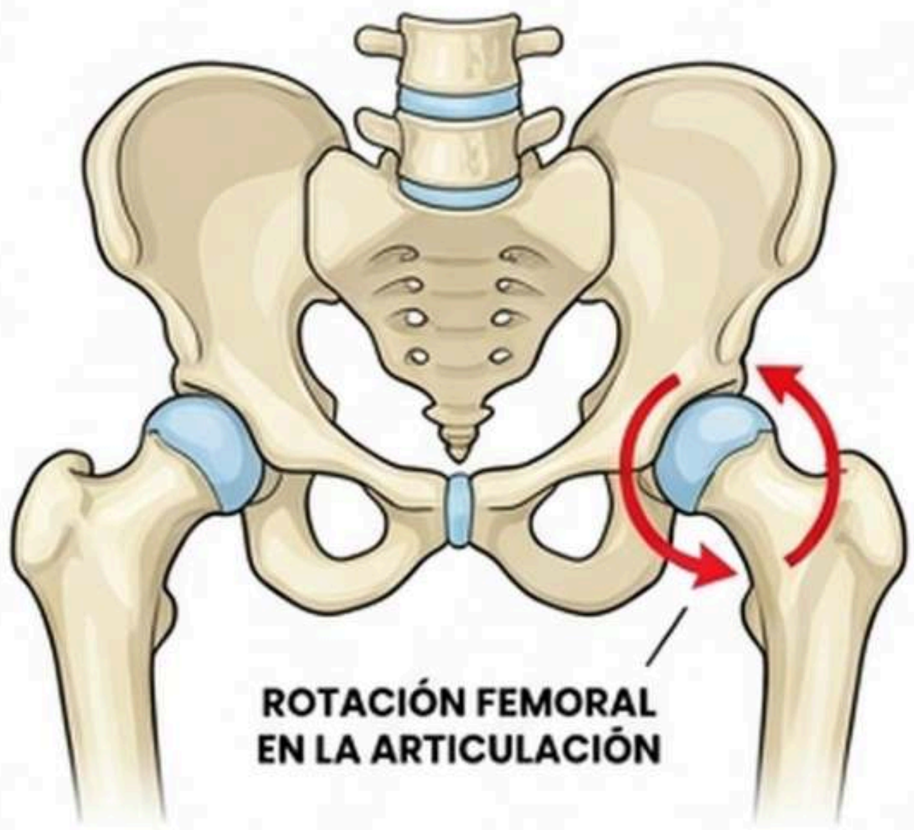
QUÉ SÍ: ARTICULAR VÉRTEBRA POR VÉRTEBRA
Flexión segmentada controlada desde el centro, pelvis en retroversión suave



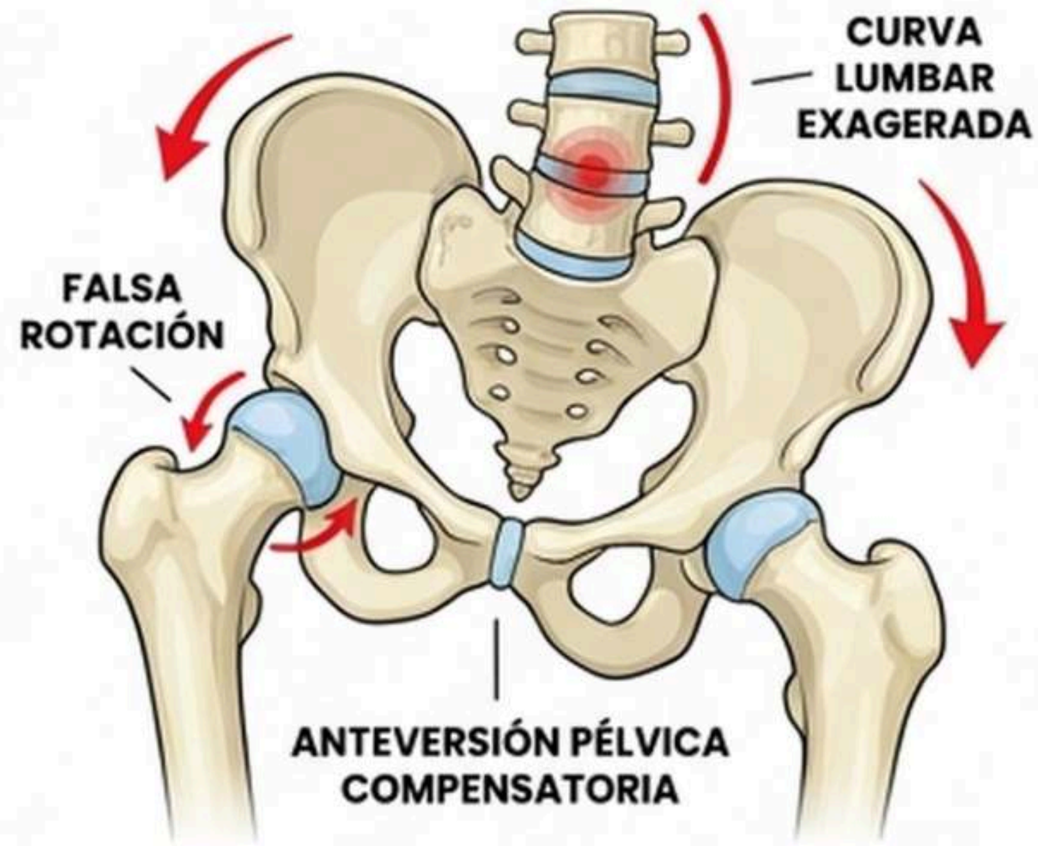
QUÉ NO: QUEBRAR LA LUMBAR
La columna se dobla en un solo bloque, pelvis anteversa, pérdida de control

DANZA: ROTACIÓN Y EXTENSIÓN

EN DEHORS REAL



COMPENSACIÓN COMÚN



TEORÍA Y PRÁCTICA: ENTRE EL RANGO Y EL CONTROL

La danza clásica y contemporánea exigen rangos extremos, especialmente la rotación externa de cadera (en dehors) y la extensión de cadera y columna (arabesque).

El riesgo principal es buscar estos rangos forzando otras articulaciones que no están diseñadas para ello. Un en dehors que no sale genuinamente ⅱ articulación de la cadera se compensa casi siempre con una marcada anteversión pélvica, una hiperlordosis lumbar y una torsión peligrosa en la rodilla.

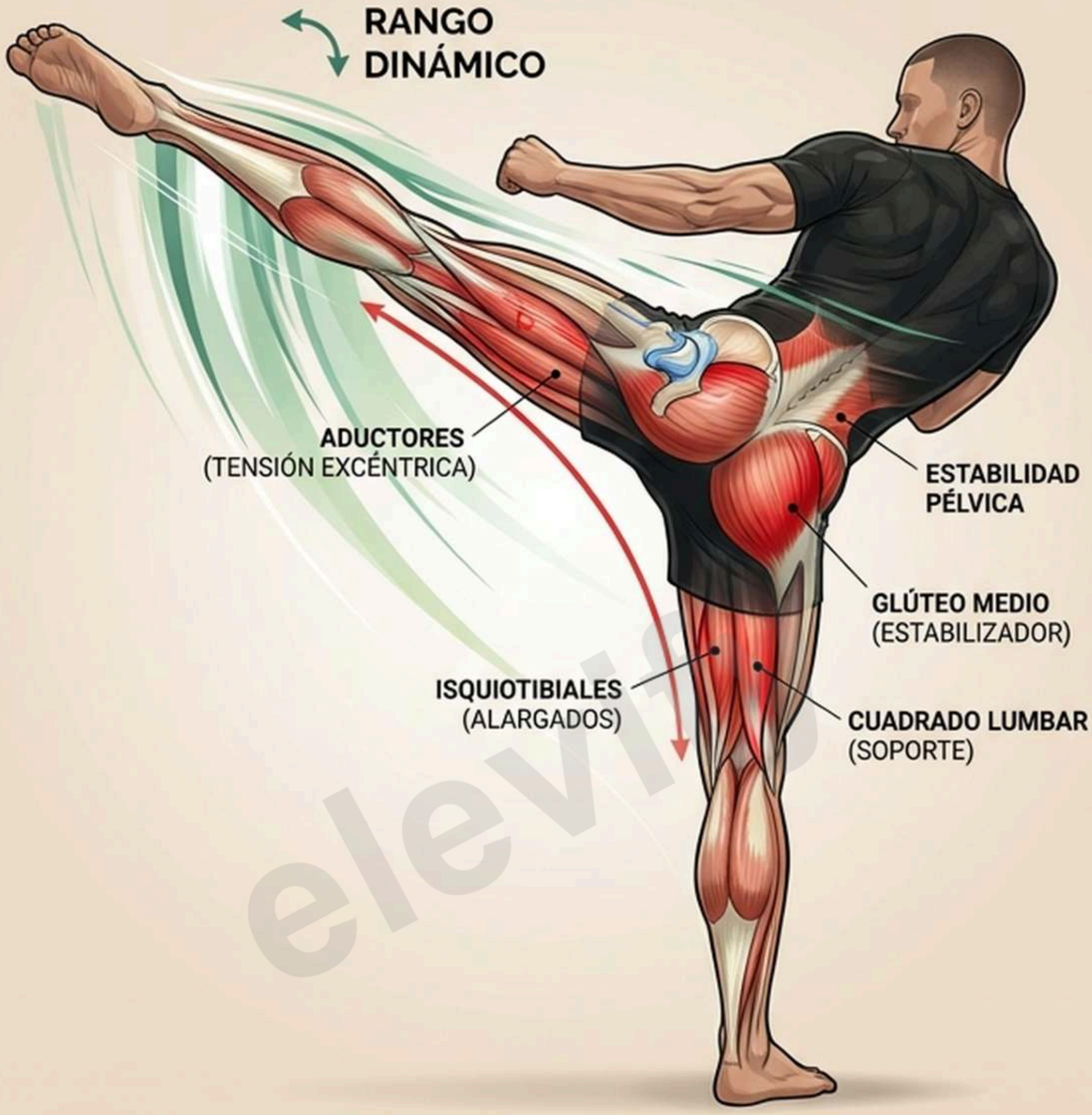
Por eso, el trabajo de flexibilidad debe enfocarse en los ROTADORES PROFUNDOS, PSOAS ILÍACO y ADUCTORES, y simultáneamente FORTALECER **los estabilizadores de la pelvis** (como el glúteo medio y los abdominales profundos) para evitar que "se quiebre la cintura".

EN LA SALA

La **bailarina con dolor lumbar crónico** que tiene los pies **perfectamente rotados**, pero a costa de una **gran anteversión pélvica.**

Consulta requerida

ARTES MARCIALES: FLEXIBILIDAD DINÁMICA



FUNDAMENTOS DE LA FLEXIBILIDAD DINÁMICA

Aquí la flexibilidad no es estática, es dinámica y balística. Se necesita un gran rango de movimiento que, además, pueda ser alcanzado a alta velocidad y con potencia. Esto requiere no solo flexibilidad pasiva (poder abrirse de piernas), sino sobre todo flexibilidad activa y control excéntrico.

Los aductores y los isquiotibiales deben poder alargarse rápidamente sin que se active el reflejo miotático de protección.

Por eso, el entrenamiento combina estiramientos estáticos con muchos ejercicios de movilidad dinámica y control motor en los rangos finales. El control neuromuscular es clave para evitar lesiones durante los movimientos explosivos.

CLAVES DEL ENTRENAMIENTO

- Movilidad articular diaria.
- Estiramientos dinámicos antes de entrenar.
- Fortalecimiento excéntrico en rangos finales.
- Progresión gradual de la velocidad y altura.

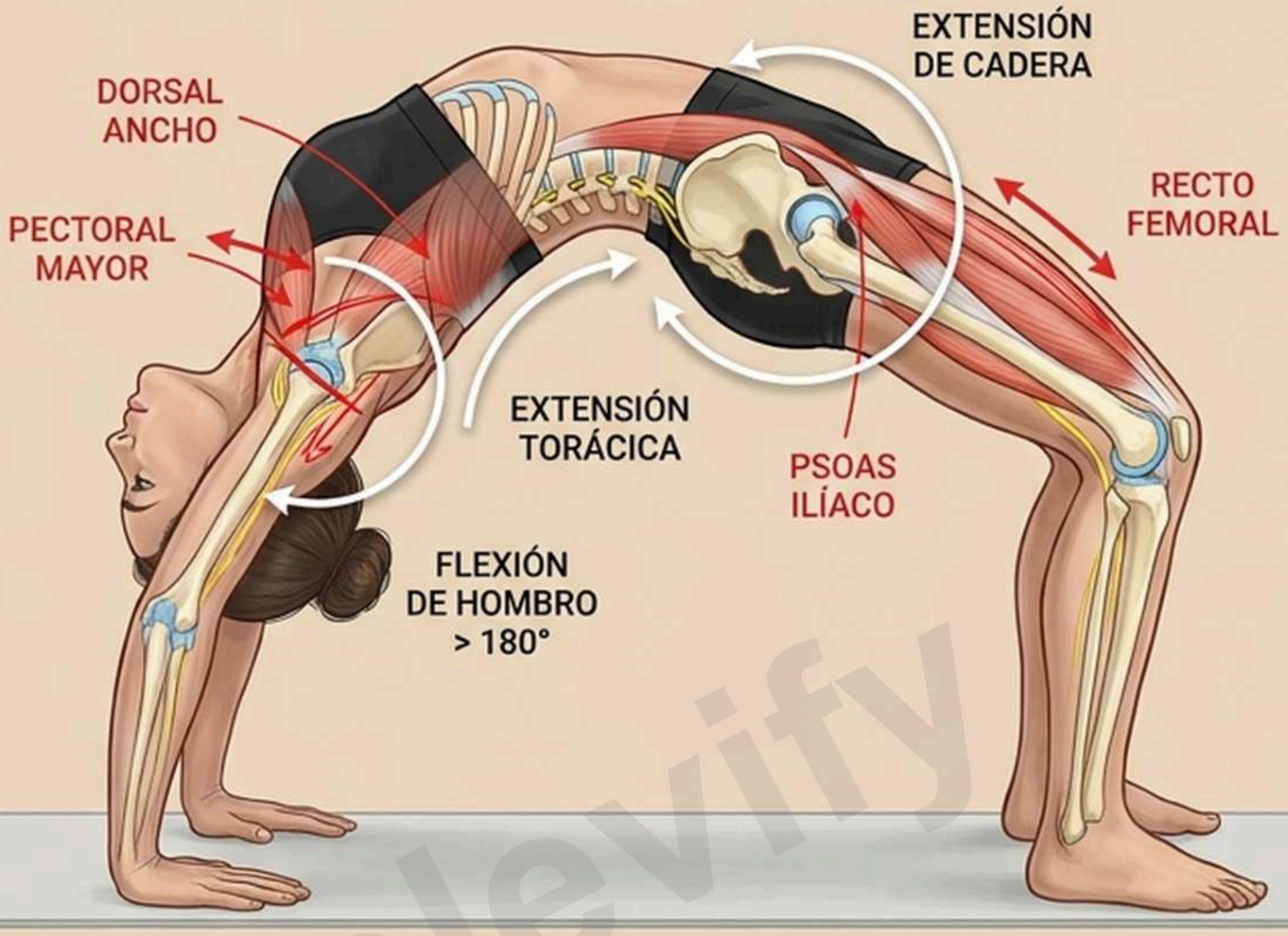
ERRORES COMUNES

- Rebotar sin control al estirar.
- Descuidar la estabilidad del core y la pelvis.
- Forzar el rango sin calentamiento adecuado.
- Ignorar el dolor agudo durante la práctica.

EN LA SALA

El practicante que sufre un desgarro en el isquiotibial al lanzar una patada alta, porque le falta control excéntrico en el rango final del movimiento. Aunque tiene flexibilidad pasiva, su músculo no está entrenado para soportar la carga y la velocidad en la extensión máxima, provocando la lesión. La solución pasa por fortalecer el músculo en su posición alargada.

GIMNASIA: RANGOS EXTREMOS



LA GIMNASIA Y LA ACROBACIA LLEVAN LA FLEXIBILIDAD A SUS LÍMITES FISIOLÓGICOS

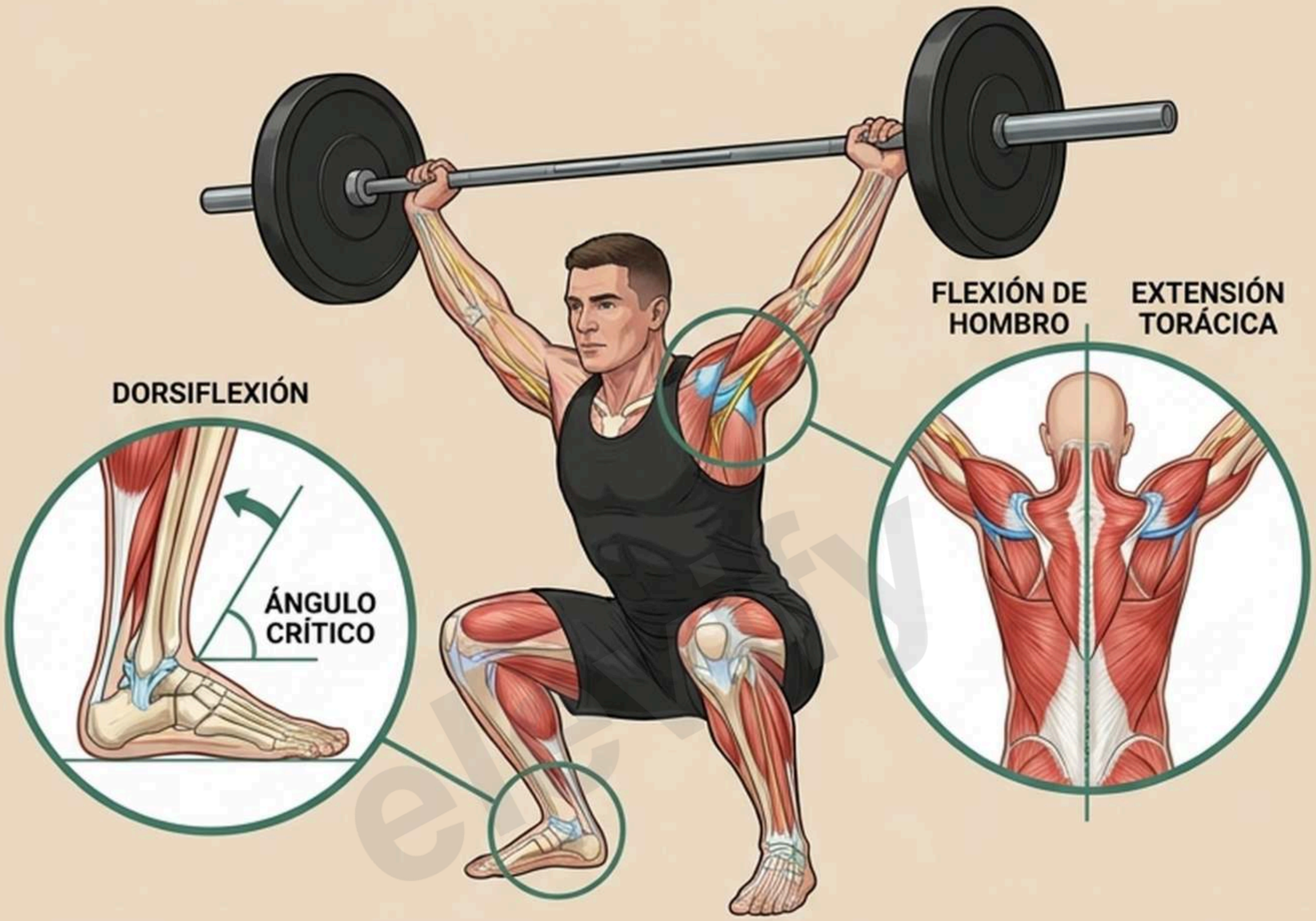
Posturas como el puente o el split requieren una **combinación de rangos extremos en múltiples articulaciones** a la vez. En un puente, por ejemplo, no es solo la columna la que se extiende; se necesita una enorme **flexión de hombro** y una gran **extensión de cadera.**

Si los hombros están rígidos (por un dorsal ancho o pectoral cortos), la alumna compensará con una hiperextensión lumbar peligrosa. Por eso, el trabajo de flexibilidad **debe ser integral y equilibrado.**

EN LA SALA: ERRORES FRECUENTES

La gimnasta que para mejorar su puente solo **fuerza la zona lumbar**, en lugar de **trabajar la apertura de sus hombros y caderas.**

FUERZA: MOVILIDAD PARA LEVANTAR



La flexibilidad como medio para la técnica

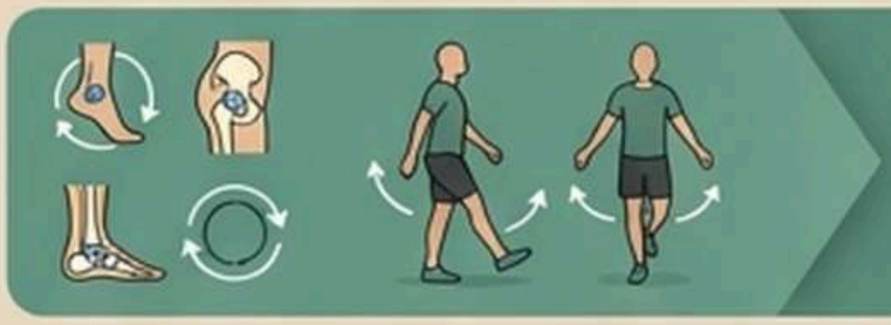
En el entrenamiento de fuerza, la flexibilidad no es el fin, sino el medio para lograr una técnica segura y eficiente. Una sentadilla profunda es imposible sin una buena **dorsiflexión de tobillo y movilidad de cadera**; si faltan, el alumno compensará inclinando el torso o levantando los talones, lo que aumenta el riesgo de lesión. Lo mismo ocurre en un press sobre la cabeza: una falta de movilidad en el hombro o en la columna torácica se compensa arqueando la zona lumbar. La movilidad aquí es un prerrequisito para la fuerza.

EN LA SALA

"Cuando bajo en la sentadilla se me levantan los talones del piso": casi siempre es un déficit de dorsiflexión del tobillo.

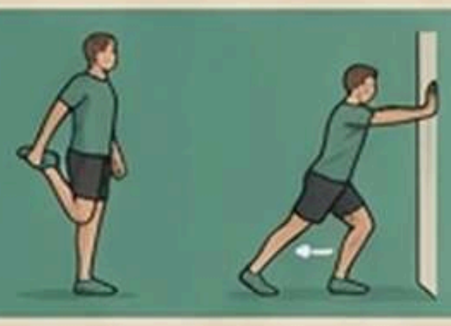
RUNNING: ESTIRAR CON ESTRATEGIA

ANTES DE CORRER



Movilidad Articular y Estiramientos Dinámicos. Preparación activa para el movimiento.

DESPUÉS DE CORRER

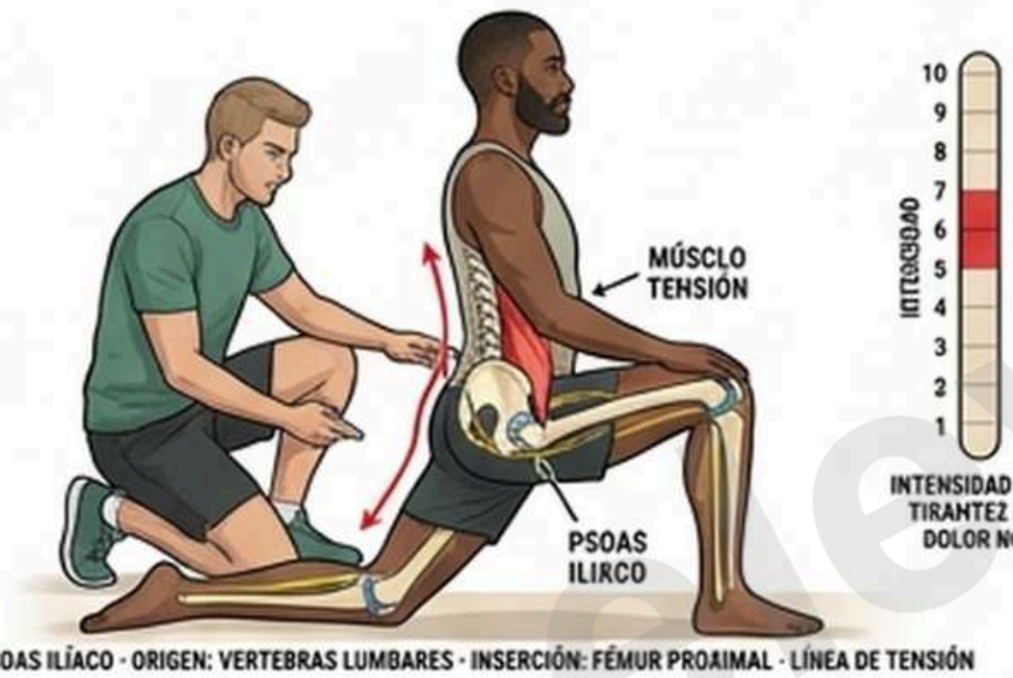


Estiramientos Estáticos Suaves. Relajación muscular post-esfuerzo.

DÍAS DE DESCANSO

Sesión Profunda: Liberación Miofascial y Técnicas Avanzadas (PNF).

LA NUEVA EVIDENCIA: Durante años se creyó que los corredores debían estirar mucho estáticamente antes de salir, pero la evidencia actual muestra otra cosa. El estiramiento estático prolongado justo antes de correr puede disminuir temporalmente la capacidad del músculo para generar fuerza y la rigidez necesaria para el impulso. Por eso, la entrada en calor se enfoca en movilidad articular y estiramientos dinámicos. Los estiramientos estáticos se dejan para después de la carrera o para sesiones separadas, enfocados en los músculos que más se acortan: psoas ilíaco, recto femoral, isquiotibiales y gemelos.



PSOAS ILÍACO · ORIGEN: VERTEBRAS LUMBARES · INSERCIÓN: FÉMUR PROXIMAL · LÍNEA DE TENSIÓN

RECTO FEMORAL · ORIGEN: ESPINA ILÍACA · INSERCIÓN: TIBIA PROXIMAL

ISQUIOTIBIALES · ORIGEN: ISQUION · INSERCIÓN: TIBIA Y PERONÉ PROXIMAL

GEMELOS · ORIGEN: FÉMUR DISTAL · INSERCIÓN: CALCÁNEO

EN LA SALA: ERROR COMÚN

El corredor amateur que llega 5 minutos antes de la clase y se pone a hacer estiramientos estáticos largos de 60 segundos con mala técnica.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

Movilidad articular y estiramientos dinámicos antes de correr. Foco en activación y preparación.

QUÉ NO

Estiramientos estáticos largos e intensos justo antes de correr o competir. Puede reducir la eficiencia.

REVISIÓN DEL KINESIÓLOGO

La ilustración coperier etiqueteda como "PNF - ISQUIOTIBIALES" se lo vociles anterior ors Deeseudnisaeeote incorrests. La postura mestreda oe era uoe técnica cetánder poro isquiotibiales. Suda eligeria de moraulo dobe cerrespender ot shtecalo que realroenle ce attire eo oca poiuiido, en oocoada ol isqaietibiasi de lo gierna de odelante NO se catite, ct psoas ce cetlis en catentóio de codera, oe en flesiin, lo linea de tencidn ve sulre et máscalo que se

ADULTO MAYOR: MOVILIDAD FUNCIONAL

FLEXIÓN DE HOMBRO

FUERZA Y MOVILIDAD DE CADERA Y RODILLA

FLEXIÓN DE CADERA Y COLUMNA

EL OBJETIVO FUNCIONAL

En el trabajo con adultos mayores, el objetivo de la flexibilidad cambia radicalmente. No buscamos rangos extremos, sino mantener y mejorar el rango de movimiento funcional necesario para las actividades de la vida diaria: atarse los cordones, alcanzar algo en una alacena, levantarse de una silla o del suelo.

La pérdida de movilidad en la cadera, los hombros y la columna torácica impacta directamente en la autonomia y aumenta el riesgo de caídas. Por eso, el foco está en ejercicios suaves, seguros y consistentes que mejoren la calidad de vida.

EN LA SALA

La alumna mayor que cuenta que ahora puede volver a jugar en el piso con sus nietos **porque recuperó la movilidad para levantarse sola.**

GLOSARIO DEL PROFE DE FLEXIBILIDAD

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA EN LA SALA
Rango de movimiento activo	Es la amplitud que una articulación puede alcanzar por la contracción voluntaria de los músculos, sin ayuda externa. Mide la función y el control motor.
Rango de movimiento pasivo	Es la amplitud que alcanza una articulación con ayuda externa (del profe, una banda o la gravedad). Casi siempre es mayor que el activo; la diferencia entre ambos es tu potencial de mejora.
Reflejo miotático	Es la respuesta de protección del sistema nervioso: cuando un músculo se estira demasiado rápido o fuerte, se contrae para evitar un desgarro. Por eso los estiramientos son lentos y progresivos.
PNF (FNP)	Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. Es un método avanzado que alterna contracciones isométricas y relajación para 'engañar' al reflejo miotático y ganar rango de forma segura.
Liberación miofascial	Técnicas manuales o con elementos (como rodillos o pelotas) para reducir la tensión y las adherencias en la fascia, el tejido conectivo que envuelve los músculos.
Hipermovilidad	Es una condición donde las articulaciones tienen un rango de movimiento mayor al normal, a menudo por laxitud ligamentaria. En estos casos, el foco es el control y la estabilidad, no forzar más flexibilidad.
Dorsiflexión	El movimiento del tobillo que lleva la punta del pie hacia la tibia. Es clave para una sentadilla profunda y para la salud de la rodilla y la cadena posterior.
Anteversión pélvica	La inclinación de la pelvis hacia adelante, que acentúa la curva lumbar. Un psoas ilíaco y un recto femoral cortos suelen contribuir a una anteversión excesiva.
Contracción excéntrica	Cuando el músculo se alarga mientras está bajo tensión (ej: la fase de bajada en una sentadilla). Es fundamental para construir fuerza en rangos amplios y prevenir lesiones.

elevify

CIERRE

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS

Contraindicaciones absolutas y relativas.

Tu criterio profesional es clave. Ante la duda, siempre es mejor derivar a un médico o kinesiólogo.

ABSOLUTAS (No estirar, derivar)	RELATIVAS (Precaución, adaptar, consultar)
• Lesión muscular o ligamentaria aguda (desgarro, esguince grado II-III). • Fractura ósea no consolidada. • Inflamación, infección o hematoma agudo y evidente en la zona. • Dolor agudo, punzante o que irradia (como en una ciática activa). • Bloqueo articular mecánico.	• Hernia de disco (depende de la fase, dirección y síntomas; requiere criterio). • Cirugía reciente (solo con el alta médica específica para elongar). • Osteoporosis severa (evitar palancas fuertes y flexión de columna). • Hipermovilidad articular (priorizar la estabilidad y el control en el rango final). • Embarazo (adaptar posiciones, evitar presión abdominal y estiramientos extremos por la relaxina). • Dolor crónico no diagnosticado (entender la causa antes de intervenir).

TU PRÓXIMO PASO

La anatomía es un mapa, pero el territorio es cada cuerpo que tenés enfrente.

Tu formación no termina con este libro, recién empieza.

Seguí aprendiendo, cuestionando y conectando con otros profes que, como vos, buscan la excelencia.

Estamos para acompañarte.

Unite al canal de WhatsApp de Elevify.

Seguinos en Instagram @elevify.oficial.

Ver tu siguiente material.

CIERRE

AVISO: MATERIAL EDUCATIVO

Este libro es material educativo para profesionales del movimiento y practicantes avanzados; no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico o kinesiológico. La información anatómica y los ejercicios se presentan como una guía y deben ser aplicados con criterio profesional.

Ante un dolor agudo, hormigueo, mareos, una lesión reciente, embarazo de riesgo o cualquier duda sobre la condición de un alumno, la indicación es detener la práctica y consultar a un profesional de la salud. Si existe una contraindicación médica, el ejercicio no debe realizarse.

Elevify no se responsabiliza por la aplicación incorrecta de las técnicas aquí descritas.